STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
KEPERAWATAN

RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Daftar Isi ii

SPO KEBUTUHAN FISIOLOGIS

1. SPO BANTUAN HIDUP NEONATUS 1
2. SPO DUKUNGAN VENTILASI DENGAN BAG VALVE 4
3. SPO EKSTUBASI SELANG ENDROTRAKHEAL 6
4. SPO FISIOTERAPI DADA 8
5. SPO LATIHAN BATUK EFEKTIF 10
6. SPO LATIHAN PERNAPASAN 12
7. SPO PEMANTAUAN PERNAPASAN 14
8. SPO PEMANTAUAN SATURASI OKSIGEN 16
9. SPO PEMANTAUAN DAN GEJALA KETIDAKSEIMBANGAN ASAM BASA 18
10. SPO PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN ENDOTRACHEALTUBE (ETT) 20
11. SPO PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN LARYNGEAL MASKAIRWAY (LMA) 23
12. SPO PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN NASOPHARINGEALAIRWAY (NPA) 25
13. SPO PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN OROPHARINGEALAIRWAY (OPA) 28
14. SPO PEMBEBASAN JALAN NAPAS DENGAN HEAD-TILT DAN CHIN LIFT 30
15. SPO PEMBEBASAN JALAN NAPAS DENGAN JAW THRUST 32
16. SPO PEMBERIAN OBAT INHALASI 34
17. SPO PEMBERIAN OBAT INTRAPLEURA 36
18. SPO PEMBERIAN OBAT NASAL 38
19. SPO PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN MASKER REBREATHING DAN NON REBREATHING 40
20. SPO PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN MASKER WAJAH (SIMPLE MASK ATAU FACE MASK) 42
21. SPO PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN NASAL KANUL 44
22. SPO PENGAMBILAN SAMPEL DARAH ARTERI 46
23. SPO PENGAMBILAN SAMPEL DARAH KAPILER 48
24. SPO PENGAMBILAN SAMPEL DARAH VENA 50
25. SPO PENGATURAN POSISI FOWLER 52
26. SPO PENGATURAN POSISI SEMI-FOWLER 54
27. SPO PENGATURAN VENTILASI MEKANIK 56
28. SPO PENGELUARAN SUMBATAN BENDA PADAT DENGAN MAGILL FORCEP 58
29. SPO PENGHISAPAN JALAN NAPAS 60
30. SPO PENGUBAHAN POSISI ENDOTRACHEAL TUBE (ETT)..... 62
31. SPO PERAWATAN SELANG DADA 64
32. SPO PERAWATAN TRAKEOSTOMI 66
33. SPO SKRINING TB 68
34. SPO PEMANTAUAN CAPILLARY REFILL TIME (CRT) 70

35. SPO PEMANTAUAN CENTRAL VENOUS PRESSURE (CVP) ….. 72
36. SPO PEMANTAUAN MEAN ARTERIAL PRESSURE (MAP) …….. 74
37. SPO PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA PERDARAHAN …….. 76
38. SPO PEMANTAUAN TANDA VITAL ……. 78
39. SPO PEMASANGAN AKSES INTRAVENA …… 80
40. SPO PEMASANGAN AKSES VENA SENTRAL ……. 84
41. SPO PEMASANGAN MONITOR JANTUNG ……..... 86
42. SPO PEMASANGAN STOCKING ELASTIS …… 88
43. SPO PEMASANGAN TORNIKET PNEUMATIK …… 90
44. SPO PEMBERIAN BALUT TEKAN …… 92
45. SPO PEMBERIAN DEFIBRILASI …….. 94
46. SPO PEMBERIAN OBAT INTRAMUSKULER ……. 97
47. SPO PEMBERIAN OBAT INTRAOSEUS …… 99
48. SPO PEMBERIAN OBAT INTRAVENA …… 101
49. SPO PEMBERIAN OBAT INTRAVENA MELALUI SELANG INFUS…….. 104
50. SPO PEMBERIAN PRODUK DARAH …….. 107
51. SPO PENGAMBILAN SPESIMEN ……. 110
52. SPO PENGATURAN POSISI SUPINE …… 112
53. SPO PENGATURAN POSISI TUNDELENBURG ……... 114
54. SPO PENGGUNAAN SYRINGE PUMP ……... 116
55. SPO PEREKAMAN ELEKTROKARDIOGRAM (EKG) 12 SADAPAN…….. 118
56. SPO REHABILITASI JANTUNG …… 121
57. SPO RESUSITASI JANTUNG PARU PADA PASIEN DEWASA …. 123
58. SPO RESUSITASI JANTUNG PARU PADA PASIEN ANAK …… 126
59. SPO DETEKSI DINI STATUS GIZI …… 129
60. SPO KONSELING LAKTASI …….. 131
61. SPO PEMANTAUAN INTAKE DAN OUTPUT CAIRAN ……. 133
62. SPO PEMANTAUAN KEPATENAN SELANG NASOGASTRIK..... 135
63. SPO PEMANTAUAN RESIDU GASTER ……. 137
64. SPO PEMANATAUAN TANDA DAN GEJALA HIPERGLIKEMIA … 139
65. SPO PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA HIPERVOLEMIA …… 141
66. SPO PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA HIPOGLIKEMIA ……. 143
67. SPO PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA HIPOVOLEMIA …….. 145
68. SPO PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA KETIDAKSEIMBANGAN ELEKTROLIT …… 147
69. SPO PEMASANGAN SELANG NASOGASTRIK (NGT) …… 150
70. SPO PEMASANGAN SELANG OROGASTRIK …….. 153
71. SPO PEMBERIAN CAIRAN INTRAVENA …… 156
72. SPO PEMBERIAN FOTOTERAPI NEONATUS …….. 158
73. SPO PEMBERIAN LATIHAN MENELAN ……. 160
74. SPO PEMBERIAN MAKANAN ENTERAL ……... 163
75. SPO PEMBERIAN NUTRISI PARENTERAL ……..... 165
76. SPO PEMBERIAN OBAT MELALUI SELANG NASOGASTRIK ….. 167
77. SPO PEMBERIAN OBAT SUBKUTAN …… 169
78. SPO PENANGANAN HIPOTENSI DURANTE HEMODIALISIS ….. 171
79. SPO PENGATURAN FILTRASI HEMODIALISIS ……... 173
80. SPO PENGUKURAN LINGKAR ABDOMEN ……... 175
81. SPO PENGUKURAN LINGKAR KEPALA …… 177

82. SPO PENGUKURAN PANJANG BADAN 179
83. SPO PENGUKURAN TINGGI BADAN 181
84. SPO PENIMBANGAN BERAT BADAN 183
85. SPO PERAWATAN IKTERIK NEONATUS 185
86. SPO PERAWTAAN RESUSITASI CAIRAN 187
87. SPO PIJAT OKSITOSIN 190
88. SPO PROMOSI BERAT BADAN 192
89. SPO PROMOSI LAKTASI 194
90. SPO RESTRIKSI CAIRAN 196
91. SPO RUJUKAN KE KELAS LAKTASI PASCA PERSALINAN 198
92. SPO RUJUKAN KE KELOMPOK DUKUNGAN MENYUSUI 200
93. SPO EDUKASI TOILET TRAINING 202
94. SPO EVAKUASI FESES SECARA MANUAL 204
95. SPO FASILITASI BERKEMIH TERATUR 207
96. SPO IRIGASI KANDUNG KEMIH 209
97. SPO IRIGASI KOLOSTOMI 211
98. SPO IRIGASI UROSTOMI 213
99. SPO MASASE (PIJAT) ABDOMEN 216
100. SPO PEMANTAUAN BISING USUS 218
101. SPO PEMANTAUAN DISTENSI KANDUNG KEMIH 220
102. SPO PEMASANGAN KATETER URINE PASIEN LAKI-LAKI 222
103. SPO PEMASANGAN KATETER URINE PASIEN PEREMPUAN 225
104. SPO PEMBERIAN LATIHAN ELIMINASI FEKAL 228
105. SPO PEMBERIAN LATIHAN KANDUNG KEMIH (BLADDER TRAINING)..... 231
106. SPO PEMBERIAN OBAT SUPOSITORIA ANAL 232
107. SPO PENGAMBILAN SAMPEL URINE TENGAH (MIDSTREAM) 234
108. SPO PERAWATAN INKONTINENSIA FEKAL 236
109. SPO PERAWATAN INKONTINENSIA URINE 238
110. SPO PERAWATAN KATETER URINE 241
111. SPO PERAWATAN STOMA 243
112. SPO DUKUNGAN AMBULASI 246
113. SPO DUKUNGAN MOBILISASI FISIK 248
114. SPO DUKUNGAN TIDUR 250
115. SPO PEMANTAUAN KELELAHAN FISIK DAN MENTAL 252
116. SPO PEMASANGAN BIDAI 254
117. SPO PEMBERIAN LATIHAN RENTANG GERAK 256
118. SPO PEMBERIAN TIRAH BARING 259
119. SPO PERAWATAN GIPS 261
120. SPO PERAWATAN TRAKSI 263
121. SPO IRIGASI MATA 265
122. SPO IRIGASI TELINGA 267
123. SPO LATIHAN MEMORI 269
124. SPO LATIHAN ORIENTASI 271
125. SPO PEMANTAUAN CPP (CEREBRAL PERFUSSION PRESSURE)..... 273
126. SPO PEMANTAUAN EFEK SAMPING PASCA ECT (ELECTROCONVULSIVE THERAPY)..... 275
127. SPO PEMANTAUAN PENINGKATAN TEKANAN 277

INTRAKRANIAL 277
128. SPO PEMANTAUAN STATUS NEUROLOGIS 279
129. SPO PEMANTAUAN TINGKAT DELIRIUM 281
130. SPO PEMANTAUAN TINGKAT KESADARAN DENGAN SKALA KOMA GLASGOW (GCS) 383
131. SPO PEMANTAUAN TINGKAT ORIENTASI 285
132. SPO PEMANTAUAN PERUBAHAN SENSORIK 287
133. SPO PEMASANGAN PENAHAN GIGI SEBELUM ECT 289
134. SPO PEMBERIAN SALEP MATA 290
135. SPO PEMBERIAN OBAT TETES MATA 291
136. SPO PENCEGAHAN KEJANG 293
137. SPO PERSIAPAN ECT 295
138. SPO STIMULASI KOGNITIF 296
139. SPO EDUKASI PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL YANG SEHAT DAN AMAN 298
140. SPO EDUKASI KONTRASEPSI 301
141. SPO EDUKASI PENCEGAHAN PERILAKU SEKSUAL BERESIKO 303
142. SPO EDUKASI PENDAMPING PERSALINAN 305
143. SPO EDUKASI PERAWATAN KEHAMILAN 307
144. SPO EDUKASI PERAWATAN PERINEUM PASCA PERSALINAN SEKSUALITAS 309
145. SPO EDUKASI PERSIAPAN PROGRAM IVF (IN VITRO FERTILITATION) 311
146. SPO EDUKASI PPIA (PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK) 314
147. SPO EDUKASI PRAKONSEPSI 317
148. SPO EDUKASI TANDA BAHAYA PASCA PERSALINAN 319
149. SPO FASILITASI INISIASI MENYUSU DINI 321
150. SPO FASILITASI INTERAKSI ORANG TUA DAN BAYI 324
151. SPO FASILITASI INTERAKSI ORANG TUA DAN JANIN 326
152. SPO FASILITASI KENYAMANAN IBU PASCA PERSALINAN 329
153. SPO IDENTIFIKASI KEMAMPUAN IBU MERAWAT BAYI 331
154. SPO IDENTIFIKASI KONDISI PSIKOSOSIAL IBU BERSALIN 333
155. SPO IDENTIFIKASI PERSALINAAN RISIKO TINGGI 335
156. SPO IDENTIFIKASI RIWAYAT KEHAMILAN DAN PERSALINAN 337
157. SPO KONSELING GENETIK 339
158. SPO KONSELING KEHAMILAN 341
159. SPO KONSELING PENGANIAYAAN DAN PENCEGAHAN SEKSUAL 343
160. SPO KONSELING PRAKONSEPSI 345
161. SPO KONSELING SEKSUALITAS 348
162. SPO LATIHAN SENAM HAMIL 350
163. SPO LATIHAN SENAM NIFAS 353
164. SPO PELAKSANAAN MTBS-MTBM 355
165. SPO PEMANTAUAN KARDIOTOGRAFI (CTG) 358
166. SPO PEMANTAUAN GERAK JANIN 360
167. SPO PEMANTAUAN INFUS TOKOLISIS 362
168. SPO PEMANTAUAN PERSALINAN DENGAN PARTOGRAF 364

169. SPO PEMBERIAN OBAT VAGINA 369
170. SPO PEMERIKSAAN DENYUT JANTUNG JANIN DENGAN DOPPLER..... 371
171. SPO PEMERIKSAAN LOCHEA 373
172. SPO PEMERIKSAAN PAYUDARA 375
173. SPO PEMERIKSAAN PERINEUM 378
174. SPO PEMERIKSAAN TANDA HOMAN 380
175. SPO PEMERIKSAAN TANDA-TANDA KEHAMILAN 381
176. SPO PEMERIKSAAN URINE KEHAMILAN 383
177. SPO PENDAMPINGAN KEHAMILAN RISIKO TINGGI 385
178. SPO PERAWATAN PERSALINAN RISIKO TINGGI 387
179. SPO PERAWATAN INTRANATAL KALA I 389
180. SPO PERAWATAN INTRANATAL KALA II 391
181. SPO PERAWATAN INTRANATAL KALA III 393
182. SPO PERAWATAN INTRANATAL KALA IV 395
183. SPO PERAWATAN PASCA INDUKSI PERSALINAN 397
184. SPO PERAWATAN PERDARAHAN SELAMA KEHAMILAN 399
185. SPO PERAWATAN PERAWATAN ROBEKAN JALAN LAHIR 401
186. SPO PERAWATAN VULVA HYGIENE 403
187. SPO PERSIAPAN PAP SMEAR 405
188. SPO PERSIAPAN PEMERIKSAAN USG KEHAMILAN 407
189. SPO PERSIAPAN PERSLAINAN DENGAN TINDAKAN SECTIO CAESAREA (SC)..... 409
190. SPO PERSIAPAN PROSEDUR AMNIOSENTESIS 411
191. SPO PERSIAPAN TINDAKAN PESSARIUM 413
192. SPO PERSIAPAN TINDAKAN TRANSFER EMBRIO (EMBRYO TRANSFER [ET])..... 415
193. SPO PERSIAPAN TINDAKAN HISTEROSKOPI DIAGNOSTIK 418
194. SPO PERSIAPAN TINDAKAN OVUM PICK OUT (OPU) 420

SPO KEBUTUHAN PSIKOLOGIS

195. SPO EDUKASI MANAJEMEN NYERI 423
196. SPO PEMANTAUAN EFEK SAMPING TERAPI RADIASI 425
197. SPO PEMANTAUAN NYERI 427
198. SPO PEMANTAUAN NYERI PADA ANAK 429
199. SPO PEMBERIAN AKUPRESURE 431
200. SPO PEMBERIAN KOMPRES DINGIN 433
201. SPO PEMBERIAN KOMPRES HANGAT 435
202. SPO PEMBERIAN LATIHAN OTOGENIK 437
203. SPO PEMBERIAN TEKNIK IMAJINASI TERBIMBING 439
204. SPO PENGELOLAAN NYERI PADA ANAK 441
205. SPO TERAPI RELAKSASI NAPAS DALAM 443
206. SPO TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF 445
207. SPO DISKUSI KELOMPOK TERARAH 447
208. SPO DUKUNGAN EMOSIONAL 449
209. SPO DUKUNGAN HIPNOSIS DIRI 451
210. SPO DUKUNGAN KELOMPOK 453
211. SPO DUKUNGAN MEMAAFKAN 456

212. SPO DUKUNGAN PELAKSANAAN IBADAH …….. 458
213. SPO DUKUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ……. 460
214. SPO DUKUNGAN PENGUNGKAPAN KEBUTUHAN …… 462
215. SPO DUKUNGAN PENGUNGKAPAN PERASAAN …….. 464
216. SPO DUKUNGAN PERASAAN BERSALAH ……... 466
217. SPO DUKUNGAN PERKEMBANGAN SPIRITUAL …… 468
218. SPO DUKUNGAN PERLINDUNGAN PENGANIAYAAN ……..... 470
219. SPO DUKUNGAN PROSES BERDUKA …….. 472
220. SPO EDUKASI KETERAMPILAN KOPING ……. 474
221. SPO EDUKASI KETERAMPILAN PENCEGAHAN KEKAMBUHAN 476
222. SPO EDUKASI METODE MODULASI PENGALAMAN EMOSI ….. 478
223. SPO EDUKASI PEMANTAUAN MOOD SECARA MANDIRI …… 480
224. SPO EDUKASI PENANGANAN GANGGUAN MOOD …….. 482
225. SPO EDUKASI PENANGANAN MARAH ……. 484
226. SPO EDUKASI TEKNIK PENGONTROLAN HALUSINASI …….. 494
227. SPO IDENTIFIKASI PENYEBAB-PEMICU KEMARAHAN …… 488
228. SPO MEDIASI KONFLIK ……. 490
229. SPO PELIBATAN KELUARGA DALAM PROGRAM PERAWATAN 492
230. SPO PEMANTAUAN ISI HALUSINASI ……. 494
231. SPO PEMBERIAN REDUKASI ANSIETAS …… 496
232. SPO PEMBERIAN SEKLUSI …….. 498
233. SPO PEMBERIAN TERAPI ASERTIF 1 ……... 500
234. SPO PEMBERIAN TERAPI ASERTIF 2 ……..... 502
235. SPO PEMBERIAN TERAPI ASERTIF 3 ……..... 503
236. SPO PEMBERIAN TERAPI ASERTIF 4 ……... 504
237. SPO PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 1 ……... 506
238. SPO PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 2 ……... 508
239. SPO PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 3 ……... 510
240. SPO PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 4 …….. 511
241. SPO PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 5 ……... 513
242. SPO PEMBERIAN TERAPI KELOMPOK …… 515
243. SPO PEMBERIAN TERAPI KELUARGA ……. 517
244. SPO PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF 1 ……. 519
245. SPO PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF 2 ……. 521
246. SPO PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF 3 ……. 523
247. SPO PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 1 …… 525
248. SPO PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 2 …… 527
249. SPO PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 3 …… 529
250. SPO PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 4 …… 531
251. SPO PEMBERIAN TERAPI MILEU …….. 533
252. SPO PEMBERIAN TERAPI PERILAKU ……... 535
253. SPO PEMBERIAN TERAPI REMEDIAL ……... 537
254. SPO PEMBERIAN TERAPI REMINISENS ……... 539
255. SPO PEMBERIAN TERAPI RUMATAN METADON …….. 542
256. SPO PEMBERIAN TERAPI SENI …….. 545
257. SPO PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 1 …… 547
258. SPO PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 2 …… 549
259. SPO PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 3 …… 551
260. SPO PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 4 …… 553

261. SPO PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ZAT 555
262. SPO PENGONTROLAN PENYALAHGUNAAN ZAT 557
263. SPO PERAWATAN JENAZAH 559
264. SPO PERWATAN PUTUS ZAT 561
265. SPO PERAWATAN PUTUS ZAT DENGAN TERAPI SUBSTITUSI 563
266. SPO PROMOSI CITRA TUBUH 565
267. SPO PROMOSI DUKUNGAN SPIRITUAL 567
268. SPO PROMOSI HARAPAN 569
269. SPO PROMOSI HUBUNGAN POSITIF 571
270. SPO PROMOSI KEPERACAYAAN DIRI 573
271. SPO PROMOSI KESADARAN DIRI 575
272. SPO PROMOSI KOPING 577
273. SPO DETEKSI DINI STUNTING 579
274. SPO EDUKSI DETEKSI DINI HIV (AIDS) PADA BAYI (ANAK) 581
275. SPO EDUKASI PENCEGAHAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) 583
276. SPO EDUKASI PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA ANAK 586
277. SPO EDUKASI PERAWATAN BAYI 588
278. SPO EDUKASI PERAWATAN HIV-AIDS PADA ANAK 590
279. SPO EDUKASI STIMULASI PERKEMBANAGAN BAYI (ANAK) 592
280. SPO MEMANDIKAN BAYI 594
281. SPO PEMANTAUAN ANTROPOMETRI PADA BAYI (ANAK) 597
282. SPO PEMBERIAN ASUHAN PERKEMBANAGAN PADA NEONATUS 599
283. SPO PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MPASI) 601
284. SPO PEMBERIAN TERAPI BERCERITA 603
285. SPO PEMBERIAN TERAPI BERMAIN 605
286. SPO PEMERIKSAAN BAYI SEBELUM PEMULANGAN 607
287. SPO PERAWATAN PALIATIF PADA ANAK 609
288. SPO PERAWATAN TALI PUSAT 611
289. SPO PIJAT BAYI 613

SPO PERILAKU

290. SPO DUKUNGAN PERAWATAN DIRI (BERPAKAIAN) 621
291. SPO DUKUNGAN PERAWATAN DIRI (MANDI) 623
292. SPO PERAWATAN DIRI 625
293. SPO PERAWATAN GIGI PALSU 626
294. SPO PERAWATAN KAKI 628
295. SPO PERAWATAN KUKU 630
296. SPO PERAWATAN MULUT 632
297. SPO PERAWATAN RAMBUT 634
298. SPO BIMBINGAN ANTISIPATIF 637
299. SPO BIMBINGAN SISTEM KESEHATAN 639
300. SPO EDUKASI KELUARGA 641
301. SPO EDUKASI KESEHATAN 643
302. SPO MANAJEMEN KASUS 645
303. SPO PERENCANAAN PULANG 647

SPO RELASIONAL

304. SPO DUKUNGAN INTERAKSI SOSIAL …….. 649
305. SPO DUKUNGAN KELUARGA MERENCANAKAN PERAWATAN 651
306. SPO DUKUNGAN PENAMPILAN PERAN …….. 653
307. SPO EDUKASI KOMUNIKASI EFEKTIF …….. 655
308. SPO EDUKASI PADA PENGASUH …….. 658
309. SPO KOORDINASI DISKUSI KELUARGA …….. 660
310. SPO MOBILISASI KELUARGA …….. 662
311. SPO MODIFIKASI PERILAKU KETERAMPILAN KELUARGA …… 664
312. SPO PENDAMPINGAN KELUARGA …… 666
313. SPO PROMOSI DUKUNGAN KELUARGA …… 668
314. SPO PROMOSI DUKUNGAN SOSIAL …… 670
315. SPO PROMOSI KEUTUHAN KELUARGA …….. 672
316. SPO PROMOSI KOMUNIKASI EFEKTIF …….. 674
317. SPO PROMOSI PENGASUHAN ……... 676
318. SPO PROMOSI PROSES EFEKTIF KELUARGA …….. 678
319. SPO PROMOSI SOSIALISASI …….. 680

SPO LINGKUNGAN

320. SPO DUKUNGAN PEMELIHARAAN RUMAH …… 682
321. SPO EDUKASI KESELAMATAN LINGKUNGAN …… 684
322. SPO EDUKASI KESELAMATAN RUMAH ……... 686
323. SPO IDENTIFIKASI RISIKO MASALAH KESEHATAN …… 688
324. SPO KEBERSIHAN TANGAN DENGAN HANDRUB …… 690
325. SPO KEBERSIHAN TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR MENGALIR…… 692
326. SPO MANAJEMEN ISOLASI …… 694
327. SPO MANAJEMEN KENYAMANAN LINGKUNGAN …… 696
328. SPO MANAJEMEN KESELAMATAN LINGKUNGAN …… 698
329. SPO MANAJEMEN REAKSI ALERGI …….. 700
330. SPO PELEPASAN ALAT PELINDUNG DIRI (COVERALL) …….. 702
331. SPO PELEPASAN ALAT PELINDUNG DIRI (GOWN) …….. 704
332. SPO PEMANTAUAN RISIKO BUNUH DIRI …… 706
333. SPO PEMANTAUAN RISIKO JATUH …….. 708
334. SPO PEMANTAUAN RISIKO PERILAKU KEKERASAN …… 710
335. SPO PEMASANGAN ALAT PELINDUNG DIRI (COVERALL) ……. 712
336. SPO PEMASANGAN ALAT PELINDUNG DIRI (GOWN) …….. 714
337. SPO PEMASANGAN ALAT PENGAMAN …… 716
338. SPO PEMASANGAN NECK COLLAR …….. 718
339. SPO PEMBERIAN IMUNISASI-VAKSIN …….. 720
340. SPO PEMBERIAN TEPID-SPONGE …… 723
341. SPO PEMBERIAN TERAPI SKIN TO SKIN …… 725
342. SPO PENCEGAHAN CEDERA …….. 727
343. SPO PENCEGAHAN INFEKSI …….. 729

344. SPO PENCEGAHAN INFEKSI INTRAOPERATIF 731
345. SPO PENCEGAHAN JATUH 733
346. SPO PENGEKANGAN FISIK 735
347. SPO PENGEKANGAN KIMIAWI 737
348. SPO PENGONTROLAN INFEKSI 739
349. SPO PENJAHITAN LUKA 741
350. SPO PERAWATAN AMPUTASI 743
351. SPO PERAWATAN BAYI DALAM INKUBATOR 745
352. SPO PERAWATAN INTEGRITAS KULIT 747
353. SPO PERAWATAN INTEGRITAS KULIT AKIBAT PEMBERIAN OBAT ANTINEOPLASTIK 749
354. SPO PERAWATAN KEMOTERAPI 751
355. SPO PERAWATAN LUKA 753
356. SPO PERAWATAN LUKA BAKAR 755
357. SPO PERAWATAN METODE KANGURU 757
358. SPO PERAWATAN PASCAOPERATIF 759
359. SPO PERAWATAN PREOPERATIF 761
360. SPO PERAWATAN SIRKUMSISI 763
361. SPO SKRINING PASIEN ISOLASI 765
362. SPO TRANSFER PASIEN 767
363. SPO TRIASE 773
364. SPO TRIASE BENCANA 775
365. SPO PENCGAHAN PERILAKU KEKERASAN 777
366. SPO MANAJEMEN KESEHATAN KERJA 779

SPO JIWA

367. SPO TERAPI BERMAIN UNTUK PASIEN GANGGUAN JIWA..... 781
368. SPO PENGKAJIAN RESIKO BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI 784
369. SKRINING RESIKO BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI 787
370. TERAPI ELEKTROKONVULSIF (ECT) 790
371. TATALAKSANA PENCEGAHAN RESIKO BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI 793
372. MANAJEMEN PERILAKU AGRESIF DALAM TERAPI KELOMPOK..... 796
373. ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN WAHAM 798
374. ALUR PENERIMAAN PASIEN OLEH PERAWAT DI UNIT PERAWATAN INTENSIF PSIKIATRI (UPIP) 800
375. PSIKOEDUKASI PASIEN DAN KELUARGA 802
376. TERAPI REKREASI 805
377. TERAPI REMINISCENCE 807
378. TERAPI RELAKSASI 809
379. TERAPI SPIRITUAL 811
380. TERAPI SUPORTIF 813
381. TERAPI AKTIFITAS KELOMPOK (TAK) DEFISIT PERAWATAN DIRI 815
382. TERAPI OKUPASI 819
383. TERAPI KELUARGA 821
384. TERAPI MUSIK 825
385. TERAPI KOGNITIF PERILAKU (CBT) BERBASIS KEPERAWATAN ... 827
386. TERAPI INDIVIDU 829

387. TERAPI HUBUNGAN SALING PERCAYA (BHSP) 832
388. TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) SOSIALISASI 835
389. TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) STIMULASI PERSEPSI 839
390. TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) ORIENTASI REALITA 842
391. TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) HARGA DIRI RENDAH (HDR) 846
392. TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) HALUSINASI 851
393. IMPLEMENTASI KNOW EACH OTHER (SALING MENGENAL SATU SAMA LAIN) 855
394. IMPLEMENTASI MUTUAL HELP MEETING (PERTEMUAN YANG BERMUTU DAN MEMBANTU 858
395. KONTROL MARAH PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA VERBAL 861
396. CODE WHITE 863
397. ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DEFISIT PERAWATAN DIRI : BERDANDAN 866
398. ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DEFISIT PERAWATAN DIRI : MANDI 868
399. ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN HARGA DIRI RENDAH 870
400. ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ISOLASI SOSIAL : MENARIK DIRI 872
401. BERKUNJUNG DI BANGSAL JIWA 874
402. FAMILY GATHERING TERPADU SEMARPATRI 876
403. FIKSASI MEKANIS : RESTRAIN 880
404. FIKSASI MEKANIS : SEKLUSI 883
405. IMPLEMENTASI BAD NEWS MITIGATION (IDENTIFIKASI BERITA BURUK) 885
406. IMPLEMENTASI CALM DOWN METHODS (METODE MENURUNKAN KETEGANGAN DAN AGITASI 887
407. IMPLEMENTASI CLEAR MUTUAL EXPECTATION (HARAPAN PASIEN DAN STAF YANG JELAS KEBERADAAN DI RS) 890
408. IMPLEMENTASI DISCHARGE MESSAGES (PESAN PELEPASAN/ PEMINDAHAN / PEMULANGAN) 892
409. IMPLEMENTASI POSITIVE WORDS 895
410. IMPLEMENTASI REASSURANCE (PEMBERIAN JAMINAN KEJELASAN DAN KEPASTIAN) 897
411. IMPLEMENTASI SOFT WORDS (KATA-KATA YANG LEMBUT) 899
412. IMPLEMENTASI TALK DOWN (BERBICARA UNTUK MENENANGKAN PASIEN 901
413. KOMUNIKASI KELUARGA / PASIEN PSIKIATRI MELALUI MEDIA SOSIAL 904
414. KOMUNIKASI KOMUNITAS PASIEN RAWAT INAP DENGAN MEDIA SOSIAL “PERMADI SAKTI” 905
415. KONTROL HALUSINASI PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA KEGIATAN POSITIF 906
416. KONTROL HALUSINASI PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA MENGHARDIK 908
417. KONTROL MARAH PADA RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA FISIK 910

418. KONTROL MARAH PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA SPIRITUAL 912
419. MENCEGAH PASIEN MELARIKAN DIRI 914
420. PEMAKAIAN SERAGAM KERJA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP PSIKIATRI 916
421. PEMAKAIAN SERAGAM PASIEN DI RAWAT INAP PSIKIATRI 918
422. PENANGANAN BULLYING DI RUANG RAWAT INAP PSIKIATRI 920
423. PENANGANAN PASIEN MELARIKAN DIRI 922
424. PENATALAKSANAAN GADUH GELISAH / AGITASI 924
425. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL DI RAWAT INAP PSIKIATRI 926
426. PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP PSIKIATRI 928
427. PENGELOLAAN PASIEN GELANDANGAN / TIDAK ADA IDENTITAS DIRUANG PSIKIATRI 930
428. PENGELOLAAN PASIEN GELANDANGAN / TIDAK ADA IDENTITAS DI RUANG PSIKIATRI 933
429. PENGGUNAAN OBAT YANG BAIK DAN BENAR PADA PASIEN GANGGUAN JIWA 934
430. PERAWATAN PASCA ECT 936
431. PERAWATAN TOTAL PASIEN PSIKIATRI 937
432. RUJUKAN PASIEN JIWA KE LUAR RUMAH SAKIT 938
433. TATALAKSANA PAMULANGAN PASIEN RAWAT INAP PSIKIATRI .. 940
434. TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) 942

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**BANTUAN HIDUP NEONATUS**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1405 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan pertolongan pada usaha napas bayi baru lahir.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memberikan bantuan hidup neonatus supaya ventilasi spontan meningkat, sirkulasi spontan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan tiga detail wajib, (nama, tanggal lahir,dan nomor rekam medis) 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan persiapan tim resusitasi dan pembagian tugas. 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Laringoskop dengan baterai, dan lampu cadangan. b. Daun laringoskop (no. 1 dan no. 0). c. Pipa ET no. 2.5, 3.0, 3.5, dan 4.0. d. Stilet, jika tersedia. e. Pendeteksi CO2, jika tersedia. f. Kateter penghisap no. 10 atau lebih. g. Plesterdan gunting. h. Oropharyngeal airway (OPA), sesuai ukuran. i. Aspirator Mekonium.

j. Stetoskop.
k. Balon resusitasi, sungkup, dan manometer.
l. Epinefrin 1: 10.000.
m. Nacl 0,9%.
n. Naloxon hidroklorida
o. Pemancar panas (radian marmer)
p. Sarung tangan bersih dan steril

11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah.
12. Gunakan sarung tangan bersih.
13. Lakukan penilaian awal saat bayi lahir:
    a. Apakah bernapas, menangis atau memiliki tonus otot baik
    b. Lakukan perawatan rutin jika Ya, dan lanjutkan resusitasi, jika Tidak.
13. Lakukan langkah awal resusitasi selama 30 detik:
    a. Pastikan bayi tetap hangat.
    b. Atur posisi kepala sedikit ekstensi dan bersihkan jalan napas.
    c. Keringkan dan berikan stimulasi.
    d. Posisikan kembali.
14. Periksa usaha napas, laju denyut jantung (LDJ) dan tonus otot:
    a. Jika bayi bernapas spontan, masih ada sianosis sentral persisten tanpa distres napas maka pertimbangkan pemberian oksigen dan monitor SpO2.
    b. Jika terdapat distres napas (takipnea, retraksi atau merintih) maka berikan CPAP dengan TPAE 7-8 cmHO dan monitor SpO2 Jika setelah diberikan CPAP, bayi tidak bernapas, pertimbangkan intubasi.
    c. Jika bayi tidak bernapas atau napas megap-megap dan/atau LDJ kurang dari 100 x/menit, maka lakukan Ventilasi Tekanan Positif (VTP) selama 20-30 kali tiap 30 detik sambil monitor SpO_2.
15. Lakukan penilaian awal VTP, jika tidak efektif maka

	lakukan evaluasi pelekatan sungkup. 16. Lakukan penilaian VTP kedua: a. Hasil penilaian LDJ 60-90 x/menit, lanjutkan evaluasi ventilasi dan jika denyut jantung lebih atau sama dengan 100 x/menit maka lanjutkan ke perawatan pasca resusitasi. b. Hasil penilaian LDJ kurang dari 60 x/menit maka lakukan evaluasi ventilasi, pertimbangkan intubasi, VTP (02 100%) ditambah dengan kompresi dada kompresi: 1 napas), dan monitor LDJ serta usaha napas tiap 60 detik . 17. Lakukan pemberian obat-obatan dan cairan jika LDJ kurang dari 60 x/menit. 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 19. Lepaskan sarung tangan. 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 21. Lakukan koordinasi untuk pemindahan bayi ke ruang intensif neonatus. 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan kondisi bayi.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat. 2. Instalasi Rawat Inap. 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif. 4. Instalasi Bedah Sentral.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN VENTILASI DENGAN BAG VALVE MASK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1375 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi dalam mempertahankan pernapasan spontan untuk memaksimalkan pertukaran gas di paru-paru
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memberikan bantuan dengan alat bag valve mask supaya pola napas membaik, ventilasi spontan meningkat, penyampihan ventilator meningkat, pertukaran gas meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. BVM c. Selang End to End d. Suplai oksigen 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN VENTILASI DENGAN BAG VALVE MASK**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1375 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 2/2
	8. Pasang sarung tangan bersih. 9. Atur posisi telentang. 10. Sambungkan kanul BVM ke nipple nut oksigen. 11. Atur kadar oksigen 10-15 L/menit atau sesuai kebutuhan. 12. Pasangkan masker BVM ke area hidung dan mulut dengan teknik EC-Clamp. 13. Pompa BVM, sesuai perkiraan volume tidal. 14. Hentikan prosedur, jika pasien bemapas spontan secara adekuat. 15. Angkat masker BVM dari hidung dan mulut pasien. 16. Ganti BVM dengan NRM 10-15 L/menit. 17. Atur posisi pasien semi-Fowler. 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 19. Lepaskan sarung tangan. 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EKSTUBASI SELANG ENDOTRAKHEAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1376 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melepaskan selang endotrakhea dari jalan napas melalui mulut
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memberikan bantuan dengan alat bag valve mask supaya pola napas membaik, ventilasi spontan meningkat. pertukaran gas meningkat, penyapihan ventilator meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas: (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Identifikasi indikasi pelepasan selang endotrakeal. 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Spuit 20 cc c. Selang oksigen pengganti (seperti RM, NRM), sesuai kebutuhan d. Kasa e. Selang suction, ukuran sesuai kebutuhan f. Mesin suction 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah.

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">EKSTUBASI SELANG ENDOTRAKHEAL</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

900.7.4 / 1376 / 2026</td><td>No.Revisi

04</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">9. Pasang sarung tangan bersih.
10. Posisikan pasien telentang, atau sesuai kebutuhan.
11. Lakukan penghisapan lendir pada selang endotrakeal dan mulut, jika perlu.
12. Kempiskan balon endotrakheal menggunakan spuit 20 cc.
13. Lepaskan fiksasi luar.
14. Tarik selang endotrakheal melalui mulut.
15. Ulangi penghisapan lendir, jika perlu.
16. Bersihkan area bibir dengan kasa, jika perlu.
17. Berikan oksigen via selang oksigen pengganti, sesuai kebutuhan.
18. Atur aliran oksigen, sesuai kebutuhan.
19. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan.
20. Lepaskan sarung tangan.
21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah.
22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
5. Instalasi Bedah Sentral</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FISIOTERAPI DADA**		
	No.Dokumen 400.7.9/1377/ 2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. LOEKMONO HADI dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memobilisasi sekresi jalan napas melalui perkusi, getaran dan drainase postural
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah postural drainase/mengeluarkan dahak pada pasien, ventilasi spontan meningkat, bersihan Jalan napas meningkat pertukaran gas meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas: (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Bengkok berisi cairan desinfektan c. Tisu d. Suplai oksigen, jika perlu e. Set suction, jika perlu 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 8. Pasang sarung tangan bersih.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FISIOTERAPI DADA**		
	No.Dokumen 400.7.4/1377/2026	No.Revisi 04	Halaman : 2/2
	9. Periksa status pernapasan (meliputi frekuensi napas, kedalaman napas. 10. Karakteristik sputum, bunyi napas tambahan) 11. Posisikan pasien sesuai dengan area paru yang mengalami penumpukan sputum. 12. Gunakan bantal untuk mengatur posisi. 13. Lakukan perkusi dengan posisi tangan ditangkupkan selama 3-5 menit. 14. Hindari perkusi pada tulang belakang, ginjal, payudara wanita, daerah insisitulang rusuk yang patah. 15. Lakukan vibrasi dengan posisi tangan rata bersamaan dengan ekspirasi melalui mulut. 16. Lakukan penghisapan sputum, jika perlu. 17. Anjurkan batuk segera setelah prosedur selesai. 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 19. Lepaskan sarung tangan. 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan, karakteristik sputum dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 5. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN BATUK EFEKTIF**		
	No.Dokumen 400.7.4/1378/2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melatih kemampuan batuk secara efektif untuk membersihkan faring, trakea dan bronkus dari sekret atau benda asing di jalan napas
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah batuk efektif pada pasien untuk bersihan jalan napas meningkat, perlambatan pemulihan pasca bedah status neurologis membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih, jika perlu b. Tisu c. Bengkok dengan cairan desinfektan d. Suplai oksigen, jika perlu b. Pengalas atau underpad

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN BATUK EFEKTIF**		
	No.Dokumen 400.7.9/1378/2026	No.Revisi 04	Halaman : 2/2
	7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 8. Pasang sarung tangan bersih, jika perlu. 9. Identifikasi kemampuan batuk. 10. Atur posisi semi-Fowler dan Fowler. 11. Anjurkan menarik napas melalui hidung selama 4 detik, menahan napas selama 2 detik, kemudian menghembuskan napas dari mulut dengan bibir dibulatkan (mencucu) selama 8 detik. 12. Anjurkan mengulangi tindakan menarik napas dan hembuskan selama 3 kali 13. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ke-3 14. Kolaborasi pemberian mukolitik dan ekspektoran, jika perlu. 15. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 16. Lepaskan sarung tangan. 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 5. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN PERNAPASAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1379/2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi dalam mempertahankan pernapasan spontan untuk memaksimalkan pertukaran gas di paru dan meningkatkan kenyamanan
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melatih pernapasan, untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien, pertukaran gas meningkat, rasa nyaman meningkat, pemulihan pasca bedah meningkat, pola napas membaik, tingkat nyeri menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 7. Monitor frekuensi, irama dan kedalaman napas. 8. Sediakan tempat yang tenang dan nyaman. 9. Posisikan pasien nyaman dan rileks. 10. Anjurkan memposisikan satu tangan di dada dan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN PERNAPASAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1379/2026	No.Revisi 04	Halaman : 2/2

	satu tangan di perut. 11. Anjurkan menarik napas melalui hidung selama 4 detik, menahan napas selama 2 detik, kemudian menghembuskan napas dari mulut dengan bibir dibulatkan (mencucu) selama 8 detik. 12. Pastikan dinding dada mengembang saat inspirasi. 13. Anjurkan mengulangi latihan napas sebanyak 5-10 kali. 14. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 5. Instalasi Bedah Sentral

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN PERNAPASAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1380 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data untuk memastikan kepatenan jalan napas dan keefektifan pertukaran gas
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk ventilasi spontan meningkat , tingkat aspirasi menurun, bersihan jalan napas meningkat, pertukaran gas meningkat, pola napas membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Stetoskop b. Jam atau pengukur waktu 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 8. Monitor adanya sumbatan jalan napas (seperti sputum, darah, benda padat.)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN PERNAPASAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1380/2026	No.Revisi 04	Halaman : 2/2
	9. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya Napas. 10. Monitor tanda dan gejala distres pernapasan (seperti sesak napas, napas cuping hidung, penggunaan otot bantu napas, retraksi dinding dada) 11. Monitor kemampuan batuk efektif. 12. Auskultasi bunyi napas. 13. Monitor saturasi oksigen. 14. Monitor nilai Analisa Gas Darah (AGD), jika perlu 15. Monitor hasil rontgen dada, jika perlu. 16. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu. 17. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien. 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 19. Dokumentasikan hasil pemantauan.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 5. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN SATURASI OKSIGEN**		
	No.Dokumen 400.7.9/1381/2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data terkait presentasi hemoglobin.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk curah jantung meningkat, perfusi perifer meningkat, bersihan jalan napas meningkat, pertukaran gas meningkat, pola napas membaik, perfusi miokard meningkat, tingkat syok menurun, tingkat aspirasi menurun,ventilasi spontan meningkat, sirkulasi spontan meningkat, penyapihan ventilator meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Oksimetri nadi b. Alcohol swab, jika perlu 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN SATURASI OKSIGEN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1381 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 2/2
	8. Bersihkan area pemasangan oksimetri nadi dengan alcohol swab, jika perlu 9. Tekan tombol "On/Off" untuk mengaktifkan alat oksimetri nadi 10. Pasang probe oksimetri nadi pada ujung jari. 11. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 12. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien. 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 14. Dokumentasikan hasil pemantauan.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 5. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA KETIDAKSEIMBANGAN ASAM-BASA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1382 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	
PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data untuk menilai ketidaknormalan ekuilibrium antara ion hidrogen di ruang intraseluler dan ekstraseluler		
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk bersihan jalan napas meningkat, curah jantung meningkat, pertukaran gas meningkat, status cairan membaik, pola napas membaik, perfusi perifer meningkat, tingkat aspirasi menurun, perfusi miokard meningkat, ventilasi spontan meningkat, tingkat syok menurun, sirkulasi spontan meningkat, penyapihan ventilator meningkat		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.		
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien. 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan. 5. Monitor frekuensi dan kedalaman napas. 6. Monitor irama dan frekuensi jantung. 7. Monitor status neurologi (tingkat kesadaran, status mental). 8. Monitor perubahan pH, PaCO2 dan HCO3. 9. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu.		

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA KETIDAKSEIMBANGAN ASAM-BASA</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen
400.7.4 / 1382 / 2026</td><td>No.Revisi
04</td><td>Halaman :
2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">10. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien.
11. Dokumentasikan hasil pemantauan.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Bedah Sentral</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN ENDOTRACHEAL TUBE (ETT)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1383 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasukkan pipa jalan napas buatan ke dalam trakea melalui mulut
TUJUAN	Ventilasi spontan meningkat penyapihan ventilator meningkat, bersihan jalan napas neningkat pertukaran gas meningkat,, sirkulasi spontan meningkat, kapasitas adaptif intrakranial meningkat, pola napas membaik tingkat aspirasi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Scope (Jaringoskop dan stetoskop) b. Tube (ETT sesuai ukuran) c. Airway (pipa orofaring atau nasofaring) d. Tape (plester dan gunting untuk fiksasi) e. Introducer (mandrin atau stylet)

f. Connector (selang penyambung)
g. Suction
h. Sarung tangan steril
i. Masker N95
j. Jeli
k. Spuit 20 cc
l. Bag-valve-mask (BVM)

7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah.
8. Pasang sarung tangan dan masker.
9. Periksa integritas balon ETT.
10. Pasang mandrin pada bagian dalam ETT.
11. Lumasi ETT dengan jeli.
12. Posisikan pasien telentang dengan leher ekstensi.
13. Lakukan pendampingan pasien selama pemasangan dilakukan operator:
    a. Buka mulut pasien dengan teknik cross finger (ibu jari dan telunjuk)
    b. Masukkan blade laringoskop dengan tangan kiri sampai epiglottis terlihat jelas
    c. Masukkan ETT melewati epiglotis dengan tangan kanan
    d. Kembangkan balon ETT
    e. Angkat blade laringoskop dari mulut pasien
    f. Pegang ETT dengan satu tangan dan lepas mandrin dengan tangan lainnya
14. Lakukan suction, jika perlu.
15. Sambungkan ETT dengan BVM.
16. Periksa ketepatan posisi ETT dengan auskultasi bunyi paru.
17. Fiksasi ETT dengan plester.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN** **ENDOTRACHEAL TUBE (ETT)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1383 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 3/3
	18. Sambungkan ETT dengan connector sumber oksigen. 19. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 20. Lepaskan sarung tangan dan masker. 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN LARYNGEAL MASKAIRWAY (LMA)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1384 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasukkan pipa jalan napas buatan ke dalam laring melalui mulut
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk ventilasi spontan meningkat, bersihan jalan japas meningkat, pertukaran gas meningkat, penyapihan ventilator meningkat, sirkulasi spontan meningkat, kapasitas adaptif intrakranial Meningkat, pola napas pembaik, tingkat aspirasi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Laringeal Mask Airway sesuai ukuran b. Stetoskop c. Plester dan gunting d. Connector (selang penyambung)

	e. Suction f. Sarung tangan g. Masker h. Jell i. Spuit 20 cc Bag-valve-mask (BVM) 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 8. Pasang sarung tangan dan masker. 9. Periksa integritas balon LMA. 10. Lumasi bagian posterior LMA dengan jeli. 11. Posisikan pasien telentang dengan kepala ekstensi. 12. Buka mulut pasien dengan teknik cross finger (ibu jari dan telunjuk) . 13. Lakukan suction, jika perlu. 14. Masukkan LMA ke dalam faring dan teruskan hingga terasa ada tahanan. 15. Kembangkan balon LMA. 16. Sambungkan LMA dengan BVM. 17. Periksa ketepatan posisi LMA dengan auskultasi bunyi paru. 18. Fiksasi LMA dengan plester. 19. Sambungkan LMA dengan connector sumber oksigen. 20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan . 21. Lepaskan sarung tangan dan masker. 22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 23. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN NASOPHARINGEAL AIRWAY (NPA)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1385 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasukkan pipa jalan napas buatan ke dalam faring melalui hidung
TUJUAN	Sebagai acuan langka-langkah untuk bersihan jalan napas meningkat, ventilasi spontan meningkat, pertukaran gas meningkat, penyapihan ventilator meningkat sirkulasi spontan meningkat, pola napas membaik, tingkat aspirasi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. NPA sesuai ukuran b. Sarung tangan bersih b. Jeli 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 8. Pasang sarung tangan bersih.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN** **NASOPHARINGEAL AIRWAY (NPA)**		
	No.Dokumen 400.7.4/1385/2026	No.Revisi 04	Halaman : 2/2
	9. Posisikan pasien telentang dengan leher ekstensi. 10. Bersihkan lubang hidung, jika perlu. 11. Pilih ukuran NPA yang tepat (panjang NPA sama dengan jarak antara lubang hidung ke ujung daun telinga). 12. Lumasi ujung NPA dengan jeli. 13. Masukkan NPA ke dalam lubang hidung dengan bevel menghadap ke septum secara perlahan hingga faring posterior. 14. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 15. Lepaskan sarung tangan. 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN NASOPHARINGEAL AIRWAY (NPA)**		
	No.Dokumen 400.7.4/1385/2026	No.Revisi 03	Halaman : 2/2
	9. Posisikan pasien telentang dengan leher ekstensi. 10. Bersihkan lubang hidung, jika perlu. 11. Pilih ukuran NPA yang tepat (panjang NPA sama dengan jarak antara lubang hidung ke ujung daun telinga). 12. Lumasi ujung NPA dengan jeli. 13. Masukkan NPA ke dalam lubang hidung dengan bevel menghadap ke septum secara perlahan hingga faring posterior. 14. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 15. Lepaskan sarung tangan. 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN OROPHARINGEALAIRWAY (OPA)**		
	No.Dokumen 900.7.9 / 1386 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasukkan pipa jalan napas buatan ke dalam faring melalui mulut.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk bersihan jalan napas meningkat, ventilasi spontan meningkat, pertukaran gas meningkat, pola napas membaik, penyapihan ventilator meningkat, tingkat aspirasi menurun, sirkulasi spontan meningkat, kapasitas adaptif intrakranial meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. OPA sesuai ukuran b. Sarung tangan bersih c. Spatel lidah 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN OROPHARINGEALAIRWAY (OPA)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1386 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	8. Pasang sarung tangan bersih 9. Posisikan pasien telentang dengan leher ekstensi 10. Bersihkan rongga mulut, jika perlu. 11. Pilih ukuran OPA yang tepat (panjang OPA sama dengan jarak antara ujung mulut ke ujung daun telinga). 12. Buka mulut pasien dengan teknik cross finger (ibu jari dan telunjuk) . 13. Metode 1: Masukkan OPA terbalik (sisi lengkung menhadap ke atas) sampal menyentuh palatum mole, lalu putar 180°. Metode 2: Tekan lidah dengan spatel lidah dan masukkan OPA ke daerah faring posterior 14. Lepaskan sarung tangan. 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 16. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBEBASAN JALAN NAPAS DENGAN HEAD-TILT DAN CHIN-LIFT**		
	No.Dokumen 400.7.9/1389/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Membebaskan jalan napas untuk menjamin kepatenan pertukaran udara dengan mendongakkan kepala dan mengangkat dagu.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk bersihan jalan napas meningkat, ventilasi spontan meningkat, pertukaran gas meningkat, penyapihan ventilator meningkat , sirkulasi spontan meningkat, pola napas membaik, tingkat aspirasi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 7. Pasang sarung tangan bersih. 8. Atur posisi perawat di samping kepala pasien. 9. Letakkan telapak tangan di dahi. 10. Tekan dahi ke bawah hingga posisi kepala tengadah.

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMBEBASAN JALAN NAPAS DENGAN HEAD-TILT DAN CHIN-LIFT</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen
400.7.4/1387/2026</td><td>No.Revisi
05</td><td>Halaman :
2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">11. Pegang tulang dagu dengan ibu jari dan jari telunjuk.
12. Angkat dan dorong tulang dagu ke depan.
13. Lepaskan sarung tangan.
14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah.
15. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Bedah Sentral</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBEBASAN JALAN NAPAS DENGAN JAW THRUST**		
	No.Dokumen 400.7.4/1388/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Membebaskan jalan napas untuk menjamin kepatenan pertukaran udara mendorong rahang ke arah depan.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk ventilasi spontan meningkat, bersihan jalan napas meningkat, pertukaran gas meningkat, penyapihan ventilator meningkat, pola napas membaik, sirkulasi spontan meningkat kapasitas adaptif intrakranial meningkat, tingkat aspirasi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 7. Pasang sarung tangan bersih. 8. Atur posisi perawat di bagian atas kepala pasien. 9. Letakkan kedua tangan di samping kanan dan kiri rahang pasien. 10. Dorong rahang ke arah depan sehingga barisan gigi

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMBEBASAN JALAN NAPAS DENGAN JAW THRUST</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4 / 1388 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">bawah berada di depan barisan gigi atas
11. Hindari adanya ekstensi pada leher.
12. Lepaskan sarung tangan.
13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah.
14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Bedah Sentral</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INHALASI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1389 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan dan memberikan agen farmakologis berupa spray (semprotan) across uap atau bubuk halus untuk mendapatkan efek lokal atau sistemik
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk ersihan jalan napas meningkat, tingkat aspirasi menurun, pertukaran gas meningkat, pola napas membaik, ventilasi spontan meningkat, penyapihan ventilator meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Mesin nebulizer b. Masker dan selang nebulizer sesuai ukuran c. Obat inhalasi sesuai program d. Cairan NaCl sebagai pengencer, jika perlu e. Sumber oksigen, jika tidak menggunakan mesin nebulizer f. Sarung tangan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INHALASI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1389/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	g.Tisu 7. Lakukan prinsip 6 benar (pasien, obat, dosis, waktu, rute, dokumentasi). 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 9. Pasang sarung tangan bersih. 10. Posisikan pasien senyaman mungkin dengan posisi semi-Fowler atau Fowler. 11. Masukkan obat ke dalam chamber nebulizer. 12. Hubungkan selang ke mesin nebulizer atau sumber oksigen. 13. Pasang masker menutupi hidung dan mulut. 14. Anjurkan untuk melakukan napas dalam saat. inhalasi dilakukan. 15. Mulai lakukan inhalasi dengan menyalakan mesin nebulizer atau mengalirkan oksigen 6-8 L/menit. 16. Monitor respons pasien hingga obat habis. 17. Bersihkan daerah mulut dan hidung dengan tisu. 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 19. Lepaskan sarung tangan. 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAPLEURA**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1390 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan dan memberikan agen farmakologis melalui kateter agar berdifusi pada rongga pleura
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk bersihan jalan napas meningkat pertukaran gas meningkat, tingkat aspirasi menurun, pola napas membaik, ventilasi spontan meningkat, Penyapihan ventilator meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Obat interpleura sesual program b. Spuit sesuai kebutuhan c. Mesin pompa (seperti syringe pump), jika perlu d. Alcohol swab e. Sarung tangan steril f. Bengkok 7. Lakukan prinsip 6 benar (pasien, obat, dosis, waktu, rute, dokumentasi).

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAPLEURA**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1390 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Gunakan Masker N95 10. Pasang sarung tangan 11. Posisikan pasien senyaman mungkin dengan posisi semi-Fowler atau Fowler 12. Pastikan ketepatan posisi kateter intrapleura dengan X-ray, jika perlu 13. Desinfeksi ujung kateter dengan alcohol swab sebelum pemberian obat 14. Aspirasi cairan intrapleura 15. Periksa tidak adanya darah balik sebelum pemberian obat 16. Tunda pemberian obat jika terdapat >2 cc cairan balik saat pengecekan kateter interpleura. 17. Berikan obat melalui kateter intrapleura secara intermitten atau kontinu, sesuai kebutuhan. 18. Sambungkan kateter intrapleural dengan mesin pompa, jika perlu. 19. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 20. Lepaskan sarung tangan. 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT NASAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1391 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan dan memberikan agen farmakologis berupa tetesan melalui hidung untuk mendapatkan efek lokal atau sistematik.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk bersihan jalan napas meningkat, tingkat infeksi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Jaga privasi pasien. 4. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Obat nasal sesuai program b. Sarung tangan bersih c. Tisu atau kapas lidi (cotton bud) 7. Lakukan prinsip 6 benar (pasien, obat, dosis, waktu, rute, dokumentasi). 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 9. Pasang sarung tangan.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT NASAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1391 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Posisikan pasien berbaring dengan kepala, jika kontraindikasi. 11. Anjurkan bernapas melalui mulut selama pemberian obat. 12. Bersihkan hidung dengan tisu atau kapas lidi. 13. Teteskan obat dengan jarak 1 cm di atas lubang hidung. 14. Anjurkan tetap supine selama 5 menit setelah pemberian obat. 15. Posisikan pasien ke posisi nyaman. 16. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 17. Lepaskan sarung tangan. 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat. 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif. 3. Instalasi Bedah Sentral.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN MASKER REBREATHING DAN NON-REBREATHING**		
	No.Dokumen 400.7.4/1434/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan tambahan oksigen dengan masker rebreathing atau non-rebreathing untuk mengatasi kondisi kekurangan oksigen jaringan
TUJUAN	Bersihan jalan napas meningkat,tingkat syok menurun, pertukaran gas meningkat curah jantung meningkat, perfusi perfier meningkat, perfusi serebral meningkat, perfusi perifer meningkat perfusi miokard meningkat, sirkulasi spontan meningkat, toleransi aktivitas meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sumber oksigen (tabung oksigen atau oksigen sentral) b. Selang masker rebreathing atau non-rebreathing c. Flowmeter oksigen Humidifier d. Cairan steril e. Stetoskop 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Tuangkan cairan steril ke humidifier sesuai batas 10. Pasang flowmeter dan humidifier ke sumber oksigen

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN MASKER REBREATHING DAN NON-REBREATHING**		
	No.Dokumen 400.7.9/1434/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Sambungkan selang masker rebreathing atau nonrebreathing ke humidifier 12. Atur aliran oksigen 8-12 L/menit (untuk masker rebreathing) atau 10-15 L/ment (untuk masker nonrebreathing) 13. Pastikan oksigen mengalir melalui selang 14. Pastikan oksigen mengisi kantung reservoir hingga mengembang 15. Pasang masker menutupi hidung dan mulut 16. Lingkarkan dan eratkan tali karet melingkari kepala 17. Bersihkan kulit area mulut dan hitung serta masker setiap 2-3 jam jika pemberian oksigen dilakukan secara kontinu 18. Monitor cuping, septum, dan hidung luar terhadap adanya gangguan integritas mukosa/kulit hidung setiap 8 jam 19. Monitor kecepatan oksigen dan status pernapasan (frekuensi napas, upaya napas, bunyi paru, saturasi oksigen) setiap 8 jam atau sesuai indikasi 20. Pasang tanda "Oksigen sedang Digunakan di dinding di belakang tempat tidur dan di pintu masuk kamar, jika perlu 21. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 23. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien: a. Motode pemberian oksigen b. Kecepatan oksigen c. Respons pasien d. Efek samping/merugikan yang terjadi		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN MASKER WAJAH (SIMPLE MASK ATAU FACE MASK)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1435 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan tambahan oksigen dengan masker wajah atau sungkup sederhana (simple mask) untuk mengatasi kondisi kekurangan oksigen jaringan
TUJUAN	Bersihan jalan napas meningkat,tingkat syok menurun, pertukaran gas meningkat, perfusi perfier meningkat, curah jantung meningkat perfusi perifer meningkat,perfusi serebral meningkat, perfusi miokard meningkat, sirkulasi spontan meningkat toleransi aktivitas meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sumber oksigen (tabung oksigen atau oksigen sentral b. Selang masker wajah (simple mask) c. Flowmeter oksigen d. Humidifier e. Cairan steril f. Stetoskop 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Tuangkan cairan steril ke humidifier sesuai batas

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN MASKER WAJAH (SIMPLE MASK ATAU FACE MASK)**		
	No.Dokumen 400.7.4/1435/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Pasang flowmeter dan humidifier ke sumber oksigen 11. Sambungkan selang masker wajah ke humidifier 12. Atur aliran oksigen 5-10 L/menit sesuai kebutuhan 13. Pastikan oksigen mengalir melalui selang sungkup sederhana 14. Pasang masker wajah menutupi hidung dan mulut 15. Lingkarkan dan eratkan tali karet melingkari kepala 16. Bersihkan kulit dan masker setiap 2-3 jam jika pemberian oksigen dilakukan secara kontinu 17. Monitor cuping, septum, dan hidung luar terhadap adanya gangguan integritas mukosa/kulit hidung setiap 8 jam 18. Monitor kecepatan oksigen dan status pernapasan (frekuensi napas, upaya napas, bunyi paru, saturasi oksigen) setiap 8 jam atau sesuai indikasi 19. Pasang tanda "Oksigen sedang Digunakan di dinding di belakang tempat tidur dan di pintu masuk kamar, jika perlu 20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien: a. Motode pemberian oksigen b. Kecepatan oksigen b. Respons pasien Efek samping/merugikan yang terjadi		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN NASAL KANUL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1436 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan tambahan oksigen dengan selang nasal untuk mencegah dan/atau mengatasi kondisi kekurangan oksigen jaringan
TUJUAN	Bersihan jalan napas meningkat, tingkat syok menurun, pertukaran gas meningkat, perfusi perfier meningkat, perfusi serebral meningkat, curah jantung meningkat perfusi perifer meningkat, sirkulasi spontan meningkat, perfusi mickard meningkat, toleransi aktivitas meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sumber oksigen (tabung oksigen atau oksigen sentral) b. Selang nasal kanul c. Flowmeter oksigen d. Humidifier e. Cairan steril f. Stetoskop 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Tuangkan cairan steril ke humidifier sesuai batas 10. Pasang flowmeter dan humidifier ke sumber oksigen

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN NASAL KANUL**		
	No.Dokumen 900.7.4 / 1436 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Sambungkan selang nasal kanul ke humidifier 12. Atur aliran oksigen 2-4 L/menit, sesuai kebutuhan 13. .Pastikan oksigen mengalir melalui selang nasal kanul 14. Tempatkan cabang kanul pada lubang hidung 15. Lingkarkan selang mengitari belakang telinga dan atur pengikatnya 16. Monitor cuping, septum, dan hidung luar terhadap adanya gangguan integritas mukosa/kulit hidung setiap 8 jam 17. Monitor kecepatan oksigen dan status pernapasan (frekuensi napas, upaya nafas, bunyi paru, saturasi oksigen) setiap 8 jam atau sesuai indikasi 18. Pasang tanda "Oksigen sedang Digunakan" di dinding di belakang tempat tidur dan di pintu masuk kamar, jika perlu 19. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien: a. Motode pemberian oksigen b. Kecepatan oksigen c. Respons pasien d. Efek samping/merugikan yang terjadi		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGAMBILAN SAMPEL DARAH ARTERI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1437/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengambil sampel darah arten untuk mendapatkan nilai tekanan pariat oksigen dan karbondioksida, asam-basa darah, serta saturasi oksigen.
TUJUAN	Status cairan membaik, integritas kulit dan jaringan meningkat perfusi miokard meningkat, curah jantung meningkat perfusi perifer meningkat, sirkulasi spontan meningkat, keseimbangan cairan meningkat keseimbangan elektrolit meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Spuit AGD atau spuit 3 cc c. Heparin, jika tidak menggunakan spuit AGD d. Karet e. Alcohol swab f. Plester g. Bantalan h. Pengalas Bengkok 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan bersih

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGAMBILAN SAMPEL DARAH ARTERI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1437 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Lakukan Allen test sebelum menusuk nadi radialis 11. .Bilas spuit dengan heparin, jika tidak menggunakan spuit AGD 12. Tentukan area penusukan dengan merasakan denyut nadi 13. Pasang alas di bawah area penusukan 14. Pasang bantalan di bawah area pergelangan tangan, jika perlu 15. Bersihkan area penusukan dengan alcohol swab 16. Stabilisasi arteri dengan meregangkan kulit 17. Tusukkan jarum dengan sudut 45-90° dengan bevel menghadap ke atas 18. Aspirasi sampel darah 1-3 cc 19. Cabut jarum dari arteri secara perlahan 20. Tusukkan jarum spuit pada karet 21. Berikan penekanan pada area penusukan selama 5-15 menit 22. Pasang plester pada area penusukan jika darahtelah berhenti 23. .Berikan label pada sampel darah dan kirim segera ke laboratorium 24. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 25. Lepaskan sarung tangan 26. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 27. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT -	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGAMBILAN SAMPEL DARAH KAPILER**		
	No.Dokumen 400.7.4/1438/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengambil sampel darah melalui pembuluh darah kapiler untuk pemeriksaan laboratorium
TUJUAN	Pertukaran gas meningkat, keseimbangan elektrolit meningkat, kestabilan kadar glukosa darah meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Alcohol swab c. Kasa kering steril d. Lancet e. Pipa kapiler atau microcontainer f. Plester g. Bengkok h. Safety box 8. Tentukan area penusukan yang akan dipilih: a. Bayi berusia <6 bulan : area tumit b. Bayi berusia >6 bulan dan anak: area tengah bantalan jari tengah atau jari manis c. Dewasa: area ujung jari tangan 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGAMBILAN SAMPEL DARAH KAPILER**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1438 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Pasang sarung tangan bersih dan biarkan mengering 11. Bersihkan area penusukan dengan alcohol swab 12. Fiksasi tumit atau jari 13. Lakukan penusukan menggunakan lancet steril 14. Tampung tetesan darah ke dalam microcontainer atau pipa kapiler 15. Tekan area penusukan dengan kasa kering steril selama kurang lebih 3 menit kemudian tempelkan plester 16. Berikan label pada pipa kapiler atau microcontainer 17. Buang jarum pada safety box 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 19. Lepaskan sarung tangan 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGAMBILAN SAMPEL DARAH VENA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1439 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengambil sampel darah melalui intravena untuk pemeriksaan laboratorium
TUJUAN	Status cairan membaik, curah jantung meningkat, integritas kulit dan jaringan meningkat, perfusi perifer meningkat sirkulasi spontan meningkat, perfusi miokard meningkat keseimbangan cairan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Spuit atau vacutainer sesuai ukuran c. Alcohol swab d. Tabung sampel darah, sesuai kebutuhan e. Torniket f. Plester g. Pengalas h. Bengkok i. Safety box 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Pasang sarung tangan bersih 12. Pilih vena yang akan dilakukan penusukan 13. Pasang pengalas di bawah area vena yang dipilih 14. Lakukan pembendungan dengan memasang torniket

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGAMBILAN SAMPEL DARAH VENA**		
	No.Dokumen 400.7.4/1439/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	5-10 cm di atas area penusukan 15. Anjurkan membuka dan mengepalkan tangan 16. Bersihkan area penusukan dengan alcohol swab 17. Lakukan penusukan dengan sudut 20-30° dengan bevel menghadap ke atas 18. Aspirasi sampel darah sesuai kebutuhan (jika menggunakan spuit) atau pegang adapter lalu tekan tabung vakum dan biarkan darah masuk sampai sesuai kebutuhan (jika menggunakan vacutainer) 19. Lepaskan torniket 20. Keluarkan jarum dari vena secara perlahan 21. Lakukan penekanan pada area penusukan 22. Berikan balutan dengan kasa steril, jika perlu 23. Pasang plester pada area penusukan jika darah telah berhenti 24. Pindahkan darah dari spuit ke dalam tabung vakum (jika menggunakan spuit) 25. Berikan label pada tabung sampel darah dan kirim segera ke laboratorium 26. Buang jarum pada safety box 27. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 28. Lepaskan sarung tangan 29. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 30. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN POSISI FOWLER**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1440 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan posisi duduk untuk meningkatkan kesehatan fisiologis dan/atau psikologis
TUJUAN	Bersihan jalan napas meningkat, pertukaran gas meningkat, pola napas membaik, tingkat aspirasi menurun, status cairan membaik, status menelan meningkat, mobilitas fisik meningkat, rasa nyaman meningkat, pemulihan pascabedah meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih,jika perlu b. Bantal 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan bersih 10. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 11. Monitor frekuensi nadi dan tekanan darah sebelum memulai pengaturan posisi 12. Elevasikan bagian kepala tempat tidur dengan sudut 60-90° 13. Letakkan bantal di bawah kepala dan leher 14. Pastikan pasien dalam posisi nyaman

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN POSISI FOWLER**		
	No.Dokumen 900.7.4 /1440/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	15. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 16. Lepaskan sarung tangan 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN POSISI SEMI-FOWLER**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1441 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan posisi setengah duduk untuk meningkatkan kesehatan fisiologis dan/atau psikologis
TUJUAN	Bersihan jalan napas meningkat, status menelan meningkat, pertukaran gas meningkat pola napas membaik, mobilitas fisik meningkat,ventilasi spontan meningkat penyapihan ventilator meningkat, kapasitas adaptif intrakranial meningkat rasa nyaman meningkat, tingkat aspirasi menurun status cairan membaik, pemulihan pascabedah meningkat toleransi aktivitas meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih, jika perlu b. Bantal 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Pasang sarung tangan bersih 12. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 13. Monitor frekuensi nadi dan tekanan darah sebelum memulai pengaturan posisi 14. Elevasikan bagian kepala tempat tidur dengan sudut 30-45 15. Letakkan bantal di bawah kepala dan leher

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN POSISI SEMI-FOWLER**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1441 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	16. Pastikan pasien dalam posisi nyaman 17. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 18. Lepaskan sarung tangan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dikerjakan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN VENTILASI MEKANIK**		
	No.Dokumen 400.7.4/1442/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengelola pemberian sokongan napas buatan, baik melalui alat bantu napas no invasif maupun invasif
TUJUAN	Bersihan jalan napas meningkat, ventilasi spontan meningkat, penyapihan ventilator meningkat, pertukaran gas meningkat, pola napas membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 8. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Mesin ventilator b. Bag Valve Mask c. Set sirkuit ventilator 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Hubungkan mesin ventilator dengan sumber oksigen 11. Rangkai set sirkuit pada ventilator 12. Hidupkan mesin ventilator 13. Lakukan kalibrasi ventilator dan tes kebocoran 14. Atur mode ventilator, sesuai kebutuhan 15. Hubungkan alat bantu napas (ETT, LMA, masker CPAP) dengan sirkuit ventilator 16. Siapkan BVM di samping tempat tidur untuk

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN VENTILASI MEKANIK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1492 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	antisipasi malfungsi mesin 17. Monitor respons pasien terhadap ventilasi mekanik 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan mode ventilator yang diberikan dan respons pasien terhadap ventilasi mekanik		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGELUARAN SUMBATAN BENDA PADAT DENGAN MAGILL FORCEP**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1443 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Membebaskan jalan napas dari obstruksi benda asing dengan menggunakan perangkat yang dimasukan ke dalam rongga mulut atau jalan napas
TUJUAN	Bersihan jalan napas meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Magill forcep c. Bengkok d. Kasa 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan bersih 10. Posisikan telentang agar sumbatan bisa terlihat dengan jaw thrust atau head tilt - chin lift 11. Bebaskan jalan napas dengan teknik jaw thrust 12. Buka mulut dengan teknik cross finger 13. Ambil sumbatan dengan menggunakan Magill forcep 14. Buang sumbatan pada bengkok atau tempat kotor 15. Bersihkan mulut dari cairan akibat prosedur dengan kasa

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PENGELUARAN SUMBATAN BENDA PADAT DENGAN MAGILL FORCEP</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.9/1443/
2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">16. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
17. Lepaskan sarung tangan
18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Bedah Sentral</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGHISAPAN JALAN NAPAS**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1444 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Membersihkan sekret dengan memasukkan kateter suction bertekanan negatif Ke dalam mulut, nasofaring, trakea dan/atau endotracheal tube (ETT)
TUJUAN	Bersihan jalan napas meningkat, tingkat aspirasi menurun, ventilasi spontan meningkat penyapihan ventilator meningkat, status menelan meningkat, sirkulasi spontan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 8. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 9. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan steril (untuk naso-faring, trakea dan ETT) atau sarung tangan bersih (untuk mulut) b. Masker dan google, jika perlu c. Selang suction, sesuai ukuran d. Selang penyambung e. Mesin suction f. Kom steril berisi cairan steril g. Tisu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGHISAPAN JALAN NAPAS**		
	No.Dokumen 400.7.4/1444/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	h. Pengalas i. Sumber oksigen j. Stetoskop k. Oksimetri nadi 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Posisikan semi-Fowler 12. Auskultasi suara napas 13. Pasang oksimetri nadi 14. Letakkan pengalas di bawah dagu atau dada 15. Hubungkan selang penyambung ke mesin suction 16. Hubungkan selang penyambung dengan ujung selang suction 17. Nyalakan mesin suction dan atur tekanan negatif, sesuai kebutuhan (dewasa 120-150 mmHg, anak 100-120 mmHg, bayi 60-100 mmHg) 18. Berikan oksigenasi 100% minimal 30 detik dengan selang oksigen 19. Pasang sarung tangan steril 20. Lakukan penghisapan tidak lebih dari 15 detik 21. Lakukan penghisapan pada ETT terlebih dahulu lalu hidung dan mulut, jika pasien terpasang ETT 22. Bilas selang suction dengan cairan steril 23. Berikan kesempatan bernapas 3-5 kali sebelum penghisapan berikutnya 24. Monitor saturasi oksigen selama penghisapan 25. Lepas dan buang selang suction 26. Matikan mesin suction 27. Auskultasi kembali suara napas 28. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 29. Lepaskan sarung tangan 30. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 31. Dokumentasikan warna, jumlah, konsistensi sputum, kemampuan batuk saturasi oksigen, dan suara napas, serta respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGUBAHAN POSISI ENDOTRACHEAL TUBE (ETT)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1495 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memindahkan posisi ETT secara rutin untuk mencegah terjadinya risiko luka tekan pada bibir, mulut dan jalan napas
TUJUAN	Integritas kulit dan jaringan meningkat, tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Spuit 20 cc c. Plester d. Stetoskop 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan bersih 10. Lepaskan plester ETT 11. Periksa batas insersi ETT sebelumnya 12. Kempiskan balon ETT 13. Pindahkan posisi ETT dari sisi pinggir bibir sebelumnya ke sisi bibir yang berseberangan 14. Periksa ulang batas insersi ETT 15. Kembangkan balon ETT

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PENGUBAHAN POSISI ENDOTRACHEAL TUBE (ETT)</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4 / 1495 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">16. Plester ETT
17. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
18. Lepaskan sarung tangan
19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
20. Dokumentasikan tanggal dan waktu, posisi ETT, pengisian balon, ukuran ETT dan batas insersi ETT, serta respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Bedah Sentral</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN SELANG DADA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1496 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola pasien yang terpasang selang dada dan sistem water seal drainage (WSD)
TUJUAN	Pertukaran gas meningkat, tingkat infeksi menurun, pola napas membaik, pemulihan pascabedah meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan steril b. Set WSD c. Klem 2 buah d. Cairan steril e. Alcohol swab f. Plester g. Pengaman selang (karet gelang atau peniti) h. Set perawatan luka 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Identifikasi indikasi penggantian botol WSD: a. Botol telah terisi 3/4 penuh, atau b. Botol telah terpasang 3 hari 12. Posisikan pasien semi-Fowler (pada pneumotoraks) atau Fowler (pada hemotoraks)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN SELANG DADA**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1496 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Pasang sarung tangan 14. Buka set WSD baru dengan tetap mempertahankan kesterilan 15. Isi botol WSD dengan cairan steril hingga ujung selang terendam 2 cm 16. Klem selang dada dan selang WSD 17. Lepaskan sambungan selang dada dan selang WSD 18. Desinfeksi ujung selang dada dengan alcohol swab 19. Sambungkan selang dada dengan selang WSD baru 20. Plester sambungan selang 21. Buka klem selang dada 22. Amati adanya undulasi pada selang 23. Gulung kelebihan selang pada tempat tidur dan amankan dengan karet gelang atau peniti 24. Gantung WSD di samping tempat tidur dengan posisi selalu lebih rendah dari insersi selang dada 25. Lakukan perawatan luka pada area insersi selang dada dengan teknik steril 26. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 27. Lepaskan sarung tangan 28. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 29. Dokumentasikan tanggal dan waktu, jumlah dan tipe drainase dalam botol WSD lama, dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN TRAKEOSTOMI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1497 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat bersihan dan kepatenan jalan napas serta komplikasi akibat pemasangan trakeostomi
TUJUAN	Bersihan jalan napas meningkat, tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Sarung tangan steril c. Masker dan goggle atau masker visor d. Handuk atau tisu e. Kasa steril dan kapas lidi steril f. Set ganti balutan steril g. Kom steril dan cairan steril h. Kasa gulung atau tali trakeostomi i. Gunting 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Posisikan pasien semi-Fowler 10. Pasang tisu atau handuk 11. Pasang masker dan sarung tangan bersih 12. Lepaskan balutan kotor

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN TRAKEOSTOMI**		
	No.Dokumen A00.7.4/1497/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Lepaskan sarung tangan 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Buka set ganti balutan steril 16. Isi kom steril dengan cairan steril 17. Pakai sarung tangan steril dan pertahankan tangan yang dominan tetap steril selama prosedur 18. Lepaskan oksigen dengan tangan non-dominan, jika terpasang oksigen 19. Lepaskan inner kanul trakeostomi dengan tangan non-dominan 20. Bersihkan inner kanul menggunakan tangan dominan dengan sikat steril dan bilas dengan cairan steril 21. Pasang kembali inner kanul 22. Bersihkan stoma dan kulit sekitar dengan kasa lembab steril atau kapas lidi steril 23. Keringkan kulit sekitar stoma dengan kasa steril 24. Lepaskan ikatan trakeostomi yang kotor 25. Pasang balutan steril dan ikatan pada trakeostomi 26. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 27. Lepaskan sarung tangan 28. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 29. Dokumentasikan tanda-tanda infeksi sekitar stoma, perdarahan, dan karakteristik sputum, serta respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**SKRINING TB**		
	No. Dokumen 400.7.8.1/1274/2026	No. Revisi 2	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 23 Februari 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO Pembina Tk. I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Skrining Tuberkulosis (TB) adalah proses pemeriksaan awal yang dilakukan untuk menemukan orang yang berisiko atau bergejala TB sedini mungkin, bahkan sebelum penyakitnya menjadi parah atau menular luas ke orang lain..
TUJUAN	Secara umum, tujuan utama dari skrining TB (Tuberkulosis) adalah untuk menemukan kasus TB sedini mungkin dan memutus rantai penularan di Rumah Sakit.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Lakukan skrining pasien di pintu masuk rawat jalan dan rawat inap 2. Berikan pertanyaan sebagai berikut :

RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

SKRINING TB

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
900.7.8.1 / 1279 / 2026	2	2/2

NO	PERTANYAAN SKRINING BATUK (beri tanda √ pada jawaban disamping)	YA	TIDAK
1.	Apakah anda batuk selama ≥ 2 minggu ?		
2.	Apakah anda sedang batuk ? (*semua batuk tanpa melihat durasi*)		
3.	Apakah anda mengalami demam hilang timbul tanpa penyebab jelas		
4.	Apakah anda berkeringat malam hari tanpa kegiatan		
5.	Apakah berat badan turun tanpa penyebab yang jelas : nafsu makan turun BB tidak naik *(pada anak)*		
6.	Apakah anda sesak napas tanpa nyeri dada ?		
7.	Apakah ada pembesaran di leher atau di ketiak (kelenjar getah bening ≥ 2 cm) *dengan palpasi*		
8.	Apakah ada yang sakit TB sedang minum obat TB dalam satu rumah? bila YA, sebutkan : nama (yang sakit TB) : alamat (yang sakit TB) :	I	
9.	Faktor Risiko		
	a. DM		
	b. HIV		
	Kesimpulan		
	TERDUGA TBC AKTIF, jika : a. *Ya pada nomor 1* b. *Ya pada nomor 2 dan Ya pada* ***salah satu gejala*** *nomor 3 / 4 / 5 / 6 / 7* c. *Ya* ***hanya pada*** *nomor 7*		
	TERDUGA TBC LATEN, jika : *Ya pada nomor 8 dan TIDAK pada nomor 1 s/d 7*		

3. Jika hasil skrining masuk kriteria berikan pasien masker bedah
4. Untuk pasien rawat jalan :
    a. Jika sudah membawa hasil TCM TB Positif Arahkan pasien ke klinik TB Central
    b. Jika pasien belum terdiagnosis arahkan ke Klinik paru/Klinik lain dengan pelayanan fastrack
5. Untuk pasien IGD/Rawat Inap :
    a. Jika sudah membawa hasil TCM TB Positif tempatkan di Ruang Isolasi IGD dan lakukan prosedur penanganan TBC
    b. Jika pasien belum terdiagnosis lakukan dengan pelayanan fastrack

UNIT TERKAIT	1. Pendaftaran Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat jalan 3. Instalasi Gawat Darurat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN CAPILLARY REFILL TIME (CRT)**		
	No.Dokumen 400.7.9/1998/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memantau sirkulasi jaringan perifer melalui penilaian durasi pengisian kapiler setelah dilakukan penekanan sesaat pada area perifer
TUJUAN	Perfusi perifer meningkat, curah jantung meningkat, status cairan membaik,tingkat syok menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Tentukan area ujung kuku yang akan dilakukan pemantauan 9. Tekan selama 1-2 detik area yang telah ditentukan sebelumnya 10. Lepaskan bagian yang kuku ditekan 11. Hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan warna kuku kembali seperti semula 12. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 13. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan hasil pemantauan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN CAPILLARY REFILL TIME (CRT)**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1498 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN CENTRAL VENOUS PRESSURE (CVP)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1449 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memantau tekanan di atrium kanan yang ditentukan oleh fungsi atrium kanan dan tekanan darah vena di vena cava
TUJUAN	Perfusi perifer meningkat curah jantung meningkat, status cairan membaik, tingkat syok menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Manometer b. Water pass atau penggaris c. Cairan NaCl 0,9% d. Three-way e. Set Infus 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pastikan kepatenan selang CVC (central venous catheter) 10. Posisikan pasien dalam keadaan supine atau dalam posisi semi recumbent 11. Tentukan titik nol (zero point) dengan mensejajarkan manometer dengan aksis plebostatik. 12. Pastikan ketepatan titik nol dengan menggunakan

	water pass atau penggaris yang terdapat pada manometer 13. Berikan tanda pada aksis plebostatik 14. Tutup three-way ke arah pasien dan buka ke arah manometer 15. Buka klem cairan infus pasien dan alirkan perlahan untuk mengisi manometer ke level yang lebih tinggi dari nilai normal atau sampai batas 20 cmH2O 16. Tutup aliran infus dari pasien dan buka three-way dari manometer ke arah pasien 17. Perhatikan penurunan cairan dalam manometer dan tunggu hingga penurunan cairan berhenti 18. Lakukan pembacaan nilai manometer pada angka di manometer di level cairan berhenti 19. Informasikan hasil pengkuran, jika perlu 20. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan hasil pemantauan
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN MEAN ARTERIAL PRESSURE (MAP)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1450 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data tekanan arteri rata-rata selama satu siklus denyutan jantung yang didapatkan dari pengukuran tekanan darah sistol dan diastol
TUJUAN	Curah jantung meningkat perfusi miokard meningkat, status cairan membaik tingkat syok menurun, perfusi perifer meningkat sirkulasi spontan meningkat, kapasitas adaptif intrakranial meningkat perfusi serebral meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan, jika perlu b. Spigmomanometer c. Stetoskop 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Lakukan pengukuran tekanan darah 12. Hitung MAP dengan rumus (TDS+ 2TDD) / 3 atau TDD + 1/3 (TDS-TDD) 13. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 14. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 15. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN MEAN ARTERIAL PRESSURE (MAP)**		
	No.Dokumen 400.7.4/1450/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	pasien 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan hasil pemantauan posisi semi recumbent		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA PERDARAHAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/2149/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data terkait tanda dan gejala yang menunjukkan kehilangan darah
TUJUAN	Status cairan membaik, perfusi gastrointestinal meningkat, tingkat perdarahan menurun, perfusi serebral meningkat, pemulihan pasca bedah meningkat, tingkat syok menurun, curah jantung meningkat perfusi perifer meningkat, tingkat cedera menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Monitor tanda dan gejala: a. Peningkatan frekuensi nadi b. Pulsasi nadi lemah c. Akral dingin d. Tekanan darah rendah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA PERDARAHAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2149 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	e. Frekuensi napas meningkat f. Perubahan status mental atau penurunan kesadaran g. Feses bercampur darah h. Urine berwarna merah i. Tampak keluar darah 8. Monitor hasil laboratorium seperti Prothrombin Time (PT), Partial Thromboplastin Time (PTT), fibrinogen, platelet, degradasi fibrin, jika perlu 9. Identifikasi faktor risiko perdarahan (trauma atau non-trauma) 10. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 11. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 12. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan hasil pemantauan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA VITAL**		
	No.Dokumen 400.7.9/1296/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data hasil pengukuran fungsi vital kardiovaskuler pernapasan dan suhu tubuh
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk bersihan jalan napas meningkat, pertukaran gas meningkat, pola nafas membaik, penyapihan ventilator meningkat, curah jantung meningkat, perfusi perifer meningkat, sirkulasi spontan meningkat, status cairan membaik, keseimbangan cairan meningkat, tingkat perdarahan menurun, tingkat syok menurun, perfusi ,gastrointestinal meningkat, perfusi renal meningkat, kapasitas adaptif intrakranial meningkat, termoregulasi membaik toleransi aktivitas meningkat, pemulihan pasca bedah meningkat, status neurologis membaik, organisasi perilaku bayi meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA VITAL**		
	No.Dokumen 400.7.4/1296/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih, jika perlu b. Spigmomanometer dan manset c. Stetoskop d. Oksimetri nadi e. Termometer f. Jam atau pengukur waktu g. Pulpen dan lembar pemantauan tanda vital 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan 10. Periksa tekanan darah dengan spigmomanometer 11. Periksa frekuensi, kekuatan dan irama nadi 12. Periksa frekuensi dan kedalaman napas 13. Periksa suhu tubuh dengan termometer 14. Periksa saturasi oksigen dengan oksimetri nadi 15. Identifikasi penyebab perubahan tanda vital 16. Rapikan pasien dan alat yang digunakan 17. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 18. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi 19. Lepaskan sarung tangan 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan hasil pemantauan a. Feses bercampur darah b. Urine berwarna merah c. Tampak keluar darah		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN AKSES INTRAVENA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1781 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan jalur masuk ke dalam pembuluh darah vena perifer untuk pemberian cairan, obat-obatan, dan produk darah
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk curah jantung meningkat, perfusi miokard meningkat, perfusi perifer meningkat, tingkat syok menurun, integritas kulit dan jaringan, perfusi renal meningkat, sirkulasi spontan meningkat, status cairan membaik, keseimbangan cairan meningkat, eliminasi fekal membaik, perfusi gastrointestinal meningkat ,kapasitas adaptif intrakranial meningkat, tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan:

a. Sarung tangan bersih
b. Torniket
c. Kateter intravena sesua) ukuran (bayi/anak no.24, dewasa no. 20 atau 22, geriatri no. 22 atau 24
d. Alcohol swab
e. Balutan transparan (transparent dressing) atau kasa
f. Plester
g. Set infus atau injection plug
h. Cairan infus, jika perlu
i. Pengalas
j. Bengkok

8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
9. Siapkan cairan infus (jika akan diberikan terapi cairan
   a. Sambungkan set infus dengan wadah cairan
   b. Pastikan rol klem terkunci dan isi setengah bilik (chamber) infus dengan cairan infus
   c. Alirkan cairan infus hingga seluruh selang terisi cairan infus
   d. Pastikan tidak ada gelembung udara di sepanjang selang infus
10. Atur posisi senyaman mungkin
11. Pilih vena yang akan diinsersi:
    a. Vena pada ekstremitas non-dominan, kecuali kontraindikasi (seperti terdapat luka, fistula, untuk dialisis, riwayat mastektomi)
    b. Vena yang lurus, cukup besar, dapat di palpasi, dan jauh dari persendian
12. Letakkan pengalas dibawah lengan pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN AKSES INTRAVENA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1781 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/4

13. Pasang sarung tangan bersih
14. Dilatasikan vena dengan memasang torniket 15-20 cm di atas vena yang akan diinsersi, dan/atau beberapa metode ini:
    a. Posisikan area insersi lebih rendah dari jantung
    b. Kepalkan telapak tangan
    c. Ketuk-ketuk dengan lembut menggunakan ujung jari
    d. Masase dari arah distal ke proksimal dibawah vena yang akan diinsersi
    e. Kompres hangat pada area insersi
15. Bersihkan daerah yang akan diinsersi dengan menggunakan alcohol swab
16. Regangkan kulit di bawah vena yang akan diinsersi dengan menggunakan tangan yang tidak dominan
17. Insersikan kateter pada vena dengan sudut 10-30° dengan tangan dominan.
18. Rendahkan sudut insersi saat terlihat darah pada ruang kateter dan tarik sedikit stilet
19. Dorong kateter hingga mencapai pangkalnya
20. Lepaskan torniket
21. Tekan ujung kateter yang berada di dalam vena dan lepaskan stilet dari kateter
22. Sambungkan kateter intravena dengan set infus atau injection plug
23. Pasang balutan transparan (transparent dressing) pada area insersi
24. Berikan label pada dressing dan tuliskan tanggal dan waktu pemasangan
25. Rapikan pasien dan peralatan yang telah digunakan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN AKSES INTRAVENA**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1781 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 4/4
	26. Lepaskan sarung tangan 27. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 28. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN AKSES VENA SENTRAL**		
	No.Dokumen 400.7.9/2173/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan jalur masuk ke dalam pembuluh darah vena sentral untuk pemberian cairan, obat-obatan, dan produk darah
TUJUAN	Curah jantung meningkat, perfusi miokard meningkat, integritas kulit dan jaringan tingkat syok menurun, perfusi perifer meningkat, perfusi renal meningkat, sirkulasi spontan meningkat, perfusi gastrointestinal meningkat, kapasitas adaptif intrakranial meningkat, status cairan membaik, tingkat infeksi menurun, keseimbangan cairan meningkat eliminasi fekal membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan steril b. Baju tindakan steril c. Duk tindakan steril

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN AKSES VENA SENTRAL**		
	No.Dokumen 400.7.9/2193/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	d. Kateter vena sentral, sesuai ukuran e. Set kateter vena sentral (Central Venous Catheter [CVC]) f. Jarum dan benang jahit steril g. Spuit 3 cc dan 5 cc h. Lidocain injeksi i. Cairan antiseptikj j. Pengalas k. Bengkok 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Atur posisi pasien, sesuai kebutuhan (semi-Fowler atau supine) 10. Siapkan alat dan bahan di samping pasien 11. Pasang baju dan sarung tangan steril 12. Desinfeksi area insersi dengan cairan antiseptik 13. Pasang duk steril 14. Dampingi dan observasi pasien selama pelaksanaan prosedur oleh operator 15. Pastikan akses vena sentral terpasang dan berfungsi dengan baik 16. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 17. Lepaskan baju dan sarung tangan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN MONITOR JANTUNG**		
	No.Dokumen 400.7.9/2179/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasang elektroda untuk mendapatkan sadapan potensial listrik jantung tertentu secara kontinu yang dihasilkan oleh aktivitas jantung
TUJUAN	Curah jantung meningkat, sirkulasi spontan meningkat, keseimbangan elektrolit meningkat toleransi aktivitas meningkat, perfusi miokard meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Mesin monitor jantung b. Kabel monitor jantung c. Elektroda d. Alcohol swab, jika perlu 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Atur posisi pasien senyaman mungkin a. Duk tindakan steril

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN MONITOR JANTUNG**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2174 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2

	b. Kateter vena sentral, sesuai ukuran c. Set kateter vena sentral (Central Venous Catheter [CVC]) d. Jarum dan benang jahit steril e. Spuit 3 cc dan 5 cc f. Lidocain injeksi g. Cairan antiseptikj h. Pengalas i. Bengkok 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Atur posisi pasien, sesuai kebutuhan (semi-Fowler atau supine) 12. Siapkan alat dan bahan di samping pasien 13. Pasang baju dan sarung tangan steril 14. Desinfeksi area insersi dengan cairan antiseptik 15. Pasang duk steril 16. Dampingi dan observasi pasien selama pelaksanaan prosedur oleh operator 17. Pastikan akses vena sentral terpasang dan berfungsi dengan baik 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 19. Lepaskan baju dan sarung tangan 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN STOCKING ELASTIS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2175 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasang stocking lentur yang memiliki efek penekanan pada vena tungkai bawah untuk meningkatkan alir balik vena ke jantung
TUJUAN	Perfusi perifer meningkat, curah jantung meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Stocking, sesuai ukuran b. Meteran, jika perlu 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pertahankan privasi pasien 10. Posisikan pasien dalam posisi supine 11. Cuci dan keringkan kaki pasien, jika perlu 12. Pasangkan stocking dengan tepat atau sesuai petunjuk pabrik

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN STOCKING ELASTIS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2175 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Pastikan stocking bebas dari kerutan dan ujung stocking tidak tergulung 14. Monitor adanya sianosis, penurunan nadi pedis, kesemutan, dan nyeri pada ektremitas bawah 15. Rapikan pasien dan alat yang digunakan 16. Anjurkan untuk melaporkan adanya keluhan seperti kesemutan dan nyeri pada ekstremitas bawah 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN TORNIKET PNEUMATIK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2176 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan penekanan dengan pembebatan pada area tertentu untuk mengontro sirkulasi venia dan arteri untuk meminimalkan perdarahan atau poter der lainnya
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, perfusi perifer meningkat tingkat perdarahan menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan, ang diperlukan, a. Sarung tangan b. Set torniket pneumatik 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan 10. Identifikasi integritas kulit yang akan dipasang torniket 11. Pilih manset sesuai ukuran

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN TORNIKET PNEUMATIK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2176 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Pasang torrniket pada ekstremitas atas atau bawah sesuai indikasi 13. Atur tekanan torniket 50 mmHg lenggi dari TDS (pada ekstremitas atas). atau 100 mmHg lebih tinggi dari TDS (pada ekstremitas bawah), atau sesuai indikasi 14. Berikan penekanan selama 60 menit pada ekstremitas atas, atau 90 menit pada ekstremitas bawah, atau sesuai indikasI 15. Berikan jeda waktu pengempisan manset selama 15 menit 16. Monitor tekanan torniket dan pulsasi nadi perifer 17. Rapikan pasien dan alat yang digunakan 18. Lepaskan sarung tangan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN BALUT TEKAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2177 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Membalut luka dengan tekanan untuk mencegah atau menghentikan perdarahan
TUJUAN	Status cairan membaik, perfusi perifer meningkat, tingkat syok menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Kasa steril c. Plester 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan 10. Tinggikan bagian tubuh yang cedera di atas level jantung, jika tidak ada fraktur 11. Anjurkan membatasi gerak pada area cedera

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN BALUT TEKAN**		
	No.Dokumen 100.7.4 /2177/ 2006	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Tutup luka dengan kasa 13. Tekan kasa dengan kuat di atas luka sampai tidak timbul perdarahan 14. Tekan arteri (pressure point) yang mengarah ke area perdarahan, jika perlu 15. Fiksasi kasa dengan plester setelah perdarahan berhenti 16. Rapikan pasien dan berikan posisi nyaman 17. Lepaskan sarung tangan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN DEFIBRILASI**		
	No.Dokumen 400.7.4/2178/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan terapi kejut listrik dengan menggunakan alat defibrillator untuk mengatasi gangguan kelistrikan jantung yang mengancam jiwa, berupa takikardi ventrikel tanpa nadi (PVT) dan fibrilasi ventrikel (VF)
TUJUAN	Sirkulasi spontan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Jeli b. Mesin defibrillator c. Paddle atau pad defibrillator d. Elektroda e. Tisu 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan bersih

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN DEFIBRILASI**		
	No.Dokumen 400.7.4/2178/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3
	10. Lakukan resusitasi jantung paru (RJP) hingga mesin defibrillator slap 11. Hidupkan mesin defibrilator 12. Tempelkan elektroda dan sambungkan dengan kabel EKG dari mesin defibrilator 13. Pastikan irama EKG henti jantung shockable (VF atau pVT) 14. Angkat paddle dari mesin dan oleskan jeli pada paddle atau pasang pad 15. Atur jumlah energi dengan mode unsynchronized sebesar 200 joule (pada bifasik), atau 360 joule (pada monofasik), atau gunakan energi tertinggi (jika tidak diketahui), atau 2-4 joule/kgBB pada anak 16. Tempelkan paddle atau pad stemum pada sisi kanan sternum di bawah klavikula (ICS 2-3) dan paddle atau pad apeks pada garis midklavikula setinggi elektroda V6 (ICS 4-5) 13. Isi energi dengan menekan tombol charge pada paddle atau pada mesin defibrillator dan tunggu hingga energi yang diinginkan tercapai 17. Teriak bahwa defibrillator telah siap (misal "I'm clear, you're clear, everybody's clear" atau "saya siap, area siap") 18. Hentikan RJP dan pastikan tidak ada yang menyentuh pasien 19. Lepaskan energi dengan menekan tombol discharge 20. Angkat paddle dan langsung lanjutkan RJP tanpa menunggu hasil irama yang muncul pada monitor 21. Lanjutkan RJP selama 2 menit 22. Evaluasi irama dan ulangi pemberian defibrilasi jika masih irama henti jantung shockable 23. Bersihkan area dada dengan tisu		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN DEFIBRILASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2178 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	24. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 25. Lepaskan sarung tangan 26. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 27. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien 28. Anjurkan membatasi gerak pada area cedera		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAMUSKULER**		
	No.Dokumen 400.7.4 /2179 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memberikan agen farmakologis yang diprogramkan melalui jalur intramuskular
TUJUAN	Pertukaran gas meningkat, tingkat nyeri menurun, status neurologis membaik, ventilasi spontan, meningkat penyapihan ventilator meningkat integritas kulit/jaringan meningkat, kontrol diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Spuit, sesuai kebutuhan c. Obat intramuskuler d. Alcohol swab e. Plester f. Safety box

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAMUSKULER**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 2179 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	8. Lakukan prinsip 6 benar (pasien, obat, dosis, waktu, rute, dan dokumentasi) 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Pasang sarung tangan 11. Tarik obat ke dalam spuit dari ampul/vial 12. Pilih area injeksi yang sesuai (seperti vastus lateralis, ventrogluteal, deltoid) 13. Hindari area yang mengalami memar, radang, edema, lesi,atau perubahan warna 14. Desinfeksi area injeksi dengan alcohol swab 15. Gunakan teknik z-track untuk mencegah obat keluar ke jaringan subkutan dan kulit 16. Tusukkan jarum dengan sudut 90° 17. Lakukan aspirasi dan pastikan tidak ada darah 18. Injeksikan obat secara perlahan 19. Cabut jarum 20. Hindari melakukan masase pada area penusukan 21. Tutup area penusukan dengan plester 22. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 23. Lepaskan sarung tangan 24. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 25. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAOSEUS**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 2180 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memberikan agen farmakologis yang diprogramkan melalui jalur korteks tulang
TUJUAN	Curah jantung meningkat, status cairan membaik, perfusi perifer meningkat sirkulasi spontan meningkat, tingkat syok menurun, tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Obat intraoseus sesual order c. Alcohol swab d. Spuit sesuai kebutuhan e. Cairan pelarut, jika perlu 8. Lakukan prinsip 6 benar (pasien, obat, dosis, waktu, rute, dan dokumentasi) 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAOSEUS**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 2180 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Pasang sarung tangan 11. Imobilisasi ekstremitas 12. Aspirasi akses intraoseus sebelum menyuntikan obat untuk memastikan ketepatan posisi ujung jarum sesuai protokol 13. Sambungkan selang dengan jarum dan alirkan dengan gravitasi atau tekanan sesuai kecepatan aliran yang diperlukan 14. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 15. Lepaskan sarung tangan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAVENA**		
	No.Dokumen 400.7.4/2181/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memberkan agen farmakologis yang diprogramkan melalui pembuluh darah vena
TUJUAN	Tingkat nausea menurun tingkat nyeri menurun, tingkat alergi menurun, tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Obat IV sesuai order c. Alcohol swab d. Spuit sesuai kebutuhan e. Cairan pelarut, jika perlu f. Tomiket g. Pengalas h. Bengkok i. Safety box

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAVENA**		
	No.Dokumen 900.7.4 / 2181 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

8. Campurkan obat dengan cairan pelarut, sesuai kebutuhan
9. Lakukan prinsip 6 benar (pasien, obat, dosis, waktu, rute, dan dokumentasi)
10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
11. Pasang sarung tangan bersih
12. Pilih area vena yang akan dilakukan penusukan
13. Pasang pengalas dibawah area vena yang dipilih
14. Lakukan pembendungan dengan memasang torniket 5 - 10 cm di atas area penusukan
15. Anjurkan membuka dan mengepalkan tangan beberapa kali untuk membantu vena berdilatasi
16. Bersihkan area penusukan dengan alcohol swab
17. Lakukan penusukan dengan sudut 20-30" dengan bevel menghadap ke atas
18. Tarik sedikit plunger spuit sampai terlihat darah pada plunger spuit
19. Lepaskan torniket
20. Injeksikan obat intravena
21. Keluarkan jarum dari vena secara perlahan
22. Buang jarum dan spuit ke dalam safety box tanpa recapping (menutup kembali jarum)
23. Lakukan penekanan pada area penusukan
24. Berikan balutan dengan kasa steril, jika perlu
25. Pasang plester pada area penusukan jika darah telah berhenti
26. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
27. Lepaskan sarung tangan
28. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
29. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respon pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAVENA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2181 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAVENA MELALUI SELANG INFUS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2182 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memberkan agen farmakologis yang diprogramkan melalui kateter intravena
TUJUAN	Perfusi serebral meningkat, perfusi renal meningkat, status cairan membaik, curah jantung meningkat perfusi perifer meningkat, perfusi gastrointestinal meningkat tingkat infeksi menurun, perfusi miokard meningkat tingkat syok menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Obat IV sesuai program c. Alcohol swab d. Spuit sesuai kebutuhan e. Cairan pelarut, jika perlu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAVENA MELALUI SELANG INFUS**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 2182 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

f. Safety box

8. Campurkan obat dengan cairan pelarut, sesuai kebutuhan
9. Lakukan prinsip 6 benar (pasien, obat, dosis, waktu, rute, dan dokumentasi)
10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
11. Pasang sarung tangan bersih
12. Pastikan ketepatan dan kepatenan akses IV
13. Lakukan double check, terutama untuk obat high alert
14. Bersihkan akses IV dengan menggunakan alcohol swab
15. Sambungkan spuit dengan injection site selang infus
16. Hentikan aliran infus dengan mengunci roller clamp pada selang infus
17. Tarik sedikit plunger spuit sampai terlihat darah pada selang infus
18. Injeksikan obat dengan kecepatan yang direkomendasikan
19. Monitor respon pasien selama injeksi obat
20. Lepaskan spuit dari injection site selang infus
21. Buang jarum dan spuit ke dalam safety box tanpa recapping (menutup jarum)
22. Atur kecepatan tetesan infus seperti semula atau sesuai kebutuhan
23. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
24. Lepaskan sarung tangan
25. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
26. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT INTRAVENA MELALUI SELANG INFUS**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 2182 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN PRODUK DARAH**		
	No.Dokumen 400.7.4/2183/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memberikan produk darah dengan menggunakan set transfusi
TUJUAN	Status cairan membaik, perfusi perifer meningkat, tingkat syok menurun, tingkat alergi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Produk darah, sesuai kebutuhan b. Sarung tangan bersih c. Set transfusi (blood set) d. Cairan NaCl 0,9% e. Kateter IV f. Spuit 3 cc g. Alcohol swab h. Pengalas i. Bengkok j. Plester

k. Gunting

8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
9. Pasang sarung tangan bersih
10. Lakukan pengecekan ganda (double check) pada label darah (golongan darah, rhesus, tanggal kadaluarsa, nomor seri, jumlah dan identitas pasien)
11. Pasang akses intravena, jika belum terpasang
12. Periksa kepatenan akses intravena, flebitis dan tanda infeksi lokal
13. Berikan NaCl 0,9% 50-100 ml sebelum transfusi dilakukan
14. Sambungkan kantong darah dengan set transfusi
15. Atur kecepatan transfusi 2 mL/menit pada 15 menit pertama dan jika tidak terjadi respons alergi maka transfusi dapat dipercepat sesuai target dan kondisi pasien
16. Berikan transfusi dalam waktu maksimal 4 jam (untuk WB, PRC, PRC-LD, WE 2 jam (untuk TC), atau 6 jam (untuk FFP dan cryoprecipitate)
17. Bilas selang dengan mengalirkan cairan NaCl 50-100 ml
18. Monitor TTV dan adanya tanda/gejala respons alergi (saat transfusi dimulai, 15 menit setelah transfusi dimulai, saat transfusi selesai, 4 jam setelah transfusi selesai)
19. Hentikan transfusi jika terdapat reaksi transfusi
20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
21. Lepaskan sarung tangan
22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
23. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN PRODUK DARAH**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2183 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGAMBILAN SPESIMEN**		
	No.Dokumen 400.7.4/2184/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengambil bahan contoh untuk pemeriksaan laboratorium
TUJUAN	Status cairan membaik curah jantung meningkat, perfusi perfier meningkat perfusi miokard meningkat, tingkat syok menurun, eliminasi fekal membaik, keseimbangan cairan meningkat,keseimbangan elektrolit meningkat, perfusi serebral meningkat perfusi renal meningkat, perfusi gastrointestinal meningkat, integritas kulit dan jaringan meningkat,tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Penampung (container) spesimen, sesuai kebutuhan 8. Ambil spesimen sesuai kebutuhan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGAMBILAN SPESIMEN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2184 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Tampung spesimen dalam penampung (container) yang tepat 10. Ajarkan cara mengambil atau menampung spesimen, jika perlu kontaminasi 11. Tutup rapat penampung spesimen untuk mencegah kebocoran dan 12. Simpan spesimen yang telah diambil sesuai prosedur 13. Labeli spesimen dengan data-data yang diperlukan (nama pasien, nomor rekam, tanggal dan waktu pengambilan spesimen) 14. Lengkapi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasi prosedur yang telah dilakukan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN POSISI SUPINE**		
	No.Dokumen 400.7.4/2185/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan posisi telentang dengan merebahkan punggung pada tempat tidur
TUJUAN	Mobilitas fisik meningkat integritas kulit dan jaringan meningkat, pola tidur membaik, status kenyamanan meningkat toleransi aktivitas meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Bantal 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan bersih, jika perlu 10. Posisikan pasien tidur terlentang 11. Letakkan bantal di bahu dan kepala pasien 12. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN POSISI SUPINE**		
	No.Dokumen 900.7.4/2185/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Lepaskan sarung tangan 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN POSISI TRENDELENBURG**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2186 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengatur posisi berbaring dengan bagian kepala lebih rendah dari pada bagian kaki
TUJUAN	Status cairan membaik, tingkat syok menurun, perfusi perfier meningkat, tingkat alergi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Selimut dan bantal b. Sarung tangan bersih 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan bersih, jika perlu 10. Atur posisi berbaring 11. Turunkan posisi tempat tidur bagian kepala 12. Atur hingga posisi kepala terletak lebih rendah dari kaki

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN POSISI TRENDELENBURG**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 2186 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Lepaskan sarung tangan 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGGUNAAN SYRINGE PUMP**		
	No.Dokumen 400.7.4/2150/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memanfaatkan perangkat pompa mekanis untuk memberikan cairan, elektrolit dan/atau agen farmakologis dengan takaran yang akurat dalam jangka waktu tertentu
TUJUAN	Curah jantung meningkat, perfusi miokard meningkat perfusi perifer meningkat, sirkulasi spontan meningkat, perfusi renal meningkat, perfusi gastrointestinal , meningkat kapasitas adaptif intrakranial meningkat, keseimbangan cairan meningkat, keseimbangan elektrolit meningkat tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Jaga privasi pasien 4. Cuci tangan 5. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Mesin syringe pump c. Spuit 50 cc, 20 cc, 10 cc spuit atau 5 cc d. Perfusor line e. Tree way, jika perlu f. Obat sesuai program g. Cairan pelarut (NaCl 0,9%, water for injection, atau D5W), jika perlu h. Standar infus 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGGUNAAN SYRINGE PUMP**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 2150 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Pasang sarung tangan bersih 10. Campurkan obat dengan pelarut 11. Sambungkan perfusor line ke spuit dan pastikan tidak ada gelembung udara 12. Pasang three-way jika belum terpasang 13. Atur three-way untuk menutup aliran intravena ke pasien 14. Sambungkan perfusor line ke three-way 15. Atur three-way untuk membuka aliran intravena ke pasien 16. Hubungkan syringe pump ke sumber listrik 17. Hidupkan mesin syringe pump dan pastikan mesin berfungsi dengan baik 18. Pasang spuit ke mesin syringe pump 19. Atur kecepatan aliran sesuai dosis obat yang diprogramkan 20. Tekan tombol start untuk memulai mengalirkan obat 21. Pastikan obat dapat mengalir dengan baik 22. Lepaskan sarung tangan 23. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 24. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEREKAMAN ELEKTROKARDIOGRAM (EKG) 12 SADAPAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1780 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasang elektroda pada area tertentu pada ektremitas dan dada untuk mendapatkan sadapan potensial listrik yang dihasilkan oleh aktivitas jantung.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk meningkatkan keseimbangan elektrolit dan toleransi aktivitas meningkat, curah jantung meningkat sirkulasi spontan meningkat perfusi miokard meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 6 langkah 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Mesin EKG b. Elektroda dada (prekordial) dan ektremitas c. Alkohol swab d. Jeli

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEREKAMAN ELEKTROKARDIOGRAM (EKG)** **12 SADAPAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1780 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

e. Tisu
f. Sampiran/tiral
g. Bengkok

8. Atur posisi pasien senyaman mungkin
9. Bersihkan permukaan kulit di pergelangan tangan dan kaki serta dada
10. Berikan jeli secukupnya pada area yang akan dipasangi elektroda
11. Sambungkan kabel dengan manset elektroda extremitas
12. Pasang manset elektroda ektremitas pada pergelangan tangan dan kaki:
    a. Kabel RA dengan elektroda di pergelangan tangan kanan
    b. Kabel LA dengan elektroda di pergelangan tangan kiri
    c. Kabel LF (atau LL) dengan elektroda di pergelangan kaki kiri
    d. Kabel RF (atau LF, N) dengan elektroda di pergelangan kaki kanan
13. Sambungkan kabel dengan elektroda dada
14. Pasang balon elektroda pada dada:
    a. C1: Ruang interkosta IV tepi sternal kanan
    b. C2: Ruang interkosta IV tepi sternal kiri
    c. C3: Pertengahan C2 dan C4
    d. C4: Ruang interkosta V kiri di garis midklavikula
    e. C5: Ruang interkosta V kiri di garis aksila anterrio
    f. C6: Ruang interkostal V kiri di garis mid-aksila
15. Nyalakan mesin EKG dan operasikan mesin EKG sesuai petunjuk penggunaan mesin
16. Anjurkan bernapas normal dan tidak bergerak serta

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEREKAMAN ELEKTROKARDIOGRAM (EKG)
12 SADAPAN</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4 / 1780 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">tidak berbicara saat perekaman
17. Lakukan perekaman jantung
18. Matikan mesin EKG
19. Lepaskan elektroda pada dada dan ekstemitas
20. Bersihkan dada dan ekstremitas
21. Tuliskan identitas atau tempelkan label identitas pasien pada kertas EKG
22. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
23. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
24. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Bedah Sentral
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Rawat Jalan</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**REHABILITASI JANTUNG**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1779 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengelola periode pemulihan fungsi jantung setelah mengalami gangguan yang berakibat pada ketidakseimbangan kebutuhan dan suplai oksigen miokard, serta meminimalkan kejadian, perilaku beresiko dan dampak psikososial.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk curah jantung meningkat, perfusi miokard meningkat, sirkulasi spontan meningkat, toleransi aktivitas meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan, prosedur dan fase-fase rehabilitasi jantung Jaga privasi pasien 5. Cuci tangan 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Spigmomanometer b. Stetoskop

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**REHABILITASI JANTUNG**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1779 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Monitor tingkat toleransi pasien 11. Periksa kontraindikasi latihan (takikardia > 120 x/menit, TDS > 180 mmHg, TDD > 110 mmHg, hipotensi ortostatik > 20 mmHg, angina, dispnea, gambaran EKG iskemia, blok antrioventrikuler derajat 2 dan 3, takikardia ventrikel) 12. Lakukan skrining ansietas dan depresi, jika perlu 13. Anjurkan menjalani latihan sesuai toleransi 14. Fasilitasi menjalani latihan sesuai fase rehabilitasi 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RESUSITASI JANTUNG PARU PADA PASIEN DEWASA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1778 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan pertolongan pertama pada kondisi henti napas dan henti jantung dengan eknik kombinasi kompresi pada dada dan bantuan napas pada pasien dewasa.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk sirkulasi spontan meningkat, gangguan ventilasi meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Periksa respons pasien dengan memanggil, Menepuk bahu dan/atau memberikan rangsangan nyeri 8. Aktifkan Emergency Medical System atau berteriak meminta tolong 9. Pasang sarung tangan bersih, jika memungkinkan 10. Posisikan pasien di tempat datar dan keras

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RESUSITASI JANTUNG PARU PADA PASIEN DEWASA**		
	No.Dokumen 900.7.4 / 1778 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

11. Atur posisi penolong berlutut di samping dada pasien (jika pasien di lantai) atau berdiri di samping dada pasien (jika pasien di tempat tidur)
12. Periksa nadi karotis dan napas secara bersamaan dalam waktu <10 detik
13. Lakukan rescue breathing jika nadi karotis teraba tapi tidak ada napas
14. Lakukan kompresi dada jika nadi karotis tidak teraba:
    a. Posisikan tumit telapak tangan pada pertengahan dada atau seperdua bawah sternum
    b. Lakukan kompresi dada dengan kecepatan 100-120 kali/menit dan kedalaman 4 cm atau sepertiga ketinggian dada
15. Buka dan bersihkan jalan napas dengan teknik head tilt- chin lift atau jaw thrust (jika curiga cedera servikal)
16. Berikan bantuan napas (ventilasi) 2 kali dengan menggunakan BVM
17. Lakukan kompresi dan ventilasi dengan kombinasi 30.2 (untuk 1 orang penolong) atau 15:2 (untuk 2 orang penolong) sebanyak 5 siklus atau sekitar 2 menit
18. Periksa nadi karotis dan napas setiap 2 menit atau 5 siklus
    a. Lakukan RJP kembali jika nadi karotis belum teraba
    b. Lakukan rescue breathing 10-12 kali/menit jika nadi karotis teraba dan napas tidak ada
22. Berikan posisi pemulihan (recovery position) jika nadi karotis teraba dan napas ada tetapi belum

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">RESUSITASI JANTUNG PARU PADA PASIEN DEWASA</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

A00.7.4 / 1778 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">sadar (jika pasien di lantai) atau berikan posisi semi fowler (jika pasien di tempat tidur)
23. Lepaskan sarung tangan
24. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
25. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Bedah Sentral
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Rawat Jalan</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RESUSITASI JANTUNG PARU PADA PASIEN ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1777 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan pertolongan pertama pada kondisi henti napas dan henti jantung dengan eknik kombinasi kompresi pada dada dan bantuan napas pada pasien anak.
TUJUAN	Sirkulasis spontan meningkat, gangguan ventilasi meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Periksa respons pasien dengan memanggil, Menepuk bahu dan/atau memberikan rangsangan nyeri 8. Aktifkan Emergency Medical System atau berteriak meminta tolong 9. Pasang sarung tangan bersih, jika memungkinkan 10. Posisikan pasien di tempat datar dan keras

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RESUSITASI JANTUNG PARU PADA PASIEN ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1777 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

11. Atur posisi penolong berlutut di samping dada pasien (jika pasien di lantai) atau berdiri di samping dada pasien (jika pasien di tempat tidur)
12. Periksa nadi karotis dan napas secara bersamaan dalam waktu <10 detik
13. Lakukan rescue breathing jika nadi karotis teraba tapi tidak ada napas
14. Lakukan kompresi dada jika nadi karotis tidak teraba:
    a. Posisikan tumit telapak tangan pada pertengahan dada atau seperdua bawah sternum
    b. Lakukan kompresi dada dengan kecepatan 100-120 kali/menit dan kedalaman 4 cm atau sepertiga ketinggian dada
    c. Buka dan bersihkan jalan napas dengan teknik head tilt- chin lift atau jaw thrust (jika curiga cedera servikal)
15. Berikan bantuan napas (ventilasi) 2 kali dengan menggunakan BVM
16. Lakukan kompresi dan ventilasi dengan kombinasi 30.2 (untuk 1 orang penolong) atau 15:2 (untuk 2 orang penolong) sebanyak 5 siklus atau sekitar 2 menit
17. Periksa nadi karotis dan napas setiap 2 menit atau 5 siklus.
    a. Lakukan RJP kembali jika nadi karotis belum teraba
    b. Lakukan rescue breathing 10-12 kali/menit jika nadi karotis teraba dan napas tidak ada
18. Berikan posisi pemulihan (recovery position) jika nadi karotis teraba dan napas ada tetapi belum sadar (jika pasien di lantai) atau berikan posisi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RESUSITASI JANTUNG PARU PADA PASIEN ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1777 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	semi Fowler (jika pasien di tempat tidur) 19. Lepaskan sarung tangan. 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DETEKSI DINI STATUS GIZI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1776 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan penilaian awal pasien yang beresiko mengalami malnutrisi untuk mencegah penurunan status gizi.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk status nutrisi membaik, status perkembangan membaik, status pertumbuhan membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Gunakan instrumen skrining yang valid dan terpercaya 8. Lakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan dan indeks massa tubuh (IMT) 9. Lakukan pemeriksaan laboratorium, jika perlu 10. Identifikasi status gizi dalam 1 x 24 jam setelah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DETEKSI DINI STATUS GIZI**		
	No.Dokumen A00.7.4 / 1776 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	pasien masuk rumah sakit 11. Lakukan skrining ulang setelah satu minggu, jika skrining gizi menunjukkan tidak berisiko malnutrisi 12. Informasikan hasil skrining status gizi 13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING LAKTASI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1775 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menganjurkan ibu untuk memutuskan yang terbaik dalam pemberian nutrisi bayi dengan teknik mendengarkan dan mempelajari sehingga menumbuhkan kepercayaan diri dalam kegiatan menyusui.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk status menyusui membaik, perlekatan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Identifikasi keadaan emosional ibu saat akan dilakukan konseling menyusui 8. Identifikasi maksud dan tujuan menyusui 9. Monitor permasalahan yang ibu temui selama proses menyusui 10. Gunakan teknik mendengarkan dan mempelajari

	seperti duduk sama tinggi. sediakan waktu untuk mendengarkan permasahan ibu, perhatikan intonasi suara dan hindari penghalang 11. Berikan kesempatan ibu untuk menceritakan permasalahan selama menyusui 12. Berikan pujian kepada ibu terhadap perilaku yang benar untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk melanjutkan menyusui 13. Berikan informasi dan saran sesuai dengan kebutuhan ibu menggunakan bahasa yang mudah diterima dan tidak menghakimi 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN INTAKE DAN OUTPUT CAIRAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1774 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data jumlah cairan yang masuk dan keluar tubuh.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk curah jantung meningkat, perfusi miokard meningkat, perfusi perifer meningkat, sirkulasi spontan meningkat, keseimbangan cairan meningkat, keseimbangan elektrolit meningkat, eliminasi fekal membaik, tingkat mual menurun, tingkat syok menurun, perfusi renal meningkat, perfusi gastrointestinal meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Gelas ukur

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN INTAKE DAN OUTPUT CAIRAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1779 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	c. Format pemantauan intake dan output cairan 8. Pasang sarung tangan bersih 9. Ukur volume output cairan (meliputi urine, defekasi, muntah, NGT , dan drain) 10. Ukur volume input cairan (meliputi minum dan cairan intravena) 11. Hitung balans cairan 12. Lepaskan sarung tangan 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Hitung insensible water loss (IWL), jika perlu 15. Hitung balans cairan sesuai periode waktu yang dibutuhkan (misal per jam, per 8 jam, per 12 jam, per 24 jam), jika perlu 16. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN KEPATENAN SELANG NASOGASTRIK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1773 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data tentang ketepatan posisi dan kepatenan selang yang dipasang melalui hidung, melewati tenggorokan sampai ke dalam lambung.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk tingkat aspirasi menurun, status nutrisi membaik, motilitas gastrointestinal membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Stetoskop c. Plester d. Catheter tip atau spuit, sesuai ukuran e. Kertas pH, jika perlu

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMANTAUAN KEPATENAN SELANG NASOGASTRIK</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4 / 1773 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">10. Pasang sarung tangan bersih
11. Periksa ketepatan posisi selang nasogastrik dengan aspirasi cairan lambung. atau auskultasi hembusan udara, atau cek keasaman cairan lambung dengan kertas pH
12. Periksa ketepatan fiksasi selang nasogastrik sesuai batas penandaan
13. Lepaskan sarung tangan
14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Bedah Sentral
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Rawat Jalan</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN RESIDU GASTER**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1772 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data tentang karakteristik cairan yang tertinggal lambung dengan cara mengalirkan selang naso/orogastrik yang ujung selangnya berada di dalam lambung.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk tingkat aspirasi menurun, status nutrisi membaik, motilitas gastrointestinal membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Catheter tip atau spuit sesuai ukuran c. Kertas pH, jika perlu 10. Pasang sarung tangan bersih

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN RESIDU GASTER**		
	No.Dokumen 400.7.4/1772/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	Sambungkan selang naso/orogastrik dengan catheter tip atau spuit 11. Aspirasi cairan lambung dengan menarik pendorong catheter tip atau spuit 12. Periksa keasaman cairan lambung dengan kertas pH untuk memastikan cairan lambung, jika perlu 13. Ukur volume residu lambung 14. Amati wama dan karakteristik residu lambung 15. Lepaskan sarung tangan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA HIPERGLIKEMIA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1771 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data tanda dan gejala yang menigindikasikan peningkatan kadar glukosa darah di atas batas normal.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk kestabilan kadar glukosa darah meningkat, status cairan membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/ atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Monitor tanda dan gejala, seperti: a. Lelah atau lesu b. Haus meningkat c. Mulut kering d. Jumlah urine meningkat Kadar glukosa darah/ urine tinggi 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA HIPERGLIKEMIA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1771 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 10. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 11. Dokumentasikan: a. Tanda dan gejala yang tampak b. Waktu munculnya tanda dan gejala 12. Durasi munculnya tanda dan gejala		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA HIPERVOLEMIA**		
	No.Dokumen 900.7.4 / 1770 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data tanda dan gejala yang menigindikasikan peningkatan volume cairan dalam tubuh.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk status cairan membaik, keseimbangan cairan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Monitor tanda dan gejala, seperti: a. Ortopnea b. Dispnea c. Paroxysmal nocturnal dyspnea (PND) d. Edema anasarka dan/atau edema perifer e. Berat badan meningkat dalam waktu singkat f. JVP atau CVP meningkat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA HIPERVOLEMIA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1770 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	g. Refleks hepatojugularis positif h. Distensi vena jugularis i. Terdengar suara napas tambahan j. Kadar Hb atau Ht turun k. Oliguria l. Intake lebih banyak dari output (balans cairan positif) 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 10. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 11. Dokumentasikan: a. Tanda dan gejala yang tampak b. Waktu munculnya tanda dan gejala 12. Durasi munculnya tanda dan gejala		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA HIPOGLIKEMIA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1769 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data tanda dan gejala yang menigindikasikan peningkatan volume cairan dalam tubuh.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk kestabilan kadar glukosa darah meningkat, status cairan membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap. tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Monitor tanda dan gejala, seperti: a. Mengantuk b. Pusing c. Lapar d. Palpitasi e. Gemetar f. Kesadaran menurun

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA HIPOGLIKEMIA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1769 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	g. Berkeringat h. Berperilaku aneh i. Kadar glukosa darah/urine turun 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 12. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 13. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 14. Dokumentasikan: a. Tanda dan gejala yang tampak b. Waktu munculnya tanda dan gejala 15. Durasi munculnya tanda dan gejala		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA HIPOVOLEMIA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1968 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data tanda dan gejala yang menigindikasikan penurunan volume cairan dalam tubuh.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk status cairan membaik, keseimbangan cairan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap. tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Monitor tanda dan gejala, seperti: a. Merasa lemah b. Mengeluh haus c. Frekuensi nadi meningkat d. Nadi teraba lemah e. Tekanan darah menurun f. Tekanan nadi menyempit

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA HIPOVOLEMIA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1768 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	g. Turgor kulit menurun h. Membran mukosa kering i. Suhu tubuh meningkat j. Volume urine menurun k. Konsentrasi urine meningkat l. Berat badan turun tiba-tiba m. Hematokrit meningkat n. Output lebih banyak dari input (balans cairan negatif) 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 12. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 13. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 14. Dokumentasikan: a. Tanda dan gejala yang tampak b. Waktu munculnya tanda dan gejala 15. Durasi munculnya tanda dan gejala		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA KETIDAKSEIMBANGAN ELEKTROLIT**		
	No.Dokumen 900.7.4 / 1782 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data terkait keseimbangan kadar elektrolit.
TUJUAN	Status cairan membaik, keseimbangan cairan meningkat, keseimbangan elektrolit meningkat, tingkat syok menurun, tingkat mual menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Monitor kadar elektrolit serum 8. Monitor tanda dan gejala ketidakseimbangan kadar elektrolit: a. Hipokalemia (meliputi kelemahan otot, interval QT memanjang, gelombang T datar atau terbalik b. depresi segmen ST, gelombang U, kelelahan parestesia, penurunan refleks, anoreksia,

konstipasi, motilitas usus menurun, pusing, depresi pernapasan)

c. Hiperkalemia (meliputi peka rangsang, gelisah, mual, muntah, takikardia mengarah ke bradikardia, fibrilasi/takikardia ventrikel, gelombang T tinggi, gelombang P datar, Kompleks QRS tumpul, blok jantung mengarah asistol
d. Hiponatremia (meliputi disorientasi, otot berkedut, sakit kepala, membran mukosa kering, hipotensi postural, kejang, latergi, penurunan kesadaran)
e. Hipernatremia (meliputi haus, demam, mual, muntah, gelisah, peka rangsang, membran mukosa kering, takikardia, hipotensi, latergi, konfusi kejang)
f. Hipokalsemia (meliputi peka rangsang, tanda Chvostek [spasme otot wajah, tanda Trousseau [spasme karpal], kram otot, interval QT memanjang)
g. Hiperkalsemia (meliputi nyeri tulang, haus, anoreksia, latergi, kelemahan otot, segmen QT memendek, gelobang T lebar, compels QRS lebar, interval PR memanjang)
h. Hipomagnesemia (meliputi depresi pernapasan, apatis, tanda chvostek, tanda Trousseau, konfusi, disritmia)
i. Hipermagnesemia (meliputi kelemahan otot. hiporefleks, bradikardia, depresi SSP, latergi, koma, depresi)

11. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu
12. Atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien
13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
14. Dokumentasikan hasil pemantauan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TANDA DAN GEJALA KETIDAKSEIMBANGAN ELEKTROLIT**		
	No.Dokumen 400.7.9/1782/2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN SELANG NASOGASTRIK**		
	No.Dokumen 900.7.9/1767/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820913 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memasang selang yang dimasukkan melalui hidung, melewati tenggorokan sampai ke dalam lambung.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk kebutuhan status nutrisi membaik, tingkat aspirasi menurun, status menelan membaik, motilitas gastrointestinal membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Selang nasogastrik sesuai ukuran Jeli c. Catheter tip atau spuit sesuai kebutuhan d. Stetoskop e. Plester f. Tisu g. Bengkok h. Pengalas i. Kertas pH, jika perlu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN SELANG NASOGASTRIK**		
	No.Dokumen 900.1.4 / 1767 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

8. Pasang sarung tangan bersih
9. Posisikan semi-Fowler
10. Letakkan pengalas di dada pasien
11. Tentukan panjang selang nasogastrik dengan mengukur dari ujung hidung ke telinga lalu ke prosesus xiphoideus
12. Tandai panjang selang yang telah diukur
13. Periksa kepatenan lubang hidung
14. Lumasi ujung selang nasogastrik sekitar 10 cm dengan jell
15. Masukkan selang perlahan tapi tegas melalui lubang hidung sampai batas yang di tentukan
16. Anjurkan menundukkan kepala saat selang nasogastrik mencapai nasofaring
17. Anjurkan menelan saat selang nasogastrik dimasukkan
18. Periksa posisi ujung selang dengan cara:
    a. Memasukkan sekitar 10 mL udara ke dalam
    b. selang dan auskultasi bunyi udara pada lambung
    c. Aspirasi cairan lambung
19. Cek keasaman cairan lambung dengan kertas Ph
20. Fiksasi selang nasogastrik pada hidung dengan plester
21. Rapikan pasien dan alat-alat yang telah digunakan
22. Lepaskan sarung tangan
23. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
24. Dokumentasikan ukuran NGT, panjang NGT yang dimasukkan, lubang hidung yang digunakan, pengecekan posisi NGT yang dilakukan dan respons pasiesn selama prosedur

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN SELANG NASOGASTRIK**		
	No.Dokumen A00.7.A / 1767 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN SELANG OROGASTRIK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1392 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memasang selang yang dimasukkan melalui mulut, melewati tenggorokan sampai ke dalam lambung.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk meningkatkan status nutrisi, tingkat aspirasi menurun, status menelan membaik, motilitas gastrointestinal membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 6 langkah 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Selang orogastrik sesuai ukuran c. Catheter tip atau spuit sesuai kebutuhan d. Stetoskop e. Plester

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN SELANG OROGASTRIK**		
	No.Dokumen 400.7.4/1392/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

f. Tisu
g. Bengkok
h. Pengalas
i. Kertas pH, jika perlu

8. Pasang sarung tangan bersih
9. Posisikan semi-Fowler
10. Letakkan pengalas di dada pasien
11. Tentukan panjang selang orogastrik dengan mengukur dari ujung mulut ke telinga lalu ke prosesus xiphoideus
12. Tandai panjang selang yang telah diukur
13. Lumasi ujung selang oroogastrik sekitar 10 cm dengan air
14. Masukkan selang perlahan tapi tegas melalui mulut sampai batas yang telah diukur
15. Anjurkan menelan saat selang orogastrik dimasukkan
16. Periksa posisi ujung selang dengan cara
    a. Memasukkan sekitar 10 mL udara ke dalam selang dan auskultasi bunyi udara pada lambung
    b. Aspirasi cairan lambung
17. Cek keasaman cairan lambung dengan kertas pH
18. Fiksasi selang pada salah satu sisi mulut dengan plester
19. Rapikan alat-alat yang telah didigunakan
20. Lepaskan sarung tangan
21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
22. Dokumentasikan ukuran OGT, panjang OGT yang dimasukkan, pengecekan posisi OGT yang dilakukan dan respons pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN SELANG OROGASTRIK**		
	No.Dokumen A00.7.4 / 1392 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN CAIRAN INTRAVENA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1393 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memberikan cairan melalui jalur intravena.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk meningkatkan keseimbangan cairan, eliminasi fekal membaik, tingkat syok menurun, keseimbangan elektrolit meningkat, perfusi perifer meningkat, dan curah jantung meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Cairan sesuai kebutuhan c. Bengkok 10. Identifikasi indikasi pemberian cairan intravena 11. Periksa jenis, jumlah, tanggal kadaluarsa, jenis

	cairan dan kerusakan wadah 12. Lakukan prinsip 6 benar (pasien, obat, dosis, waktu, rute, dokumentasi) 13. Pasang sarung tangan bersih 14. Periksa kepatenan akses intravena 15. Pertahankan teknik aseptik 16. Berikan cairan pada suhu kamar melalui intravena sesuai program 17. Gunakan infussion pump, jika perlu 18. Lakukan pembilasan selang infus setelah pemberian larutan pekat 19. Monitor aliran akses IV dan area penusukan kateter selama pemberian cairan 20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 21. Lepaskan sarung tangan 22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 23. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN FOTOTERAPI NEONATUS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1394 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan terapi penyinaran pada bayi yang mengalami ikterik akibat bilirubin tidak berkonjugasi masuk ke dalam sirkulasi.
TUJUAN	Sebagai acuan untuk mengatasi ikterus pada bayi akibat bilirubin tidak terkonjugasi yang masuk ke sirkulasi supaya integritas kulit dan jaringan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 6 langkah 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Unit fototerapi b. Penutup mata yang tidak tembus cahaya c. Kain/tirai putih d. Termometer e. Formulir pemakaian fototerapi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN FOTOTERAPI NEONATUS**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1394 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	8. Lakukan pemeriksaan fungsi unit fototerapi 9. Ukur suhu bayi, jika <36, 5°C lakukan fototerapi dalam inkubator 10. Buka baju bayi kecuali diapers 11. Pasang penutup mata selama bayi dilakuka fototerapi 12. Letakkan bayi di bawah unit fototerapi dengan jarak 45-50 cm 13. Nyalakan tombol lampu fototerapi 14. Pasang kain/tirai putih di atas unit fototerapi 15. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Lakukan pencatatan tanggal dan waktu pemasangan lampu fototerapi pada formulir pemakaian fototerapi 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Bedah Sentral 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN LATIHAN MENELAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1395 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan latihan untuk memulihkan, memampukan menelan dan meminimalkan terjadinya komplikasi akibat gangguan menelan
TUJUAN	Sebagai acuan Langkah-langkah untuk status menelan membaik, status nutrisi membaik, tingkat aspirasi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Alat makan: piring dan sendok c. Tisu d. Makanan Junak e. Permen lollipop

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN LATIHAN MENELAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1395/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

f. Set oral hygiene
g. Klorheksidin 0,2%
h. Bengkok

7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
8. Pasang sarung tangan bersih
9. Berikan pasien lingkungan yang nyaman
10. Posisikan pasien duduk
11. Fasilitasi oral hygene dengan klorheksidin
12. Fasilitasi posisi kepala fleksi ke depan untuk persiapan menelan
13. Anjurkan membuka dan menutup mulut untuk persiapan memanipulasi makana
14. Anjurkan tidak berbicara saat makan
15. Letakkan makanan di bagian belakang mulut kontraindikasi
16. Hindari penggunaan sedotan
17. Berikan permen lollipop untuk meningkatkan kekuatan lidah, jika tidak ada
18. Monitor gerakan lidah saat makan
19. Monitor tanda dan gejala aspirasi
20. Monitor tanda kelelahan saat makan, minum dan menelan
21. Pertahankan posisi duduk selama 30 menit setelah makan
22. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
23. Lepaskan sarung tangan
24. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
25. Dokumentasikan respons pasien dan prosedur yang telah dilakukan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN LATIHAN MENELAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1395/2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN MAKANAN ENTERAL**		
	No.Dokumen 400.7.4/1396/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memberikan nutrisi melalui selang oro/nasogastrik
TUJUAN	Sebagai acuan Langkah-langkah untuk status nutrisi membaik, status menelan membaik, tingkat aspirasi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Catheter tip atau spuit 20-50 cc, sesuai kebutuhanSet oral hygiene b. Sarung tangan bersih c. Stetoskop d. Makanan cair e. Air minum f. Tisu

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMBERIAN MAKANAN ENTERAL</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4/1396/
2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">g. Pengalas
7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
8. Pakai sarung tangan bersih
9. Posisikan semi-Fowler
10. Letakkan pengalas di dada pasien
11. Periksa posisi dan kepatenan NGT serta residu lambung
12. Tunda pemberian makanan jika residu lebih dari 50 cc
13. Buka penutup ujung NGT dan sambungkan dengan catheter tip atau spuilt
14. Masukkan makanan cairan ke dalam catheter tip
15. Alirkan makanan perlahan tanpa mendorong
16. Bilas selang dengan air minum
17. Tutup kembali ujung selang
18. Pertahankan posisi semi-Fowler selama 30 menit setelah makan
19. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
20. Lepaskan sarung tangan
21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
22. Dokumentasikan respons pasien dan prosedur yang telah dilakukan</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Rawat Inap</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN NUTRISI PARENTERAL**		
	No.Dokumen 400.7.9/1397/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memberikan nutrisi melalui pembuluh darah vena baik sentral (untuk nutrisi parenteral total) atau vena perifer (untuk nutrisi parenteral parsial) pada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui oral atau enteral
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk status nutrisi membaik, motilitas gastrointestinal membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Sarung tangan bersih b. Spuit sesuai kebutuhan c. Nutrisi parenteral sesuai kebutuhan d. *Infusion pump* atau *syringe pump*, jika perlu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN NUTRISI PARENTERAL**		
	No.Dokumen 400.7.4/1397/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	e. *Extention tube* f. *Three-way* g. Alcohol swab h. Bengkok i. Standar infus 7. Lakukan prinsip 6 benar terhadap terapi nutrisi yang diberikan 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pakai sarung tangan bersih 10. Periksa kepalenan akses intravena 11. Sambungkan set infus ke wadah nutrisi parenteral 12. Atur jalur intravena pada three-way 13. Atur kecepatan dan volume nutrisi parenteral sesuai program 14. Gunakan infusion pump atau syringe pump, jika perlu 15. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 16. Lepaskan sarung tangan 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan respons pasien dan prosedur yang telah dilakukan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT MELALUI SELANG NASOGASTRIK**		
	No.Dokumen 400.7.4/1398/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memberikan nutrisi melalui selang oro/nasogastrik
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk status nutrisi membaik , status menelan membaik, tingkat aspirasi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. *Catheter tip* atau spuit 20-50 cc, sesuai kebutuhan *set oral hygiene* b. Sarung tangan bersih c. Stetoskop d. Makanan cair e. Air minum

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMBERIAN OBAT MELALUI SELANG NASOGASTRIK</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4/1398/2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">f. Tisu
g. Pengalas
8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
9. Pakai sarung tangan bersih
10. Posisikan semi-Fowler
11. Letakkan pengalas di dada pasien
12. Periksa posisi dan kepatenan NGT serta residu lambung
13. Tunda pemberian makanan jika residu lebih dari 50 cc
14. Buka penutup ujung NGT dan sambungkan dengan catheter tip atau spult
15. Masukkan makanan cairan ke dalam catheter tip
16. Alirkan makanan perlahan tanpa mendorong
17. Bilas selang dengan air minum
18. Tutup kembali ujung selang
19. Pertahankan posisi semi-Fowler selama 30 menit setelah makan
20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
21. Lepaskan sarung tangan
22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
23. Dokumentasikan respons pasien dan prosedur yang telah dilakukan</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Rawat Inap</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT SUBKUTAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1399 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memberikan agen farmakologis melalui subkutan untuk mendapatkan efek lokal maupun sistemik
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk kestabilan kadar glukosa darah meningkat, perfusi miokard meningkat, tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapksn alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Obat sesuai program c. Spuit dan jarum sesuai kebutuhan d. Alcohol swab e. Bak suntik

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT SUBKUTAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1399 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	f. Bengkok 8. Lakukan prinsip 6 benar pemberian obat (pasien, obat, dosis, waktu, rute, dokumentasi) 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Pasang sarung tangan bersih 11. Pilih lokasi penyuntikan yang bebas dari luka, nyeri, bengkak dan inflamasi 12. Bersihkan area penyuntikan dengan alcohol swab 13. Genggam dan cubit area yang mengelilingi lokasi penyuntikan (pada pasien kurus) atau meregangkan kulit (pada pasien gemuk) 14. Pegang spuit dengan tangan yang dominan di antara ibu jari dan jari telunjuk 15. Tusukkan jarum secara cepat dengan sudut 45-90° 16. Lakukan aspirasi dan injeksikan obat secara perlahan, jika tidak tampak darah jangan memijat area penyuntikan 17. Tarik jarum dan 18. Usap dengan alcohol swab 19. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 20. Lepaskan sarung tangan 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan respons pasien dan prosedur yang telah dilakukan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENANGANAN HIPOTENSI DURANTE HEMODIALISIS**		
	No.Dokumen 400.7.4/1400/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan penanganan pada kondisi penurunan tekanan darah di bawah rentang normal saat menjalani hemodialisis
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk status cairan membaik, curah jantung meningkat, tingkat syok menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Monitor jantung c. Selang oksigen dan sumber oksigen 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PENANGANAN HIPOTENSI DURANTE HEMODIALISIS</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4/1400/2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">10. Atur posisi trendelenburg
11. Turunkan pompa darah (QB) sampai 150 Rpm
12. Matikan ultrafiltrasi
13. Masukkan kembali darah di sirkulasi extra-corporeal ke dalam tubuh
14. Berikan oksigen sesuai kebutuhan
15. Monitor tekanan darah pasien setiap 15 menit
16. Berikan cairan NaCl 0,9% sebanyak 100 s/d 150 Ml via blood line hemodialisis
17. Lanjutkan dialisis jika tekanan darah meningkat dan gejala berkurang/hilang. Hentikan dialisis jika tekanan darah tidak meningkat dan gejala tidak berkurang/hilang
18. Kolaborasi dengan tim medis untuk penanganan lebih lanjut
19. Jelaskan kepada pasien dan/atau keluarga tentang kondisi yang dialami pasien
20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
21. Lepaskan sarung tangan
22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
23. Dokumentasikan respons pasien dan prosedur yang telah dilakukan</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Rawat Jalan</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN FILTRASI HEMODIALISIS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1901 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengatur laju filtrasi pada pasien yang menjalani proses hemodialisis
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk perfusi renal meningkat, status cairan membaik, keseimbangan cairan meningkat, keseimbangan elektrolit meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Pasang sarung tangan 9. Identifikasi kondisi pasien (meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, suhu tubuh, berat badan, tinggi badan, edema, keseimbangan cairan) 10. Monitor status hemodinamik selama proses hemofiltrasi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kira **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGATURAN FILTRASI HEMODIALISIS**		
	No.Dokumen 400.7.9/1401/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Monitor *ultrafiltration rate*, hemodinamik dan kebocoran 12. Monitor *intake* dan *output* cairan tiap jarn 13. Ambil sampel darah untuk pemeriksaan fungsi ginjal, dan elektrolit sebelum terapi 14. Gunakan teknik steril untuk melakukan *priming blood line hemofiltrasi*, saat menyambungkan *arteri blood line* dan vena pasien 15. Bebaskan sirkuit hemofiltrasi dari udara 16. Berikan heparin sesuai indikasi 17. Periksa kepatenan hubungan *blood line*, arteri maupun vena 18. Hentikan hemofiltrasi jika kondisi pasien menurun 19. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 20. Lepaskan sarung tangan 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan respons pasien dan prosedur yang telah dilakukan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGUKURAN LINGKAR ABDOMEN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1402/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menilai diameter perut dengan menggunakan metera
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk status pertumbuhan membaik, berat badan membaik, status cairan membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Meteran atau pita b. Alat tulis 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Posisikan pasien telentang 10. Buka pakaian area abdomen 11. Ukur lingkar perut sejajar umbilikus 12. Baca hasil pengukuran dengan teliti

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGUKURAN LINGKAR ABDOMEN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1402 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan hasil pengukuran		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGUKURAN LINGKAR KEPALA**		
	No.Dokumen 400.7.4/1404/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menilai diameter kepala bayi dengan menggunakan meteran yang mencerminkan ukuran dan pertumbuhan otak
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk status pertumbuhan membaik, status perkembangan membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Meteran atau pita ukur b. Alat tulis 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Gendong bayi dalam posisi duduk 9. Lingkarkan pita ukur dari area frontalis ke oksipitalis di atas telinga 10. Baca hasil pengukuran dengan teliti

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGUKURAN LINGKAR KEPALA**		
	No.Dokumen 400.7.4/1404/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Rapihkan pasien dan alat-alat yang digunakan 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 13. Dokumentasikan hasil pengukuran		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGUKURAN PANJANG BADAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1406/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menilai pertumbuhan skeletal sebagai salah satu indikator status nutrisi dari pertumbuhan bayi
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk status pertumbuhan membaik, risiko defisit nutrisi
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Meteran atau pita ukur b. Alat tulis 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Baringkan bayi pada alas yang datar dan aman 9. Lepaskan sepatu dan hiasan kepala bayi 10. Tempelkan kepala bayi pada ujung pengukur pada batas angka 0 11. Pegang kepala bayi dengan lembut agar tidak

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGUKURAN PANJANG BADAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1906/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	bergerak 12. Tahan lutut bayi agar kaki lurus 13. Tempelkan telapak kaki bayi pada pengukur dengan posisi telapak kaki fleksi 14. Baca hasil pengukuran dengan teliti 15. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Informasikan hasil pengukuran, jika perlu 18. Dokumentasikan hasil pengukuran		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGUKURAN TINGGI BADAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1407/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 27 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menilai pertumbuhan Skeletal sebagai salah satu indikator status nutrisi dan pertumbuhan
TUJUAN	Status pertumbuhan membaik, risiko defisit nutrisi
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Meteran atau pita ukur b. Alat tulis 7. Anjurkan melepas alas kaki 8. Anjurkan berdiri tegak menghadap lurus ke arah depan 9. Pastikan bagian belakang kepala, punggung, bokong dan tumit menempel pada tiang pengukur 10. Turunkan batas atas pengukur sampai menempel ke ubun-ubun

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGUKURAN TINGGI BADAN**		
	No.Dokumen 900.7.4/1407/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Baca hasil pengukuran dengan teliti 12. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Informasikan hasil pengukuran, jika perlu 15. Dokumentasikan hasil pengukuran		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENIMBANGAN BERAT BADAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1408/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengukur bobot tubuh dengan menggunakan timbangan
TUJUAN	Status pertumbuhan membaik, status perkembangan membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Timbangan injak/lantai (untuk anak dan dewasa) b. Timbangan bayi dan pengalas c. Alat tulis 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Letakkan timbangan pada permukaan yang datar 9. Pastikan posisi awal menunjukkan angka 0 10. Anjurkan melepaskan alas kaki, jaket atau barang lainnya yang dapat mempengaruhi hasil penimbangan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENIMBANGAN BERAT BADAN**		
	No.Dokumen 900.7.9/1408/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Fasilitasi pasien anak/dewasa berdiri di atas timbangan tanpa berpegangan. atau baringkan bayi dengan hati-hati di atas timbangan 12. Bacalah angka yang ditunjukkan oleh timbangan 13. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Informasikan hasil pengukuran, jika perlu 16. Dokumentasikan hasil penimbangan berat badan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN IKTERIK NEONATUS**		
	No.Dokumen 400.7.4/1409/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan perawatan pada bayi yang kulit dan membran mukosanya menguning akibat bilirubin tidak berkonjugasi masuk ke dalam sirkulasi
TUJUAN	Integritas kulit dan jaringan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 8. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 9. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Unit fototerapi b. Penutup mata yang tidak tembus cahaya c. Kain/tirai putih d. Termometer e. Formulir pemakaian fototerapi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN IKTERIK NEONATUS**		
	No.Dokumen 400.7.4/1409/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Lakukan pemberian fototerapi 12. Monitor suhu setiap 3 jam 13. Buka penutup mata setiap kali melakukan tindakan keperawatan 14. Penuhi kebutuhan cairan untuk mempertahankan hidrasi 15. Periksa adanya tanda-tanda kernikterik (demam, mudah mengantuk, lemas, muntah, gerakan mata yang tidak normal, kaku di seluruh tubuh, otot menegang/melemah, tidak mau menyusu) 16. Periksa hasil laboratorium bilirubin secara berkala 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons bayi		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN RESUSITASI CAIRAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1410 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan perawatan pada pasien yang menjalani pemberian cairan intravena dengan cepat sesuai indikasi
TUJUAN	Status cairan membaik, perfusi perifer meningkat, tingkat syok menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Cairan kristaloid (Ringer Laktat, NaCl 0.9% atau Asering) c. Produk darah, jika perlu d. Set infus atau set transfusi (blood set) e. Kateter IV ukuran besar (nomor 16 atau 18) f. Torniket

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN RESUSITASI CAIRAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1910/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

g. Spuit 3 cc
h. Tabung sampel darah
i. Alcohol swab
j. Plester
k. Gunting
l. Monitor jantung
m. Oksimetri nadi
n. Stetoskop
o. Pengalas
p. Bengkok

7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
8. Pasang sarung tangan
9. Monitor status hemodinamik (frekuensi napas, frekuensi nadi, kekuatan nadi, TD, tekanan nadi, MAP)
10. Monitor status oksigenasi (saturasi oksigen, AGD)
11. Monitor status cairan (intake-output, akral, CRT, turgor kulit)
12. Monitor nilai BUN, kreatinin, protein total, dan albumin, jika perlu
13. Identifikasi kelas syok untuk estimasi kehilangan darah
14. Pasang jalur IV berukuran besar (nomor 16 atau 18)
15. Berikan infus cairan kristaloid 1-2 L pada dewasa atau 20 mL/kgBB pada anak
16. Ambil sampel darah untuk pemeriksaan cross matching
17. Berikan produk darah, jika perlu
18. Monitor tanda dan gejala edema paru
19. Dokumentasikan respons pasien dan prosedur yang telah dilakukan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN RESUSITASI CAIRAN**		
	No.Dokumen 400.7A/1910/2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PIJAT OKSITOSIN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1911/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pengeluaran ASI dengan merangsang hormon oksitosin melalui pijatan di bagian punggung
TUJUAN	Status menyusui membaik, peran menjadi orang tua, membaik, perlekatan membaik, status pasca partum membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Handuk kecil b. Minyak kelapa c. Washlap d. Air hangat e. Baskom kecil 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Anjurkan ibu membuka pakaian bagian atas 9. Atur posisi ibu duduk membungkuk dengan payudara menggantung 10. Letakkan handuk di pangkuan ibu, untuk menampung tetesan ASI 11. Oleskan minyak kelapa secukupnya di kedua telapak

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PIJAT OKSITOSIN</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4/1411/2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">tangan pemijat dan daerah punggung ibu yang akan dipijat
12. Temukan titik pijat antara tulang servikal dan thorakal di bagian bahu
13. Pijat di antara tulang belakang, 1 cm dari kanan dan kiri tulang belakang (tidak memijat di atas tulang belakang secara langsung)
14. Pijat dengan ibu jari (4 jari dalam posisi menggenggam) yang digerakkan secara melingkar hingga turun sejajar payudara bagian bawah (tali bra)
15. Lakukan pijatan dari atas ke bawah selama kurang lebih 1 menit atau sesuai kenyamanan ibu
16. Periksa pengeluaran ASI pada saat atau setelah pemijatan
17. Anjurkan ibu untuk memerah payudara sesuai kenyamanan ibu, apabila payudara terasa bengkak
18. Bersihkan punggung ibu dari minyak dengan waslap hangat
19. Anjurkan ibu mengenakan/mengganti pakaian bagian atas
20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
21. Dokumentasikan respons pasien dan prosedur yang telah dilakukan</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
2. Instalasi Rawat Inap</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI BERAT BADAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1412/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi peningkatan bobot atau massa tubuh
TUJUAN	Status nutrisi membaik, berat badan membaik, status pertumbuhan membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi kemungkinan penyebab BB kurang 8. Monitor adanya mual dan muntah 9. Monitor jumlah kalori yang dikonsumsi sehari-hari 10. Monitor berat badan 11. Monitor albumin, limfosit, dan elektrolit serum, jika perlu 12. Berikan perawatan mulut sebelum pemberian makan, jika perlu 13. Sediakan makanan yang tepat sesuai kondisi pasien

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PROMOSI BERAT BADAN</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4/1412/2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(seperti makanan dengan tekstur halus, makanan yang di-blender, makanan cair yang diberikan melalui NGT atau gastrostomi, total perenteral nutrition, sesuai indikasi)
14. Hidangkan makanan secara menarik
15. Berikan suplemen, jika perlu
16. Berikan pujian pada pasien/keluarga untuk peningkatan yang dicapai
17. Jelaskan jenis makanan yang bergizi tinggi, namun tetap terjangkau
18. Jelaskan peningkatan asupan kalori yang dibutuhkan
19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
20. Dokumentasikan respons pasien dan prosedur yang telah dilakukan</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
2. Instalasi Rawat Inap</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI LAKTASI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1413/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	
PENGERTIAN	Meningkatkan cakupan ASI eksklusif secara efektif dan dilanjutkan sampai 2 tahun		
TUJUAN	Status menyusui membaik, perlekatan meningkat		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.		
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Lakukan promosi laktasi pada masa kehamilan a. Pahamkan ibu tentang manfaat ASI ekslusif b. Pilihkan fasilitas pelayanan dantenaga kesehatan yang menjamin kemudahan proses menyusui c. Anjurkan mengikuti kelas persiapan menyusui pada usia kehamilan 36 minggu 7. Lakukan promosi laktasi pada masa persalinan a. Fasilitasi ibu saat melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) b. Letakkan bayi di dada ibu untuk kontak kulit		

segera setelah lahir dan biarkan merangkak ke payudara untuk inisiasi menyusu minimal 1 jam

c. Lakukan rawat gabung ibu dan bayi rawat 24 jam
d. Ajarkan ibu mengatur posisi dan perlekatan yang benar
e. Ajarkan ibu memerah ASI dalam 6-24 jam pasca persalinan
f. Gunakan sendok dan cangkir saat bayi belum bisa menyusul

8. Lakukan promosi laktasi pada masa pasca persalinan
   a. Damping ibu selama kegiatan menyusui berlangsung
   b. Monitor kondisi ibu menyusui dan tumbuh kembang bayi secara berkala
   c. Ajarkan ibu melakukan manajemen laktasi
   d. Ajarkan ibu mengenali masalah menyusui
   e. Jelaskan pentingnya menyusui sampal 2 tahu
   f. Anjurkan suami dan orang terdekat untuk mendukung ibu menyusui ASI eksklusif
   g. Informasikan akses layanan konseling menyusui yang tersedia jika sewaktu-waktu diperlukan
9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
10. Dokumentasikan respons pasien dan prosedur yang telah dilakukan

UNIT TERKAIT	1. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 2. Instalasi Rawat Inap

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RESTRIKSI CAIRAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1414/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pembatasan asupan cairan untuk meminimalkan kelebihan cairan dalam tubuh.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk status cairan membaik, curah jantung meningkat, perfusi renal meningkat, keseimbangan cairan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Periksa tanda dan gejala hipervolemia (seperti ortopnea, dispnea, edema, JVP/CVP meningkat, refleks hepatojugular positif, suara napas tambahan) 9. Periksa status hemodinamik (meliputi frekuensi nadi, tekanan darah, MAP, CVP, PAP, PCWP, CO,CI), jika tersedia Ukur intake, output

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RESTRIKSI CAIRAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1919 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	dan balance cairan 10. Periksa kecepatan infus secara ketat 11. Timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama 12. Batasi asupan cairan dan garam 13. Anjurkan melapor jika output urine <0,5 mL/kg/jam dalam 6 jam 14. Anjurkan melapor jika BB bertambah >1 kg dalam sehari 15. Ajarkan cara mengukur dan mencatat input dan output cairan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RUJUKAN KE KELAS LAKTASI PASCA PERSALINAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1415/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 27 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan transfer pasien yang mengalami kesulitan menyusui ke klinik laktasi.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk status menyusui membaik, status kenyamanan pasca partum meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Identifikasi kemampuan ibu dalam kegiatan menyusui 9. Periksa kondisi payudara ibu (meliputi jenis puting, adanya bengkak, adanya lecet pada puting) 10. Periksa pertambahan berat badan bayi 11. Jelaskan tujuan ibu ke klinik laktasi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RUJUKAN KE KELAS LAKTASI PASCA PERSALINAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1415/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Motivasi ibu untuk mengikuti kelas laktasi 13. Monitor tanda-tanda vital ibu sebelum ke klinik laktasi 14. Daftarkan ibu ke bagian klinik laktasi 15. Dampingi ibu ke klnik laktasi, jika perlu 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RUJUKAN KE KELOMPOK DUKUNGAN MENYUSUI**		
	No.Dokumen 400.7.A / 1416 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan pelimpahan layanan kesehatan ibu hamil dan menyusui dalam mempersiapkan dan mempertahankan menyusui ASI eksklusif.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk status menyusui membaik, tingkat pengetahuan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Identifikasi usia kehamilan ibu 9. Identifikasi motivasi ibu untuk menyusui 10. Identifikasi pengetahuan ibu tentang menyusui 11. Identifikasi dukungan yang diterima ibu selama kehamilan, persalinan dan pasca persalinan 12. Diskusikan pentingnya bergabung dengan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RUJUKAN KE KELOMPOK DUKUNGAN MENYUSUI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1416 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	kelompok dukungan menyusui 13. Motivasi ibu untuk bergabung dengan kelompok dukungan menyusui 14. Anjurkan ibu mengunjungi kelompok dukungan menyusui 15. Rujuk ke kelompok dukungan menyusui 16. Kolaborasi dengan konselor menyusui, jika perlu 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI TOILET TRAINING**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1417 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyediakan informasi dan dukungan untuk menentukan kesiapan anak berkemih secara mandiri dan strategi pendampingan yang digunakan.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk status perkembangan membaik, eliminasi fekal membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 9. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 10. Ajarkan orang tua mengidentifikasi kesiapan anak untuk berkemih mandiri 11. Ajarkan orang tua mengidentifikasi kesiapan anak

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI TOILET TRAINING**		
	No.Dokumen 400.7.4/1417/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	secara psikososial 12. Ajarkan strategi untuk latihan toilet 13. Ajarkan cara mengajak anak ke toilet 14. Ajarkan cara memberikan pujian atas keberhasilan anak 15. Berikan kesempatan untuk bertanya 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EVAKUASI FESES SECARA MANUAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1918 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Pengeluaran feses yang mengeras pada rektum atau sigmoid bagian bawah secara manual.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk eliminasi fekal membaik, status kenyamanan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 8. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Pispot bertutup c. Jeli d. Botol berisi air e. Kapas f. Tisu toilet

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EVAKUASI FESES SECARA MANUAL**		
	No.Dokumen 400.7.4/1918/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

g. Handuk
h. Bengkok lidokain, jika perlu

9. Pasang sampiran
10. Posisikan pasien miring dengan lutut fleksi
11. Pasang handuk menutupi bagian panggul dan paha
12. Pasang pengalas di bawah bokong
13. Buka pakaian bawah pasien
14. Letakkan pispot di samping pasien
15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
16. Pasang sarung tangan
17. Berikan jeli pada jari telunjuk
18. Berikan lidokain untuk anestesi lokal dengan mengoleskan 1-2 mL pada rektum 5 menit sebelum prosedur, jika perlu
19. Masukkan jari telunjuk ke dalam rektum dan lanjutkan dengan perlahan di sepanjang dinding rektal ke arah umbilikus
20. Keluarkan massa feses secara perlahan
21. Tarik feses ke bawah ke arah anus dan keluarkan potongan secara bertahap
22. Anjurkan menarik napas dan rileks saat dilakukan evakuasi feses
23. Periksa secara berkala frekuensi, irama, dan kekuatan nadi, serta tanda kelelahan
24. Periksa adanya keluhan seperti nyeri, perdarahan, frekuensi nadi turun, perubahan irama nadi atau diaforesis
25. Bersihkan anus dengan menyiramkan air dan usap dengan kapas dari arah depan ke belakang
26. Keringkan dengan tisu
27. Singkirkan pispot dan buang feses
28. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
29. Lepaskan sarung tangan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EVAKUASI FESES SECARA MANUAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1918 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	30. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 31. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan (konsistensi, warna, bau, nyeri, lendir, darah, perubahan frekuensi, irama dan kekuatan nadi serta tanda kelelahan) dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1.Instalasi Gawat Darurat 2.Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3.Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI BERKEMIH TERATUR**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1419 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pola pengeluaran urine yang teratur.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk eliminasi urine membaik, kontinensia urine membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Siapkan area toilet yang aman 9. Sediakan peralatan yang dibutuhkan dekat dan mudah dijangkau, seperti kursi komod, pispot, urinal, sesuai kebutuhan 10. Identifikasi penyebab gangguan berkemih, seperti kognitif, kehilangan ekstremitas atau fungsi ekstremitas, atau kehilangan penglihatan 11. Periksa pola dan kemampuan berkemih

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI BERKEMIH TERATUR**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1419 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Jelaskan pentingnya berkemih secara teratur 13. Informasikan arah menuju kamar mandi/toilet 14. Anjurkan asupan cairan adekuat untuk mendukung output urine optimal 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien dengan kapas dari arah depan ke belakang		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IRIGASI KANDUNG KEMIH**		
	No.Dokumen 400.7.9/1420/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Membersihkan atau membilas kandung kemih untuk mencegah bekuan darah, memberikan obat, dan mengeluarkan benda asing dari kandung kemih
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk eliminasi urine membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Larutan irigasi steril, sesuaikan suhu dalam kantung dengan suhu ruangan b. Selang irigasi dengan klem (dengan atau tanpa konektor) c. Sarung tangan bersih

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IRIGASI KANDUNG KEMIH**		
	No.Dokumen 400.7.4/1420/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	d. Tiang infus e. Alcohol swab f. Wadah metrik g. Konektor Y h. Selimut mandi 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Pasang sarung tangan 11. Periksa abdomen bawah untuk tanda distensi kandung kemih 12. Hubungkan ujung selang irigasi ke dalam kantung larutan irigasi dengan menggunakan teknik aseptik 13. Tutup klem selang drainase dan buka klem selang irigasi 14. Alirkan cairan sebanyak yang diprogramkan ke dalam kandung kemih 15. Tutup klem selang irigasi dan buka klem selang drainase 16. Hitung kecepatan tetesan dan atur klem pada selang irigasi secara tepat, jika irigasi kontinu 17. Rapikan pasien dan alat-alat yang telah digunakan 18. Lepaskan sarung tangan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IRIGASI KOLOSTOMI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1421/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengeluarkan isi kolon (feses) secara terjadwal dengan memasukkan sejumlah air dengan suhu sama dengan tubuh/hangat.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk eliminasi fekal membaik, tingkat infeksi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Pengalas c. Tiang infus d. Air hangat e. Kateter f. Cone-tip g. Jeli h. Sabun

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IRIGASI KOLOSTOMI**		
	No.Dokumen 900.7.9/1921/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Pasang sarung tangan bersih 11. Letakkan pengalas di bawah kolostomi 12. Isi kantung irigasi dengan air yang tersedia (air hangat atau air khusus untuk irigasi) 13. Gantung kantung irigasi pada tiang infus 14. Alirkan air ke dalam selang dan hindari adanya udara dalam selang 15. Lepaskan kantung stoma lalu pasang plastik irigasi dan masukkan ujung selang ke stoma 16. Letakkan plastik irigasi ke dalam kloset atau kantung pembuangan 17. Hubungkan cone-tip kateter dengan kateter dan beri jeli 18. Masukkan cone-tip ke dalam stoma dan tangan tetap memegang cone-tip 19. Alirkan air dengan aliran yang cukup (10-15 menit) 20. Lambatkan aliran jika terdapat tanda-tanda kram abdomen 21. Klem kateter dan tutup stoma 15-20 menit 22. Biarkan sampai semua feses keluar setelah 40-60 menit 23. Bersihkan area stoma dengan sabun dan air 24. Pasang kembali kantung stoma 25. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 26. Lepaskan sarung tangan 27. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 28. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IRIGASI UROSTOMI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1422/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Membersihkan atau membilas kandung kemih untuk mencegah bekuan darah dan pemberian obat hematuria dan mengeluarkan benda asing dari kandung kemih.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk eliminasi urine membaik, tingkat infeksi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Alat steril b. Sarung tangan steril c. Pinset anatomis dan sirurgis d. Kom 1 buah e. Kasa

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IRIGASI UROSTOMI**		
	No.Dokumen	No.Revisi	Halaman :
	900.7.4/1922/2026	05	2/3

f. Spuit 10 cc
g. Alat tidak steril
h. Sarung tangan bersih
i. Kantong urostomi
j. Cairan antiseptik
k. Cairan NaCL 0,9%
l. Urine bag
m. Plester
n. Gunting
o. Baskom
p. Pengalas
q. Bengkok
r. Plastik kuning/infeksius
s. Tempat sampah

8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
9. Pasang pengalas
10. Dekatkan bengkok dan baskom ke pasien
11. Isi kom dengan NaCL 0,9%
12. Pasang sarung tangan steril
13. Bersihkan kulit sekitar stoma dengan cairan antiseptik
14. Lakukan spoeling urostomi/nefrostomi dengan cairan NaCL 0,9%
15. Aspirasi perlahan urostomi/nefrostomi
16. Periksa kepatenan aliran dan produksi urostomi/nefrostomi
17. Bersihkan kembali stoma urostomi/nefrostomi dengan cairan antiseptik dan cairan NaCL 0,9%
18. Sambungkan selang pigtail dengan urine bag
19. Tutup urostomi/nefrostomi dengan kasa steril
20. Lakukan fiksasi dengan plester

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IRIGASI UROSTOMI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1422/2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	21. Rapikan pasien dan alat – alat yang digunakan 22. Lepaskan sarung tangan 23. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 24. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MASASE (PIJAT) ABDOMEN**		
	No.Dokumen 900.7.4/1423/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan pemijatan pada abdomen untuk memperbaiki sirkulasi darah dan sistem pencemaan serta meningkatkan kenyamanan.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk eliminasi fekal membaik, perfusi gastrointestinal meningkat, status kenyamanan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Minyak kelapa atau minyak zaitun b. Handuk 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Posisikan pasien berbaring di tempat tidur 10. Periksa adanya luka, nyeri atau kondisi lainnya sebelum melakukan pemijatan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MASASE (PIJAT) ABDOMEN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1423 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Letakkan handuk di dada dan di bawah area abdomen 12. Tuangkan minyak ke telapak tangan dan oleskan ke area abdomen 13. Pijat area abdomen dengan gerakan memutar searah jarum jam 14. Pijat area abdomen dengan gerakan membentuk garis dari bagian bawah dada menuju pubis, dari kiri ke kanan dengan jarak 3 cm 15. Lakukan pemijatan selama 10-15 menit 16. Rapikan pasien dan berikan posisi nyaman 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN BISING USUS**		
	No.Dokumen 400.7.4/1425/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 29 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan pengamatan secara berkala terhadap gerakan peristaltik usus dengan menggunakan stetoskop.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk eliminasi fekal membaik, motilitas gastrointestinal membaik, perfusi gastrointestinal meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Stetoskop b. Jam atau pengukur waktu 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Posisikan pasien berbaring di tempat tidur 10. Anjurkan tidak berbicara selama pemeriksaan 11. Letakkan sisi diafragma stetoskop dengan penekanan yang ringan mulai pada kuadran kiri

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN BISING USUS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1425 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	bawah 12. Dengarkan bising usus dan perhatikan frekuensi dan karakternya 13. Lanjutkan pemeriksaan pada kuadran abdomen lainnya 14. Rapikan pasien dan alat yang digunakan 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 17. Dokumentasikan frekuensi bising usus dan karakter bising usus (terdenga/tidak terdengar, normal/hiperaktif/hipoaktif)		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN DISTENSI KANDUNG KEMIH**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1426 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi peningkatan tekanan pada perabaan kandung kemih.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk eliminasi urine membaik, kontinensia urine membaik, status kenyamanan meningkat, tingkat nyeri menurun, tingkat infeksi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan, jika perlu b. Selimut 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Posisikan pasien berbaring di tempat tidur 10. Anjurkan pasien rileks

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMANTAUAN DISTENSI KANDUNG KEMIH</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.9/1926/2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">11. Buka pakaian pada area simpisis pubis dan tutup area bawah dengan selimut
12. Lakukan palpasi pada area simpisis pubis dan rasakan adanya distensi kandung kemih
13. Periksa adanya nyeri tekan
14. Lakukan perkusi untuk mengecek keredupan dan menentukan ketinggian kandung kemih di atas simpisis pubis, jika perlu
15. Rapikan pasien dan alat yang digunakan
16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
17. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu
18. Dokumentasikan hasil pemantauan (teraba distensi/tidak, redup/tidak, nyeri tekan/tidak, ketinggian kandung kemih dari simpisis)</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Bedah Sentral
3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
4. Instalasi Rawat Inap</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN KATETER URINE PASIEN LAKI-LAKI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1427 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RSUD dr. LOEKMONO HADI dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasukkan selang katater urine ke dalam kandung kemih melalui uretra pada pasien laki-laki.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk eliminasi urine membaik, kontinensia urine membaik, status kenyamanan meningkat, tingkat nyeri menurun, tingkat infeksi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan steril b. Kateter urine sesuai ukuran c. Urine bag dan penggantungnya d. Spuit yang berisi 20 mL aquades/NaCl atau sesuai anjuran pabrik e. Jeli lidokain 2%

f. Cairan antiseptik
g. Sarung tangan bersih
h. Kom bersih
i. Wadah sampel urine, jika perlu
j. Kapas/kasa dan cairan antiseptik
k. Pengalas
l. Bengkok
m. Sampiran

8. Jaga privasi dengan memasang sampiran
9. Atur posisi telentang dengan kaki abduksi
10. Letakkan pengalas di bawah bokong
11. Tutup area pinggang dengan selimut
12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
13. Pasang sarung tangan bersih
14. Bersihkan area genitalia dengan kapas/kasa dan cairan antiseptik
15. Bilas dan keringkan, kemudian lepaskan sarung tangan bersih
16. Buka set kateter steril dan alat-alat steril lainnya dan tempatkan di alas steril dengan tetap mempertahankan teknik aseptik
17. Pasang sarung tangan steril
18. Sambungkan kateter dengan urine bag
19. Pegang penis tegak lurus dengan tangan nondominan dan masukkan 10 mL jell ke dalam meatus uretra dengan tangan dominan
20. Tutup meatus uretra dengan jari telunjuk selama 1-2 menit
21. Masukkan kateter ke dalam meatus uretra secara perlahan dengan tangan dominan sampai pangkal kateter sambil menganjurkan tarik napas dalam
22. Lakukan fiksasi internal dengan memasukkan aquades/NaCl untuk mengembangkan balon

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN KATETER URINE PASIEN LAKI-LAKI**		
	No.Dokumen 400.7.A / 1927 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	kateter 23. Tarik kateter perlahan sampai terasa ada tahanan untuk memastikan kateter terfiksasi dengan baik dalam kandung kemih 24. Lepaskan sarung tangan steril 25. Lakukan fiksasi eksternal dengan plester di area abdomen bawah dengan penis mengarah ke dada 26. Gantungkan urine bag dengan posisi lebih rendah dari pasien 27. Pasang sarung tangan bersih dan ambil sampel urine segera dari urine bag, jika perlu 28. Lepaskan sarung tangan bersih 29. Rapihkan pasien dan alat yang digunakan 30. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 31. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan (warna urine, jumlah urine yang keluar, jumlah aquades/NaCl untuk mengembangkan balon, tanggal/waktu dipasang) dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN KATETER URINE PASIEN PEREMPUAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1428/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasukkan selang katater urine ke dalam kandung kemih melalui uretra pada pasien perempuan.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk eliminasi urine membaik, kontinensia urine membaik, status kenyamanan meningkat, tingkat nyeri menurun, tingkat infeksi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan steril b. Kateter urine sesuai ukuran c. Urine bag dan penggantungnya d. Spuit yang berisi 20 mL aquades/NaCl atau sesuai anjuran pabrik e. Jeli lidokain 2%

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN KATETER URINE PASIEN PEREMPUAN**		
	No.Dokumen 900.7.4/1428/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

f. Cairan antiseptik
g. Sarung tangan bersih
h. Kom bersih
i. Wadah sampel urine, jika perlu
j. Kapas/kasa dan cairan antiseptik
k. Pengalas
l. Bengkok
m. Sampiran

8. Jaga privasi dengan memasang sampiran
9. Atur posisi telentang dengan kaki abduksi
10. Letakkan pengalas di bawah bokong
11. Tutup area pinggang dengan selimut
12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
13. Pasang sarung tangan bersih
14. Bersihkan area perineum dengan kapas/kasa dan cairan antiseptik
15. Bilas dan keringkan, kemudian lepaskan sarung tangan bersih
16. Buka set kateter steril dan alat-alat steril lainnya dan tempatkan di alas steril dengan tetap mempertahankan teknik aseptik
17. Pasang sarung tangan steril
18. Sambungkan kateter dengan urine bag
19. Lumasi ujung kateter 2,5-5 cm dengan jeli
20. Buka kedua labia minora dengan ibu jari dan telunjuk tangan nondominan
21. Masukkan kateter 5-7,5 cm ke dalam meatus uretra secara perlahan sambil menganjurkan tarik napas dalam
22. Perhatikan adanya aliran urine dalam selang urine bag
23. Lakukan fiksasi internal dengan memasukkan aquades/NaCl untuk mengembangkan balon

	kateter 24. Tarik kateter perlahan sampai terasa ada tahanan untuk memastikan kateter terfiksasi dengan baik dalam kandung kemih 25. Lepaskan sarung tangan steril 26. Lakukan fiksasi eksternal dengan plester di area paha dalam 27. Gantungkan urine bag dengan posisi lebih rendah dari pasien 28. Pasang sarung tangan bersih dan ambil sampel urine segera dari urine bag, jika perlu 29. Lepaskan sarung tangan bersih 30. Rapihkan pasien dan alat yang digunakan 31. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 32. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan (warna urine, jumlah urine yang keluar, jumlah aquades/NaCl untuk mengembangkan balon, tanggal/waktu dipasang) dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN LATIHAN ELIMINASI FEKAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1429 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengajarkan kemampuan melatih usus untuk dievakuasi pada interval tertentu.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk kontinensia fekal membaik, eliminasi fekal membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. 0bat supositoria c. Jeli lidokain d. Stetoskop 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan bersih 10. Periksa peristaltik usus secara teratur 11. Anjurkan waktu yang konsisten untuk buang

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN LATIHAN ELIMINASI FEKAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1429 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	air besar 12. Berikan privasi, kenyamanan dan posisi yang meningkatkan proses defekasi 13. Gunakan enema rendah, jika perlu 14. Anjurkan dilatasi rektal manual, jika perlu 15. Anjurkan mengkonsumsi makanan tertentu sesuai program 16. Anjurkan asupan cairan yang adekuat sesuai kebutuhan 17. Anjurkan olahraga sesuai toleransi 18. Kolaborasi penggunaan supositoria, jika perlu 19. Lepaskan sarung tangan 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respon pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN LATIHAN KANDUNG KEMIH (BLADDER TRAINING)**		
	No.Dokumen 400.7.4/1430/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Pemberian latihan sebelum pelepasan kateter urine untuk mengatasi instabilitas detrusor akibat pemasangan kateter sehingga pola berkemih dapat kembali normal.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk kontinensia urine membaik, eliminasi urine membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Klem atau pengikat b. Sarung tangan bersih c. Pengukur waktu 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Lakukan klem atau pengikatan selang pada posisi antara katater dan urine bag

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMBERIAN LATIHAN KANDUNG KEMIH
(BLADDER TRAINING)</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4 /1430/
2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">10. Pertahankan klem atau pengikatan selama 2 jam atau sampai pasien merasa kandung kemih terasa penuh dan ingin berkemih
11. Buka klem selama 5 menit, kemudian lakukan klem atau pengikatan kembali
12. Teruskan proses membuka dan menutup klem atau pengikatan selama 12 jam
13. Pasang sarung tangan bersih dan lepaskan kateter urine
14. Rapikan pasien dan alat yang digunakan
15. Lepaskan sarung tangan
16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
17. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien
18. Anjurkan waktu yang konsisten untuk buang air besar</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Bedah Sentral
3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
4. Instalasi Rawat Inap</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT SUPOSITORIA ANAL**		
	No.Dokumen 400.7.9/1429/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan dan memberikan agen farmakologis berupa supositoria yang dimasukkan melalui anal untuk membuat efek lokal atau sistemik.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk eliminasi fekal membaik, tingkat cedera menurun, tingkat nyeri menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Obat supositoria, sesuai indikasi c. Jeli d. Tisu 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan 10. Jaga privasi pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT SUPOSITORIA ANAL**		
	No.Dokumen 400.7.9/1424/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Atur posisi Sims 12. Lepaskan obat dari wadahnya dan berikan jeli pada ujungnya 13. Anjurkan nafas dalam untuk merilekskan sfingter anus 14. Regangkan bokong dengan tangan nondominan 15. Masukkan obat secara perlahan melalui anus, melalui sfingter anal internal dan mengenai dinding rectal 16. Tarik jari dan bersihkan area anal 17. Anjurkan mempertahankan posisi selama 5 menit 18. Rapikan pasien dan alat yang digunakan 19. Lepaskan sarung tangan 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGAMBILAN SAMPEL URINE TENGAH (MIDSTREAM)**		
	No.Dokumen 400.7.1/1931/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	
PENGERTIAN	Mengambil sampel urine pancaran atau porsi tengah untuk pemeriksaan laboratorium.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk perfusi perifer meningkat, keseimbangan cairan meningkat, keseimbangan elektrolit meningkat.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.		
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Beri tahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Wadah sampel urine 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan 10. Jaga privasi pasien 11. Anjurkan menginformasikan jika pasien akan berkemih		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGAMBILAN SAMPEL URINE TENGAH (MIDSTREAM)**		
	No.Dokumen 400.7.4/1431/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Anjurkan aliran urine awal dibuang dan aliran selanjutnya ditampung di wadah 13. Anjurkan penampungan urine selesai sebelum aliran urine habis 14. Tutup rapat wadah urine untuk mecegah kebocoran dan kontaminasi 15. Berikan label pada wadah sampel urine (nama pasien, nomor rekam medis, tanggal dan waktu pengambilan sampel) 16. Kirim sampel ke laboratorium 17. Lepaskan sarung tangan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INKONTINENSIA FEKAL**		
	No.Dokumen 400.7.4/1432/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat pasien yang mengalami perubahan kebiasaan buang air besar yang ditandai dengan pengeluaran feses secara involunter (tidak disadari)
TUJUAN	Kontinensia fekal membaik; integritas kulit dan jaringan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi penyebab inkontinensia fekal baik fisik maupun psikologis (seperti gangguan saraf motorik bawah, penurunan tonus otot, gangguan sfingter rektum, diare kronis, gangguan kognitif, stress berlebihan) 8. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Air dan sabun

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PERAWATAN INKONTINENSIA FEKAL</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4 / 1432 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">c. Pakaian ganti, jika perlu
d. Linen (seprei, stik laken), jika perlu
e. Bengkok
9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
10. Pasang sarung tangan
11. Jaga privasi pasien
12. Lepaskan pakaian bawah pasien
13. Bersihkan area perineum dengan kapas antiseptik
14. Identifikasi perubahan frekuensi defekasi dan karakteristik feses
15. Pasang popok, jika perlu
16. Ganti linen dan pakaian, jika perlu
17. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
18. Jadwalkan BAB secara teratur
19. Lepaskan sarung tangan
20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
21. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat darurat
2. Instalasi Bedah Sentral
3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
4. Instalasi Rawat Inap</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INKONTINENSIA URINE**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1783 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat pasien yang mengalami perubahan kebiasaan buang air kecil yang ditandai dengan pengeluaran urine secara involunter (tidak disadari)
TUJUAN	Kontinensia Urine Membaik, Integritas Kulit dan Jaringan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi penyebab inkontinensia urine (seperti disfungsi neurologis, gangguan medulla spinalis, gangguan refleks detrusor, obat-obatan, usia riwayat operasi, gangguan fungsi kognitif) 8. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Kapas antiseptik (seperti klorheksidin 2%)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INKONTINENSIA URINE**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1783 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

c. Air dan sabun

d. Pakaian ganti, jika perlu

e. Linen (seprei, stik laken), jika perlu

f. Bengkok

9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
10. Pasang sarung tangan
11. Jaga privasi pasien
12. Bebaskan area genital dari pakaian
13. Bersihkanarea perineum dengan sabun dan air setelah BAK 14. Identifikasi perubahan frekuensi BAK dan karakteristik urine
15. Pasang popok, jika perlu
16. Ganti linen dan pakaian, jika perlu
17. Rapikan pasien dan alat yang digunakan
18. Lepaskan sarung tangan
19. Jadwalkan BAK secara teratur
20. Jadwalkan konsumsi obat diuretik dan hindarkan pemberian di malam hari
21. Anjurkan membatasi konsumsi cairan 2-3 jam sebelum tidur
22. Anjurkan minum minimal 1500 co/hari, jika tidak ada kontra indikasi
23. Anjurkan menghindari kopi, minuman bersoda, teh dan coklat
24. Ajarkan memantau cairan masuk dan cairan keluar
25. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
26. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respon pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INKONTINENSIA URINE**		
	No.Dokumen	No.Revisi	Halaman :
	900.7.4 / 1783 / 2026	05	3/3
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN KATETER URINE**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1784 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pencegahan invasi mikroorganisme patogen dan komplikasi lainnya akibat pemasangan kateter urine
TUJUAN	Tingkat Infeksi Menurun, Integritas Kulit dan Jaringan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua Identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi penyebab inkontinensia urine (seperti disfungsi neurologis, gangguan medulla spinalis, gangguan refleks detrusor, obat-obatan, usia Riwayat operasi, gangguan fungsi kognitif) 8. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Kapas antiseptik (seperti klorheksidin 2%) c. Bengkok

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN KATETER URINE**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1784 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Pasang sarung tangan 11. Jaga privasi pasien 12. Bebaskan area genital dari pakaian 13. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran kemih 14. Monitor tanda dan gejala obstruksi aliran urune 15. Monitor kebocoran kateter, selang dan kantung urine 16. Pastikan selang kateter dan kantung urine tidak tertekuk atau terbebas dari lipatan 17. Pastikan kantung urine diletakkan di bawah kantung kemih dan tidak di lantai 18. Lakukan perawatan perineal minimal 2 kali sehari 19. Kosongkan kantung urine jika telah terisi setengahnya 20. Ganti kateter dan kantung urine secara rutin sesuai protokol atau sesuai indikasi 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN STOMA**		
	No.Dokumen 900.7.4/1785/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat pasien yang memiliki stoma dengan membersihkan stoma dan kulit sekitar stoma, serta mengganti kantung stoma secara berkala
TUJUAN	Tingkat Infeksi Menurun, Integritas Kulit dan Jaringan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Kantung kolostomi c. Kassa/kapas/tisu d. Cairan fisiologis e. Plastik hitam f. Pinset sirurgis g. Pinset anatomis h. Kom steril

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN STOMA**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1785 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3
	8. Stomahaesive pasta, jika perlu 9. Stomahaesive powder, jika perlu 10. Gunting 11. Pengalas 12. Bengkok 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Pasang sarung tangan 15. Jaga privasi pasien 16. Pasang pengalas dan gulung di bawah lokasi stoma 17. Letakkan bengkok yang telah dilapisi plastik di atas pengalas 18. Buka klip kantung kolostomi di atas plastik hitam dengan hati-hati 19. Buka kantong stoma, buang feses/urine dan masukkan ke kantong plastik 20. Angkat base plate perlahan-lahan menggunakan cairan fisiologis (dimulai dari bagian yang jauh dari jahitan luka terlebih dahulu) dan masukkan ke dalam kantung plastik hitam 21. Ganti sarung tangan 22. Bersihkan stoma dan kulit sekitar stoma menggunakan kapas/kassa dan cairan fisiologis dengan diameter 10-15 cm 23. Bersihkan jahitan di sekeliling stoma menggunakan lidi kapas yang diberi cairan fisiologis 24. Keringkan kulit sekitar stoma dengan kasa kering 25. Tutup lubang stoma menggunakan kasa lembab dan siapkan pola pada base plate baru yang akan dipasang menggunakan stoma guide 26. Gunting base plate sesuai pola dan rapikan tepian guntingan base plete dengan jari 27. Buka kertas pengalas dan berikan pasta di sekeliling pinggiran lubang pola tersebut, kemudian dirapikan		

	menggunakan jari telunjuk yang telah dicelupkan dalam cairan fisiologis 28. Pasang base plate pada kulit sekitar stoma dimulai dari posisi stoma bagian bawah 29. Tekan dengan hati-hati sekeliling base plate menggunakan jari-jari tangan 30. Pasang kantung stoma sambil mengangkat kassa yang berada di atas lubang stoma 31. Pasangkan klipnya di bagian bawah kantung stoma sekitar 2 cm 32. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 33. Lepaskan sarung tangan 34. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 35. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN AMBULASI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1786 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pasien dalam melakukan aktivitas berpindah
TUJUAN	Mobilitas Fisik Meningkat , Toleransi Aktivitas Meningkat, Tingkat Jatuh Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih, jika perlu b. Tongkat/Kruk 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Pasang sarung tangan, jika perlu 9. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik 10. Identifikasi toleransi fisik dalam melakukan ambulasi 11. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi 12. Rendahkan posisi tempat tidur 13. Atur posisi Fowler

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN AMBULASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1786 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	14. Fasilitasi posisi kaki menggantung di samping tempat tidur (jika di kursi, posisikan pasien duduk tegak dengan kaki rata di lantai) 15. Fasilitasi pasien untuk berdiri di samping tempattidur 16. Anjurkan melapor jika pasien merasa pusing (jika pusing, dudukkan kembal pasien di tempat tidur) 17. Pastikan lantai bersih dan kering 18. Fasilitasi berpindah dengan menggunakan tongkat atau kruk 19. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi 20. Dorong melakukan ambulasi yang lebih jauh sesuai toleransi 21. Libatkan keluarga dalam membantu pasien melakukan ambulasi 22. Lepaskan sarung tangan, jika menggunakan 23. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 24. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan, jenis gaya berjalan yang digunakan, alat bantu, jumlah bantuan diperlukan, jarak berjalan, dan toleransi aktivitas.menggunakan jari-jari tangan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN MOBILISASI FISIK**		
	No.Dokumen 400.7.4/1787/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Waka Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pasien dalam melakukan aktivitas pergerakan
TUJUAN	Mobilitas Fisik Meningkat,Toleransi Aktivitas Meningkat, Integritas Kulit dan Jaringan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih, jika perlu b. Bantal 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Pasang sarung tangan, jika perlu 9. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik 10. Identifikasi toleransi fisik dalam melakukan mobilisasi 11. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi 12. Berikan posisi miring kanan selama maksimal 2 jam

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN MOBILISASI FISIK**		
	No.Dokumen 400.7.4/1787/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	dan berikan sokongan bantal pada punggung 13. Berikan posisi miring kiri selama maksimal 2 jam dan berikan sokongan bantal pada punggung 14. Berikan posisi terlentang selama maksimal 2 jam 15. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi 16. Libatkan keluarga dalam membantu pasien untuk melakukan mobilisasi 17. Lepaskan sarung tangan, jika menggunakan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN TIDUR**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1788 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi agar siklus tidur dan terjaga pasien teratur
TUJUAN	Pola Tidur Membaik, Tingkat Keletihan Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Identifikasi pola aktivitas dan tidur 7. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau psikologis) 8. Siapkan lingkungan yang mendukung untuk tidur: a. Atur pencahayaan ruangan b. Minimalkan kebisingan c. Atur suhu ruangan sejuk d. Bersihkan dan rapikan tempat tidur e. Batasi waktu berkunjung menjelang jadwal tidur 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Tetapkan bersama pasien jadwal tidur rutin Lakukan prosedur yang meningkatkan kenyamanan (seperti pemijatan pengaturan posisi, teknik

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN TIDUR**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1788 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	relaksasi, mandi air hangat, membaca/dibacakan kisah, musik menenangkan, akupresur) 11. Sesuaikan jadwal pemberian obat atau Tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga 12. Anjurkan mematuhi jadwal tidur rutin 13. Anjurkan melakukan olah raga/aktivitas fisik rutin di pagi hari 14. Batasi waktu tidur siang, jika perlu 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN KELELAHAN FISIK DAN MENTAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1789 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis tanda dan gejala ketidakcukupan energiatau penurunan kapasitas kerja fisik dan mental
TUJUAN	Toleransi Aktivitas Meningkat, Pola Tidur Membaik, Tingkat Keletihan Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5.Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Monitor adanya gejala kelelahan: a. Mengeluh lelah b. Mengeluh sesak napas saat/setelah beraktivitas c. Merasa lemah d. Merasa kurang tenaga e. Merasa tidak nyaman setelah aktivitas f. Merasa tenaga tidak pulih walaupun telah istirahat/tidur g. Merasa bersalah karena tidak mampu menjalankan tanggung jawab

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMANTAUAN KELELAHAN FISIK DAN MENTAL</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

900.7.9 / 1789 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">h. Mengeluh libido menurun
7. Monitor adanya tanda kelelahan:
a. Tampak lesu
b. Tidak mampu menuntaskan aktivitas rutin
c. Kebutuhan istirahat meningkat
d. Frekuensi nadi meningkat >20% dari kondisi istirahat
e. Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat
8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
9. Dokumentasikan hasil pemantauanBersihkan dan rapikan tempat tidur</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat darurat
2. Instalasi Bedah Sentral
3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
4. Instalasi Rawat Inap</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN BIDAI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1790 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan pemasangan penopang untuk menstabilisasi, mengimobilisasi dan memproteksi bagian tubuh yang cedera
TUJUAN	Integritas Jaringan Meningkat , Neurovaskuler Perifer Meningkat, Mobilitas Fisik Meningkat, Tingkat Nyeri Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3.Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Bidai sesuai ukuran (melewati dua persendian ekstremitas c. Mitela atau perban elastis d. Kasa stril, jika perlu 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Pasang sarung tangan 9. Atur posisi pasien senyaman mungkin

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN BIDAI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1990 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Buka pakaian yang menutupi area fraktur 11. Lakukan penghentian perdarahan dengan balut tekan, jika terjadi perdarahan 12. Lakukan perawatan luka, pada fraktur terbuka atau terdapat luka 13. Periksa pulsasi, motorik dan sensorik (PMS) 14. Pasang bidai melewati dua persendian 15. Fiksasi bidai dengan mitela atau perban elastis 16. Periksa kembali pulsasi, motorik dan sensorik (PMS) 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN LATIHAN RENTANG GERAK**		
	No.Dokumen 400.7.4/1791/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2024	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan latihan berupa gerakan aktif dan pasif pada persendian untuk mempertahankan dan mengembalikan kelenturan sendi dan meningkatkan sirkulasi
TUJUAN	Mobilitas Fisik Meningkat, Integritas Kulit/Jaringan Meningkat, Neurovaskuler Perifer Meningkat, Pemulihan Pascabedah Meningkat , Rasa Nyaman Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jaga privasi dengan memasang tirai atau menutup pintu kamar pasien 8. Atur tinggi tempat tidur yang sesuai dan nyaman 9. Berdiri di sisi tempat tidur di posisi ekstremitas pasien yang akan dilatih 10. Lakukan latihan dengan: a. Melakukan Gerakan Perlahan Dan Lembut b. Menyokong Dengan Memegang Area Proksimal Dan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN LATIHAN RENTANG GERAK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1791 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

Distal Sendi

c. Mengulangi Setiap Gerakan 5-10 Kali Setiap Sendi
d. Menghentikan Gerakan Jika Kesakitan Atau Ada tahanan

11. Latihan pada leher
    a. Fleksi-ekstensi: tekuk leher ke depan sampai dagu menempel di dada, lal kembali ke posisi tegak
    b. Fleksi lateral: tekuk leher ke samping kanan dan kiri
    c. Rotasi lateral: palingkan wajah ke kiri dan kanan
    d. Latihan pada bahu:
    e. Elevasi-depresi: Angkat dan turunkan bahu
    f. Fleksi-ekstensi: Angkat lengan dari samping tubuh ke atas, lalu kembali seperti semula
    g. Abduksi-Adduksi Angkat lengan ke samping tubuh hingga sejajar bahu, lalu kembalikan seperti semula
    h. Sikumduksi bahu: putar lengan pada poros bahu
12. Latihan pada siku:
    a. Fleksi-ekstensi: Gerakkan tangan hingga jari-jari menyentuh bahu, lalu kembali seperti semula
    b. Supinasi-pronasi: Putar lengan bawah ke arah
    c. Abduksi-adduksi: renggangkan jari-jari kaki, lalu rapatkan seperti semula
13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
14. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien ekstremitas
    d. luar sehingga telapak tangan menghadap ke atas, lalu putar ke arah dalam sehingga telapak tangan menghadap ke bawah
15. Latihan pada pergelangan tangan:
    a. Fleksi-ekstensi-hiperekstensi: tekuk telapak tangan ke bawah, luruskan, lalu tekuk ke atas
    b. Fleksi radial-fleksi ulnar: Tekuk telapak tangan ke

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN LATIHAN RENTANG GERAK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1791 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	samping ke arah ibu jari dan ke arah kelingking c. Sirkumduksi: Putar tangan pada poros pergelangan tangan 16. Latihan pada jari-jari tangan: a. Fleksi-ekstensi: Kepalkan jari dan luruskan seperti semula b. Abduksi-adduksi: Renggangkan jari-jari dan rapat kembali 17. Latihan pada pelviks dan lutut: a. Fleksi-ekstensi: Angkat kaki lurus lalu tekuk lutut. Gerakkan lutut ke arah dada, turunkan kaki, luruskan, lalu ke posisi semula b. Abduksi-adduksi: gerakkan kaki ke samping menjauhi sumbuh tubuh lalu gerakkan ke arah c. sebaliknya sehingga melewati sumbu tubuh menyilang ke kaki lainnya d. Rotasi internal-rotasi eksternal: putar kaki ke arah dalam lalu ke samping tubuh 18. Latihan pada pergelangan kaki: a. Dorso fleksi-plantar fleksi: dorong telapak kaki ke atas, ke posisi semula, lalu dorong ke atas b. Eversi-inversi: putar telapak kaki keluar, lalu ke dalam c. Sirkumduksi: putar telapak kaki pada poros pergelangan kaki 19. Latihan pada jari-jari kaki: a. Fleksi-ekstensi: dorong jari-jari ke arah atas dan ke bawah		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TIRAH BARING**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1792 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Membaringkan pasien di tempat tidur untuk jangka waktu yang berkesinambungan dan tidak melakukan aktivitas di luar tempat tidur
TUJUAN	Mobilitas Fisik Meningkat, Curah Jantung Meningkat, Toleransi Aktivitas Meningkat, Tingkat Keletihan Menurun , Perfusi Miokard Meningkat, Ventilasi Spontan Meningkat, Sirkulasi Spontan Meningkat, Perfusi Perifer Meningkat, Neurovaskuler Perifer Meningkat, Pemulihan Pascabedah Meningkat, Integritas Kulit dan Jaringan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Pasang sarung tangan, jika perlu 8. Tempatkan pada kasur terapeutik, jika tersedia 9. Posisikan senyaman mungkin 10. Pertahankan seprei tetap kering, bersih dan tidak

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TIRAH BARING**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1792 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	kusut 11. Pasang siderails, jika perlu 12. Posisikan tempat tidur dekat dengan nurse station, jika perlu 13. Dekatkan posisi meja tempat tidur 14. Berikan latihan rentang gerak sendi aktif atau pasif 15. Pertahankan kebersihan pasien 16. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari 17. Berikan stocking antiembolisme, jika perlu 18. Ubah posisi setiap 2 jam 19. Monitor komplikasi tirah baring (meliputi kehilangan massa otot, sakit punggung konstipasi, stres, depresi, kebingungan, perubahan irama tidur, infeksi salura kemih, sulit buang air kecil, pneumonia) 20. Pasang sarung tangan, jika menggunakan 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN GIPS**		
	No. Dokumen 400.7.4 / 1793 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat pasien yang menjalani imobilisasi ekstremitas dengan gips
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk integritas jaringan tulang meningkat, neurovaskuler, erifer meningkat, mobilitas fisik meningkat, tingkat nyeri menurun, integritas kulit dan jaringan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan 8. Periksa tanda-tanda infeksi (seperti gips berbau, eritema, demam) 9. Periksa tanda-tanda gangguan sirkulasi atau fungsi neurologi (5P meliputi pain [nyeri], pale [pucat], pulseless (nadi tidak teraba), parestesi, paralisis) 10. Monitor sirkulasi dan fungsi neurologis pada bagian proksimal dan distal dari lokasi pemasangan gips 11. Monitor tanda-tanda drainase dari luka di bawah gips

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN GIPS**		
	No. Dokumen 400.7.4 / 1793 / 8026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Periksa retak atau kerusakan pada gips 13. Topang gips dengan bantal sampai gips kering 14. Hindari meletakan gips pada permukaan yang keras atau tajam selama masa pengeringan 15. Hindari menekan gips selama masa pengeringan 16. Bersihkan kulit sekitar area pemasangan dari sisa material gips 17. Atasi segera gangguan sirkulasi (seperti reposisi gips, lakukan rentang gerak ekstremitas, hilangkan tekanan akibat gips) 18. Hindari gips menjadi basah (seperti gunakan pelindung yang sesuai saat mandi atau kaus kaki atau sarung tangan pelindung) 19. Posisikan gips pada bantal untuk mengurangi ketegangan 20. Tinggikan ekstremitas yang terpasang gips di atas level jantung 21. Gunakan arm sling untuk penopang, jika perlu 22. Berikan bantalan (padding) pada tepi gips 23. Informasikan gips akan terasa hangat selama proses pemasangan 24. Informasikan perlunya membatasi aktivitas selama masa pengeringan gips 25. Anjurkan tidak menggaruk kulit di bawah gips 26. Ajarkan cara merawat gips 27. Lepaskan sarung tangan 28. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 29. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN TRAKSI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1794 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat pasien yang terpasang traksi untuk mengimobilisasi dan menstabilkan bagian tubuh
TUJUAN	Integritas Kulit dan Jaringan Meningkat, Neurovaskuler Perifer Meningkat, Mobilitas Fisik Meningkat , Tingkat Nyeri Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal du identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan 8. Monitor kemampuan perawatan diri saat terpasang Traksi 9. Monitor alat fiksasi eksternal 10. Monitor tempat insersi pen 11. Monitor tanda-tanda ganguan integritas kulit pada area penonjolan tulang 12. Monitor sirkulasi, pergerakan, dan sensasi pada

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN TRAKSI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1794/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	ekstremitas yang cedera 13. Monitor adanya komplikasi imobilisasi 14. Posisikan tubuh pada kesejajaran yang tepat 15. Pertahankan posisi baring yang tepat di tempat tidur 16. Pastikan beban traksi terpasang tepat 17. Pastikan tali dan katrol bebas menggantung 18. Pastikan tarikan tali dan beban tetap berada di sepanjang sumbu tulang fraktur 19. Amankan beban traksi saat menggerakkan pasien 20. Lakukan perawatan pada area insersi pen 21. Lakukan perawatan kulit pada area-area gesekan 22. Ajarkan perawatan alat fiksasi eksternal, sesuai kebutuhan 23. Jelaskan pentingnya nutrisi yang memadai untuk penyembuhan tulang 24. Lepaskan sarung tangan 25. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 26. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien eritema, demam		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

5

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IRIGASI MATA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1795 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Membilas mata untuk menghilangkan inflamasi lokal konjungtiva, memberikan larutan aseptik atau membilas keluar eksudat dari mata
TUJUAN	Tingkat Nyeri Menurun , Status Kenyamanan Meningkat, Tingkat Infeksi Menurun, Perawatan Diri Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Spuit 10 cc atau penetes mata c. Bola kapas atau kasa d. Cairan NaCl atau cairan irigasi sesuai kebutuhan e. Pengalas tahan air f. Bengkok 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Posisikan berbaring dengan kepala miring ke arah

5

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IRIGASI MATA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1795 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	mata yang akan diirigasi 10. Tempatkan pengalas di bawah wajah 11. Pasang sarung tangan 12. Bersihkan garis kelopak dan bola mata secara perlahan dengan bola kapus dar bagian dalam ke luar kantus 13. Isi spuit irigasi atau penetes mata 14. Pegang spuit irigasi atau penetes mata sekitar 2,5 cm di atas kantus dalam 15. Minta pasien melihat ke arah atas 16. Irigasi secara perlahan dengan mengarahkan cairan ke dalam kantung konjungtiva bawah ke arah kantus luar 17. Lanjutkan irigasi sampai mata telah bersih 18. Keringkan kelopak mata dan area wajah dengan bola kapas 19. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 20. Lepaskan sarung tangan 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IRIGASI TELINGA**		
	No.Dokumen 400.7.9/1475/2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 10 JUNI 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 198920915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Irigasi telinga adalah tindakan membersihkan liang telinga dengan mengalirkan cairan irigasi secara terkontrol untuk mengeluarkan serumen atau debris yang mengganggu pemeriksaan maupun menyebabkan keluhan, setelah dipastikan tidak terdapat kondisi yang menjadi kontraindikasi.
TUJUAN	Mengeluarkan serumen yang menyumbat liang telinga..
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Posisikan pasien duduk dengan kepala sedikit dimiringkan ke sisi telinga yang akan dilakukan irigasi. 2. Letakkan perlak/handuk dan bengkok di bawah telinga untuk menampung cairan. 3. Siapkan cairan irigasi dengan suhu yang nyaman dan sesuai standar. 4. Isi spuit atau alat irigasi dengan cairan. 5. Tarik daun telinga secara perlahan untuk meluruskan liang telinga: a. Dewasa: ke atas dan ke belakang. b. Anak: sesuai usia dan anatomi telinga.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IRIGASI TELINGA**		
	No.Dokumen 400.7.4/1475/2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/2
	6. Masukkan ujung alat irigasi secara hati-hati dan tidak dalam ke pintu liang telinga. 7. Arahkan aliran cairan ke dinding liang telinga, bukan langsung ke membran timpani. 8. Alirkan cairan secara perlahan dengan tekanan terkontrol. 9. Biarkan cairan dan serumen keluar ke dalam bengkok. 10. Ulangi irigasi seperlunya sampai serumen/debris terangkat atau liang telinga cukup bersih. 11. Selama tindakan, observasi keluhan pasien. 12. Hentikan segera apabila pasien mengalami: a. nyeri hebat; b. pusing/vertigo; c. mual berat; d. penurunan pendengaran mendadak; e. perdarahan; f. keluhan lain yang mengindikasikan komplikasi. 13. Setelah serumen keluar, periksa kembali liang telinga dan membran timpani. 14. Keringkan bagian luar telinga dengan kasa. 15. Bila diperlukan, lakukan tindakan lanjutan sesuai instruksi dokter.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi rawat jalan 2. Instalasi Farmasi 3. Instali Radiologi 4. Instalasi Rekam Medik		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN MEMORI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1796 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan latihan untuk meningkatkan daya ingat.
TUJUAN	Memori Meningkat, Tingkat Konfusi Menurun, Komunikasi Verbal Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi masalah memori yang dialami 8. Identifikasi kesalahan terhadap orientasi 9. Rencanakan metode mengajar sesuai kemampuan pasien 10. Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan, jika perlu 11. Koreksi kesalahan orientasi 12. Fasilitasi mengingat kembali pengalaman masa lalu, jika perlu 13. Fasilitasi tugas pembelajaran (seperti mengingat informasi verbal dan gambar

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN MEMORI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1796/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	14. Fasilitasi kemampuan konsentrasi (seperti bermain kartu pasangan), jika perlu 15. Stimulasi menggunakan memori pada peristiwa yang baru terjadi (seperti bertanya ke mana saja ia pergi akhir-akhir ini), jika perlu 16. Ajarkan teknik memori yang tepat (seperti imajinasi visual, perangkat mnemonik permainan memori, isyarat memori, teknik asosiasi, membuat daftar, papan nama) 17. Monitor perilaku dan perubahan memori selama terapi 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN ORIENTASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1797 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan latihan untuk membiasakan diri dengan lingkungan dan situasi sekitar
TUJUAN	Memori Meningkat, Tingkat Konfusi Menurun, Status Orientasi Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi 8. Identifikasi apa yang dilakukan dan tujuannya berdasarkan keinginan dan kebutuhan 9. Minta mengevaluasi perilaku secara berkelanjutan 10. Fasilitasi untuk menyusun rencana yang realistis 11. Fasilitasi untuk membuat komitmen dalam melaksanakan rencana 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN ORIENTASI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1797 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN CPP (CEREBRAL PERFUSION PRESSURE)**		
	No.Dokumen 400.7.4/1798/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memantau dan menganalisis data regulasi tekanan pada perfusi otak yang tidak stabil
TUJUAN	Kapasitas Adaptif Intrakranial Membaik, Perfusi Serebral Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Monitor status neurologi (tekanan darah, reflek pupil dan tingkat kesadaran) 8. Monitor tekanan nadi (selisih tekanan darah sistolik dan diastolik) 9. Monitor MAP (Mean Arteri Pressure) 10. Monitor status pernapasan (meliputi frekuensi, irama, dan kedalaman pernapasan, PaO2, PCO2, pH, dan kadar bikarbonat) 11. Monitor parameter pengiriman oksigen jaringan (meliputi $PaCO_2$, SaO_2 dan kadar hemoglobin dan

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMANTAUAN CPP (CEREBRAL PERFUSION PRESSURE)</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4/1798/2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">curah jantung)
12. Pertahankan PCO, pada level 25 mmHg atau lebih
13. Lakukan pembacaan pada pemantauan tekanan perfusi serebral invasif (seperti kateter intraventrikuler, sensor mikritransduser, kateter epidural, tekanan lumbal cairan serebrospinal), jika tersedia
14. Pertahankan sterilitas sistem pemantauan tekanan perfusi serebral
15. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu
16. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien
17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
18. Dokumentasikan hasil pemantauan</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat darurat
2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif
3. Instalasi Rawat Inap</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN EFEK SAMPING PASCA ECT (ELECTROCONVULSIVE THERAPY)**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1433 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memantau dan menganalisis munculnya efek samping setelah menjalani ECT
TUJUAN	Keterlibatan Sosial Meningkat,Status Orientasi Membaik, Keterlibatan Sosial Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: 8. Sarung tangan, jika perlu 9. Spigmomanometer 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Monitor tanda -tanda vital, status mental, oksimetri nadi, dan EKG 12. Monitor adanya sakit kepala, mual, muntah, mengantuk, dan kejang

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN EFEK SAMPING PASCA ECT (ELECTROCONVULSIVE THERAPY)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1933 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Monitor kesadaran dan orientasi waktu atau tempat 14. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 15. Dokumentasikan hasil pemantauan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN PENINGKATAN TEKANAN INTRAKRANIAL**		
	No.Dokumen 400.7.4/1451/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencegah atau meminimalkan komplikasi akibat peningkatan tekanan di dalam ruang kranium
TUJUAN	Kapasitas Adaptif Intrakranial Membaik, Perfusi Serebral Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Monitor trias peningkatan tekanan intrakranial (PTIK) akut (meliputi sakit kepala, muntah proyektil, papiledema) 8. Monitor peningkatan tekanan darah 9. Monitor pelebaran tekanan nadi (selisih TDS dan TDD) 10. Monitor penurunan frekuensi nadi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN PENINGKATAN TEKANAN INTRAKRANIAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1451 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Monitor ireguleritas irama napas 12. Monitor penurunan tingkat kesadaran 13. Monitor perlambatan atau ketidaksimetrisan respon pupil 14. Monitor tekanan perfusi sereberal, jika tersedia 15. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 16. Dokumentasikan hasil pemantauan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN STATUS NEUROLOGIS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1452 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencegah atau meminimalkan komplikasi akibat gangguan neurologis
TUJUAN	Kapasitas Adaptif Intrakranial Membaik, Perfusi Serebral Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Monitor ukuran, bentuk, kesimetrisan, dan reaktifitas pupil 8. Monitor tingkat kesadaran (secara kualitatif atau kuantitatif [GCS]) 9. Monitor tingkat orientasi 10. Monitor ingatan terakhir, rentang perhatian, memori masa lalu , mood, dan perilaku

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN STATUS NEUROLOGIS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1452 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3
	11. Monitor ICP (Intracranial Pressure) dan CPP (Cerebral Perfusion Pressure), jika tersedia 12. Monitor refleks kornea 13. Monitor batuk dan refleks muntah 14. Monitor kekuatan otot 15. Monitor adanya tremor 16. Monitor kesimetrisan wajah 17. Monitor gangguan visual (seperti diplopia, nistagmus, pernotongan bidang visual, penglihatan kabur, dan ketajaman penglihatan) 18. Monitor keluhan sakit kepala 19. Monitor karakteristik bicara: kelancaran, kehadiran afasia, atau kesulitan mencari kata 20. Monitor diskriminasi tajam / tumpul atau panas / dingin 21. Monitor parestesi (mati rasa dan kesemutan) 22. Monitor pola berkeringat 23. Monitor respons Babinski 24. Monitor respons Cushing 25. Monitor balutan kraniotomi atau laminektomi terhadap adanya drainase 26. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 27. Dokumentasikan hasil pemantauan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TINGKAT DELIRIUM**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1453 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kondisi akut penurunan perhatian dan disfungsi kognitif
TUJUAN	Kapasitas Adaptif Intrakranial Membaik, Perfusi Serebral Meningkat, Persepsi Sensori Membaik, Kontrol Diri Meningkat, Tingkat Konfusi Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Monitor adanya perubahan status mental yang mendadak (akut) 8. Monitor adanya perilaku abnormal yang berfluktuasi (hilang-timbul atau keparahan meningkat-menurun)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TINGKAT DELIRIUM**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1453 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Monitor kemampuan memusatkan perhatian (misalnya mudah teralih atau sulit mengikuti pembicaraan) 10. Monitor adanya pemikiran tidak tertata atau tidak koheren (misalnya percakapan melantur atau tidak relevan, aliran gagasan tidak jernih atau tidak logis, berganti- ganti topik secara tidak terduga) 11. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 12. Dokumentasikan hasil pemantauan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TINGKAT KESADARAN DENGAN SKALA KOMA GLASGOW (GCS)**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1459 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kesadaran berdasarkan respons membuka mata, suara dan motorik
TUJUAN	Kapasitas Adaptif Intrakranial Membaik, Perfusi Serebral Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Posisikan pasien baring 7. Periksa respons mata (eye): a. Membuka mata spontan, skor 4 b. Membuka mata dengan perintah, skor 3 c. Membuka mata terhadap rangsang nyeri, skor 2 d. Tidak berespons, skor 1 8. Periksa respons suara (verbal): a. Orientasi baik, skor 5.

	b. Mengucapkan kalimat tapi tidak sesuai, skor 4 c. Mengucapkan kata-kata kacau, skor 3 d. Bersuara tanpa arti, skor 2 e. Tidak berespons, skor 1 9. Periksa respons motorik (motoric): a. Mengikuti perintah, skor 6 b. Melokalisasi nyeri, skor 5 c. Menolak rangsangan nyeri pada anggota gerak, skor 4 d. Fleksi abnormal, skor 3 e. Ekstensi abnormal, skor 2 f. Tidak ada respons, skor 1 10. Tuliskan total skor dan masing-masing komponen skor GCS, seperti GCS 15 (E4V5M6) 11. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 12. Dokumentasikan hasil pemantauan
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN TINGKAT ORIENTASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1455 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data untuk menilai perhatian, pandangan, atau kecenderungan terhadap waktu, orang, tempat dan kejadian/situasi
TUJUAN	Kapasitas Adaptif Intrakranial Membaik, Perfusi Serebral Meningkat, Persepsi Sensori Membaik, Kontrol Diri Meningkat, Tingkat Konfusi Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Tanyakan tentang memori jangka panjang dan saat ini meliputi, siapa nama pasien, di mana pasien berada, tanggal berapa saat ini dan apa yang terjadi 8. Monitor tingkat orientasi: a. X1: Orientasi pada orang (mengenali nama dan orang terdekat)

	b. X2: Orientasi pada orang dan tempat (mengenali nama dan tempat) c. X3: Orientasi pada orang, tempat dan waktu (mengenali nama, tempat, tanggal dan/atau hari) d. X4: Orientasi pada orang, tempat, waktu dan situasi (mengenali nama, tempat, dan waktu serta situasi alasan mengapa pasien dirawat) 9. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 10. Dokumentasikan hasil pemantauan
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN PERUBAHAN SENSORIK**		
	No.Dokumen A007.A / 1956 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi kemampuan merasakan perubahan sensorik (suara, rasa, raba, aroma dan gambar visual)
TUJUAN	Persepsi Sensorik Membaik, Tingkat Cedera Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: 7. Lembar pemantauan perubahan sensasi a. Kartu snellen b. Lembar bacaan/koran c. Garpu tala d. Aroma rasa (seperti lemon, garam, gula) e. Benda tajam/tumpul f. Air panas/dingin 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN PERUBAHAN SENSORIK**		
	No.Dokumen A00.7.4 / 1456 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Periksa ketajaman visual dengan menggunakan bagan kartu Snellen atau bahan bacaan lainnya seperti koran, gambar, visual 10. Periksa ketajaman pendengaran dengan mengamati percakapan pasien dengan orang lain atau dengan melakukan tes bisikan atau tes garpu tala (Weber dan Rinne) 11. Periksa ketajaman penciuman dengan meminta pasien mengidentifikasi aroma tertentu (misalnya lemon, garam, gula) 12. Periksa ketajaman indra taktil dengan melakukan sentuhan ringan, sensasi tajam dan tumpul pada dua arah/ekstermitas, sensasi panas dan dingin, sensasi getaran, indra posisi dan stereognosis 13. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 14. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 15. Dokumentasikan hasil pemantauan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN PENAHAN GIGI SEBELUM ECT**		
	No.Dokumen 400.7.9/1957/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasang penahan gigi untuk melindungi gigi dan mulut akibat penekanan involunter saat prosedur ECT
TUJUAN	Keterlibatan Sosial Meningkat , Tingkat Cedera Menurun, Status Orietasi Membaik, Tingkat Jatuh Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Penahan gigi c. Tisu 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Pasang sarung tangan 9. Periksa mulut untuk mengidentifikasi masalah gigi, adanya gigi palsu alau penggunaan alat lain

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN PENAHAN GIGI SEBELUM ECT**		
	No.Dokumen A00.7.9/1957/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Lepaskan semua gigi palsu atau alat lain yang digunakan dalam mulut 11. Dokumentasikan status gigi dengan referensi hasil pemeriksaan (seperti gigi buruk, gigi longgar, rusak, implan gigi, mahkota, dan gigi palsu) 12. Pilih jenis penahan gigi yang sesuai 13. Siapkan penahan gigi (bite block) dengan prinsip bersih, sesuai indikasi 14. Lakukan jaw thrust maneuver dengan memastikan gigi bersentuhan dengan pelindung mulut saat tindakan ECT dilakukan 15. Lepaskan penahan gigi segera setelah rahang mulai mengendur 16. Buang penahan gigi (jika disposable) atau cuci bersih (jika reuse) 17. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 18. Lepaskan sarung tangan 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT TETES MATA**		
	No.Dokumen 400.7.9/1458/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan obat tetes pada mata untuk mencegah atau meminimalkan ancaman pada integritas jaringan mata dan fungsi visualnya
TUJUAN	Persepsi Sensori Membaik, Tingkat Infeksi Menurun, Tingkat Nyeri Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Obat tetes mata, sesuai program c. Tisu 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Monitor adanya kemerahan, eksudat, atau ulserasi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT TETES MATA**		
	No.Dokumen 400.7.9/1458/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Posisikan kepala condong ke belakang 10. Anjurkan pasien melirik ke atas 11. Tarik palfebra inferior ke bawah dengan jari telunjuk pada mata yang akan diberikan obat salep mata 12. Pegang botol tetes mata dengan menggunakan tangan lainnya sedekat mungkin dengan palfebra inferior mata tanpa menyetuhnya 13. Teteskan obat tetes mata sesuai program 14. Anjurkan mengedipkan mata agar obat merata 15. Bersihkan sisa obat di wajah dengan tisu 16. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 17. Lepaskan sarung tangan 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN KEJANG**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1459 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan menurunkan risiko terjadinya kontraksi otot dan gerakan yang tidak terkendali
TUJUAN	Termoregulasi Membaik, Perfusi Serebral Meningkat, Kapasitas Adaptif Intrakranial Meningkat, Tingkat Cedera Menurun, Tingkat Jatuh Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Rendahkan ketinggian tempat tidur 7. Pasang side-rail tempat tidur 8. Berikan alas empuk di bawah kepala, jika memungkinkan 9. Jauhkan benda-benda berbahaya terutama benda tajam 10. Sediakan suction di samping tempat tidur

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN KEJANG**		
	No.Dokumen 900.7.9 / 1459 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Anjurkan segera melapor jika merasakan aura 12. Anjurkan tidak berkendara 13. Ajarkan keluarga pertolongan pertama pada kejang 14. Berikan anti konvulsan, sesuai program 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien inflamasi, pengeluaran cairan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN ECT**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1209 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Persiapan ECT adalah tahapan prosedur yang dijalankan pada pasien sebagai persiapan untuk dilakukan tindakan ECT
TUJUAN	1. Meningkatkan mutu pelayanan 2. Terlaksananya keselamatan pasien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Penanggung jawab pasien memberikan persetujuan tindakan secara tertulis (*informed consent*). 2. Sebelum tindakan pasien diharuskan menjalani pemeriksaan penunjang : a. EKG b. Laboratorium (Darah rutin, GDS, SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, dan elektrolit (Na, K, Cl)). 3. Pasien diharuskan puasa tidak makan dan minum 6 jam sebelum tindakan. 4. Pasien didaftarkan ke ruang ECT untuk dijadwalkan tindakan ECT. 5. Gigi palsu dan lensa kontak harus dilepas sebelum tindakan ECT premedikasi dilakukan. a. Bagi pasien rawat inap, dilepas di ruang rawat inap. 6. Bagi pasien rawat jalan, dilepas di ruang tindakan.
UNIT TERKAIT	1. Psikiater 2. Dokter anestesi yang terlatih 3. Dokter umum 4. Instalasi Rawat Inap Psikiatri 5. Instalasi Laboratorium

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**STIMULASI KOGNITIF**		
	No.Dokumen 400.7.9/1460/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan menurunkan risiko terjadinya kontraksi otot dan gerakan yang tidak terkendali
TUJUAN	Keterlibatan Sosial Meningkat, Status Orientasi Membaik, Keterlibatan Sosial Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Periksa tanda-tanda vital, status mental, oksimetri nadi, dan EKG 7. Orientasikan waktu dan tempat pelaksanaan prosedur ECT 8. Berikan dukungan emosional, sesuai kebutuhan 9. Pastikan pasien telah puasa 10. Berikan pakaian yang longgar yang dapat dibuka dari depan 11. Lepaskan gigi palsu, perhiasan, kaca mata atau

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**STIMULASI KOGNITIF**		
	No.Dokumen 400.7.4/1960/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	lensa kontak, 12. Pastikan pasien telah berkemih 13. Sediakan alat pemantauan (EEG, EKG, oksimeter nadi, spigmomanometer) 14. Sediakan penahan gigi 15. Pasang pagar pengaman tempat tidur 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL YANG SEHAT DAN AMAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/ 1461/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi tentang seksualitas sesuai dengan tahapan siklus kehidupan wanita (hamil, pasca bersalin, dan menopause)
TUJUAN	Pola Seksual Membaik, Tingkat Pengetahuan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Periksa kesiapan dan kemampuan menerima informasi 8. Berikan informasi tentang kebutuhan seksual yang sehat dan aman

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL YANG SEHAT DAN AMAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1961/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

a. Masa kehamilan
   1) Identifikasi riwayat obstetric dan pola seksual selama kehamilan
   2) Informasikan posisi yang aman saat melakukan hubungan seksual sesuai dengan usia kehamilan, dan pastikan tidak ada penekanan pada daerah perut ibu
   3) Informasikan posisi yang aman saat melakukan hubungan seksual
      - Posisi wanita diatas
      - Posisi duduk
      - Posisi berlutut
      - Posisi menyamping
   4) Hindari penetrasi ketika keluar air ketuban
   5) Hindari rangsangan pada puting pada kehamilan berisiko

b. Pasca bersalin
   1) Identifikasi riwayat persalinan
   2) Informasikan tahapan pengeluaran lochea
   3) Informasikan kegiatan seksual dapat dilakukan setelah pengeluaran lochea alba (berwarna putih kekuningan yang banyak mengandung bakteri dan waktunya 14 hari pasca melahirkan sampai 40 hari)
   4) Hindari hubungan seksual jika ibu merasa nyeri dan tidak nyaman
   5) Hindari posisi wanita dibawah sehingga menekan luka operasi

c. Menopause

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL YANG SEHAT DAN AMAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1461/2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	1) Identifikasi kesiapan ibu menjelang menopause 2) Informasikan pengaruh hormonal terhadap libido dan organ reproduksi 3) Informasikan penggunaan pelumnas pada daerah vagina untuk meningkatkan kenyamanan 4) Anjurkan melakukan foreplay lebih lama untuk meningkatkan libido 5) Informasikan posisi yang bervariasi saat melakukan hubungan seksual 6) Hindari penggunaan sabun atau pembersih vagina 9. Dokumentasikan edukasi yang telah dilakukan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KONTRASEPSI**		
	No.Dokumen 400.7.9/1462/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi tentang jenis dan manfaat alat kontrasepsi
TUJUAN	Tingkat Pengetahuan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jaga privasi pasien 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Sediakan lingkungan yang kondusif 9. Jadwalkan edukasi sesuai kesepakatan 10. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 11. Identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KONTRASEPSI**		
	No.Dokumen 400.7.9/1962/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	pemakaian alat kontrasepsi 12. Diskusikan pertimbangan agama, budaya, perkembangan, sosial, ekonomi, terhadap pemilihan alat kontrasepsi 13. Berikan edukasi sesuai dengan jadwal yang disepakati (meliputi jenis, manfaat kelebihan dan kekurangan alat kontrasepsi) 14. Evaluasi pemahaman pasien tentang edukasi yang telah diberikan 15. Dokumentasikan edukasi yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PENCEGAHAN PERILAKU SEKSUAL BERESIKO**		
	No.Dokumen 400.7.4/1963/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi tentang upaya pencegahan perilaku seksual yang berisiko
TUJUAN	Tingkat Pengetahuan Meningkat, Perilaku Kesehatan Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jadwalkan edukasi sesuai kesepakatan 8. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 9. Identifikasi pengetahuan tentang perilaku seksual

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PENCEGAHAN PERILAKU SEKSUAL BERESIKO**		
	No.Dokumen 400.7.4/1463/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	berisiko 10. Berikan edukasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati (meliputi aktivitas seksual yang menimbulkan risiko, dampak perilaku seksual berisiko, dan pencegahan perilaku seksual berisiko) 11. Evaluasi pasien tentang edukasi yang telah diberikan 12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PENDAMPING PERSALINAN**		
	No.Dokumen 400.7.9/1464/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi kepada pendamping atau orang terdekat agar memberikan dukungan selama persalinan
TUJUAN	Tingkat Pengetahuan Meningkat, Tingkat Ansietas Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jadalkan edukasi sesuai kesepakatan 8. Identifikasi kesiapan pendamping persalinan menerima informasi 9. Berikan informasi kepada pendamping persalinan berupa:

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PENDAMPING PERSALINAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1464/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	a. Bersikap respek dan empati saat mendampingi Ibu b. Mendengarkan dan berespon cepat terhadap keluhan Ibu 10. Berada di samping Ibu selama proses persalinan 11. Membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti memberi minum, makan teknik relaksasi dan distraksi 12. Evaluasi pemahaman pendamping persalinan tentang edukasi yang telah diberikan 13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PERAWATAN KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1465/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi dalam mengoptimalkan kemampuan beradaptasi secara fisik dan psikologis selama periode kehamilan
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan menurunkan tingkat cidera
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jadwalkan edukasi sesuai kesepakatan 8. Identifikasi pengetahuan tentang perawatan kehamilan 9. Berikan edukasi sesuai dengan yang sudah disepakati:

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PERAWATAN KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1965/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	a. Perubahan fisik dan psikologis masa kehamilan b. Perkembangan janin c. Ketidaknyamanan selama kehamilan d. Kebutuhan nutrisi kehamilan e. Seksualitas masa kehamilan f. Kebutuhan aktivitas dan istirahat g. Tanda bahaya kehamilan h. Adaptasi siblings i. Persiapan persalinan j. Sistem dukungan selama kehamilan k. Manajemen nyeri persalinan l. Cara perawatan bayi 10. Anjurkan untuk rutin memeriksakan kehamilannya sesuai jadwal 11. Evaluasi pemahaman pasien tentang edukasi yang telah diberikan 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 13. Dokumentasikan edukasi yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PERAWATAN PERINEUM PASCA PERSALINAN SEKSUALITAS**		
	No.Dokumen 900.7.9/1914/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi cara melakukan perawatan perineum setelah persalinan
TUJUAN	Sebagai acuan penerpan langkah - langkah untuk memberikan informasi cara melakukan perawatan perineum setelah persalinan
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jadwalkan edukasi sesuai kesepakatan 8. Identifikasi pengetahuan tentang perawatan perineum 9. Jelaskan prosedur perineal hygiene yang benar 10. Anjurkan selalu menjaga area genital agar tidak lembab

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">EDUKASI PERAWATAN PERINEUM PASCA PERSALINAN SEKSUALITAS</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.9/1714/
2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">11. Anjurkan menggunakan air bersih saat membilas area genitalia
12. Anjurkan membersihkan area genitalia dari arah depan ke belakang
13. Anjurkan memakai pakaian dalam yang bersih
14. Anjurkan mengganti pembalut setelah BAK atau ketika pembalut penuh
15. Ajarkan menilai perdarahan pascasalin abnormal
16. Ajarkan penggunaan pembalut yang tepat
17. Evaluasi pemahaman pasien tentang edukasi yang telah diberikan
18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
19. Dokumentasikan edukasi yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat darurat</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PERSIAPAN PROGRAM IVF (IN VITRO FERTILITATION)**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1715 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan penjelasan kepada pasien dan suami tentang prosedur program in Veitro Fertilitation (IVF) dengan metode konsepsi yang meningkatkan peluang kehamilan dengan menempatkan sel telur yang dibuahi atau sel telur langsung ke uterus atau rahim
TUJUAN	Sebagai acuan langkah - langkah untuk meningkatkan pengetahuan peluang kehamilan
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Pastikan bahwa pasien dan pasangan sudah melengkapi administrasi, antara lain: a. Formulir persetujuan program IVF sudah ditandatangani b. Fotokopi KTP suami dan istri yang sudah dibandingkan dengan yang asli sebelumnya c. Fotokopi Kartu Keluarga yang sudah dibandingkan dengan yang asli sebelumnya

d. Fotokopi buku nikah atau sertifikat nikah dibandingkan dengan yang asli sebelumnya
e. Pasfoto suami-istri

7. Jelaskan bahwa pasien dan pasangan akan melewatkan 5 tahap, yaitu:
   a. Konsultasi medis, dimana pada tahap ini pasien diminta datang saat menstruasi pada hari ke-2 (dua) atau ke-3 (tiga) untuk dilakukan USG transvaginal, risiko dan presentasi kehamilan, skrining laboratorium pasangan suami dan istri
   b. Stimulasi ovarium, yaitu pemberian obat hormonal akan diberikan sesu dengan program medis dengan minimal 8 kali suntik dan maksimal sesuai dengan respons ovarium terhadap obat, setelah dipastikan bahwa hasi skrining suami dan istri normal. Periode ini dimulai pada menstruasi hari ke 2
   c. Pemilihan sel telur yang akan dilakukan oleh tim embriologi
   d. Inseminasi, yaitu sperma dan sel telur diinkubasi yang memungkinkan pembuahan terjadi. Pasien dan suaminya akan diinformasikan setelah ditemukan adanya pembuahan
   e. Transfer embrio, yaitu pemindahan embrio ke dalam rahim setelah ditemukan adanya pembuahan pada saat menstruasi hari ke-2, ke-3 atau ke-5
8. Jelaskan bahwa pada menstruasi hari ke-6, pasien akan menjalani:
   a. Konsultasi dokter
   b. Persiapan Ovum Pick Out (OPU)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PERSIAPAN PROGRAM IVF (IN VITRO FERTILITATION)**		
	No.Dokumen 400.7.4/1715/2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	c. USG transvaginal 9. Jelaskan bahwa pada menstruasi hari ke-10, pasien akan menjalani: a. Konsultasi dokter b. USG transvaginal c. Konsultasi Dokter Anestesi d. Suntik trigger e. Pemeriksaan laboratorium: E2, P4 10. Jelaskan bahwa pada menstruasi hari ke-12 pasien akan menjalani tindakan OPU sedangkan suami diminta untuk mengeluarkan sperma di ruangan masturbasi 11. Jelaskan bahwa pada menstruasi hari ke-15 atau ke-17 pasien akan dilakukan Embryo Transfer (ET) 12. Evaluasi pemahaman pasien dan suami terkait edukasi yang diberikan 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan edukasi yang telah diberikan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PPIA (PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1716 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi untuk mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu kepada anak
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk meningkatkan pengetahuan, menurunkan tingkat cidera
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jadwalkan edukasi sesuai kesepakatan 8. Siapkan ruangan dan alat bantu yang bisa menjaga kerahasiaan dan memberikan rasa aman bagi PUS (pasangan usia subur) 9. Sediakan ruangan yang tertutup dan terhindar dari kebisingan 10. Berikan kesempatan pada PUS untuk

menyampaikan masalah kesehatan dengan pertanyaan terbuka, seperti: "Apakah ada sesuatu tentang pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak?"

11. Identifikasi perencanaan kehamilan dan pengobatan HIV
12. Anjurkan ibu mengkonsumsi obat antiretroviral (ARV) teratur dan pengguna alat kontasepsi (kondom) untuk mencegah kehamilan
13. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi ARV sebelum kehamilan untuk menurunka viral load
14. Anjurkan ibu untuk meneruskan ARV jika ibu hamil
15. Hindari kontrasepsi hormonal yang dapat mengurangi efektifitas ARV
16. Anjurkan menggunakan Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), jika risiko infeksi menular seksual (IMS) rendah dan pasangan tidak berisiko
17. Anjurkan ibu mengkonsumasi ARV mulai dari 14 minggu kehamilan, jika terjadi mual dan muntah
18. Anjurkan PUS tetap menggunakan kondom jika berhubungan seksual karena bersifat dual protection
19. Anjurkan PUS hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat untuk menghindari infeksi pada janin
20. Anjurkan ibu menjelang persalinan melakukan pemeriksaan Viral Load untuk menentukan jenis persalinan yang akan dipilih oleh PUS
21. Ajarkan ibu tentang cara memilih makanan untuk bayinya
22. Anjurkan ibu mentaati AFASS (Aceptable, Feasible, Affordable, Suistaintable and Safe) saat ibu

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">EDUKASI PPIA (PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK)</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.9/1716/2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">memutuskan untuk pemberian susu formula
23. Anjurkan ibu memberikan ASI selama 3 bulan tanpa disertai puting lecet ata ASI perah dengan metode pasteurisasi
24. Rujuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mendapatkan dukunga dan bimbingan yang lebih komprehensif, jika perlu
25. Evaluasi pemahaman pasien tentang edukasi yang telah diberikan
26. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
27. Dokumentasikan edukasi yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat darurat</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PRAKONSEPSI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1717 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan pada pasangan subur (PUS) sebelum terjadinya kehamilan
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah- langkah untuk meningkatkan pengetahuan, memperbaiki peran menjadi orang tua
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jadwalkan edukasi sesuai kesepakatan 8. Identifikasi kebutuhan edukasi prakonsepsi 9. Siapkan ruangan dan alat bantu yang bisa menjaga kerahasiaan dar memberikan rasa aman bagi PUS (pasangan usia subur)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PRAKONSEPSI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1717 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Sediakan ruangan yang tertutup dan terhindar dari kebisingan 11. Berikan penjelasan pentinganya preconseption care yang dapat dilakukan dalam rentang 100 hari (3 bulan) sampai dengan 1 tahun sebelum konsepsi 12. Anjurkan ibu mempertimbangkan untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi hormonal 3 bulan sebelum konsepsi 13. Anjurkan ibu mempertimbangkan untuk melepas AKDR 3 bulan sebelum konsepsi 14. Anjurkan PUS untuk menghindari konsumsi alkohol, merokok, dan kopi (lebih dari 3 gelas dalam 1 hari) 15. Anjurkan ibu menjaga IMT 19-23 kg/m² sebelum kehamilan 16. Anjurkan ibu berolahraga teratur, periksa gigi, monitor siklus menstruasi dan istirahat yang cukup 17. Anjurkan ibu mengkomsumsi asam folat 0,4 mg per hari selama 100 hari sampai dengan 1 tahun sebelum konsepsi 18. Anjurkan mengkonsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan dan buah-buahan 19. Evaluasi pemahaman pasien tentang edukasi yang telah diberikan 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan edukasi yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI TANDA BAHAYA PASCA PERSALINAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1718 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi tentang tanda bahaya yang harus menjadi perhatian setelah ibu menjalani persalinan
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk meningkatkan pengetahuan
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jadwalkan edukasi sesuai kesepakatan 8. Identifikasi kebutuhan edukasi tanda bahaya pascasalin 9. Ajarkan menilai perdarahan pascasalin abnormal (jenis lochea, wama, dan Jumlah) 10. Monitor tanda-tanda vital tiap 4 jam (setelah 2 jam persalinan) dan tiap 8 jam pada hari berikutnya

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI TANDA BAHAYA PASCA PERSALINAN**		
	No.Dokumen 400.7.9/1718/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	sampai dengan pulang 11. Anjurkan menyusui sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya perdarahan 12. Ajarkan gejala eklampsi pascasalin (seperti pandangan kabur, nyeri kepala hebat, dan nyeri epigastrium) 13. Anjurkan melakukan masase uterus dengan lembut, jika terjadi perdarahan 14. Ajarkan teknik relaksasi untuk menurunkan stres 15. Anjurkan mobilisasi dini untuk mencegah thromboflebitis dan edema 16. Evaluasi pemahaman pasien tentang edukasi yang telah diberikan 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan edukasi yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI INISIASI MENYUSU DINI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1719 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan dukungan proses menyusui segera setelah lahir selama 1 jam menyusu sampai selesai
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk memperbaiki status menyusui, memperbaiki peran menjadi orang tua
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Termometer c. Handuk kecil d. Selimut e. Penutup kepala bayi 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Periksa tanda-tanda vital bayi dan Ibu 9. Periksa kepatenan jalan napas bayi 10. Buka pakaian bagian atas ibu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI INISIASI MENYUSU DINI**		
	No.Dokumen 400.7.9 /1919/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

11. Keringkan tubuh bayi dengan handuk, kecuali bagian tangan yang akan menuntun bayi untuk mencari puting
12. Letakkan bayi dengan posisi tengkurap untuk kontak kulit ke kulit di antara dua payudara dan kepala bayi dimiringkan ke salah satu sisi
13. Berikan selimut pada punggung dan pasangkan penutup kepala bayi
14. Anjurkan ibu untuk membiarkan bayi menemukan puting dan mulai menyusu
15. Anjurkan ibu dan orang lainnya untuk tidak menginterupsi proses menyusu (seperti memindahkan bayi dari satu payudara ke payudara lainnya)
16. Biarkan bayi menemukan puting dalam waktu 30-60 menit dan biarkan kontal kulit ibu dan bayi minimal 1 jam, walaupun bayi sudah menemukan putting kurang dari 1 jam atau menyusu sampai selesai
17. Tunda semua asuhan bayi baru lahir normal lainnya sampai bayi selesai menyusu setidaknya 1 jam atau lebih, jika bayi menemukan puting setelah 1 jam
18. Usahakan ibu dan bayi dipindahkan bersama setelah mendapat perawatan di jam ruang bersalin dengan mempertahankan kontak kulit ibu dan bayi
19. Posisikan bayi lebih dekat dengan puting ibu dan biarkan kontak kulit dengan kulit selama 30-60 menit berikutnya, jika bayi belum menemukan puting dalam 1 jam
20. Pindahkan ibu ke ruang pemulihan dengan bayi tetap di dada ibu, jika bayi masih belum menemukan puting ibu dalam waktu 2 jam

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI INISIASI MENYUSU DINI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1719 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	21. Berikan asuhan neonatus esensial (seperti menimbang, pemberian vitamin K- 1, salep mata) dan kemudian kembalikan bayi kepada ibu untuk menyusu 22. Monitor proses IMD setiap 15 menit 23. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 24. Lepaskan sarung tangan 25. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 26. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI INTERAKSI ORANG TUA DAN BAYI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1920/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan bayinya
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah- langkah untuk meningkatkan proses perlekatan, memperbaiki proses pengasuhan, memperbaiki peran menjadi orang tua, meningkatkan tingkat pengetahuan
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi riwayat kesehatan saat ini dan riwayat kehamilan serta persalinan sebelumnya 7. Identifikasi tingkat pengetahuan dan kemampuan tentang interaksi orang tua dan bayi 8. Jelaskan tujuan dan manfaat interaksi orangtua dan bayi 9. Berikan kesempatan ibu mengenali kesehatan emosionalnya, tanggap terhadap kebutuhan bayi, mampu mengidentifikasi kebutuhan bayi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI INTERAKSI ORANG TUA DAN BAYI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1720 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Evaluasi kemampuan Ibu melakukan interaksi dengan bayi 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan danrespon pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI INTERAKSI ORANG TUA DAN JANIN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1721 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan bayinya
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk memperbaiki proses pengasuhan, memperbaiki peran menjadi orang tua, meningkatkan pengetahuan
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Identifikasi status kehamilan (meliputi riwayat, adaptasi kehamilan, usia kehamilan) 6. Identifikasi pengetahuan, penerimaan, dan harapan pasien serta dukungan suami/keluarga terhadap kehamilan interaksi orang tua dengan janin 7. Berikan rasa nyaman saat memfasilitasi 8. Bina hubungan terapeutik dengan orang tua 9. Buat tujuan dan jadwal interaksi orang tua dan janin 10. Libatkan suami setiap kali interaksi 11. Latih interaksi trimester I a. Stimulasi gizi terkait dengan tumbuh kembang

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI INTERAKSI ORANG TUA DAN JANIN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1721 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

janin

b. Konsumsi sumber makanan (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, asam folat)
c. Makan buah-buahan dan sayuran berwarna hijau gelap (seperti sawi dan brokoli)

12. Latih interaksi trimester II
    a. Stimulasi suara
        - Ajak janin bicara setiap hari Perdengarkan suara ayah
        - Berbicaralah tentang apa saja
        - Memperdengarkan musik
        - Membacakan buku cerita, mendendangkan lagu, atau membacakan kitab suci atau doa-doa untuk kebaikan janin
    b. Stimulasi sentuhan
        - Anjurkan ibu mengusap-usap perutnya, ketika melakukan stimulasi suara
        - Sentuh dengan cara melingkar menggunakan jari dan telapak tangan terbuka dengan sedikit tekanan
        - Menepuk perut ibu dengan lembut
    c. Stimulasi cahaya
        - Mengarahkan cahaya senter ke perut ibu
        - Nyalakan dan mematikan lampu dalam hitungan detik dan jeda yang teratur
13. Latih interaksi trimester III dengan stimulasi suara pada minggu-minggu menjelang bersalin, berisi pernyataan positif, bahwa nanti dapat melewati proses persalinan dengan lancar dan selamat
14. Berikan dukungan interaksi orang tua dan janin
15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI INTERAKSI ORANG TUA DAN JANIN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1921 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI KENYAMANAN IBU PASCA PERSALINAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1722 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan kenyamanan setelah ibu melahirkan secara sectio caesaria dan pervaginam
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk meningkatkan status kenyamanan pascapartum, menurunkan tingkat nyeri
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan, jika perlu b. Gurita c. Pakaian ibu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan 8. Anjurkan mobilisasi dini 6-12 jam setelah SC atau 4 jam setelah melahirkan per vaginam 9. Ajarkan teknik relaksasi dengan napas dalam 10. Anjurkan menyusui sesegera mungkin 11. Ajarkan posisi dan perlekatan menyusui

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FASILITASI KENYAMANAN IBU PASCA PERSALINAN**		
	No.Dokumen A00.7.4 / 1922 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Anjurkan duduk di kursi yang datar agar posisi jahitan episiotomi terlindungi dengan melakukan latihan otot panggul 13. Identifikasi tanda-tanda depresi pascasalin 14. Fasilitasi memasang gurita, simpul tali ada di sebelah kanan atau kiri 15. Anjurkan menggunakan pakaian yang nyaman 16. Anjurkan turun dari tempat tidur secara bertahap 17. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 18. Lepaskan sarung tangan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IDENTIFIKASI KEMAMPUAN IBU MERAWAT BAYI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1723 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi kemampuan ibu dalam melakukan perawatan kesehatan bayi
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk memperbaiki proses pengasuhan, memperbaiki peran menjadi orang tua
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Perlengkapan mandi bayi c. Set perawatan tali pusat d. Pakaian bayi 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi kemampuan ibu melakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Identifikasi kemampuan ibu dalam: a. Menilai kondisi umum bayi b. Memandikan bayi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IDENTIFIKASI KEMAMPUAN IBU MERAWAT BAYI**		
	No.Dokumen 900.7.9/1723/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	c. Merawat tali pusat d. Memasangkan dan melepas popok e. Melakukan pemijatan bayi f. Memasangkan pakaian bayi 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IDENTIFIKASI PSIKOSOSIAL IBU BERSALIN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1729 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menilai keadaan psikologis dan sosial ibu menjelang persalinan
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk memperbaiki status intrapartum
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Alat tulis b. Format penilaian psikososial ibu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi riwayat psikososial ibu 8. Identifikasi pengetahuan ibu tentang persalinan 9. Identifikasi ekspresi dan respons ibu terhadap perubahan inpartu 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IDENTIFIKASI PSIKOSOSIAL IBU BERSALIN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1729 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PERSALINAN RISIKO TINGGI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1939 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat ibu bersalin yang berisiko dengan tindakan.
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, tingkat ansietas menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan, yang diperlukan a. Sarung tangan, jika perlu b. Doppler BJF c. Spigmomanometer d. Stetoskop e. Jam dan pengukur waktu f. Jell g. Tisu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi faktor risiko persalinan risiko tinggi 8. Identifikasi riwayat obstetrik pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PERSALINAN RISIKO TINGGI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1934/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Identifikasi kondisi umum pasien 10. Dampingi ibu saat merasa cemas 11. Diskusikan persiapan persalinan dan kelahiran 12. Jelaskan risiko janin mengalami kelahiran prematur 13. Monitor tanda-tanda vital pasien 14. Monitor kelainan tanda vital pada ibu dan janin 15. Monitor tanda-tanda persalinan 16. Monitor denyut jantung janin secara periodik 17. Monitor adanya perdarahan intranatal 18. Siapkan kemungkinan dilakukan intervensi persalinan 19. Kolaborasi dengan tim untuk tatalaksana kegawatan ibu dan janin 20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IDENTIFIKASI RIWAYAT KEHAMILAN DAN PERSALINAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1926 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menilai riwayat kehamilan dan persalinan untuk mendeteksi adanya potensial masalah yang akan terjadi selama kehamilan dan persalinan saat ini
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk menurunkan tingkat cedera, meningkatkan pengetahuan
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Alat tulis b. Format pengkajian antenatal 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi kesiapan ibu untuk wawancara 8. Identifikasi pengetahuan ibu tentang kehamilannya 9. Identifikasi pengetahuan ibu tentang perawatan masa kehamilan 10. Identifikasi status kehamilan (GPA) 11. Identifikasi kelainan atau komplikasi kehamilan dan persalinan sebelumnya

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IDENTIFIKASI RIWAYAT KEHAMILAN DAN PERSALINAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1926 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Identifikasi tindakan yang dilakukan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan sebelumnya 13. Identifikasi jumlah dan tempat pelayanan kehamilan dan persalinan sebelumnya 14. Identifikasi suplemen dan status gizi kehamilan dan persalinan sebelumnya 15. Identifikasi kondisi janin dan bayi/anak yang telah dilahirkan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING GENETIK**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1727 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan bimbingan pada orang tua mengenai kemungkinan kelainan genetik
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk meningkatkan pengetahuan
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi pengetahuan, persepsi dan mispersepsi tentang cacat lahir ata kondisi genetik 8. Identifikasi respons saat mengetahui faktor risiko genetik 9. Berikan privasi dan jamin kerahasiaan 10. Bina hubungan terapeutik atas dasar kepercayaan dan rasa hormat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING GENETIK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1727 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Buat tujuan dan jadwal sesi konseling genetik 12. Berikan dukungan pengambilan keputusan 13. Berikan ringkasan sesi konseling genetik yang telah dilakukan 14. Jelaskan perkiraan risiko berdasarkan fenotip (pasien karakteristik), riwayat keluarga (analisis silsilah), genotip (hasil pengujian genetik) 15. Jelaskan riwayat penyakit, strategi penanganan dan strategi pencegahan 16. Jelaskan pilihan pengobatan atau manajemen dan pilihan penanganan risiko frekurensi 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan hasil konseling dan respons pasien 19. Rujuk ke spesialis, jika perlu deteksi atau tindakan kelainan genetik		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1728 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan bimbingan pada ibu hamil dan suami mengenai perubahan kehamilan beradaptasi dengan perubahan dan tindakan dalam mengatasi keluhan kehamilan
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk menurunkan tingkat cedera, memperbaiki status antepartum, meningkatkan pengetahuan
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Media b. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi pengetahuan, penerimaan, dan harapan pasien serta dukungan suami/keluarga terhadap kehamilan 8. Identifikasi adaptasi terhadap kehamilan dan keluhan selama kehamilan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1728 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Berikan rasa nyaman saat konseling 10. Bina hubungan terapeutik terhadap pasien 11. Buat tujuan dan jadwal sesi konseling kehamilan 12. Berikan dukungan pengambilan keputusan 13. Berikan ringkasan dari sesi konseling kehamilan yang telah dilakukan 14. Jelaskan peyebab perubahan fisik dan psikologis kehamilan 15. Jelaskan tindakan pencegahan atau mengatasi keluhan klien 16. Jelaskan pilihan pencarian bantuan dan kontrol kehamilan 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan hasil konseling dan respons pasien 19. Rujuk ke spesialis, jika perlu deteksi atau tindakan lebih lanjut		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING PENGANIAYAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1729 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan nasihat dan/atau anjuran untuk menemukan jalan keluar dari peristiwa penganiayaan dan pelecehan seksual
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk meningkatkan ketahanan personal, harapan dan keberdayaan
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi dan media konseling b. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi keterlibatan keluarga: a. Libatkan keluarga dalam memberikan dukungan pada pasien b. Fasilitasi keluarga untuk memberikan dukungan pada pasien 8. Bangun hubungan konseling yang melibatkan pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING PENGANIAYAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1729 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Perjelas dan definisikan masalah 10. Diskusikan kontrak interaksi dengan pasien 11. Identifikasi masalah dan kebutuhan pasien 12. Fasilitasi pasien memperoleh perspektif atau alternatif baru yang mungkin berbeda dengan sebelumnya dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan 13. Pertahankan hubungan konseling selalu terpelihara 14. Pertahankan proses konseling berjalan sesuai kontrak 15. Jelaskan bentuk pelecehan seksual a. Bentuk verbal: tatapan yang nafsu, tatapan yang mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual b. Bentuk verbal: siulan, gosip, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam c. Bentuk fisik: sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan hasil konseling dan respons pasien 18. Rujuk ke spesialis, jika perlu deteksi atau tindakan lebih lanjut		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING PRAKONSEPSI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1730 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi, petunjuk dan bantuan dalam pengambilan keputusan pada pasangan usia subur (PUS) sebelum terjadinya kehamilan
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan menjadi orang tua
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi dan media konseling b. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Berikan kesempatan untuk menyampaikan masalah prakonsepsi, dengan pertanyaan terbuka (seperti Apakah ada sesuatu tentang kesehatan prakonsepsi [sebelum kehamilan) anda yang ingin anda diskusikan?") 8. Identifikasi riwayat reproduksi dan upaya konsepsi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING PRAKONSEPSI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1730 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

sebelumnya (seperti adakah infertilitas, hasil akhir kehamilan yang tidak normal, keguguran kehamilan ektopik atau kematian janin berulang)

9. Identifikasi beberapa pajanan yang mungkin dapat mempengaruhi fertillas (seperti usia ibu, konsumsi alkohol dan rokok, pajanan bakteri/virus, logam berat zat kimia, pestisida atau air tercemar, olahraga, makanan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga)
10. Identifikasi riwayat penyakit medis pada PUS yang dapat mempengaruhi fertiltas
11. Tawarkan informasi yang sesuai dengan masalah prakonsepsi, termasuk kemungkinan penyebab masalahnya setelah PUS dapat mengidentifikasi dan menyampaikan masalah prakonsepsinya
12. Jelaskan dan sepakati tentang perencanaan dan tujuan sesi konseling untuk mengatasi masalah bersama
13. Hormati pilihan dan keputusan yang diambil
14. Jelaskan pentingnya saling mendukung kepada PUS
15. Jelaskan penyiapan lingkungan yang optimal bagi perkembangan calon janin
16. Informasikan akses pemeriksaan medis dan laboratorium yang diperlukan
17. Jelaskan upaya-upaya untuk mengatasi masalah, dan alternatif lain jika saran bdak menyelesaikan masalah
18. Akhiri sesi konseling dengan menyampaikan perkembangan penyelesaian masalah prakonsepsi pasiendan rencana tindak lanjut
19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah pasien
20. Dokumentasikan hasil konseling dan respons
21. Rujuk ke pelayanan spesialis, untuk mendapatkan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING PRAKONSEPSI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1730 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	dukungan dan bimbingan yang lebih komprehensif, jika perlu		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING SEKSUALITAS**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1731 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi, petunjuk dan bantuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah seksual.
TUJUAN	Fungsi seksual Membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Materi dan media konseling b. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Berikan kesempatan untuk menyampaikan masalah kesehatan seksual yang dialami dengan pertanyaan terbuka (seperti "Apakah ada sesuatu tentang kesehatan seksual anda yang ingin anda diskusikan?") 8. Identifikasi perilaku seksual yang menyimpang

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONSELING SEKSUALITAS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1731 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Tawarkan informasi yang sesuai dengan masalah seksual (termas kemungkinan penyebab masalahnya setelah pasien dapat mengidentifikasi menyampaikan masalah seksualnya. 10. Jelaskan dan sepakati masalah dan tujuam sesi konseling untuk mengatasi Masalah seksual 11. Jelaskan upaya-upaya mengatasi masalah dan alternatif jika saran tidak menyelesaikan masalah 12. Hormati pilihan dan keputusan pasien 13. Akhiri sesi konseling dengan menyampaikan perkembangan penyelesaian masalah seksual dan rencana tindak lanjut 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan hasil konseling dan respons pasien 16. Rujuk ke pelayanan spesialis, untuk mendapatkan dukungan dan bimbinga yang lebih komprehensif, jika perlu		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN SENAM HAMIL**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1932 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan stimulasi peningkatan kesehatan, kenyamanan dan relaksasi melalui serangkaian teknik napas dan gerakan-gerakan tertentu yang berfokus pada otot-otot inti yang efektif dalam kehamilan dan persiapan persalinan.
TUJUAN	Tingkat cidera menurun, status kenyamanan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Ruangan yang representative b. Matras c. Pengeras suara d. Music jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi usia kehamilan dan kondisi fisik ibu hamil 8. Identifikasi toleransi terhadap Latihan 9. Identifikasi jenis latihan dan gerakan senam yang

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN SENAM HAMIL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1732 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

dibutuhkan sesuai usia kehamilan

10. Ukur tanda-tanda vital dan DJJ
11. Latih ibu melakukan gerakan senam
12. Atur frekuensi melakukan senam hamil, sesuai kemampuan ibu
13. Lakukan teknik pemanasan
    a. Duduk dengan kedua lutut ditekuk ke dalam dan tangan berada di atas paha
    b. Gerakkan leher ke belakang-depan, menoleh kiri-kanan dan memutar leher masing-masing 8 kali hitungan
    c. Putar sendi bahu siku dan pergelangan tangan masing-masing 8 kali hitungan
    d. d. Gerakkan tubuh ke samping dan putar ringan masing-masing 8 kali hitungan
    e. Luruskan kaki dan renggangkan panggul
    f. Rentangkan lutut dan putar pergelangan kaki 8 kali hitungan
    g. Rentangkan jari-jari kaki selama 15-30 detik
14. Duduk tegak dengan kaki bersila
15. Tarik napas, rentangkan tangan kiri ke atas, buang napas, tekuk siku kini dan letakkan telapak tangan kiri pada punggung di antara kedua belikat
16. Letakkan telapak tangan pada siku kiri, tarik napas, panjangkan tulang punggung, buang napas, tarik siku kiri ke arah kanan selama 15 detik
17. Duduk dengan kedua lutut ditekuk, telapak kaki ditempelkan dan letakkan kedua tangan pada lutut
18. Condongkan tubuh ke depan namun jaga agar tidak membungkuk

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN SENAM HAMIL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1732 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	19. Gerakkan tubuh berputar secara perlahan membuat lingkaran besar sebanyak 5-10 putaran lalu ganti arah 20. Luruskan kaki dan gerak-gerakkan otot kaki 21. Lakukan postur beristirahat miring a. Posisi tidur miring ke samping kiri b. Tekuk lutut kanan dan sangga lutut dengan bantal serta biarkan kaki kiri lurus c. Istirahatkan kepala posisi miring ke kiri dan sangga dengan bantal d. Letakkan tangan kanan di atas perut dan lengan kini di alas sambil melakukan napas dalam 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN SENAM NIFAS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1733 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan latihan fisik pada masa pascasalin untuk mengembalikan kondisi kesehatan dan pemulihan
TUJUAN	Status kenyamanan pascapartum meningkat, tingkat pengetahuan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Ruangan yang representatif b. Matras c. Pengeras suara, jika perlu d. Musik, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi pengetahuan dan kemampuan ibu melakukan senam nifas 8. Anjurkan menggunakan pakaian yang nyaman 9. Ajarkan gerakan senam nifas secara bertahap mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 setelah melahirkan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**LATIHAN SENAM NIFAS**		
	No.Dokumen 400.7.9/1733/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Ajarkan melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan melakukan latihan pernapasan 11. Ajarkan mengecek denyut nadi sebelum melakukan 12. Monitor kondisi pasien selama menjalankan senam 13. Anjurkan melakukan senam sesuai dengan toleransi 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PELAKSANAAN MTBS-MTBM**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1734 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melaksanakan upaya pendekatan yang terintegrasi /terpadu dalam tatalaksana balita sakit usia 0-59 bulan
TUJUAN	Tingkat pengetahuan meningkat, eliminasi fekal membaik, status cairan membaik, termoregulasi membaik, termoregulasi neonatus, membaik, tingkat infeksi menurun, status nutrisi membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Buku bagan MTBS-MTBM b. Formulir pencatatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) atau MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) c. Alat tulis d. Termometer e. Timbangan

f. Kebutuhan lain sesuai yang tercantum dalam buku bagan MTBS-MTBM

6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
7. Lakukan anamnesa terkait kondisi bayi/balita(meliputi keluhan utama, lama sakit, pengobatan yang diberikan, dan riwayat penyakit lainnya)
8. Lakukan pemeriksaan dengan menggunakan formulir yang sesuai dengan usia anak
   a. Bayi 1 hari 2 bulan (MTBM): Periksa kemungkinan kejang, ganggua napas, demam, adanya infeksi, ikterik neonatus, diare, status HIV, berat badan rendah, masalah pemberian ASI/minum, status vitamin K, status imunisasi, masalah atau keluhan lain serta masalah/keluhan ibu
   b. 2 bulan-5 tahun (MTBS): Tanda bahaya umum, batuk dan sukar bernapas, diare, derajat dehidrasi, demam, periksa telinga, status gizi, anemia, status HIV, status imunisasi, vitamin A, masalah atau keluhan lain dan penilaian pemberian makan
9. Catat hasil anamnesa, pemeriksaan, klasifikasi dan tindakan/pengobatan
10. Berikan pengobatan sesuai klasifikasi dan pedoman di buku MTBS atau MTBM
11. Rujuk ke ruang pengobatan atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut
12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
13. Dokumentasi hasil pemeriksaan yang didapatkan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PELAKSANAAN MTBS-MTBM**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1739 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN KARDIOTOGRAFI (CTG)**		
	No.Dokumen 400.7.9/1735/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan pemeriksaan detak jantung janin pada ibu hamil dengan menggunakan mesin kardiotokografi (CTG)
TUJUAN	Tingkat cidera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Alat tulis (Pulpen/pensil dan kertas) b. Mesin CTG c. Doppler d. Jeli e. Tisu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Atur posisi pasien dengan posisi semi Fowler atau miring ke sisi kiri pasien 8. Buka pakaian khususnya pada bagian yang akan dilakukan pemeriksaan (bagian perut)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN KARDIOTOGRAFI (CTG)**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1735 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Lakukan palpasi abdomen (Leopold 2) untuk mencari punggung janin dan menentukan punctum maximum (DJJ yang paling jelas terdengar) 10. Dengarkan DJJ dengan dopler 11. Pasang Probe Cardio yang telah diberi jeli pada bayangan bulat, kemudian letakkan pada punctum maximum 12. Pasang Probe Toco pada fundus uteri 13. Ikat dengan tali pengikat khusus (ikatan probe tidak terlalu kuat atau longgar) 14. Berikan knop gerak janin pada pasien dan anjurkan untuk menekan knop tersebut setiap merasakan gerakan janin 15. Lakukan perekaman CTG 16. Perhatikan gambaran DJJ (grafik rekaman, irama jantung janin) selama perekaman berlangsung 17. Identifikasi tanda gawat janin (seperti DJJ lebih dari 160 kali/menit, kurang dari 120 kali/menit, dan gerakan janin berkurang) 18. Dokumentaskan hasil pemeriksaan CTG		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN GERAK JANIN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1736 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan pemeriksaan frekuensi gerakan janin dimulai usia kehamilan 28 minggu
TUJUAN	Tingkat Cidera Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Alat tulis (pulpen/pensil dan kertas) b. Formulir pemantauan gerak janin c. Jam atau penunjuk waktu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Anjurkan posisi nyaman miring kiri 8. Anjurkan ibu mencatat waktu pada saat merasakan gerakan janin 9. Lakukan penghitungan frekuensi gerakan janin (minimal terdapat 10 kali gerakan dalam 12 jam) 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN GERAK JANIN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1736 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Dokumentasikan hasil pemantauan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN INFUS TOKOLISIS**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1937 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengobservasi terapi melalui infus untuk menurunkan, mencegah atau menghentikan kontraksi uterus
TUJUAN	Tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Alat tulis b. Formulir pemantauan c. Jam atau pengukur waktu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi riwayat penyakit kardiovaskuler dan metabolik 8. Identifikasi kontraindikasi penggunaan obat 9. Monitor respons dan efek pasien terhadap pemberian obat 10. Monitor TTV, kontaksi dan DJJ 7. Monitor

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN INFUS TOKOLISIS**		
	No.Dokumen 900.7.4 / 1737 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	kelancaran infus tiap 3-4 jam 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 12. Dokumentasikan hasil pemantauan yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN PERSALINAN DENGAN PARTOGRAF**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1738 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan pemantauan kemajuan persalinan dan memberikan informasi untuk membuat keputusan klinik segera selama persalinan kala I Fase Aktif menggunakan pencatatan pada lembar Partograf WHO
TUJUAN	Tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Lembar partograf b. Alat tulis (pulpen, penggaris) 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi riwayat persalinan sebelumnya dan kehamilan saat ini 8. Lengkapi bagian awal (atas) partograf (informasi tentang ibu) secara teliti pada saat memulai a. Nama dan umur ibu b. Gravida, para, abortus

c. Nomor catatan medik
d. Catat waktu kedatangan (jam dan pukul) dan perhatikan kemungkinan ibu datang pada fase laten
e. Tanggal dan waktu mulai dirawat (atau tanggal
f. dan waktu penolong persalinan mulai merawat ibu)
g. f. Waktu pecahnya ketuban, sejak jam berapa. Jika tidak/belum tulis strip bukan kosong

9. Catat waktu di kotak-kotak yang tertera angka 1-12 bagian bawah kotak pembukaan serviks dan penurunan janin, setiap kotak menyatakan satu jam sejak dimulainya fase aktif persalinan.
10. Catat hasil observasi denyut jantung janin dan catat setiap 30 menit. Cata dengan memberikan tanda titik (•) sesuai dengan angka yang sesuai, kemudian hubungkan yang satu titik dengan yang lainnya dengan garis tegas dan bersambung. Waspada pada DJJ dibawah 120 kali/menit dan di atas 160 kali/menit
11. Na kondisi dan air ketuban setiap kali periksa dalam, nilai warna air ketuban a selaput ketuban pecah, Catat dalam kotak yang sesuai di bawah lajur DJJ Beni kode U (selaput ketuban masih utuh (belum pecah]), kode J (selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban jernih), kode M (selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur mekonium), kode D (selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur darah) atau kode K

(selaput ketuban sudah pecah tapi air ketuban tidak mengalir lagi [kering])

12. Catat penyusupan (molase) tulang kepala janin setiap periksa dalam, gunakan kode 0 (tulang-tulang kepala janin terpisah, sutura dengan mudah dapat dipalpasi), kode 1 (tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan) kode 2 (tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan), kode 3 (tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan)
13. Nilai dan catat pembukaan serviks setiap 4 jam (lebih sering dilakukan jika ada tanda-tanda penyulit). Catat dengan tanda "X" pada garis waktu yang sesuai dengan lajur besamya pembukaan serviks Pilih angka pada tepi kiri luar kolom pembukaan serviks yang sesuai. Untuk pemeriksaan pertama pada fase aktif. temuan (pembukaan serviks) dari hasil periksa dalam harus dicantumkan pada garis waspada. Hubungkan antar tanda X dengan garis utuh
14. Cantumkan hasil pemeriksaan penurunan kepala (perlimaan) yang menunjukkan seberapa jauh bagian terbawah janin memasuki rongga panggul Berikan tanda "O" yang ditulis pada garis waktu yang sesuai. Hubungkan tanda "O dengan garis utuh
15. Periksa kontraksi uterus setiap 30 menit. selama 10 menit, tentukan frekuensi dan lama (durasi) kontraksi. Beri titik-titik dalam kotak yang sesuai jika durasi/lama kontraksi kurang dari 20 detik.

Beri garis-garis dalam kotak (arsir) pada kotak yang sesuai jika durasi/lama kontraksi lamanya 20-40 detik. Isi penuh kotak yang sesuai untuk menyatakan kontraksi yang lamanya lebih dari 40 detik

16. Catat pemberian oksitosin. Saat pemberian oksitosin, jika tetesan (drip) oksitosin sudah dimulai, dokumentasikan tiap 30 menit jumlah unit oksitosin yang diberikan pervolume cairan IV dan dalam satuan tetesan per menit
17. Catat semua pemberian obat dan/atau tambahan cairan IV dalam kotak yang sesuai dengan kolom waktunya
18. Nilai dan catat nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktif (lebih sering jika diduga ada penyulit, atau nilai abnormal). Beri tanda titik (•) pada kolom waktu yang sesuai
19. Nilai dan catat tekanan darah setiap 4 jam selama fase aktif, lebih sering jika ada penyulit dan nilal abnormal. Beri tanda panah untuk sistol dan diastole
20. Nilai dan catat temperatur tubuh setiap 2 jam, catat pada kotak yang sesuai
21. Ukur dan catat volume urine, protein dan aseton sedikitnya tiap 2 jam (setiap kali ibu berkemih). Periksa aseton dan protein dalam urin setiap ibu berkemih, jika perlu
22. Catat proses persalinan dan kelahiran bayi, mulai dari kala I fase aktif hingga kala IV dan bayi baru lahir pada bagian belakang lembar Partograf.
23. Catat hasil pemantauan Kala IV di 2 (dua) jam

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN PERSALINAN DENGAN PARTOGRAF**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1738 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 5/5
	pertama (setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan setiap 30 menit dalam 1 jam kedua). Bagian yang digelapkan tidak perlu diisi 24. Dokumentasikan semua hasil pemantauan dan respons pasien dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT VAGINA**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1739 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan dan memberikan agen farmakologis via vagina
TUJUAN	Tingkat Infeksi Menurun, Status Kenyamanan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Obat yang diperlukan b. Sarung tangan c. Kapas desinfektan d. Tisu e. Jeli, jika perlu f. Bengkok 6. Anjurkan pasien untuk berkemih terlebih dahulu 7. Lakukan prinsip 6 benar pemberian obat 8. Identifikasi kemungkinan alergi, interaksi dan kontraindikasi obat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN OBAT VAGINA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1739 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Pasang sarung tangan bersih 11. Olesi obat dengan jeli, jika perlu 12. Masukkan obat ke dalam vagina 13. Bersihkan area vulva dengan kapas desinfektan atau tisu bersih 14. Anjurkan pasien untuk tetap berbaring selama 10 menit 15. Lepaskan sarung tangan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN DENYUT JANTUNG JANIN DENGAN DOPPLER**		
	No.Dokumen 400.7.4/1790/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data denyut jantung janin dengan menggunakan doppler
TUJUAN	Tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Doppler b. Jam atau pengukur waktu c. Jeli d. Tisu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi status obstetrik ibu 8. Identifikasi riwayat obstetrik ibu 9. Identifikasi adanya penggunaan obat, diet, dan merokok 10. Identifikasi pemeriksaan kehamilan sebelumnya

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN DENYUT JANTUNG JANIN DENGAN DOPPLER**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1740 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Anjurkan ibu berbaring dengan posisi terlentang 12. Buka pakaian pada bagian perut ibu 13. Lakukan manuver Leopold untuk menentukan posisi janin 14. Tentukan punctum maksimum 15. Berikan jeli pada perut ibu 16. Tempelkan doppler pada perut ibu pada punctum maksimum 17. Hitung denyut jantung janin selama 1 menit 18. Informasikan hasil pemantauan DJJ 19. Bersihkan perut ibu dengan menggunakan tisu 20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan hasil pemeriksaan DJJ		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN LOCHEA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1791 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengamati dan menganalisis pengeluaran cairan rahim pervaginam pasca persalinan
TUJUAN	Tingkat Infeksi Menurun, Tingkat Ansietas Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Tisu, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jaga privasi ibu 8. Atur posisi ibu dorsal recumbent 9. Pasang sarung tangan bersih 10. Amati pengeluaran Lochea (COCA) a. Consistency: Lochea yang keluar berupa gumpalan darah atau cairan b. Odor: Lochea berbau busuk atau amis

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN LOCHEA**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1741 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	c. Color: Rubra (0-3 hari), serosa (4-7 hari), alba (>7 hari) d. Amount: Banyaknya jumlah lochea yang keluar 11. Informasikan hasil pemeriksaan lochea 12. Rapikan pasien 13. Lepaskan sarung tangan 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan hasil pemeriksaan lochea		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN PAYUDARA**		
	No.Dokumen 400.7.9/1792/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan inspeksi dan palpasi pada payudara
TUJUAN	Tingkat Nyeri Menurun, Tingkat Ansietas Menurun, Tingkat Pengetahuan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Bantal kecil b. Handuk c. Sarung tangan, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jaga privasi ibu 8. Atur posisi yang nyaman untuk pemeriksaan payudara 9. Pasang sarung tangan bersih, jika perlu 10. Identifikasi faktor risiko kanker payudara (meliputi usia saat hamil pertama, usia menarche, usia

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN PAYUDARA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1742 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

menopause, riwayat keluarga, riwayat penyakit pada payudara status paritas dan riwayat menyusui)

11. Identifkasi adanya keluhan nyari, rasa tidak nyaman, pengeluaran, perubahan bentuk payudara
12. Minta pasien membuka pakalan bagian atas
13. Inspeksi payudara (bentuk, ukuran, tekstur, warna kulit seperti kemerahan, retraksi kulit payudara)
14. Periksa adanya bekas mastektomi, lesi, jaringan parut, kemerahan, eritema
15. Tempatkan gulungan handuk atau bantal kecil di bawah pundak dan letakkan tangan di bawah kepala
16. Palpasi dengan menekan bagian puting menggunakan jempol dan jari telunjuk
17. Periksa adanya pengeluaran cairan, posisi puting kembali ke bentuk semula
18. Paipasi payudara menggunakan tiga jari dominan pemeriksa (telunjuk, jan tengah, jari manis) berjalan secara vertikal
19. Lakukan pemeriksaan dengan gerakan memutar dan menekan jaringan payudara melawan dinding dada, serta area ketiak
20. Periksa empat kuadran payudara sampai ke pangkal payudara dan ulangi pada payudara yang lainnya
21. Catat adanya massa (meliputi ukuran, lokasi, konsistensi dan pergerakan nodus)
22. Catat kesimetrisan payudara (meliputi perbedaan bentuk, ukuran, puting. kerutan atau lekukan pada kulit)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN PAYUDARA**		
	No.Dokumen A00.7.4 / 1792 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	23. Ajarkan melakukan pemeriksaan payudara sendiri 24. Anjurkan melakukan pemeriksaan mamografi secara rutin sesuai dengan usia, faktor risiko, dan kondisi pasien 25. Informasikan hasil pemeriksaan 26. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 27. Lepaskan sarung tangan 28. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 29. Dokumentasikan hasil pemeriksaan payudara		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN PERINEUM**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1793 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengamati dan menganalisis kondisi perineum
TUJUAN	Tingkat Nyeri Menurun, Status Kenyamanan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Palstik kuning c. Bengkok d. Pembalut e. Perlak 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jaga privasi ibu 8. Atur posisi ibu dorsal recumbent 9. Letakkan perlak di bawah bokong pasien 10. Buka pakaian bagian bawah ibu 11. Pasang sarung tangan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN PERINEUM**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1743 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Lakukan vulva hygiene 13. Inspeksi area vulva, kemungkinan adanya kemerahan, edema, lecet, varises 14. Lakukan pemeriksaan luka perineum mengunakan skala REEDA (Reednes, Echimosis, Edema, Discharge, Approximation) 0-15 15. Pakaikan pembalut dan pakaian bawah ibu 16. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 17. Informasikan hasil pemeriksaan perineum 18. Lepaskan sarung tangan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan hasil pemeriksaan perineum		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN TANDA HOMAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1799 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi tromboflebitis
TUJUAN	Perfusi perifer meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Letakkan tangan kiri pemeriksa pada popliteal 7. Lakukan dorso-fleksi pada telapak kaki menggunakan tangan kanan pemeriksa 8. Identifikasi adanya sensasi nyeri pada saat dorso-fleksi 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Dokumentasikan hasil pemeriksaan dan respons pasien,
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN TANDA-TANDA KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1978/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan identifikasi tanda pasti, tidak pasti dan kemungkinan mengalami kehamilan
TUJUAN	Peran Menjadi Orang Tua Membaik, Tingkat Pengetahuan Meningkat, Tingkat Ansietas Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Doppler atau Laenec c. Test pack 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Pasang sarung tangan 9. Lakukan anamnesa(riwayat perkawinan, riwayat haid, HPHT, riwayat persalinan terdahulu) 10. Identifikasi tanda pasti kehamilan: a. Terlihat gambaran janin saat dilakukan USG b. Adanya denyut jantung janin dengan Doppler atau Laenec c. Teraba gerakan janin 11. Identifikasi tanda tidak pasti kehamilan:

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN TANDA-TANDA KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1978 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	a. Perubahan pada payudara b. Mual/muntah c. Hiperpigmentasi d. Perut membesar e. Tanda Hegar, tanda Piskacek, tanda Chadwik, tanda Braxton Hiks 12. Identifikasi tanda kemungkinan hamil: a. Pemeriksaan tes urine kehamilan: HCG positif b. Amenorhea 13. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 14. Informasikan hasil pemeriksaan tanda-tanda kehamilan 15. Lepaskan sarung tangan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan hasil pemeriksaan tanda-tanda kehamilan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN URINE KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1979 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi kehamilan dengan menggunakan spesimen urine
TUJUAN	Peran menjadi orang tua membaik, tingkat pengetahuan meningkat, tingkat ansietas menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Pot urine b. Test pack kehamilan c. Sarung tangan bersih d. Label identitas pasien e. Alat tulis 6. Ajarkan pasien menampung urine midstream 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Berikan label identitas pasien pada pot urine 9. Celupkan test pack ke dalam spesimen urine

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN URINE KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1979/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	dengan tidak melebihi batas maksimal garis 10. Baca hasil pemeriksaan setelah satu menit a. Positif (+) jika terbentuk dua garis b. Negatif (-) jika terbentuk satu garis 11. Informasikan hasil pemeriksaan urine kehamilan 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 13. Dokumentasikan hasil pemeriksaan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENDAMPINGAN KEHAMILAN RISIKO TINGGI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1980/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mendampingi pasien dan keluarga dalam menjalani perawatan ibu hamil risiko tinggi
TUJUAN	Tingkat Cedera Menurun, Tingkat Pengetahuan Meningkat, Tingkat Ansietas Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Bina hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarga 7. Identifikasi faktor risiko kehamilan (seperti diabetes, hipertensi, SLE, herpes, HIV, epilepsi) 8. Identifikasi riwayat obstetrik (meliputi prematuritas, postmaturitas, preeklampsi, kehamilan multifetal, retardasi pertumbuhan uterine, abrupsio plasenta, plasenta previa, sensitisasi Rh, ketuban pecah dini, dan riwayat kelainan genetik keluarga) 9. Identifikasi faktor sosiodemografi (meliputi usia, ras, kemiskinan, terlambat atau tidak ada perawatan prenatal, penganiayaan fisik, penyalahgunaan zat) 10. Identifikasi dukungan yang dimiliki oleh pasien 11. Monitor status fisik dan psikososial

	selama kehamilan 12. Dampingi pasien saat merasa cemas 13. Dengarkan keinginan dan perasaan pasien 14. Diskusikan ketidaknyaman selama hamil 15. Diskusikan persiapan persalinan dan kelahiran pada kehamilan risiko tinggi 16. Jelaskan risiko janin mengalami kehamilan prematur 17. Informasikan kemungkinan intervensi selama proses kelahiran (seperti pemantauan janin elektronik intrapartum, induksi, perawatan SC) 18. Anjurkan melakukan perawatan diri untuk meningkatkan kesehatan 19. Ajarkan cara menghitung gerakan janin 20. Ajarkan aktivitas yang aman selama hamil 21. Ajarkan mengenali tanda bahaya pada kehamilan (seperti perdarahan pervaginam merah terang, perubahan cairan ketuban, penurunan gerak janin, kontraksi sebelum usia kehamilan 37 minggu, sakit kepala yang tidak hilang gangguan penglihatan, nyeri epigastrik, dan penambahan berat badan yang cepat dengan edema wajah) 22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 23. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PERSALINAN RISIKO TINGGI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1939 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat ibu bersalin yang berisiko dengan tindakan.
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, tingkat ansietas menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan, yang diperlukan a. Sarung tangan, jika perlu b. Doppler BJF c. Spigmomanometer d. Stetoskop e. Jam dan pengukur waktu f. Jell g. Tisu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi faktor risiko persalinan risiko tinggi 8. Identifikasi riwayat obstetrik pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PERSALINAN RISIKO TINGGI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1934/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Identifikasi kondisi umum pasien 10. Dampingi ibu saat merasa cemas 11. Diskusikan persiapan persalinan dan kelahiran 12. Jelaskan risiko janin mengalami kelahiran prematur 13. Monitor tanda-tanda vital pasien 14. Monitor kelainan tanda vital pada ibu dan janin 15. Monitor tanda-tanda persalinan 16. Monitor denyut jantung janin secara periodik 17. Monitor adanya perdarahan intranatal 18. Siapkan kemungkinan dilakukan intervensi persalinan 19. Kolaborasi dengan tim untuk tatalaksana kegawatan ibu dan janin 20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INTRANATAL KALA I**		
	No.Dokumen 400.7.9/1935/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola proses persalinan fase laten dan aktif.
TUJUAN	Tingkat nyeri menurun, status kenyamanan meningkat, tingkat ansietas menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Doppler BJF b. Spigmomanometer c. Stetoskop d. Jam atau pengukur waktu e. Jeli f. Tisu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Berikan posisi yang nyaman 8. Identifikasi kondisi proses persalinan 9. Monitor kondisi fisik dan psikologis pasien 10. Monitor kesejahteraan ibu (tanda vital, kontraksi, lama, frekuensi dan kekuatan) 11. Monitor kesejahteraan janin (gerak janin 10 kali dalam 12 jam, DJJ secara berkelanjutan) 12. Monitor kemajuan persalinan 13. Monitor tanda-tanda persalinan (seperti dorongan meneran, tekanan pada anus, perinemum menonjol, vulva membuka)

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PERAWATAN INTRANATAL KALA I</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

900.7.4 / 1935 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">14. Monitor kemajuan pembukaan menggunakan partograf saat fase aktif
15. Monitor tingkat nyeri selama persalinan
16. Lakukan pemeriksaan Leopold
17. Anjurkan ibu mengosongkan kandung kemih
18. Anjurkan pemberian cairan dan nutrisi sesuai kebutuhan
19. Anjurkan ibu untuk mobilisasi aktif sebelum fase aktif
20. Ajarkan ibu mengenali tanda-tanda persalinan
21. Ajarkan cara mengedan yang benar
22. Ajarkan teknik manajemen nyeri persalinan nonfarmakologis
23. Anjurkan ibu memilih pendamping persalinan
24. Ajarkan ibu mengenali tanda bahaya persalinan
25. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
26. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Bedah Sentral</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INTRANATAL KALA II**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1936 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola proses persalinan serta mencegah terjadinya komplikasi.
TUJUAN	Tingkat nyeri menurun, status kenyamanan meningkat, tingkat ansietas menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Spigmomanometer c. Stetoskop d. Jam atau pengukur waktu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Identifikasi kondisi proses persalinan 9. Monitor tanda-tanda vital ibu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INTRANATAL KALA II**		
	No.Dokumen 400.7.9/1936/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Fasilitasi kebutuhan fisiologis ibu (seperti makan, minum, istirahat, BAK, BAB) 11. Fasilitasi kebutuhan rasa aman (seperti posisi, pendampingan) 12. Ajarkan ibu melakukan teknik napas dalam 13. Lakukan counter pressure pada ibu 14. Berikan pujian atas keberhasilan ibu 15. Lepaskan sarung tangan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INTRANATAL KALA III**		
	No.Dokumen 400.7.9/1937/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola proses persalinan serta mencegah terjadinya komplikasi.
TUJUAN	Tingkat perdarahan menurun, tingkat nyeri menurun, status kenyamanan meningkat, tingkat ansietas, menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Spigmomanometer c. Stetoskop d. Jam atau pengukur waktu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Monitor keadaan umum ibu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INTRANATAL KALA III**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1937 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Monitor tanda-tanda vital ibu 10. Monitor volume air ketuban 11. Monitor perdarahan pervaginam 12. Fasilitasi kebutuhan fisiologis ibu (seperti makan, minum, istirahat, BAK, BAB) 13. Fasilitasi kebutuhan rasa aman (seperti posisi, pendampingan) 14. Ajarkan teknik relaksasi 15. Lepaskan sarung tangan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INTRANATAL KALA IV**		
	No.Dokumen 400.7.4/1938/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola proses persalinan serta mencegah terjadinya komplikasi.
TUJUAN	Tingkat perdarahan menurun, tingkat nyeri menurun, status kenyamanan meningkat, tingkat ansietas menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Spigmomanometer c. Stetoskop d. Jam atau pengukur waktu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Periksa kontraksi uterus (lembek atau keras) 9. Periksa tinggi fundus uteri

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INTRANATAL KALA IV**		
	No.Dokumen 400.7.4/1938/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Periksa kandung kemih (penuh, retensi atau tidak) 11. Periksa lochea (isi, jumlah, konsistensi, warna) 12. Lepaskan sarung tangan 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PASCA INDUKSI PERSALINAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1939/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola pasien setelah menjalani pemberian terapi uterotonika.
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, status kenyamanan meningkat, tingkat perdarahan menurun, tingkat ansietas menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Spigmomanometer c. Stetoskop d. Jam atau pengukur waktu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Identifikasi indikasi penggunaan uterotonika

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PASCA INDUKSI PERSALINAN**		
	No.Dokumen 400.7.9/1939/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Atur posisi yang nyaman 10. Sediakan lingkungan aman 11. Monitor kontraksi uterus 12. Monitor tanda-tanda vital pasien 13. Monitor tanda-tanda perdarahan 14. Ajarkan ibu mengenali efek samping induksi persalinan (seperti hiperstimulas ruptur uteri, perdarahan pasca persalinan) 15. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 16. Lepaskan sarung tangan 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PERDARAHAN SELAMA KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.A/1940/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat ibu yang mengalami perdarahan selama masa kehamilan.
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, tingkat cedera menurun, status cairan membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Spigmomanometer c. Stetoskop d. Jam atau pengukur waktu e. Doppler f. Jeli g. Pengalas 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Monitor tanda-tanda vital 9. Periksa adanya kontraksi uterus 10. Periksa gerak janin 11. Periksa denyut jantung janin dengan doppler prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien 12. Periksa perdarahan pervaginam (meliputi jumlah, konsistensi, warna)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PERDARAHAN SELAMA KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1940 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Fasilitasi ibu miring ke kiri atau posisi nyaman 14. Berikan cairan intravena, sesuai program 15. Berikan tokolitik, sesuai program 16. Lepaskan sarung tangan 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN ROBEKAN JALAN LAHIR**		
	No.Dokumen 400.7.4/1941/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan dan mempertahankan integritas kulit perineum.
TUJUAN	Integritas kulit dan jaringan meningkat, tingkat nyeri menurun, tingkat infeksi menurun, status kenyamanan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Perlak c. Pispot d. Waskom berisi air bersih e. Pembalut f. Bengkok 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Jaga privasi pasien 9. Atur posisi nyaman 10. Pasang perlak dan pispot 11. Anjurkan pasien untuk melepaskan pakaian bagian bawah 12. Periksa kondisi perineum (adanya luka jahitan, laserasi jalan lahir)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN ROBEKAN JALAN LAHIR**		
	No.Dokumen 400.7.4/1941/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Periksa tanda-tanda infeksi luka jahitan dengan skala REEDA (Redness Echimosis, Edema, Discharge, Approximation) 14. Bersihkan area perineum secara teratur atau lakukan vulva hygiene 3-4 kali sehari 15. Anjurkan ibu untuk menjaga perineum bersih dan kering 16. Anjurkan ibu membersihkan perineum dengan air bersih mengalir 17. Anjurkan mengganti pembalut setelah buang air kecil dan setelah buang besar 18. Ajarkan pasien dan keluarga memonitor tanda-tanda abnormal pada perineum (seperti infeksi, kemerahan, pengeluaran cairan abnormal) 19. Berikan analgetik dan/atau antiinflamasi, sesuai program 20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 21. Lepaskan sarung tangan 22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 23. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN VULVA HYGIENE**		
	No.Dokumen 400.7.4/1942/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat kebersihan vulva untuk meningkatkan kenyamanan dan mencegah terjadinya komplikasi.
TUJUAN	Perawatan diri meningkat, tingkat infeksi menurun, status kenyamanan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Kom berisi kapas savion atau kapas sublimate c. Perlak d. Pispot e. Waskom berisi air bersih f. Pembalut g. Bengkok 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Jaga privasi pasien 8. Atur posisi litotomi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN VULVA HYGIENE**		
	No.Dokumen 400.7.4/1942/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Pasang perlak dan pispot 10. Identifikasi kondisi vulva 11. Pasang sarung tangan 12. Guyur genitalia luar dengan air bersih 13. Buka vulva dengan ibu jari dan jari telunjuk kiri 14. Bersihkan vulva mulai dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, vestibulum, perineum degngan arah dari klitoris keanu dengan kapas basah 15. Pasang pembalut dan celana dalam 16. Rapikan pasien dan alat yang digunakan 17. Lepaskan sarung tangan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN PAP SMEAR**		
	No.Dokumen 400.7.4/1943/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan pasien menjalani tindakan pengambilan sampel sel dari mulut rahim untuk deteksi dini kanker mulut rahim.
TUJUAN	Perawatan diri meningkat, tingkat infeksi menurun, status kenyamanan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan steril b. Kapas dan larutan antiseptik c. Spekulum d. Penjepit has e. Spatula f. Kaca objek yang telah diberi alkohol 95% g. Wadah transpor untuk sediaan h. Meja ginekologi i. Meja instrumen j. Lampu sorot k. Label nama 6. Tentukan waktu pemeriksaan: a. Di luar masa menstruasi b. Perempuan yang telah menikah atau sudah pernah melakukan hubungan seksual

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN PAP SMEAR**		
	No.Dokumen 400.7.9/1993/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	c. Pap smear setahun sekali 7. Identifikasi persiapan sebelum dilakukan pemeriksaan pap smear a. Tidak melakukan koitus minimal dalam 24 jam b. Tidak menggunakan pembasuh vagina minimal 48 jam c. Tidak sedang menstruasi 8. Lakukan persiapan pasien: a. Anjurkan pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan melepaskan pakaian dalam b. Atur posisi pasien telentang atau miring dengan kedua lutut ditekuk 9. Celupkan kaca objek ke dalam larutan alkohol 95% selama 10, setelah sediaan didapatkan 10. Masukkan sediaan ke dalam wadah transpor dan dikirim ke bagian patologi anatomi 11. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 12. Lepaskan sarung tangan 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN PEMERIKSAAN USG KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.9/1999/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan pasien menjalani pemeriksaan untuk memeriksa perkembangan janin dengan menggunakan ultrasonografi (USG).
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, tingkat ansietas menurun, tingkat pengetahuan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Mesin USG c. Jeli d. Tisu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi indikasi dilakukan pemeriksaan 8. Siapkan pasien secara fisik dan emosional 9. Jaga privasi pasien 10. Atur posisi pasien berbaring dengan posisi nyaman

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN PEMERIKSAAN USG KEHAMILAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1999 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Buka pakaian pasien pada area abdomen 12. Hidupkan mesin USG 13. Lakukan pendataan sesuai rekam medik pasien, tekan tombol "pasien. gunakan track ball dan keyboard untuk mengisi data pada sheet pasien 14. Oleskan jeli pada pasien dan gunakan probe yang telah dipilih untuk melakukan pemeriksaan 15. Fasilitasi pemeriksaan USG 16. Cetak hasil pemeriksaan USG dari mesin 17. Diskusikan hasil pemeriksaan dengan tim medis 18. Matikan mesin USG 19. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Jadwalkan pemeriksaan ulang atau prosedur tambahan, jika perlu 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN PERSALINAN DENGAN TINDAKAN SECTIO CAESAREA (SC)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1945 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan pasien menjalani persalinan dengan pembedahan sectio caesarea (SC).
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, pemulihan pasca bedah meningkat, tingkat perdarahan menurun, tingkat ansietas menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Alat cukur c. Spigmomanometer d. Stetoskop e. Doppler f. Handuk g. Bengkok

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN PERSALINAN DENGAN TINDAKAN SECTIO CAESAREA (SC)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1945 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan 8. Informasikan tentang persiapan operasi kepada pasien: a. Jam mulai puasa b. Pencukuran area genitalia c. Resiko jatuh d. Mandi menggunakan klorheksidin 9. Monitor denyut jantung bayi dengan Doppler 10. Monitor tanda-tanda vital ibu 11. Lakukan pencukuran pada area genitalia 12. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dampingi ibu ke ruang operasi, jika perlu 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN PROSEDUR AMNIOSENTESIS**		
	No.Dokumen 400.7.4/1946/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan pasien untuk menjalani tindakan pengambilan cairan amnion melalui rongga rahim.
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, risiko infeksi menurun, tingkat ansietas menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Duk steril b. Sarung tangan steril c. Jarum amnion d. Kateter intravena e. Set infus f. Cairan infus RL g. Lidocain h. Spuit 3 ml, 5 ml, 20 ml atau sesuai kebutuhan i. Kasa steril

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN PROSEDUR AMNIOSENTESIS**		
	No.Dokumen 400.7.4/1946/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	j. Alcohol Swab 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Anjurkan pasien mandi klorheksidin pada sore dan pagi hari terutama untuk membersihkan area abdomen 8. Siapkan pasien untuk pemeriksaan USG selama tindakan amniosentesis 9. Dampingi ibu ke ruang tindakan, jika perlu 10. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN TINDAKAN PESSARIUM**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1997 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan pasien untuk menjalani tindakan pemasangan alat di dalam vagina untuk mengatasi prolapsus uteri.
TUJUAN	Integritas kulit dan jaringan meningkat, tingkat nyeri menurun, tingkat infeksi menurun, tingkat ansietas menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Sarung tangan b. Kapas sublimat c. Pessarium steril sesuai ukuran d. Set pemasangan alat pessarium e. Bengkok 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Anjurkan pasien untuk mengosongkan kandung kemih 8. Atur posisi pasien dengan posisi litotomi 9. Lakukan vulva hygiene sebelum tindakan pemasangan pessarium

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN TINDAKAN PESSARIUM**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1947 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN TINDAKAN TRANSFER EMBRIO** **(EMBRYO TRANSFER [ET])**		
	No.Dokumen 400.7.4/1948/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menempatkan kembali embrio melalui saluran reproduksi wanita saat embrio telah berusia 3 hari atau 5 hari.
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, tingkat nyeri menurun, risiko infeksi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: embrio (ET) a. Set transfer b. Set linen steril c. Set vulva hygiene d. Set USG e. Tampon tang steril f. Kogel tang steril g. Kom kecil steril 2 buah h. Kasa dan kapas bulat kecil steril sesuai kebutuhan i. Spigmomanometer j. Stetoskop k. Jam atau pengukur waktu l. Termometer m. Catatan terintegrasi n. Lembar persetujuan o. Checklist tindakan keselamatan pasien p. APD sesuai kebutuhan q. Baju pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN TINDAKAN TRANSFER EMBRIO** **(EMBRYO TRANSFER [ET])**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1998 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

6. Pastikan bahwa pasien dan pasangan sudah melengkapi administrasi antara lain:
   a. Formulir persetujuan telah ditandatangani
   b. Fotokopi KTP suami dan istri yang telah dibandingkan dengan yang asli sebelumnya
   c. Fotokopi kartu keluarga yang telah dibandingkan dengan yang asli sebelumnya
   d. Fotokopi buku nikah atau sertifikat nikah yang telah dibandingkan dengan yang asli sebelumnya
   e. Pas foto suami-istri yang berwarna 4x6
7. Siapkan pasien:
   a. Pastikan pasien datang pada hari menstruasi ke-15 atau hari ke-17
   b. Pindahkan pasien dari ruang persiapan ke ruang tindakan
   c. Berikan minum air putih 30 menit sampai 60 menit sebelum prosedur dimulai dengan minimal 200 ml, kemudian informasikan pasien untuk menahan BAK
8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
9. Periksa tanda-tanda vital pasien
10. Ganti baju pasien
11. Periksa pemenuhan kandung kencing dengan menggunakan USG
12. Posisikan pasien dengan posisi litotomi
13. Pastikan lokasi pembedahan benar, prosedur pembedahan benar dan pembedahan pada pasien yang benar,
14. Pasang APD
15. Pasang set linen steril
16. Lakukan vulva hygiene
17. Pastikan semua alat telah siap pakai
18. Pastikan kenyamanan dan keamanan pasien
19. Siapkan set ET
20. Dampingi pasien saat dokter embriologi memasukkan embrio, lalu lakukan penekanan pada syringe ET
21. Pastikan dokter embriologi telah mengecek kembali syringe kateter bahwa embrio telah tidak ada lagi di dalam kateter ET

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN TINDAKAN TRANSFER EMBRIO** **(EMBRYO TRANSFER [ET])**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1948 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	22. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 23. Pindahkan pasien ke ruang pemulihan 24. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 25. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN TINDAKAN HISTEROSKOPI DIAGNOSTIK**		
	No.Dokumen 400.7.4 /1949/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 27 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan persiapan pada pasien sebelum menjalani prosedur invasif dengan menggunakan alat histeroskopi untuk pemeriksaan struktur dalam rahim.
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, tingkat nyeri menurun, risiko infeksi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. alat dan bahan yang diperlukan: a. Catatan terintegrasi b. Lembar persetujuan tindakan 6. Siapkan pasien: a. Pastikan pasien telah dilakukan pemeriksaan HSG b. Pastikan pasien datang di periode menstruasi hari ke-5 sampai ke-9 c. Pastikan pasien telah mendapatkan penjelasan dari tim medis dan telah menyetujui tindakan

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PERSIAPAN TINDAKAN HISTEROSKOPI DIAGNOSTIK</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4 / 1949 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
8. Follow up pasien untuk periode menstruasi
9. Lakukan pemesanan ruang prosedur minimal 1 hari sebelum prosedur dilakukan
10. Informasikan jadwal prosedur akan dilakukan
11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Bedah Sentral</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN TINDAKAN OVUM PICK OUT (OPU)**		
	No.Dokumen 400.7.4/1950/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 27 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Waka Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan pasien untuk prosedur pengambilan sel telur pada folikel yang sudah matang dengan cara menusuk dan melakukan aspirasi di ovarium melalui vagina.
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, tingkat nyeri menurun, risiko infeksi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Set OPU b. Set linen steril c. Set vulva hygiene d. Set USG e. Set pemasangan kateter urine f. Set pemasangan infus g. Cairan infus sesuai kebutuhan h. Jarum aspirasi single lumen atau double lumen i. Guide j. Spekulum sesuai kebutuhan k. Tabung penampung sel telur l. Kasa steril sesuai kebutuhan m. Monitor EKG n. Alat perlindung diri (APD)

o. Baju pasien
p. Lembar catatan sel telur (oocyte)
q. Catatan terintegrasi Po
r. Lembar persetujuan
s. Checklist tindakan keselamatan pasien

6. Siapkan pasien:
   a. Pastikan pasien telah disuntik dengan obat pemecah sel telur 34-36 jam sebelumnya di malam hari sesuai dengan program
   b. Pastikan pasien telah menjalani puasa minimal 6-8 jam sebelum tindakan OPU
   c. Informasikan pasien untuk datang 1 jam lebih awal untuk tindakan OPU setelah penyuntikan pemecah sel telur ± 36 jam
   d. Pastikan pasien tidak menggunakan kosmetik dan parfum
   e. Ganti baju pasien
7. Siapkan suami pasien di hari tindakan OPU untuk pengambilan sperma dan tidak mengeluarkan sperma 3-5 hari sebelum tindakan OPU
8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
9. Pindahkan pasien dari ruang persiapan ke ruang tindakan
10. Pasang jalur intravena
11. Lakukan vulva hygiene
12. Pasang kateter urine
13. Pasang monitor EKG
14. Posisikan pasien dengan posisi litotomi
15. Pastikan lokasi pembedahan benar, prosedur pembedahan benar, dan pembedahan pada pasien yang benar
16. Pasang APD
17. Pasang set linen steril
18. Sambungkan probe yang steril ke monitor USG
19. Berikan ke operator single lumen atau double lumen yang dikaitkan dengan needle guide dan probe
20. USG saat operator akan melakukan penusukan cangkang telur
21. Lakukan penekanan pada alat penyedot saat operator melakukan tindakan aspirasi sel telur dari ovum

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERSIAPAN TINDAKAN OVUM PICK OUT (OPU)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1950 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	22. Berikan tabung berisi cairan telur yang sudah disedot kepada petugas embriologi 23. Catat jumlah oocyte di formulir oocyte sesuai informasi dari petugas embriologi 24. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 25. Lepaskan sarung tangan 26. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 27. Pindahkan pasien ke ruang pemulihan untuk dilakukan pemantauan 28. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI MANAJEMEN NYERI**		
	No.Dokumen 400.7.3.4 / 55 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi pengelolaan nyeri pada pasien dan keluarga tentang rasa nyeri dan strategi untuk meredakan dan mengendalikan rasa nyeri
TUJUAN	Tingkat Pengetahuan Meningkat, Tingkat Nyeri Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Media edukasi b. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 8. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 9. Jelaskan penyebab, periode dan strategi meredakan nyeri 10. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 11. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI MANAJEMEN NYERI**		
	No.Dokumen 400.7.3.4 / 55 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 13. Berikan kesempatan untuk bertanya 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN EFEK SAMPING TERAPI RADIASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1799 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data efek yang tidak diharapkan dari pemberian terapi radiasi
TUJUAN	Integritas Kulit/Jaringan Meningkat, Tingkat Cedera Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kemungkinan penyebab timbulnya efek samping radiasi (seperti rasa sakit pada kulit, lelah, resiko infeksi meningkat) 7. Identifikasi riwayat efek samping terapi radiasi yang pernah dialami 8. Monitor tanda dan gejala yang di akibatkan oleh efek samping terapi radiasi 9. Catat waktu dan durasi terjadinya efek samping terapi radiasi 10. Catat bagian organ tubuh yang terkena dampak efek samping terapi radiasi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN EFEK SAMPING TERAPI RADIASI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1799/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 12. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN NYERI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1800/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data nyeri
TUJUAN	Tingkat Nyeri Menurun, Kontrol Nyeri Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi faktor pencetus dan pereda nyeri 7. Monitor kualitas nyeri (seperti terasa tajam, tumpul, diremas-remas, ditimpa beban berat) 8. Monitor lokasi dan penyebaran nyeri 9. Monitor intensitas nyeri dengan menggunakan skala 10. Monitor durasi dan frekuensi nyeri 11. Atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 12. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN NYERI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1800 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN NYERI PADA ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1981 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data nyeri pada pasien berusia 0-18 tahun.
TUJUAN	Tingkat nyeri menurun, kontrol nyeri meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Skala pengukuran nyeri. b. Lembar pemantauan nyeri. c. Alat tulis. 7. Libatkan orang tua atau pengasuh dalam menginterpretasi respons perilaku anak terhadap nyeri. 8. Identifikasi faktor pencetus dan pereda nyeri, jika memungkinkan. 9. Monitor intensitas nyeri dengan menggunakan skala yang sesuai dengan usia anak : a. FLACC: untuk anak usia 2 bulan sampai 8

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN NYERI PADA ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1981 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2

	tahun (atau bahkan sampai usia 18 tahun pada anak dengan ketidakadekuatan fungsi kognitif). b. Wong-Baker faces pain scale: untuk anak berusia 3 sampai 18 tahun. c. Visual analog scale: untuk anak usia 8 tahun ke atas. 10. Periksa kualitas nyeri (seperti terasa tajam, tumpul, diremas-remas, ditimpa beban berat), jika memungkinkan. 11. Periksa lokasi dan penyebaran nyeri, jika memungkinkan. 12. Periksa durasi dan frekuensi nyeri. 13. Atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien : a. Lakukan penilaian ulang skala nyeri setidaknya 2 jam setelah pemberian analgetik untuk menilai efektifitas pemberian terapi. b. Lakukan penilaian ulang skala nyeri sesaat sebelum pemberian analgetik rutin untuk menilai perlu tidaknya analgetik tetap diberikan secara rutin. 14. Informasikan hasil pemantauan pada pasien dan/atau keluarga, jika perlu. 15. Dokumentasikan hasil pemantauan.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Anestesiologi dan Terapi Intensif

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN AKUPRESUR**		
	No.Dokumen 400.7.9/1982/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan teknik penekanan pada titik tertentu untuk mengurangi nyeri, meningkatkan relaksasi, mencegah atau mengurangi mual.
TUJUAN	Tingkat nausea menurun, tingkat nyeri menurun, tingkat kenyamanan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Sarung tangan bersih. b. Lotion, jika perlu. c. Alat bantu akupresur (seperti tongkat/pen akupresur). d. Tisu. 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 8. Pasang sarung tangan bersih. 9. Posisikan pasien sesuai dengan kebutuhan.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN AKUPRESUR**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1982 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Anjurkan pasien rileks selama dilakukan akupresur. 11. Tentukan area yang akan dilakukan akupresur Oleskan lotion secukupnya pada area yang akan dilakukan akupresur. 12. Lakukan penekanan pada titik akupresur dengan jari atau alat bantu dengan kekuatan tekanan yang memadai : a. Untuk menguatkan (tonifikasi): Titik akupresur ditekan dengan tekanan sedang dan diputar searah jarum jam sebanyak 30 kali (10-10-10). b.Untuk melemahkan (sedasi): Titik akupresur ditekan dengan tekanan sedang hingga kuat dan diputar berlawanan arah jarum jam sebanyak >40 kali. 13. Lakukan akupresur 1-2 kali sehari atau sesuai kebutuhan. 14. Hindari pemberian akupresur pada kondisi terlalu lapar/kenyang, kehamilan trimester pertama (pada area sekitar perut, punggung tangan dan bahu), serta kondisi sangat lemah. 15. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 16. Lepaskan sarung tangan. 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien (atau bahkan sampai usia 18 tahun pada anak dengan ketidakadekuatan fungsi kognitif).		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN KOMPRES DINGIN**		
	No.Dokumen 400.7.9/1983/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan stimulasi kulit dan jaringan untuk mengurangi nyeri, peradangan dan mendapatkan efek terapeutik lainnya melalui paparan dingin.
TUJUAN	Termoregulasi membaik, tingkat nyeri menurun, tingkat cedera menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Sarung tangan bersih. b. Alat kompres dingin. c. Kain penutup kompres. 7. Pilih alat kompres yang nyaman dan mudah didapat (seperti kemasan gel beku, kain atau handuk). 8. Periksa suhu alat kompres. 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN KOMPRES DINGIN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1983 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Pasang sarung tangan bersih. 11. Pilih lokasi kompres. 12. Balut alat kompres dingin dengan kain pelindung jika perlu. 13. Lakukan kompres dingin pada daerah yang sudah dipilih. 14. Hindari penggunaan kompres pada jaringan yang terpapar terapi radiasi. 15. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 16. Lepaskan sarung tangan. 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respon pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN KOMPRES HANGAT**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1984 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan stimulasi kulit dan jaringan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan kenyamanan dan mendapatkan efek terapeutik lainnya melalui paparan hangat/panas.
TUJUAN	Termoregulasi membaik, tingkat nyeri menurun, tingkat nyeri menurun, status kenyamanan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Sarung tangan bersih. b. Alat kompres hangat. c. Kain penutup kompres. 7. Pilih alat kompres yang nyaman dan mudah didapat (seperti kemasan gel beku. kain atau handuk). 8. Periksa suhu alat kompres.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN KOMPRES HANGAT**		
	No.Dokumen 400.7.4/1984/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 10. Pasang sarung tangan bersih. 11. Pilih lokasi kompres. 12. Balut alat kompres hangat dengan kain, jika perlu lakukan kompres hangat pada daerah yang sudah dipilih. 13. Hindari penggunaan kompres pada jaringan yang terpapar terapi radiasi. 14. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 15. Lepaskan sarung tangan. 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 17. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN LATIHAN OTOGENIK**		
	No.Dokumen 400.7.4/1985/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengajarkan kemampuan sugesti diri dengan perasaan senang dan kehangatan yang bertujuan untuk relaksasi.
TUJUAN	Tingkat nausea menurun, tingkat nyeri menurun, tingkat kenyamanan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Sarung tangan bersih, jika perlu. b. Kursi, jika perlu. 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 8. Pasang sarung tangan bersih. 9. Siapkan lingkungan yang tenang dan nyaman. 10. Kenakan pasien pakaian yang nyaman dan tidak membatasi pergerakan.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN LATIHAN OTOGENIK**		
	No.Dokumen 400.7.9/1985/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Anjurkan duduk di kursi atau berbaring dalam posisi terlentang. 12. Bacakan pernyataan (skrip) yang disiapkan, berhenti sejenak minta mengulang secara internal, gunakan pernyataan yang menimbulkan perasaan senang, ringan atau rasa melayang pada bagian tubuh tertentu. 13. Anjurkan mengulangi pernyataan kepada diri sendiri untuk mendapatkan perasaan lebih dalam pada bagian tubuh yang dituju. 14. Lakukan latihan selama 15-20 menit. 15. Anjurkan tetap rileks selama 15-20 menit. 16. Buat jadwal latihan selama 3 kali sehari. 17. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 18. Lepaskan sarung tangan. 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TEKNIK IMAJINASI TERBIMBING**		
	No.Dokumen 400.7.9/1986/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Membentuk imajinasi dengan menggunakan semua indera melalui pemrosesan kognitif dengan mengubah objek, tempat, peristiwa, atau situasi untuk meningkatkan laksasi, meningkatkan kenyamanan dan meredakan nyeri.
TUJUAN	Tingkat nyeri menurun, status kenyamanan meningkat, tingkat ansietas menurun, status spiritual membaik, pola tidur membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Atur posisi pasien senyaman mungkin. 7. Identifikasi masalah yang dialami. 8. Anjurkan membayangkan suatu tempat yang sangat menyenangkan yang pernah atau yang ingin dikunjungi (seperti gunung, pantai). 9. Anjurkan membayangkan berada dalam kondisi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TEKNIK IMAJINASI TERBIMBING**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1986 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	yang sehat, bersama dengan orang yang dikasihi/dicintai dalam suasana yang nyaman. 10. Periksa respons perubahan emosional. 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGELOLAAN NYERI PADA ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.9/1987/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan upaya-upaya nonfarmakologis untuk mengurangi kondisi yang menyakitkan pada anak.
TUJUAN	Tingkat nyeri menurun, kontrol nyeri meningkat,
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan dengan usia perkembangan anak : a. Formulir penilaian nyeri yang sesuai untuk anak. b. Alat permainan edukatif. 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 8. Lakukan penilaian nyeri pada anak dengan menggunakan instrumen penilaian nyeri yang sesuai. 9. Berikan tindakan non-farmakologis untuk mengurangi nyeri : a. Untuk Neonatus :

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGELOLAAN NYERI PADA ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.4/1987/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2

	1) Pembedongan a) Siapkan kain bedong. b) Bungkus bayi menggunakan kain bedong. c) dengan posisi tangan di tengah tubuh. 2) Facilitated Tucking Posisikan bayi berbaring atau terlentang dengan kedua lengan dan kaki fleksi mendekati tubuh (flexed fetal-type position). 3) Tutup inkubator dengan kain yang tidak tembus cahaya. 4) Perawatan Metode Kanguru. 5) Kecilkan suara alarm alat-alat monitor dan volume suara ketika berbicara. b. Untuk Anak Berikan terapi musik, terapi bermain, akupresur, hipnosis, teknik imajinasi terbimbing. 10. Monitor nyeri dan respons pasien selama dilakukan prosedur. 11. Kolaborasi pemberian analgetik, jika tingkat nyeri tidak menurun. 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI RELAKSASI NAPAS DALAM**		
	No.Dokumen 400.7.4/1988/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan teknik napas dalam untuk mengurangi tanda dan gejala ketidaknyamanan seperti nyeri, ketegangan otot, atau kecemasan.
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, tingkat kenyamanan meningkat, tingkat nyeri menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Sarung tangan bersih, jika perlu. b. Kursi dengan sandaran, jika perlu. c. Bantal. 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 7. Pasang sarung tangan, jika perlu. 8. Tempatkan pasien di tempat yang tenang dan nyaman. 9. Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI RELAKSASI NAPAS DALAM**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1988 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	dengan pencahayaan dan suhu ruang nyama, jika memungkinkan. 10. Berikan posisi yang nyaman (misal dengan duduk bersandar atau tidur). 11. Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. 12. Latih melakukan teknik napas dalam : a. Anjurkan tutup mata dan konsentrasi penuh. b. Ajarkan melakukan inspirasi dengan menghirup udara melalui hidung secara perlahan. c. Ajarkan melakukan ekspirasi dengan menghembuskan udara dengan cara mulut mencucu secara perlahan. d. Demonstrasikan menarik napas selama 4 detik, menahan napas selama 2. 13. Monitor respons pasien selama dilakukan prosedur detik dan menghembuskan napas selama 8 detik. 14. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 15. Lepaskan sarung tangan. 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF**		
	No.Dokumen 400.7.4/1989/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan teknik penegangan dan peregangan otot untuk meredakan ketegangan otot, ansietas, nyeri serta meningkatkan kanyamanan, konsentrasi dan kebugaran.
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, tingkat kenyamanan meningkat, tingkat nyeri menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Sarung tangan bersih, jika perlu. b. Kursi dengan sandaran, jika perlu. c. Bantal. d. Jam atau pengukur waktu. e. Spigmomanometer. f. Termometer. 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 7. Pasang sarung tangan, jika perlu. 8. Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1989 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	darah, dan suhu. 9. Tempatkan pasien di tempat yang tenang dan nyaman. 10. Anjurkan untuk menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman. 11. Berikan posisi yang nyaman, misal dengan duduk bersandar atau tidur. 12. Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. 13. Anjurkan menegangkan otot selama 5 sampai 10 detik, kemudian anjurkan untuk merilekskan otot 20-30 detik, masing-masing 8-16 kali. 14. Anjurkan menegangkan otot kaki selama tidak lebih dari 5 detik untuk menghindari kram. 15. Anjurkan fokus pada sensasi otot yang menegang atau otot yang rileks. 16. Anjurkan bernapas dalam dan perlahan. 17. Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu. 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 19. Lepaskan sarung tangan. 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DISKUSI KELOMPOK TERARAH**		
	No.Dokumen 400.7.4/1990/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan diskusi semi terstruktur untuk mengidentifikasi suatu masalah dalam kelompok.
TUJUAN	Harga diri meningkat, tingkat pengetahuan meningkat, status koping komunitas membaik, manajemen kesehatan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Catat pemikiran atau ide yang muncul dalam diskusi. 7. Atur ruangan dengan suasana nyaman, rancang posisi tempat duduk. 8. Persiapkan alat (seperti sistem audio, perekam, media tulis). 9. Lakukan orientasi kelompok (meliputi salam, peserta diminta menyebutkan nama dan informasi data diri).

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DISKUSI KELOMPOK TERARAH**		
	No.Dokumen 400.7.4/1990/2016	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Lakukan kontrak waktu. 11. Sampaikan diskusi akan direkam. 12. Arahkan pertanyaan sesuai tujuan dan hindari pertanyaan yang tidak relevan. 13. Berikan kesempatan semua peserta untuk berpartisipasi selama diskusi. 14. Motivasi interaksi peserta untuk berbicara satu sama lain, tidak harus ke fasilitator. 15. Motivasi peserta yang enggan berbicara. 16. Batasi peserta yang mendominasi diskusi melalui isyarat verbal dan non verbal. 17. Tunjukkan sikap mendengar aktif agar menjadi model praktik bagi peserta. 18. Lakukan eksplorasi mendalam tanpa mengarahkan peserta. 19. Sampaikan ringkasan secara verbal. 20. Berikan umpan balik diskusi berupa analisis dan laporan. 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN EMOSIONAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1951 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi penerimaan kondisi emosional selama masa stress.
TUJUAN	Status koping membaik, status spiritual membaik, harapan meningkat, keberdayaan meningkat, tingkat konfusi menurun, status koping membaik, keterlibatan sosial meningkat, harga diri meningkat, status koping keluarga membaik, perawatan diri meningkat, proses keluarga membaik, status spiritual membaik, memori meningkat, status menelan membaik , penyapihan ventilator meningkat, ventilasi spontan meningkat, status menyusui membaik, penerimaan meningkat, pola napas membaik, kontrol diri meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN EMOSIONAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1951 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	6. Identifikasi fungsi marah, frustasi dan amuk bagi pasien. 7. Identifikasi hal yang telah memicu emosi. 8. Fasilitasi mengungkapkan perasaan cemas, marah atau sedih. 9. Buat pernyataan suportif atau empati selama fase berduka. 10. Lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan (seperti ansietas, marah, sedih). 11. Tetap bersama pasien dan pastikan keamanan selama ansietas, jika perlu. 12. Kurangi tuntutan berpikir saat sakit atau lelah. 13. Jelaskan konsekuensi tidak menghadapi rasa bersalah dan malu. 14. Anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami 15. (seperti ansietas, marah,sedih). 16. Anjurkan mengungkapkan pengalaman emosional sebelumnya dan pola respons yang biasa digunakan. 17. Ajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat. 18. Rujuk untuk konseling, jika perlu. 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN HIPNOSIS DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.9/1991/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi penggunaan kondisi hipnosis yang dilakukan sendiri untuk manfaat terapeutik.
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, pola tidur membaik, kesiapan peningkatan tidur meningkat, kesiapan peningkatan manajemen meningkat, kontrol diri meningkat, status kenyamanan pascapartum meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Identifikasi apakah hipnosis diri dapat dilakukan. 7. Identifikasi masalah yang akan diatasi dengan hipnosis diri. 8. Identifikasi penerimaan terhadap hipnosis diri. 9. Identifikasi mitos dan kesalahpahaman terhadap penggunaan hipnosis diri. 10. Identifikasi kesesuaian sugesti hipnosis.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN HIPNOSIS DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1991 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Identifikasi teknik induksi yang sesuai (seperti ilusi pendulum chevreul, relaksasi, relaksasi otot latihan visualisasi, perhatian pada pernapasan. mengulang kata/frase kunci). 12. Identifikasi teknik pendalaman yang sesuai (seperti gerakan tangan ke wajah. teknik eskalasi, imajinasi, fraksinasi). 13. Monitor respons terhadap terhadap hipnosis diri. 14. Buatkan jadwal latihan, jika perlu. 15. Jelaskan jenis hipnosis diri sebagai penunjang terapi modalitas (seperti hipnoterapi, psikoterapi, terapi kelompok, terapi keluarga). 16. Ajarkan prosedur hipnosis diri sesuai kebutuhan dan tujuan. 17. Anjurkan memodifikasi prosedur hipnosis diri (frekuensi, intensitas, berdasarkan respons dan kenyamanan). 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 19. Dokumentasikan hasil tindakan dan respon pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN KELOMPOK**		
	No.Dokumen 400.7.4/1992/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi peningkatan kemampuan penyelesaian masalah dan perasaan yang didukung oleh kelompok individu dengan pengalaman dan masalah yang sama.
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, tingkat berduka menurun, status koping membaik, status koping keluarga membaik, kontrol diri meningkat, perilaku kesehatan membaik, harga diri meningkat, status spiritual membaik, ketahanan personal meningkat, status menyusui membaik, peran pemberi asuhan membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Identifikasi kelompok memiliki masalah yang sama. 7. Identifikasi hambatan menghadiri sesi kelompok (seperti stigma, cemas, tidak aman). 8. Siapkan lingkungan terapeutik dan rileks.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN KELOMPOK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1992 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

9. Bentuk kelompok dengan pengalaman dan masalah yang sama.
10. Mulai sesi kelompok dengan mengenalkan semua anggota kelompok dan terapis.
11. Mulai dengan percakapan ringan, berbagi informasi tentang diri masing-masing dan alasan terlibat dalam kelompok.
12. Buat aturan dan norma dalam kelompok, terutama kerahasiaan dalam kelompok.
13. Sepakati jumlah sesi yang diperlukan dalam kelompok.
14. Bangun rasa tanggung jawab dalam kelompok.
15. Diskusikan penyelesaian masalah dalam kelompok.
16. Berikan kesempatan individu untuk berhenti sejenak saat merasa distres akibat topik tertentu sampai mampu berpartisipasi kembali.
17. Berikan kesempatan istirahat disetiap sesi untuk memfasilitasi percakapan Individu dalam kelompok.
18. Berikan kesempatan saling mendukung dalam kelompok terkait masalah dan penyelesaian masalah.
19. Berikan kesempatan kelompok menyimpulkan masalah, penyelesaian masalah dan dukungan yang diperlukan untuk setiap anggota kelompok.
20. Hindari percakapan ofensif, tidak sensitif, seksual atau humor yang tidak perlu/tidak pada tempatnya.
21. Sediakan media untuk kebutuhan berkomunikasi di luar kelompok (seperti email, telepon, SMS, WA).
22. Lakukan refleksi manfaat dukungan kelompok pada
23. setiap awal dan akhir pertemuan.
24. Anjurkan anggota kelompok mendengarkan dan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN KELOMPOK**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1992 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	memberi dukungan saat mendiskusikan masalah dan perasaan. 25. Anjurkan bersikap jujur dalam menceritakan perasaan dan masalah. 26. Anjurkan setiap anggota kelompok mengemukakan ketidakpuasan, keluhan, kritik dalam kelompok dengan cara santun. 27. Anjurkan kelompok untuk menuntaskan ketidakpuasan, keluhan dan kritik. 28. Ajarkan relaksasi pada setiap sesi, jika perlu. 29. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 30. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN MEMAAFKAN**		
	No.Dokumen 400.7.9/1993/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pengalihan perasaan marah dan dendam dengan empati dan kerendahan hati.
TUJUAN	Status spiritual membaik, status koping meningkat, ketahanan personal meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Identifikasi sumber kemarahan dan kebencian. 7. Identifikasi keyakinan yang menghambat dan membantu mengungkapkan masalah. 8. Identifikasi perasaan marah, kepahitan dan dendam. 9. Dengarkan ungkapan perasaan dan pikiran secara empati. 10. Jelaskan bahwa memaafkan adalah sebuah proses Jelaskan memaafkan memiliki dimensi kesehatan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN MEMAAFKAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 /1993 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	dan pemulihan diri. 11. Ajarkan teknik melepaskan emosi dan relaksasi. 12. Fasilitasi mengatasi hambatan pemulihan dengan cara spiritual. 13. Fasilitasi kegiatan ibadah dan memohon ampun kepada Tuhan. 14. Fasilitasi kegiatan ibadah dan memohon ampun kepada Tuhan. 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PELAKSANAAN IBADAH**		
	No.Dokumen 400.7.9/1994/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pemulihan dan penyembuhan dalam perawatan melalui pelaksanaan ibadah.
TUJUAN	Status spiritual membaik, keterlibatan sosial meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Identifikasi sumber kemarahan dan kebencian. 7. Identifikasi kebutuhan pelaksanaan ibadah sesuai agama yang dianut. 8. Sediakan sarana yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan ibadah (sepert perlengkapan sholat, arah kiblat, perlengkapan kebaktian). 9. Identifikasi kebutuhan diet sesuai agama yang dianut (seperti tidak makan babi bagi yang muslim, tidak makan daging sapi bagi hindu). 10. Identifikasi pemenuhan ritual pada situasi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PELAKSANAAN IBADAH**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1999 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	khusus (seperti mengadzankan bayi. pembaptisan, pengakuan dosa, menuntun shadat saat sakaratul maut menghadap kiblat). 11. Fasilitasi pasien pelaksanaan ibadah sesuai kepercayaan yang dianut. 12. Fasilitasi penuntunan ibadah oleh keluarga dan/atau rohaniawan. 13. Konsultasi medis terkait pelaksanaan ibadah yang memerlukan perhatian (seperti puasa). 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 15. Dokumentasikan hasil tindakan dan respons pasien kepada Tuhan.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 /2238/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi dan dukungan saat pembuatan keputusan kesehatan
TUJUAN	Status Spiritual Membaik ,Harga Diri Meningkat, Citra Tubuh Meningkat, Komunikasi Verbal Meningkat, Proses Keluarga Membaik, Tingkat Keletihan Menurun, Status Koping Keluarga Membaik, Penerimaan Meningkat , Peran Pemberi Asuhan Membaik, Keberdayaan Meningkat , Tingkat Kepatuhan Meningkat, Perawatan Diri Meningkat , Manajemen Kesehatan Keluarga Meningkat, Manajemen Kesehatan Meningkat, Perilaku Kesehatan Membaik, Konsep Diri Membaik, Tingkat Pengetahuan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi persepsi mengenai masalah dan informasi yang memicu konflik 7. Klarifikasi nilai dan harapan yang membantu membuat pengambilan Keputusan 8. Diskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap Solusi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/2238/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan 10. Hormati hak pasien untuk menerima atau menolak informasi 11. Informasikan alternatif solusi secara jelas 12. Berikan informasi yang di minta pasien 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 4. Instalasi Bedah Sentral		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PENGUNGKAPAN KEBUTUHAN**		
	No.Dokumen 400.7.9/2237/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi mengungkapkan kebutuhan dan keinginan secara efektif
TUJUAN	Tingkat Ansietas Menurun, Citra Tubuh Meningkat, Harga Diri Meningkat, Harapan Meningkat, Status Koping Membaik, Status Koping Keluarga Membaik , Keberdayaan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Periksa gangguan komunikasi verbal (seperti ketidakmampuan berbicara, kesulitan mengekspresikan pikiran secara verbal) 7. Ciptakan lingkungan yang tenang 8. Hindari berbicara keras 9. Ajukan pertanyaan dengan jawaban singkat, dengan isyarat anggukan kepala. jika mengalami kesulitan berbicara

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PENGUNGKAPAN KEBUTUHAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/0237/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Fasilitasi pengungkapan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien 11. Fasilitasi komunikasi dengan media (seperti pensil dan kertas, komputer, kartu kata) 12. Informasikan keluarga dan tenaga kesehatan lain teknik berkomunikasi, dan gunakan secara konsisten 13. Anjurkan keluarga dan staf mengajak bicara meskipun tidak mampu berbicara 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PENGUNGKAPAN PERASAAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/2236/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi mengekspresikan, memahami dan mengelola emosi
TUJUAN	Tingkat Ansietas Menurun, Citra Tubuh Meningkat, Harga Diri Meningkat, Harapan Meningkat, Status Koping Membaik, Status Koping Keluarga Membaik, Keberdayaan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi tingkat emosi 7. Identifikasi isyarat verbal dan non verbal 8. Identifikasi perasaan saat ini 9. Identifikasi hubungan antara apa yang dirasakan dan perilaku 10. Fasilitasi pasien mengungkapkan pengalaman emosional yang menyakitkan 11. Identifikasi asumsi interpersonal yang

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PENGUNGKAPAN PERASAAN**		
	No.Dokumen A00.7.4/2236/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	melatarbelakangi pengalaman emosional 12. Netralkan kembali emosi yang negatif 13. Ajarkan mengeksipresikan perasaan secara asertif 14. Informasikan menekan perasaan dapat mempengaruhi interpersonal 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PERASAAN BERSALAH**		
	No.Dokumen 400.7.4/2035/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi dalam mengatasi perasaan menyakitkan akibat kegagalan tanggung jawab
TUJUAN	Status Spiritual Membaik, Tingkat Berduka Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi adanya keyakinan tidak rasional 7. Identifikasi situasi perasaan yang muncul dan respons terhadap situasi 8. Identifikasi dampak situasi pada hubungan keluarga 9. Fasilitasi memahami rasa bersalah adalah reaksi umum terhadap trauma, penganiayaan, berduka, bencana atau kecelakaan 10. Bimbing untuk mengakui kesalahan sendiri 11. Ajarkan mengidentifikasi perasaan bersalah yang menyakitkan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PERASAAN BERSALAH**		
	No.Dokumen 900.7.9/2235/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Ajarkan menggunakan teknik menghentikan pikiran dan substitusi pikiran dengan relaksasi otot saat pikiran bersalah terus dirasakan 13. Ajarkan mengidentifikasi pilihan untuk mencegah, mengganti, menebus kesalahan dan penyesalan 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PERKEMBANGAN SPIRITUAL**		
	No.Dokumen 400.7.4/2234/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pengembangan kemampuan mengidentifikasi, berhubungan dan mencari sumber makna, tujuan, kekuatan dan harapan dalam hidup
TUJUAN	Status Spiritual Membaik, Citra Tubuh Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi masalah spiritual 7. Eksplorasi keyakinan terkait pemulihan tubuh, pikiran, dan jiwa 8. Anjurkan membuat komitmen spiritual berdasarkan keyakinan dan nilai 9. Anjurkan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah (seperti hari raya, ritual dan meditasi) 10. Rujuk pada pemuka agama/kelompok agama, jika perlu 11. Rujuk kepada kelompok pendukung, swabantu, atau

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PERKEMBANGAN SPIRITUAL**		
	No.Dokumen 400.7.4/2234/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	program spiritual, jika perlu 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PERLINDUNGAN PENGANIAYAAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/2233/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pencegahan dan penanganan bahaya fisik, psikologis dan/atau seksual
TUJUAN	Tingkat Ansietas Menurun, Status Spiritual Membaik, Citra Tubuh Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi pengalaman tidak menyenangkanatau traumatis (sepertipenganiayaan, penolakan, kritik berlebihan) 7. Identifikasi hubungan dan kemampuan mengambil tanggung jawab antar anggota keluarga 8. Identifikasi adanya perlakuan penganiayaan dalam keluarga 9. Identifikasi situasi krisis yang memicu penganiayaan (seperti kemiskinan, pengangguran,

	perceraian, atau kematian orang yang dicintai) 10. Identifikasi perasaan kesulitan mempercayai diri dan orang lain 11. Identifikasi tingkat isolasi sosial dalam keluarga 12. Identifikasi ketidaksesuaian penjelasan dengan cedera dan/atau trauma yang terjadi 13. Identifikasi ketidaksesuaian peran (seperti anak menghibur orang tua, atau perilaku berlebihan atau agresif) 14. Periksa tanda-tanda penganiayaan 15. Dengarkan penjelasan kronologis cedera dan/atau trauma yang terjadi 16. Laporkan situasi dugaan penganiayaan kepada pihak berwajib 17. Anjurkan rawat inap untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, jika perlu 18. Anjurkan pasien menghubungi polisi, jika terjadi penganiayaan fisik 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PROSES BERDUKA**		
	No.Dokumen A00.7.4/2232/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi menyelesaikan proses berduka terhadap kehilangan yang bermakna
TUJUAN	Tingkat Berduka Membaik,.Harapan Meningkat, Keberdayaan Meningkat, Status Spiritual Membaik; Citra Tubuh Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kehilangan yang dihadapi 7. Identifikasi proses berduka yang dialami 8. Identifikasi sifat keterikatan pada benda yang hilang atau orang yang meninggal 9. Identifikasi reaksi awal terhadap kehilangan 10. Tunjukan sikap menerima dan empati 11. Motivasi agar mau mengungkapkan perasaan kehilangan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PROSES BERDUKA**		
	No.Dokumen 400.7.4/2232/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Motivasi untuk menguatkan dukungan keluarga atau orang terdekat 13. Diskusi strategi koping yang digunakan 14. Jelaskan pada pasien dan keluarga bahwa sikap 15. mengingkari, marah, tawar kehilangan menawar, depresi dan menerima adalah wajar dalam menghadapi 16. Anjurkan mengidentifikasi ketakutan terbesar pada kehilangan 17. Anjurkan mengekpresikan perasaan tentang kehilangan 18. Ajarkan melewati proses berduka secara bertahap 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat 4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KETERAMPILAN KOPING**		
	No.Dokumen 400.7.4/2231/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengajarkan kemampuan menggunakan pikiran, ide dan kreatifitas dalam menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap situasi
TUJUAN	Status Koping Membaik, Status Koping Membaik, Status Koping Keluarga Membaik, Status Koping Komunitas Membaik, Tingkat Pengetahuan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi situasi yang menyebabkan terjadinya masalah 7. Diskusikan pemecahan masalah yang biasa dilakukan 8. Diskusikan cara dan teknik penyelesaian masalah yang konstruktif 9. Anjurkan membuat tujuan yang spesifik

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KETERAMPILAN KOPING**		
	No.Dokumen A00.7.4/2231/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Anjurkan mengekspresikan perasaan 11. Anjurkan mengevaluasi perasaan takut, marah dan kesedihan 12. Anjurkan penggunaan sumber spiritual, keluarga dan sosial 13. Latih cara menyelesaikan masalah 14. Latih mengembangkan penilaian positif 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat 4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KETERAMPILAN PENCEGAHAN KEKAMBUHAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/2230/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi cara mengubah dan membuat kondisi kembali semula secara bertahap
TUJUAN	Manajemen Kesehatan Meningkat, Tingkat Pengetahuan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kondisi yang meningkatkan kekambuhan 7. Identifikasi tanda-tanda awal kekambuhan 8. Identifikasi faktor pemicu kekambuhan 9. Identifikasi pemahaman proses kekambuhan 10. Fasilitasi menyadari dan mengetahui proses kekambuhan 11. Hindari situasi yang sering menimbulkan stres 12. Latih kegiatan yang menyenangkan 13. Latih kemampuan untuk meningkatkan relaksasi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KETERAMPILAN PENCEGAHAN KEKAMBUHAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/2730/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	14. Anjurkan melakukan kegiatan rutin di rumah 15. Anjurkan terlibat aktif dalam kegiatan grup sesama pasien 16. Libatkan care giver dan keluarga dalam kagiatan pencegahan 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat 4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI METODE MODULASI PENGALAMAN EMOSI**		
	No.Dokumen 400.7.4/2229/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi cara menulis untuk merefleksikan dan menganalisis peristiwa pengalaman, pikiran, dan perasaan
TUJUAN	Persepsi Sensori Membaik, Tingkat Pengetahuan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Diskusikan pengalaman dan penerimaan intervensi yang sama 7. Diskusikan alasan dan tujuan kegiatan 8. Jelaskan berbagai pendekatan penulisan jurnal dan putuskan teknik penulisan jurnal (yaitu alur bebas, topik, atau menuliskan jurnal secara intensif) 9. Diskusikan jangka waktu penyelesaian tugas

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI METODE MODULASI PENGALAMAN EMOSI**		
	No.Dokumen 900.7.9/2229/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Anjurkan menulis secara rutin selama 20 menit sedikitnya 3 (tiga) kali seminggu 11. Diskusikan pemilihan media dan metode 12. Fasilitasi lingkungan yang mendukung 13. Minimalkan stimulus dan distraksi pada proses kegiatan 14. Ajarkan menulis tanggal entri jurnal untuk referensi dan refleksi 15. Anjurkan menulis sesual urutan waktu kejadian tanpa membatasi topik 16. Anjurkan mengungkapkan pikiran dan perasaan terhadap peristiwa dalam bentuk cerita atau gambar 17. Anjurkan melibatkan lima sensori dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan 18. Anjurkan mengekspresikan pikiran dan perasaan yang paling dalam 19. Ajarkan tidak berfokus pada teknik penulisan (seperti titik koma, ejaan, struktur 20. kalimat) 21. Anjurkan melatih kemampuan secara mandiri 22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 23. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat 4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PEMANTAUAN MOOD SECARA MANDIRI**		
	No.Dokumen 400.7.9/2228/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi mengenai pemantauan mood secara mandiri.
TUJUAN	Tingkat Pengetahuan Meningkat, Pola Tidur Membaik, Kontrol Diri Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kesiapan menerima informasi 7. Sediakan materi dan media pengaturan aktivitas 8. Jadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 9. Jelaskan bahwa dengan memahami mood-nya pasien dapat menangani diri sendiri 10. Minta pasien mencatat mood-nya per hari dalam grafik yang terdiri dari mood, motivasi, kecepatan berpikir, dan impulsitivitas

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PEMANTAUAN MOOD SECARA MANDIRI**		
	No.Dokumen 400.7.9/2228/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Ajarkan pasien mencatat kondisi mood setiap bangun tidur dan sebelum tidur 12. Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya 13. Laporkan grafik mood yang dimonitor setiap 2 minggu, jika ada kelainan langsung dilaporkan ke dokter 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat 4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PENANGANAN GANGGUAN MOOD**		
	No.Dokumen 400.7.4/2227/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi mengenai penanganan gangguan suasana hati
TUJUAN	Tingkat Pengetahuan Meningkat, Pola Tidur Membaik, Kontrol Diri Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kesiapan menerima informasi 7. Jadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 8. Jelaskan tentang gangguan mood dan penanganannya 9. Anjurkan berperan aktif dalam pengobatan dan rehabilitasi 10. Anjurkan rawat sesuai indikasi 11. Ajarkan mengenali pemicu gangguan mood 12. Ajarkan keterampilan koping dan penyelesaian

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PENANGANAN GANGGUAN MOOD**		
	No.Dokumen 400.7.4/2227/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	masalah baru 13. Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk beranya 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat 4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PENANGANAN MARAH**		
	No.Dokumen 400.7.9/2226/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi tentang penanganan emosi tidak nyaman dan tidak menyenangkan
TUJUAN	Tingkat Pengetahuan Meningkat, Status Koping Membaik, Tingkat Ansietas Menurun, Kontrol Diri Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Sediakan alat dan bahan: a. Materi b. Media pengaturan aktivitas 7. Identifikasi kesiapan menerima informasi 8. Jadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 9. Jelaskan makna, fungsi marah, frustasi, dan respon marah 10. Ajarkan strategi untuk mencegah ekspresi marah maladaptif

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PENANGANAN MARAH**		
	No.Dokumen 400.7.9/2226/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Ajarkan metode untuk memodulasi pengalaman emosi yang kuat (seperti latihan asertif, Teknik relaksasi, jurnal, aktifitas penyaluran energi) 12. Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya 13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat 4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI** **TEKNIK PENGONTROLAN HALUSINASI**		
	No.Dokumen 400.7.4/2225/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi teknik mengontrol halusinasi
TUJUAN	Tingkat Pengetahuan Menigkat, Persepsi Sensori Membaik, Tingkat Konfusi Menurun, Kontrol Diri Meningkat, Status Orientasi Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Sediakan alat dan bahan: a. Materi b. Media pengaturan aktivitas 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Identifikasi kesiapan menerima informasi 9. Jadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 10. Anjurkan memonitor sendiri situasi terjadinya halusinasi 11. Anjurkan pada seseorang yang dipercaya untuk

	memberikan dukungan dan umpan balik korektif terhadap halusinasi 12. Anjurkan melakukan distraksi (seperti mendengarkan musik, melakukan aktivitas dan teknik relaksasi) 13. Ajarkan pasien dan keluarga cara mengontrol halusinasi 14. Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya 15. Kolaburasi pemberian obat antipsikotik dan antiansietas, jika perlu 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat 4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IDENTIFIKASI PENYEBAB/PEMICU KEMARAHAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/2229/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menemukan dan menganalisis penyebab yang dapat memicu kemarahan
TUJUAN	Status Koping Membaik, Tingkat Ansietas Menurun, Kontrol Diri Meningkat, Ketahanan Personal Meningkat, Status Orientasi Membaik, Status Koping Keluarga Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Fasilitasi pasien mengidentifikasi pemicu marah (seperti disfungsi mood membedakan apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan) 7. Bantu klien membuat catatan perasaan marahnya dan respon yang dimunculkan 8. Identifikasi stimulus yang menyebabkan perilaku kekerasan dan cara mengatasi stimulusnya 9. Tekankan bahwa pasien bertanggung jawab terhadap

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">IDENTIFIKASI
PENYEBAB/PEMICU KEMARAHAN</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4/2224/
2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">pilihan dan perilakunya
10. Jelaskan kemungkinan akibat perilaku agresif atau perilaku kekerasan pada orang lain
11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat darurat
4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MEDIASI KONFLIK**		
	No.Dokumen 100.7.4/2223/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi komunikasi konstruktif dalam penyelesaian masalah dengan cara yang dapat diterima bersama
TUJUAN	Kontrol Diri Meningkat, Status Spiritual Membaik, Penampilan Peran Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Ciptakan suasana yang netral dalam proses komunikasi 7. Anjurkan mengungkapkan masalah yang dialami 8. Gunakan berbagai teknik komunikasi (seperti mendengar aktif, parafrase, refleksi) 9. Anjurkan menggunakan panduan dalam proses komunikasi 10. Diskusikan masalah 11. Fasilitasi mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MEDIASI KONFLIK**		
	No.Dokumen 400.7.4/2223/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Fasilitasi kedua belah pihak dalam menerima penyelesaian yang disepakati 13. Berikan penguatan positif terhadap upaya penyelesaian masalah 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat 4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PELIBATAN KELUARGA DALAM PROGRAM PERAWATAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2222 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi partisipasi anggota keluarga dalam perawatan emosional dan fisik
TUJUAN	Manajemen Kesehatan Keluarga Meningkat, Proses Keluarga Membaik, Manajemen Kesehatan Meningkat, Peran Pemberi Asuhan Membaik, Status Koping Keluarga Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kesiapan keluarga untuk terlibat dalam perawatan 7. Ciptakan hubungan teerapeutik pasien dengan keluarga dalam perawatan 8. Diskusikan cara perawatan di rumah (seperti perawatan di rumah atau rumah singgah) 9. Motivasi keluarga mengembangkan aspek positif rencana perawatan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PELIBATAN KELUARGA DALAM PROGRAM PERAWATAN**		
	No.Dokumen 400.7.9/2222/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Fasilitasi keluarga membuat keputusan perawatan 11. Jelaskan kondisi pasien kepada keluarga 12. Informasikan tingkat ketergantungan pasien kepada keluarga 13. Informasikan harapan pasien kepada keluarga 14. Anjurkan keluarga bersikap asertif dalam perawatan 15. Anjurkan keluarga terlibat dalam perawatan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat 4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN ISI HALUSINASI**		
	No.Dokumen 400.7.4/2220/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data isi halusinasi yang dialami oleh pasien
TUJUAN	Persepsi Sensori Membaik, Tingkat Konfusi Menurun, Kontrol Diri Meningkat, Status Orientasi Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Monitor perilaku yang mengindikasi halusinasi 7. Monitor isi halusinasi (seperti kekerasan atau membahayakan diri) 8. Diskusikan perasaan dan respon pasien terhadap halusinasi 9. Anjurkan memonitor sendiri situasi terjadinya halusinasi 10. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien 11. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 13. Dokumentasikan hasil pemantauan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN ISI HALUSINASI**		
	No.Dokumen 400.7.4/2220/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat 4. Instalasi anestesiologi dan terapi intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN REDUKSI ANSIETAS**		
	No.Dokumen A00.7.4 / 1858 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meminimalkan kondisi dan pengalaman subjektif terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, status spiritual membaik, status koping membaik, tingkat konfusi menurun, pola tidur membaik, kontrol diri meningkat, keberdayaan meningkat, perilaku kesehatan membaik, pola napas membaik, interaksi sosial meningkat, memori meningkat, penyapihan ventilator meningkat, status koping keluarga membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Bina hubungan saling percaya 7. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan 8. Identifikasi penyebab ansietas

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN REDUKSI ANSIETAS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1858 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Monitor tanda-tanda ansietas 10. Jelaskan secara faktual mengenai diagnosis, perawatan/pengobatan prognosis 11. Anjurkan keluarga untuk tetap bersama, jika perlu 12. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan 13. Latih teknik mengurangi ansietas 14. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN SEKLUSI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1859 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memisahkan pasien dalam ruangan khusus dengan pengawasan ketat
TUJUAN	Manajemen kesehatan keluarga meningkat, proses keluarga membaik, manajemen kesehatan meningkat, peran pemberi asuhan membaik, status koping keluarga membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi riwayat perilaku membahayakan diri sendiri dan orang lain 7. Monitor keselamatan selama di ruang seklusi 8. Ciptakan suasana lingkungan yang aman dan nyaman 9. Tentukan satu anggota staf keperawatan untuk berkomunikasi dan mengarahkan staf lain untuk mengendalikan perilaku 10. Monitor kesadaran, tanda-tanda vital sesuai kondisi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN SEKLUSI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1859 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	secara berkala 11. Dukung pemenuhan kebutuhan dasar (seperti nutrisi, eliminasi, hidrasi dan kebersihan diri) 12. Hindari menggunakan benda yang dapat menyakiti diri sendiri dan orang lain 13. Latih mengendalikan perilaku, jika perlu 14. Kolaborasi pemberian obat untuk kegelisahan atau agitasi, jika perlu 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan hasil tindakan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI ASERTIF 1**		
	No.Dokumen 400.7.4/1860/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan latihan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang membuat marah dan sikap yang muncul ketika ada kejadian yang membuat marah
TUJUAN	Kontrol diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kejadian yang membuat marah 7. Identifikasi sikap yang dilakukan saat ada kejadian yang membuat marah 8. Identifikasi sikap yang dilakukan termasuk agresif, pasif, atau asertif 9. Jelaskan tentang perilaku agresif, pasif dan asertif 10. Latih pasien untuk mengkomunikasikan kepada perawat penyebab marah dan sikap yang dilakukan 11. Latih pasien untuk bersikap asertif terhadap penyebab kemarahan 12. Berikan kesimpulan hasil terapi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI ASERTIF 1**		
	No.Dokumen 400.7.4/1860/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI ASERTIF 2**		
	No.Dokumen 400.7.4/1861/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan latihan untuk mengungkapkan cara memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi yang membuat marah
TUJUAN	Kontrol diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi 7. Identifikasi cara memenuhi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi 8. Berikan kesimpulan hasil terapi 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI ASERTIF 3**		
	No.Dokumen 400.7.4/1862/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengajarakan bersikap asertif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi dan membuat pasien marah
TUJUAN	Kontrol diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Latih bersikap asertif dalam memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dan membuat marah 7. Latih bersikap asertif dalam memenuhi keinginan yang belum terpenuhi dan membuat marah 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI ASERTIF 4**		
	No.Dokumen 400.7.4/1863/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengajarkan mengatakan tidak untuk permintaan orang lain yang tidak rasional dan alasan menolak permintaan orang lain
TUJUAN	Kontrol diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi permintaan orang lain yang tidak rasional 7. Identifikasi dampak dari cara menolak yang biasa dilakukan 8. Latih cara mengatakan tidak untuk permintaan yang tidak rasional 9. Latih mengungkapkan alasan menolak permintaan yang tidak rasional 10. Berikan kesimpulan hasil terapi 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI ASERTIF 4**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1863 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 1**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1864 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan edukasi keluarga menggunakan komunikasi terapeutik dengan mengidentifikasi masalah keluarga
TUJUAN	Status koping keluarga meningkat, tingkat pengetahuan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi masalah keluarga (care giver) dalam merawat anggota keluarga yang sakit 7. Identifikasi masalah yang muncul karena anggota keluarga sakit 8. Identifikasi keinginan dan harapan anggota keluarga selama mengikuti psiko edukasi keluarga 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 1**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1864 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 2**		
	No.Dokumen 400.7.4/1865/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan edukasi keluarga cara merawat anggota keluarga yang sakit menggunakan komunikasi terapeutik
TUJUAN	Status koping keluarga meningkat, tingkat pengetahuan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Diskusikan tentang gangguan jiwa yang dialami oleh salah satu anggota keluarga 7. Jelaskan tentang masalah yang dialami 8. Diskusikan cara merawat anggota keluarga yang sakit yang selama ini dilakukan keluarga 9. Diskusikan cara merawat anggota keluarga yang sakit 10. Demonstrasikan cara merawat anggota keluarga yang sakit 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 2**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1865 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 3**		
	No.Dokumen 400.7.9/1866/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 27 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan edukasi keluarga cara mengatasi stres
TUJUAN	Status koping keluarga meningkat, tingkat pengetahuan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Jelaskan tentang stres yang dialami keluarga 7. Latih cara mengurangi stres yang dialami keluarga 8. Evaluasi pemahaman keluarga terkait edukasi yang diberikan 9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 10. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 4**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1867 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan edukasi keluarga cara mengatasi beban
TUJUAN	Status koping keluarga meningkat, tingkat pengetahuan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Anjurkan keluarga menyampaikan beban yang dialami akibat anggota keluarga sakit 7. Anjurkan keluarga menyampaikan tindakan yang sudah dilakukan untuk mengurangi beban yang dirasakan 8. Jelaskan macam-macam beban keluarga 9. Jelaskan cara mengatasi beban yang dialami oleh keluarga 10. Latih cara mengatasi beban yang dialami 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 4**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1867 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 5**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1868 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan edukasi keluarga pemberdayaan sumber-sumber daya di luar keluarga
TUJUAN	Status koping keluarga meningkat, tingkat pengetahuan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Anjurkan keluarga menyampaikan hambatan yang dirasakan selama merawat 7. Anjurkan keluarga menyampaikan hambatan yang dialami dalam berhubungan dengan tenaga kesehatan 8. Jelaskan keluarga bagaimana seharusnya hubungan keluarga dengan tenaga kesehatan 9. Jelaskan keluarga bagaimana cara mengatasi hambatan dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI EDUKASI KELUARGA 5**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1868 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KELOMPOK**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1869 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan kelompok dengan masalah yang sama untuk memberikan dukungan emosional dan perilaku, melatih perilaku baru, dan berbagi informasi kesehatan
TUJUAN	Interaksi sosial meningkat, keterlibatan sosial meningkat, persepsi sensori membaik, status orientasi membaik, status koping membaik, kontrol diri meningkat, perilaku kesehatan membaik, harga diri meningkat, ketahanan personal meningkat, status koping keluarga membaik, penerimaan meningkat, perawatan diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 7. Bentuk kelompok 5 sampai 12 anggota 8. Berikan arahan dan informasi yang sesuai 9. Tentukan waktu dan tempat yang sesuai untuk pertemuan kelompok

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMBERIAN TERAPI KELOMPOK</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.9 / 1869 /

2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">10. Ciptakan suasana nyaman
11. Sepakati norma kelompok
12. Ciptakan iklim motivasi untuk proses kelompok
13. Arahkan anggota kelompok untuk terlibat aktif
14. Anjurkan berbagi perasaan, pengetahuan, dan pengalaman
15. Anjurkan saling membantu dalam kelompok
16. Monitor keterlibatan aktif setiap anggota
17. Mulai dan akhiri kegiatan tepat waktu
18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1870/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan anggota keluarga untuk menggerakkan keluarga melakukan cara hidup yang lebih produktif
TUJUAN	Tingkat berduka menurun, status koping membaik, kontrol diri meningkat, penampilan peran membaik, status koping keluarga meningkat, penerimaan meningkat, peran menjadi orang tua membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi riwayat kesehatan keluarga 7. Identifikasi pola komunikasi keluarga 8. Identifikasi cara keluarga memecahkan masalah 9. Identifikasi pembuatan keputusan dalam keluarga 10. Identifikasi terjadinya pelecehan dalam keluarga 11. Identifikasi kekuatan/sumber daya keluarga 12. Identifikasi peran setiap anggota keluarga dalam sistem pendukung 13. Identifikasi gangguan spesifik terkait harapan peran 14. Identifikasi penyalahgunaan zat pada anggota

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.3.9/1890/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	keluarga 15. Identifikasi ketidakpuasan/konflik yang terjadi 16. Identifikasi kejadian saat ini atau akan terjadi yang mengancam keluarga 17. Identifikasi kebutuhan dan harapan dalam keluarga 18. Identifikasi hubungan hierarkis anggota keluarga 19. Monitor respons merugikan terhadap terapi 20. Fasilitasi diskusi keluarga 21. Fasilitasi strategi menurunkan stres 22. Fasilitasi restrukturisasi sistem keluarga 23. Diskusikan cara terbaik dalam menangani disfungsi perilaku dalam keluarga 24. Diskusikan batasan keluarga 25. Diskusikan rencana terapi dengan keluarga 26. Diskusikan strategi penyelesaian masalah yang konstruktif 27. Anjurkan memprioritaskan dan memilih masalah keluarga 28. Anjurkan semua anggota untuk berpartisipasi dalam pekerjaan rumah 29. Anjurkan komunikasi lebih efektif 30. Diskusikan cara membudayakan perilaku baru 31. Rencana strategi menghentikan terapi 32. Motivasi keluarga untuk komunikasi lebih efektif 33. Anjurkan anggota keluarga berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga bersama-sama (seperti makan bersama) 34. Berikan reinforcement positif 35. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 36. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF 1**		
	No.Dokumen 400.7.9/1871/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Modifikasi distorsi kognitif dan perilaku maladaptif dengan mengidentifikasi kejadian/peristiwa negative dalam kehidupan dan pikiran otomatis yang muncul
TUJUAN	Status koping membaik, perilaku kesehatan membaik, ketahanan personal meningkat, kontrol diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Ciptakan hubungan terapeutik 7. Identifikasi riwayat gangguan kognitif yang menyeluruh 8. Identifikasi faktor gejala, faktor lingkungan budaya, biologis yang mempengaruhi kognitif 9. Identifikasi peristiwa yang tidak menyenangkan 10. Identifikasi kejadian/peristiwa negatif dalam kehidupan dan pikiran yang otomatis muncul 11. Identifikasi cara melawan atau merasionalisasi pikiran negatif

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF 1**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1871 / 2016	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Latih pasien melawan/merasionalisasi pikiran negatif menjadi pikiran positif 13. Berikan reinforcement positif 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF 2**		
	No.Dokumen 900.7.9/1872/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Modifikasi distorsi kognitif dan perilaku maladaptive dengan melawan pikiran negatif yang muncul otomatis yang kedua
TUJUAN	Status koping membaik, perilaku kesehatan membaik, ketahanan personal meningkat, kontrol diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Ciptakan hubungan terapeutik 7. Identifikasi peristiwa dan pikiran negatif yang bertambah 8. Latihan melawan pikiran negatif yang kedua menjadi pikiran positif dan memasukan kedalam jadwal kegiatan harian 9. Berikan reinforcement positif 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF 2**		
	No.Dokumen 900.7.4 / 1892 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF 3**		
	No.Dokumen 400.7.4/1873/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Modifikasi distorsi kognitif dan perilaku maladaptive dengan melawan pikiran negatif yang muncu lotomatis yang ketiga dengen memanfaatkan sistem pendukung
TUJUAN	Status koping membaik, perilaku kesehatan membaik, ketahanan personal meningkat, kontrol diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Ciptakan hubungan terapeutik 7. Identifikasi peristiwa dan pikiran negatif yang bertambah 8. Latihan melawan pikiran negatif yang ketiga menjadi pikiran positif dan memasukkan kedalam jadwal kegiatan harian 9. Identifikasi sistem sosial yang ada dan sistem pendukung yang di gunakan 10. Berikan reinforcement positif 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF 3**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1873 / a096	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 1**		
	No.Dokumen 400.7.4/1874/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan tindakan untuk memodifikasi perilaku melalui pendekatan restrukturisasi kognitif
TUJUAN	Status koping membaik, perilaku kesehatan membaik Ketahanan personal meningkat, kontrol diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Ciptakan hubungan terapeutik 7. Identifikasi riwayat penyakit yang menyeluruh 8. Identifikasi faktor gejala, faktor lingkungan budaya, biologis yang mempengaruhi kognitif dan perilaku 9. Identifikasi masalah yang menimbulkan distorsi pikiran persepsi negatif 10. Identifikasi asumsi, keyakinan yang mendasari pola pikiran dan distorsi pikiran 11. Identifikasi peristiwa yang tidak menyenangkan 12. Identifikasi pikiran negatif yang muncul otomatis terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 1**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1874 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Latih melawan pikiran negatif yang pertama : a. Pilih pikiran otomatis negatif pertama yang ingin diselesaikan saat ini b. Buat daftar aspek positif yang dimiliki oleh pasien c. Latih melawan pikiran negatif otomatis pertama secara terjadwal dalam jadwal kegiatan harian 14. Latihan mengubah perilaku negative pertama jika muncul dengan menggunakan catatan harian a. Pilih satu perilaku negatif pertama yang akan diubah b. Identifikasi perilaku positif yang sebaiknya dilakukan untuk mengubah perilaku negatif pertama menjadi perilaku positif c. Berikan penghargaan terhadap aktivitas yang dilakukan untuk mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif d. Latihan mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif dengan catatan harian 15. Berikan reinforcement positif 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 2**		
	No.Dokumen 400.7.4/1875/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan tindakan untuk memodifikasi perilaku kedua melalui pendekatan restrukturisasi kognitif
TUJUAN	Status koping membaik, perilaku kesehatan membaik Ketahanan personal meningkat, kontrol diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Ciptakan hubungan terapeutik dan kolaboratif 7. Monitor pikiran yang tidak menyenangkan yang bertambah 8. Monitor pikiran negatif dan perilaku negatif yang bertambah 9. Monitor latihan melawan pikiran negatif yang pertama jika muncul a. Monitor latihan melawan pikiran negatif dan mengubah perilaku negatif pertama dengan menggunakan jadwal harian b. Monitor latihan melawan pikiran negative dan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 2**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1875 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	hasilnya 10. Latih melawan pikiran otomatis negatif yang kedua secara terjadwal 11. Latih mengubah perilaku negatif yang kedua secara terjadwal 12. Berikan reinforcement positif 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 3**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1995 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengevaluasi manfaat melawan pikiran otomatis negatif dan mengubah perilaku negatif dengan memanfaatkan sistem pendukung.
TUJUAN	Status koping membaik, Perilaku kesehatan membaik ketahanan personal meningkat, dan kontrol diri meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Ciptakan hubungan terapeutik dan kolaboratif. 7. Monitor peristiwa yang tidak menyenangkan yang bertambah. 8. Monitor pikiran negatif yang bertambah. 9. Monitor perilaku negatif yang bertambah. 10. Monitor latihan melawan pikiran negatif dan perilaku negatif yang pertama dan kedua. 11. Monitor catatan harian (frekuensi munculnya

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 3**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1995 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	perilaku negatif dan latihan menggunakan aktivitas yang positif). 12. Monitor sistem pendukung pasien dari caregiver atau keluarga dan cara memanfaatkannya monitor sistem pendukung pasien dari luar keluarga dan cara memanfaatkannya. 13. Monitor manfaat melawan pikiran otomatis negatif dan mengubah perilaku negatife. 14. Berikan reinforcement positif. 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 4**		
	No.Dokumen A00.7.4 / 1996 / 2020	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengevaluasi manfaat melawan pikiran otomatis negatif dan mengubah perilaku negatif.
TUJUAN	Status koping membaik, perilaku kesehatan membaik ketahanan personal meningkat, kontrol diri meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Ciptakan hubungan terapeutik dan kolaboratif. 7. Monitor peristiwa yang tidak menyenangkan yang bertambah. 8. Monitor pikiran negatif yang bertambah. 9. Monitor perilaku negatif yang bertambah. 10. Monitor latihan melawan pikiran negatif dan perilaku negatif yang pertama dan kedua. 11. Monitor latihan manfaat sistem pendukung dari dalam dan dari luar pasien.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI KOGNITIF PERILAKU 4**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1996 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Monitor manfaat setelah melakukan latihan melawan pikiran dan mengubah perilaku negatif. 13. Berikan reinforcement positif. 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI MILEU**		
	No.Dokumen 400.7.9/1997/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan orang, sumber daya, dan/atau kejadian di lingkungan sekitar untuk meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi psikososial.
TUJUAN	Identitas diri meningkat, memori meningkat, tingkat konfusi menurun, penerimaan meningkat, status koping keluarga membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Sediakan lingkungan yang nyaman. 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 7. Jalin komunikasi terbuka antara pasien, perawat, dan staf lainnya. 8. Identifikasi kontribusi faktor lingkungan yang mendukung terapi. 9. Identifikasi sumber daya yang diperlukan. 10. Identifikasi jenis kegiatan yang sesuai.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI MILEU**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1997 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Sediakan buku, majalah, seni dan kerajinan sesuai latar belakang, budaya dan pendidikan. 12. Atur jadwal kegiatan harian. 13. Koordinasikan penurunan atau penyesuaian dosis obat sesuai dengan indikasi. 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI PERILAKU**		
	No.Dokumen 400.7.9/1998/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melatih mengubah perilaku melalui pemberian penghargaan (reward).
TUJUAN	Perawatan diri meningkat, pemeliharaan kesehatan meningkat, perilaku kesehatan membaik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Anjurkan pasien menyampaikan perilaku negatif dalam merawat diri. 7. Anjurkan pasien memilih satu perilaku negatif yang akan diubah. 8. Jelaskan cara mengubah perilaku yang sudah dipilih. 9. Jelaskan tentang penghargaan (reward) yang akan diberikan. 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 11. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI PERILAKU**		
	No.Dokumen 400.7.4/1998/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI REMEDIAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1999 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan penyesuaian teknik pembelajaran dan terapi pada anak berdasarkan gaya dan ketertarikan anak yang mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan berpikir secara optimal dan kemampuan logika dasar.
TUJUAN	Memori meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis.) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Berikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. 7. Identifikasi masalah dalam pembelajaran. 8. Identifikasi kemampuan dan kesulitan yang dialami. 9. Identifikasi kebutuhan akademik dan nonakademik. 10. Berikan materi agar mudah dipahami. 11. Berikan stimulus visual dan alat bantu sebagai media

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI REMEDIAL**		
	No.Dokumen 400.7.4/1999/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	pembelajaran (kartu angka, menyusun benda). 12. Berikan pertanyaan terhadap pelajaran yang sudah diberikan. 13. Berikan tugas untuk dievaluasi. 14. Berikan satu tugas pada satu waktu. 15. Berikan rutinitas terstruktur yang dapat diselesaikan anak. 16. Berikan kesempatan pasien untuk mengungkapkan perasaan setelah terapi. 17. Lakukan kontrak untuk pertemuan berikutnya. 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI REMINISENS**		
	No.Dokumen 400.7.4/2000/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan kemampuan mengenang kejadian, perasaan, dan pemikiran masa lalu untuk memfasilitasi relaksasi, kualitas hidup, atau adaptasi terhadap keadaan saat ini.
TUJUAN	Memori meningkat, tingkat ansietas menurun, tingkat berduka menurun, status spiritual membaik, harapan meningkat, tingkat konfusi menurun, status koping membaik, status koping keluarga membaik, penerimaan meningkat ketahanan personal meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis.) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Identifikasi makna kenangan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah dan nada suara. 7. Identifikasi jumlah peserta yang tepat untuk terapi reminisens dalam kelompok. 8. Gunakan pakaian yang nyaman. 9. Tetapkan metode reminisens yang paling efektif

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI REMINISENS**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 2000 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

(seperti autobiografi, jurnal, review peristiwa kehidupan, catatan, diskusi terbuka, dan storytelling).

10. Diskusikan kualitas afektif yang menyertai kenangan secara empati.
11. Berikan umpan balik positif langsung.
12. Berikan penguatan terhadap keterampilan koping sebelumnya.
13. Anjurkan mengekspresikan perasaan positif dan negatif terhadap kenangan secara lisan.
14. Anjurkan menuliskan masa lalu.
15. Anjurkan menulis surat kepada saudara atau teman lama.
16. Gunakan teknik mendengar aktif.
17. Gunakan alat bantu peraga (seperti musik untuk menstimulasi audio, album foto untuk menstimulasi kenangan).
18. Gunakan pertanyaan langsung dan terbuka tentang kejadian masa lalu.
19. Gunakan album foto untuk menstimulasi kenangan.
20. Gunakan keterampilan komunikasi (seperti memusatkan perhatian, merefleksi, dan mengekspresikan kembali, untuk mengembangkan hubungan).
21. Gunakan pertanyaan langsung untuk memfokuskan kembali ke peristiwa kehidupan, jika perlu.
22. Pertahankan berfokus pada proses daripada produk akhir setiap sesi.
23. Berikan dukungan dan empati kepada pasien dan keluarga.
24. Fasilitasi pasien dalam mengatasi kenangan buruk, kenangan yang menyakitkan, dan emosi negatif.
25. Fasilitasi keluarga terhadap manfaat terapi reminiscence.
26. Batasi lama sesi sesuai rentang perhatian, respons

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI REMINISENS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2000 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	dan kemauan melanjutkan. 27. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 28. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI RUMATAN MATADON**		
	No.Dokumen 400.7.4/2001/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan metadon disertai dengan intervensi psikososial bagi pasien dengan ketergantungan opioid sesuai kriteria diagnostik Pedoman Penggolongan Dan Diagnostik Gangguan Jiwa Ke III (PPDGJ-III).
TUJUAN	Tingkat konfusi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Lakukan pengambilan keputusan untuk indikasi Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM). 7. Lakukan skrining pasien yang memenuhi kriteria mengikuti Ptrm. 8. Rencanakan terapi (inisiasi, stabilisasi, dan rumatan) 9. Ajarkan klien dan keluarga tentang Ptrm. 10. Lakukan estimasi dosis obat yang sesuai untuk adiksi opiat.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI RUMATAN MATADON**		
	No.Dokumen 400.7.9/2001/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

11. Lakukan pemberian dosis awal yang dianjurkan, sesuai indikasi.
12. Berikan metadon dalam bentuk cair dan diencerkan sampai menjadi 100 cc dengan larutan sirup.
13. Berikan segelas air minum.
14. Pastikan metadon telah ditelan dengan meminta menyebutkan nama atau mengatakan sesuatu yang lain.
15. Monitor tanda-tanda toksisitas atau gejala putus obat selama 45 menit setelah pemberian dosis awal.
16. Lakukan dokumentasi pemberian obat disertai dengan tanda tangan.
17. Lakukan pemberian dosis stabilisasi, sesuai indikasi.
18. Lakukan pemberian dosis rumatan, sesuai indikasi.
19. Monitor dosis setiap hari.
20. Turunkan dosis secara bertahap maksimal sebanyak 10% setiap 2 minggu.
21. Lakukan penghentian metadon sesuai indikasi (seperti stabil, minimal 6 bulan terbebas heroin, dukungan hidup memadai).
22. Lakukan skrining ulang secara komprehensif jika pasien menyatakan keinginannya untuk kembali menjalani Ptrm.
23. Kolaborasi dengan tim medis untuk penilaian peningkatan/penurunan minimal satu kali seminggu pada bulan pertama, kemudian minimal setiap bulan.
24. Kolaborasi dengan tim medis, jika masih menggunakan heroin untuk peningkatan dosis.
25. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah.
26. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI RUMATAN MATADON**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2001 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SENI**		
	No.Dokumen 400.7.9 /2002/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan gambar atau bentuk kesenian lainnya untuk memfasilitasi komunikasi dan/atau penyembuhan.
TUJUAN	Harga diri meningkat, status koping membaik, tingkat ansietas menurun, tingkat konfusi menurun, kontrol diri meningkat, keberdayaan meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Identifikasi bentuk kegiatan berbasis seni. 7. Identifikasi media seni yang akan digunakan (seperti gambar/foto [manusia, keluarga), jurnal foto, jurnal media, grafik [waktu, peta tubuh], artefak [topeng.patung]). 8. Identifikasi tema karya seni. 9. Identifikasi konsep diri melalui gambar manusia.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SENI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2002 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Sediakan lingkungan tenang dan bebas distraksi. 11. Sediakan alat perlengkapan seni sesuai tingkat perkembangan dan tujuan terapi. 12. Anjurkan menggambar realistik atau artistik. 13. Anjurkan mendeskripsikan proses dan hasil pembuatan karya seni. 14. Anjurkan menggunakan lukisan atau gambar sebagai media menceritakan akibat stresor (seperti perceraian, pelecehan). 15. Batasi waktu penyelesaian. 16. Diskusikan makna karya seni yang dibuat, gabungkan penilaian pasien dengan literatur. 17. Diskusikan kemajuan sesuai tingkat perkembangan 18. Hindari mendiskusikan makna karya seni sebelum selesai dibuat. 19. Catat interpretasi klien terhadap gambar atau ciptaan artistik. 20. Salin/dokumentasikan karya seni untuk arsip, sesuai kebutuhan. 21. Rujuk sesuai indikasi (seperti pekerja sosial, terapi seni). 22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 23. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 1**		
	No.Dokumen 400.7.9/2003/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan dukungan kepada anggota kelompok pasien sehingga mampu mengidentifikasi masalah dan sumber pendukung yang ada.
TUJUAN	Manajemen kesehatan meningkat, harapan meningkat, keberdayaan meningkat, status koping membaik, penampilan peran membaik, penerimaan meningkat, psikospiritual membaik, ketahanan personal meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Bentuk kelompok 5-12 peserta. 7. Identifikasi peserta. 8. Diskusikan tentang masalah yang ada dari masing-masing peserta. 9. Identifikasi cara yang biasa dilakukan untuk mengatasi masalahnya.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 1**		
	No.Dokumen 400.7.9/2003/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Identifikasi hambatan dalam mengatasi masalah. 11. Identifikasi sumber pendukung yang ada baik internal (care giver, anak, orang tua) maupun eksternal (peer, kader, puskesmas) termasuk kemampuan. 12. Motivasi untuk mengungkapkan pendapat dan pikirannya. 13. Berikan umpan balik positif yang sudah mengungkapkan dengan benar. 14. Berikan masukan terhadap hal-hal yang belum diketahui. 15. Buat kesimpulan daftar masalah. 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 2**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 2009 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan dukungan kepada anggota kelompok pasien sehingga mampu mengidentifikasi masalah dan sumber pendukung dari dalam diri pasien.
TUJUAN	Manajemen kesehatan meningkat, harapan meningkat, keberdayaan meningkat, status koping membaik, penampilan peran membaik, penerimaan meningkat, psikospiritual membaik, ketahanan personal meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Bentuk kelompok 5-12 peserta. 7. Identifikasi peserta. 8. Diskusikan kemampuan positif dengan menggunakan sistem pendukung internal (yang ada dalam diri pasien). 9. Diskusikan hambatan dalam menggunakan sistem

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 2**		
	No.Dokumen 400.7.4/2009/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	pendukung internal (yang ada dalam diri pasien). 10. Anjurkan untuk mempraktikkan cara menggunakan sistem pendukung internal. 11. Diskusikan hasil setelah menggunakan sistem pendukung internal. 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 3**		
	No.Dokumen 400.7.4/2005/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan dukungan kepada anggota kelompok pasien sehingga mampu mengidentifikasi masalah dan sumber pendukung yang ada dari luar pasien (peer, kader, puskesmas, rumah sakit).
TUJUAN	Manajemen kesehatan meningkat, harapan meningkat, keberdayaan meningkat, status koping membaik, penampilan peran membaik, penerimaan meningkat, psikospiritual membaik, ketahanan personal meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis.) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Bentuk kelompok 5-12 peserta. 7. Identifikasi peserta. 8. Diskusikan kemampuan positif menggunakan sistem pendukung eksternal (di luar pasien). 9. Diskusikan hambatan dalam menggunakan sistem

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 3**		
	No.Dokumen 400.7.9/2005/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	pendukung eksternal. 10. Anjurkan untuk mempraktikkan cara menggunakan sistem pendukung eksternal. 11. Diskusikan hasil setelah menggunakan sistem pendukung eksternal. 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 4**		
	No.Dokumen 400.7.4/2006/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan dukungan kepada anggota kelompok pasien dengan mengevaluasi penggunaan sistem pendukung.
TUJUAN	Manajemen kesehatan meningkat, harapan meningkat, keberdayaan meningkat, status koping membaik, penampilan peran membaik, penerimaan meningkat, psikospiritual membaik, ketahanan personal meningkat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Bentuk kelompok 5-12 peserta. 7. Identifikasi peserta. 8. Anjurkan untuk menyampaikan pengalaman yang dipelajari. 9. Diskusikan hambatan dan kebutuhan yang diperlukan dalam menggunakan sistem pendukung yang ada.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SUPORTIF 4**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 2006 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Diskusikan cara memenuhi kebutuhan. 11. Diskusikan kelanjutan perawatan setelah program terapi. 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ZAT**		
	No.Dokumen 400.7.4 /2007/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan menurunkan risiko gaya hidup penggunaan zat.
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, persepsi sensori membaik, status koping membaik, kontrol diri meningkat, harga diri meningkat, ketahanan personal meningkat, status koping komunitas membaik, tingkat konfusi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Identifikasi kemungkinan perilaku berisiko penyalahgunaan zat. 7. Motivasi beradaptasi dengan peningkatan tingkat stres. 8. Motivasi mengantisipasi lingkungan yang mengakibatkan stres. 9. Motivasi pengambilan keputusan dalam memilih gaya hidup. 10. Motivasi mengikuti program Di Sekolah, Tempat Kerja

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ZAT**		
	No.Dokumen 400.7.4/2007/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	Atau Sosial. 11. Motivasi keluarga mendukung kebijakan pelarangan zat. 12. Diskusikan strategi pengurangan stres. 13. Diskusikan cara mempersiapkan diri dalam kondisi stres. 14. Libatkan dalam program aktivitas kelompok di masyarakat maupun pelayanan. 15. Dukung untuk ikut serta dalam kelompok masyarakat. 16. Dukung program pengurangan distribusi zat. 17. Fasilitasi dalam mengorganisir kegiatan bagi remaja. 18. Fasilitasi dalam mengkoordinasi berbagai kelompok masyarakat. 19. Latih asertif. 20. Latih pikiran dan perilaku. 21. Anjurkan menghindari perilaku menarik diri. 22. Ajarkan keluarga mengidentifikasi tanda dan gejala kecanduan. 23. Anjurkan keluarga berpartisipasi aktif dalam kegiatan anak di sekolah. 24. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 25. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGONTROLAN PENYALAHGUNAAN ZAT**		
	No.Dokumen 400.7.4/2008/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Pengendalian penggunaan zat yang tidak sesuai dengan indikasi medis sehingga dapat menimbulkan kecanduan hingga kematian.
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, persepsi sensori membaik, status koping membaik, kontrol diri meningkat, harga diri meningkat, ketahanan personal meningkat, status koping komunitas membaik, tingkat konfusi menurun.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 6. Identifikasi faktor penyebab stres. 7. Identifikasi perubahan fisik yang dialami. 8. Identifikasi kejadian yang menyebabkan pengguna zat dengan cara tidak menghakimi. 9. Validasi rasa frustrasi atau kemarahan dalam menangani masalah.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGONTROLAN PENYALAHGUNAAN ZAT**		
	No.Dokumen 400.7.4/2008/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Anjurkan segera mengatasi keinginan penggunaan zat (seperti pengendalian, keinginan, menolak, mengalihkan dan menghindari). 11. Ajarkan cara menghindari penggunaan zat Anjurkan mencatat aktivitas, perasaan dan pikiran dalam sebuah jurnal. 12. Latih meningkatkan motivasi (seperti latihan afirmasi dan berpikir positif). 13. Latihan sikap perilaku positif mengatasi masalah penggunaan zat. 14. Latih keterampilan sosial (seperti kontak mata, mendengarkan penuh perhatian, mengangnguk, percakapan sosial). 15. Berikan umpan balik dan dukungan positif setiap melakukan melakukan kegiatan sosial. 16. Diskusikan perencanaan jadwal sehari-hari dan jadwal mingguan. 17. Buat jadwal pada kalender, jika perlu. 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasiennyatakan keraguan sesuai fakta		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN JENAZAH**		
	No.Dokumen 400.7.4/2009/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan perawatan pada pasien yang telah Dinyatakan meninggal
TUJUAN	Tingkat Berduka Menurun, Psiko spiritual Membaik, Proses Keluarga Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Sarung tangan b. Apron c. Kain penutup jenazah d. Perban e. Kasa lembab f. Kapas lembab g. Waslap h. Bengkok 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan dan apron 8. Posisikan jenazah telentang 9. Berikan kesempatan kepada keluarga yang ingin terlibat dalam perawatan jenazah 10. Lepaskan alat-alat yang terpasang (misal infus, kateter, NGT) 11. Lepaskan perhiasan atau barang-barang pribadi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN JENAZAH**		
	No.Dokumen 400.7.4/2009/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2

	jenazah 12. Serahkan perhiasan atau barang-barang pribadi jenazah kepada keluarga 13. Bersihkan tubuh jenazah 14. Rapatkan kelopak mata jenazah dan tutup dengan kasa lembab 15. Rapatkan mulut jenazah dengan mengikat dagu dengan perban melingkari kepala 16. Posisikan tangan jenazah sesuai denga agama/kepercayaan 17. Rapatkan kedua kaki jenazah dengan perban melingkari pergelangan kaki dan kedua ibu jari kaki 18. Tutupi tubuh jenazah dengan kain penutup 19. Lepaskan sarung tangan dan apron 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Berikan dukungan emosional kepada keluarga, jika perlu 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PUTUS ZAT**		
	No.Dokumen 400.7.4 /2010/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengelola dan merawat pasien yang telah menggunakan zat secara rutin dengan dosis tertentu kemudian berhenti menggunakan atau menurunkan dosis yang menimbulkan gejala putus zat
TUJUAN	Status Koping Membaik, Perilaku Kesehatan Membaik, Ketahanan Personal Meningkat, Diri Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Ciptakan lingkungan rendah stimulasi 7. Monitor gejala putus zat, Monitor tanda-tanda vital (meliputi frekuensi napas, frekuensi nadi, tekanan darah) 8. Monitor risiko jatuh dengan menggunakan skala risiko jatuh 9. Lakukan perawatan sesuai gejala yang muncul

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PERAWATAN PUTUS ZAT</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4 / 2010 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(sepertikelelahan, gangguan sensorik, iritabel, depresi, serangan panik, ketagihan, insomnia, agitasi, nyeriotot, menguap, kelemahan, sakit kepala, pilek, pupil melebar, menggigil, ansietas, keringat, mual, muntah, tremor, psikosis, dan ataksia)
10. Fasilitasi kegiatan sehari-hari
11. Kolaborasi pemberian obat, jika perlu
12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat darurat</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PUTUS ZAT DENGAN TERAPI SUBSTITUSI**		
	No.Dokumen 400.7.A/2011/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengelola dan merawat pasien yang menjalani terapi substitusi dengan riwayat penggunaan zat secara rutin dengan dosis tertentu kemudian berhenti menggunakan atau menurunkan dosis yang menimbulkan gejala putus zat
TUJUAN	Status Koping Membaik, Perilaku Kesehatan Membaik, Ketahanan Personal Meningkat, Kontrol Diri Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Ciptakan lingkungan rendah stimulasi 7. Monitor tanda dan gejala putus zat 8. Monitor tanda-tanda vital (meliputi frekuensi napas, frekuensi nadi, tekanan darah) 9. Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala risiko jatuh

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PUTUS ZAT DENGAN TERAPI SUBSTITUSI**		
	No.Dokumen 400.7.9 /2011 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Berikan terapi subtitusi (seperti metadon, uprenofrin), sesuai indikasi 11. Pastikan pasien meminum obat dengan prinsip 6 benar 12. Pastikan obat ditelan dihadapan perawat 13. Monitor tanda-tanda vital setelah 45 menit meminum obat 14. Monitor efek terapeutik terapi subtitusi 15. Lakukan perawatan sesuai gejala yang muncul (seperti kelelahan, gangguan sensorik, iritabel, depresi, serangan panik, ketagihan, insomnia, agitasi, nyeri otot, menguap, kelemahan, sakit kepala, pilek, pupil melebar, menggigil, ansietas, keringat, mual, muntah, tremor, psikosis, dan ataksia) 16. Fasilitasi kegiatan sehari-hari 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI CITRA TUBUH**		
	No.Dokumen 400.7.4/2012/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan perbaikan perubahan persepsi terhadap Fisik pasien
TUJUAN	Harga Diri Meningkat, Konsep Diri Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkahprosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan 7. Identifikasi budaya agama, jenis kelamin dan umur terkait citra tubuh 8. Identifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial 9. Monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri 10. Monitor apakah pasien dapat melihat bagian tubuh yang berubah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI CITRA TUBUH**		
	No.Dokumen 400.7A/2012/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya 12. Diskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri 13. Diskusikan perubahan akibat pubertas, kehamilan dan penuaan 14. Diskusikan kondisi stress yang mempengaruhi citra tubuh (seperti luka, penyakit, pembedahan) 15. Anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh 16. Anjurkan menggunakan alat bantu (seperti pakaian, wig, kosmetik) 17. Latih fungsi tubuh yang dimiliki 18. Latih peningkatan penampilan diri 19. Latih mengungkapkan kemampuan diri kepada orang lain atau kelompok 20. Jelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI DUKUNGAN SPIRITUAL**		
	No.Dokumen 400.7.4/2013/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan rasa seimbang dan terhubung dengan kekuatan yang lebih besar
TUJUAN	Tingkat Berduka Menurun, Psikospiritual Membaik, Harapan Meningkat, Keberdayaan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Kesedian mendengarkan perasaan pasien 7. Identifikasi perspektif spiritual, sesuai kebutuhan 8. Perlakukan pasien dengan bermartabat dan terhormat 9. Tunjukkan keterbukaan, empati dan yakinkan bahwa perawat selalu ada dan mendukung 10. Gunakan teknik klarifikasi untuk membantu menilai keyakinan, jika perlu 11. Fasilitasi mengekspresikan dan mereda kan amarah secara tepat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI DUKUNGAN SPIRITUAL**		
	No.Dokumen 400.7.9/2013/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Motivasi meninjau kembali masalalu dan focus pada hal yang memberikan kekuatan spiritual 13. Motivasi berinteraksi dengan anggota keluarga, teman dan lainnya 14. Motivasi berpartisipasi dalam kelompok pendukung 15. Motivasi mengekspesikan perasaan (seperti kesepian, tidak berdaya dan kecemasan) 16. Fasilitasi melakukan aktivitas ibadah 17. Anjurkan untuk berdoa 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI HARAPAN**		
	No.Dokumen 900.7.9/2019/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan rasa seimbang dan terhubung dengan Kekuatan yang lebih besar
TUJUAN	Harapan Meningkat,Keberdayaan Meningkat,Tingkat Berduka Menurun,Psikospiritual Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi harapan pasien dan/atau keluarga dalam pencapaian hidup 7. Anjurkan mengungkapkan perasaan terhadap kondisi realitas 8. Sadarkan bahwa kondisi yang dialami memiliki nilai penting 9. Pandu mengingat kembali kenangan yang menyenangkan 10. Libatkan pasien secara aktif dalamperawatan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI HARAPAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 2019 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Kembangkan rencana perawatan yang melibatkan tingkat pencapain sederhana sampai ke kompleks 12. Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga terlibat dengan dukungan kelompok 13. Ciptakan lingkungan yang memudahkan kegiatan spiritual 14. Latih cara mengembangkan spiritual diri 15. Anjurkan mempertahankan hubungan (seperti menyebutkan nama orang yang dicintai) 16. Anjurkan mempertahankan hubungan terapeutik dengan orang lain 17. Latih menyusun tujuan hidup sesuai dengan harapan 18. Latih mengenang dan menikmati masa lalu (seperti prestasi dan pengalaman 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien dalam menangani situasi		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI HUBUNGAN POSITIF**		
	No.Dokumen 400.7.4/2015/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan interaksi antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan dan ditandai dengan adanya timbal balik yang sesuai
TUJUAN	Keterlibatan Sosial Meningkat,Konsep Diri Membaik, Interaksi Sosial Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Ciptakan suasana yang mendukung peningkatan hubungan 7. Diskusikan keuntungan berinteraksi dengan orang lain 8. Diskusikan kerugian tidak berinteraksi denganorang lain 9. Ajarkan cara berkenalan secara bertahap 10. Berikan pujian secara wajar jika berhasil membina hubungan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI HUBUNGAN POSITIF**		
	No.Dokumen 400.7.9/2015/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Anjurkan memasukkan jadwal berbincang dengan orang lain ke dalam jadwa kegiatan harian 12. Jelaskan kepada keluarga tentang pengertian, tanda dan gejala, serta proses terjadinya hambatan membina hubungan 13. Jelaskan kepada keluarga tentang kegiatan rumah tangga yang dapat melibatkan pasien berbicara 14. Latih keluarga cara membimbing pasien berbicara dan memberi pujian 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI KEPERCAYAAN DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.4/2016 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan keyakinan padakemampuan dalam merancang dan melaksanakan aktivitas yang dibutuhkan
TUJUAN	Citra Tubuh Meningkat,Harga Diri Meningkat,Konsep Diri Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. UcapkanSalam 2. Perkenalkandiri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Gunakan teknik mendengar aktif mengenai harapan pasien 7. Diskusikan kekuatan yang dimiliki (SWOT) serta hal yang penting (SMART) 8. Diskusikan rencana perubahan diri 9. Buat dan pilih keputusan prioritas untuk memecahkan masalah 10. Motivasi berpikir positif dan berkomitmen dalam mencapai tujuan 11. Diskusikan cara menangani situasi tidak terduga

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI KEPERCAYAAN DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.4/2016/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	secara efektif 12. Ajarkan pemecahan masalah dan situasi yang sulit 13. Buat catatan pribadi dalam menentukan pencapaian dan menikmati pencapaian 14. Kolaborasi dengan ners spesialis dalam memodifikasi intervensi, jika perlu 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang tela hdilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI KESADARAN DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2739 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Dir. Rrur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan pemahaman dan mengekplorasi pikiran, perasaan, motivasi, dan perilaku
TUJUAN	Identitas Diri Membaik, Interaksi Sosial Meningkat, Harga Diri Meningkat, Konsep Diri Membaik, Keberdayaan Meningkat, Status Koping Membaik, Penerimaan Meningkat, Psikospiritual Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi keadaan emosional saat ini 7. Diskusikan tentang pikiran, perilaku atau respon terhadap kondisi 8. Diskusikan dampak penyakit pada konsep diri 9. Anjurkan menyadari bahwa setiap orang unik 10. Anjurkan mengungkapkan perasaan 11. Anjurkan mengubah pandangan sebagai korban 12. Anjurkan mengidentifikasi perasaan bersalah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI KESADARAN DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.4/2239/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Anjurkan mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan 14. Anjurkan mengevaluasi kembali persepsi negatif tentang diri 15. Anjurkan mengekspresikan diri dengan kelompok sebaya 16. Ajarkan cara membuat prioritas hidup 17. Latih kemampuan membuat prioritas hidup 18. Anjurkan meminta bantuan orang lain, sesuai kebutuhan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI KOPING**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2017 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan upaya kognitif dan perilaku untuk menilai dan merespon stresor dan/atau kemampuan menggunakan sumber-sumber yang ada
TUJUAN	Tingkat Berduka Menurun , Status Spiritual Membaik, Harga Diri Meningkat , Citra Tubuh Meningkat, Identitas Diri Meningkat, Harapan Meningkat , Konsep Diri Membaik, Status Koping Keluarga Membaik, Keberdayaan Meningkat,Status Koping Membaik Ketahanan Personal Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Bina hubungan saling percaya 7. Identifikasi pemahaman tentang proses penyakit 8. Identifikasi dampak situasi terhadap peran dan hubungan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI KOPING**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2017 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Identifikasi metode penyelesaian masalah 10. Diskusikan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan mengevaluasi perilaku sendiri 11. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi Dukung penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat 12. Latih teknik relaksasi 13. Anjurkan penggunaan sumber spiritual,jika perlu 14. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi 15. Fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan 16. Identifikasi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang sesuai tujuan 17. Identifikasi kemampuan yang dimiliki 18. Identifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan 19. Motivasi untuk menentukan harapan yang realistis 20. Tinjau kembali kemampuan dalam mengambil keputusan 21. Hindari mengambil keputusan saat pasien berada di bawah tekanan 22. Lakukan kebersihan tangan 6 angkah 23. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI DETEKSI DINI STUNTING**		
	No.Dokumen 400.7.9/2018/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memeriksa secara dini masalah tinggi badan anak lebih Rendah atau pendek dari standar usianya
TUJUAN	Status Pertumbuhan Membaik,Status Perkembangan Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Papan pengukur panjang badan b. Timbangan berat badan c. Grafik PertumbuhanWHO(BB/U,TB/U, BB/TB) d. Alat tulis 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Lakukan penimbangan berat badan (BB) dan pengukuran panjang badan (PB) 1 bulan sekali 8. Catat hasil pengukuran BB dan PB ke dalam grafik pertumbuhan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI DETEKSI DINI STUNTING**		
	No.Dokumen A00.7.4 / 2018 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Periksa status riwayat antenata care ibu 10. Periksa status riwayat pemberian ASI eksklusif 11. Identifikasi kesiapan orangtua untuk memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) 12. Identifikasi adanya faktor risiko lain yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadi stunting pada anak (seperti pola pemberian makan,perilaku hidup bersih dan sehat) 13. Rujuk anak ke spesialis anak, jika dalam dua kali pengukuran berturut-turut tidak ada kenaikan berat badan atau bahkan mengalami penurunan untuk pemeriksaan lebih lanjut 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI DETEKSI DINI HIV/AIDS ADA BAYI/ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.4/2292/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi tentang identifikasi awal penyakit HIV/AIDS kepada orang tua keluarga terdekat
TUJUAN	Status pertumbuhan membaik, Status perkembangan membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi riwayat kehamilan 7. Identifikasi kesiapan dan kemampuan orang tua dalam menerima informasi 8. Jadwalkan edukasi sesuai dengan kesepakatan yang akan dilakukan 9. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Materi yang akan diberikan sesuai dengan deteksi dini HIV/AIDS pada bayi/anak (pengertian, penyebab, tanda dan gejala, tatalaksana, pemeriksaan HI/VAIDS secara berkala) b. Media yang digunakan (seperti leaflet, lembar balik atau booklet) c. Lembar evaluasi edukasi 10. Lakukan edukasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati 11. Pantau tumbuh kembang anak dengan HIV/AIDS, sesuai usia

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI DETEKSI DINI HIV/AIDS ADA BAYI/ANAK**		
	No.Dokumen ACO.7.4/2242/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Berikan dukungan pada anak dan keluarga dengan HIV/AIDS 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons orang tua		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI)**		
	No.Dokumen 400.7.4/2241/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi dan dukungan tentang makanan yang harus diberikan bersama dengan ASI ketika bayi telah berusia 6 bulan
TUJUAN	Status Nutrisi Bayi Membaik, Tingkat Pengetahuan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan: a. Flipchart tentang praktik-praktik pemberian makanan tambahan yang dianjurkan b. Contoh makanan lokal atau contoh pengelompokan makanan c. Contoh tekstur (kepekatan) bubur 7. Identifikasi kesiapan dan kemampuan ibu atau pengasuh untuk menerima informasi 8. Identifikasi kemampuan ibu atau pengasuh dalam

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI)**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 2291 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

menyediakan nutrisi

9. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan
10. Jelaskan tentang pentingnya tetap melanjutkan pemberian ASI setelah bayi berusia 6 bulan
11. Jelaskan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pemberian makanan tambahan bagi setiap kelompok umur, yaitu frekuensi, jumlah, tekstur (kepekatan), variasi (berbagai macam makanan), cara pemberian makanan secara aktif/responsif, dan kebersihan
12. Jelaskan langkah pemberian MP-ASI:
    a. Siapkan MP-ASI yang akan diberikan
    b. Anjurkan orang tua/pengasuh dan bayi mencuci tangan sebelum memberikan MP-ASI
    c. Jelaskan posisi bayi yang aman saat makan, yaitu duduk di pangkuan ibu atau di kursi yang aman
    d. Anjurkan menggunakan kain alas makan pada leher dan dada anak
    e. Anjurkan orangtua/pengasuh untuk menghindarkan bayi dari distraksi saat makan seperti mendudukkan anak di depan televisi, gawai atau lainnya
    f. Ajarkan untuk mendekatkan sendok berisi makanan ke bibir bayi dan biarkan bayi membuka mulutnya lebih dahulu (jangan memaksa untuk memasukkan makanan ke mulut bayi)
    g. Anjurkan memberikan makanan secara perlahan
    h. Anjurkan menghentikan pemberian makan jika bayi
    i. sudah menunjukkan tanda kenyang

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI)**		
	No.Dokumen 400.7.9/2241/2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	j. Anjurkan untuk membersihkan wajah dan tangan bayi dengan kain lap makan/tisu k. Anjurkan orang tua/pengasuh dan bayi mencuci tangan setelah pemberian makan 13. Berikan kesempatan kepada ibu atau pengasuh untuk bertanya 14. Evaluasi pemahaman ibu atau pengasuh tentang pendidikan kesehatan yang telah diberikan 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons ibu		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.9/2290/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	
PENGERTIAN	Memberikan informasi dan dukungan tentang cara menghindarkan anak dan penyakit tidak menular		
TUJUAN	Pemeliharaan Kesehatan Meningkat, Tingkat Pengetahuan Meningkat		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.		
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Sediakan media yang sesuai (seperti leaflet booklet) 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi kesiapan dan kemampuan orang tua atau pengasuh untuk menerima informasi 8. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 9. Gambarkan tentang pentingnya pencegahan PTM sejak masa kanak-kanak 10. Gambarkan tentang efek obesitas pada anak terhadap kemungkinan terjadinya PTM di masa yang akan datang		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA ANAK**		
	No.Dokumen A00.7.9/2290/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Gambarkan praktik-praktik yang dianjurkan untuk mencegah PTM pada anak (seperti pola makan, pola aktivitas) 12. Berikan kesempatan pada orang tua atau pengasuh untuk mengajukan pertanyaan 13. Periksa pemahaman orang tua atau pengasuh tentang pendidikan kesehatan yang telah dibenkan 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons orang tua		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PERAWATAN BAYI**		
	No.Dokumen 400.7.9/1876/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi dan dukungan mengenai perawatan bayi secara mandiri.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memastikan bayi mendapatkan perawatan yang tepat, mencegah infeksi, dan menjaga suhu tubuh bayi secara mandiri oleh keluarga.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Materi yang akan diberikan sesuai tahapan usia bayi b. Media yang akan digunakan (seperti leaflet, lembar balik, poster) c. Lembar evaluasi edukasi 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi kesiapan dan kemampuan orang tua atau pengasuh untuk menerima informasi.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PERAWATAN BAYI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1876 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	8. Ajarkan memandikan bayi dengan memperhatikan suhu ruangan 21-24 °C dan dalam waktu 5-10 menit, sehari 2 kali 9. Ajarkan perawatan tali pusat. 10. Anjurkan memantau tanda vital bayi, terutama suhu tubuh 11. Anjurkan untuk menjemur bayi sebelum pukul 09.00. 12. Ajarkan pijat bayi. 13. Anjurkan segera mengganti popok jika basah. 14. Anjurkan penggunaan pakaian bayi dari bahan katun. 15. Anjurkan menyusui sesuai kebutuhan bayi. 16. Berikan kesempatan kepada orang tua atau pengasuh untuk mengajukan pertanyaan. 17. Periksa pemahaman orang tua atau pengasuh. tentang pendidikan kesehatan yang telah diberikan. 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons orang tua.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PERAWATAN HIV/AIDS PADA ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1893 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi dan dukungan mengenai penatalaksanaan penyakit HIV/AIDS pada anak.
TUJUAN	Sebagai acuan dalam memberikan edukasi yang komprehensif bagi keluarga/orang tua guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan dalam penatalaksanaan HIV/AIDS pada anak, serta menekan angka infeksi.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Materi tentang perawatan HIV/AIDS pada anak (pengertian, penyebab, tanda dan gejala, perawatan, tumbuh kembang anak dengan HIV/AIDS, imunisasi, komplikasi dan tata laksana pengobatan b. Media yang akan digunakan (seperti leaflet,

	lembar balik, poster) 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi kesiapan dan kemampuan orang tua atau pengasuh untuk menerima informasi 8. Lakukan edukasi sesuai dengan jadwal yang disepakati 9. Berikan kesempatan pada orang tua atau pengasuh untuk mengajukan pertanyaan 10. Periksa pemahaman orang tua atau pengasuh tentang pendidikan kesehatan yang telah diberikan 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 12. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons orang tua.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI STIMULASI PERKEMBANGAN BAYI/ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.4/1894/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi dan dukungan tentang kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0-6 tahun agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memberikan edukasi kepada orang tua/keluarga mengenai stimulasi yang tepat guna mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP) b. Leaflet stimulasi perkembangan sesuai usia anak c. Alat bantu pemeriksaan SDIDTK d. Alat tulis 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi kesiapan dan kemampuan orang tua

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI STIMULASI PERKEMBANGAN BAYI/ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.9/1894/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	atau pengasuh mengenai stimulasi perkembangan pada bayi/anak 8. Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan, dan tahun anak lahir 9. Pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak 10. Jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab 11. Tanyakan pertanyaan satu per satu secara berurutan 12. Lakukan interpretasi hasil KPSP 13. Berikan intervensi sesuai dengan interpretasi hasil KPSP 14. Jelaskan cara stimulasi perkembangan sesuai usia anak untuk dapat dikerjakan oleh orang tua di rumah 15. Berikan *leaflet* stimulasi perkembangan sesuai usia anak 16. Berikan kesempatan kepada orang tua atau pengasuh untuk mengajukan pertanyaan 17. Periksa pemahaman orang tua atau pengasuh tentang pendidikan kesehatan yang telah diberikan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons orang tua.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MEMANDIKAN BAYI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1895 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan membersihkan kulit dan tubuh bayi untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menjaga kebersihan tubuh, meningkatkan kenyamanan, dan mencegah infeksi kulit pada bayi.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Kom besar (2 buah) b. Bak mandi (jika perlu) c. Air hangat dengan suhu sekitar 38 °C d. Sabun mandi dan sampo khusus untuk bayi e. Waslap (2 buah) f. Handuk mandi g. Termometer h. Kapas

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MEMANDIKAN BAYI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1895 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

i. Pakaian ganti (baju, popok, bedong, dan topi), sesuai kebutuhan
j. Sarung tangan bersih, jika perlu
k. Pengalas

6. Pastikan bayi tidak hipotermia (jika suhu bayi <36,5 °C, bayi hanya dilap pada muka dan bokong saja, serta jika suhu bayi >36,5 °C, bayi boleh dimandikan)
7. Siapkan pakalan ganti
8. Atur lingkungan (seperti suhu ruangan 21-24 °C, matikan AC, dan tutup jendela)
9. Pasang pengalas dan handuk mandi
10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
11. Pasang sarung tangan bersih jika perlu
12. Bersihkan daerah muka dengan waslap basah tanpa sabun dari arah dalam ke luar lalu keringkan dengan handuk
13. Bersihkan kedua mata bergantian dengan kapas basah dari arah kantus bagian dalam ke bagian luar lalu keringkan dengan handuk
14. Bersihkan daerah telinga dengan kapas basah, lalu keringkan dengan handuk
15. Bersihkan bagian kepala bayi dengan waslap basah dan sampo bayi lalu bilas dan keringkan dengan handuk
16. Lepaskan pakaian bayi
17. Bersihkan badan bayi dengan menggunakan waslap basah yang sudah diberi sabun mulai dari bagian leher, dada, perut, dan punggung
18. Bilaslah dengan waslap basah hingga bersih, lalu keringkan dengan handuk

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MEMANDIKAN BAYI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1895 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	19. Lakukan perawatan tall pusat jika tali pusat belum terlepas 20. Lepaskan popok bayi, lalu bersihkan daerah perineal dengan kapas basah 21. Bersihkan daerah perineal dengan waslap basah dan sabun, lalu bilas hingga bersih, setelah itu, keringkan dengan handuk 22. Bersihkan bagian kaki bayi dengan waslap basah dan sabun, lalu bilas hingga bersih, setelah itu, keringkan dengan handuk 23. Jika memungkinkan, bayi dapat dimandikan di dalam bak mandi 24. Pakaikan pakaian ganti 25. Pastikan bayi dalam posisi aman saat dimandikan (sangga leher dan kepala bayi dengan tepat, jaga agar bayi tidak tergelincir saat di dalam bak mandi) 26. Pastikan tubuh bayi selalu tertutup saat mandi kecuali daerah yang sedang dibersihkan, untuk menghindari kedinginan 27. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 28. Lepaskan sarung tangan jika menggunakan 29. Lakukan kebersihan tangan dengan 6 langkah 30. Dokumentasikan prosedur, respons, dan temuan yang ada (seperti kondisi tali pusat, dan kondisi kulit jika ada iritasi atau luka).		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN ANTROPOMETRI PADA BAYI/ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1896 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis data untuk menilai status pertumbuhan dan status gizi.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menilai status pertumbuhan dan perkembangan bayi/anak secara akurat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Rekam medis dan/atau buku KIA b. Timbangan c. Meteran d. Grafik pertumbuhan WHO 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Lakukan pengukuran antropometri pada pasien (meliputi berat badan, tinggi atau panjang badan, lingkar lengan atas)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN ANTROPOMETRI PADA BAYI/ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1896 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	8. Lakukan analisis dengan menggunakan indikator yang disepakati: a. TB/U (Tinggi Panjang Badan menurut Umur) b. BB/U (Berat Badan menurut Umur) c. BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan) d. IMT/U (Indeks Massa Tubuh menurut Umur) e. Z-Score 9. Bandingkan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya 10. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 12. Dokumentasikan hasil pemantauan.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN ASUHAN PERKEMBANGAN PADA NEONATUS**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1897 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi kelanjutan kehidupan neonatus seperti kehidupan dalam uterus.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam mengoptimalkan pertumbuhan, perkembangan, dan stabilisasi kondisi bayi selama perawatan.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Kain bedong untuk membuat *nesting* b. Kain penutup inkubator yang tidak tembus cahaya c. Alat monitor d. Alat pengukur intensitas suara e. Instrumen penilaian nyeri untuk neonatus 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Posisikan bayi seperti dalam rahim dengan

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PEMBERIAN ASUHAN PERKEMBANGAN PADA NEONATUS</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4 /1897/
2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">menggunakan nesting yang sesuai dengan ukuran bayi
8. Lakukan Perawatan Metode Kanguru (PMK)
9. Lakukan pembedongan (swaddling) pada bayi
10. Tutup inkubator dengan kain yang tidak tembus cahaya
11. Periksa bayi terus-menerus dengan menggunakan alat monitor
12. Kecilkan suara alarm alat-alat monitor dan volume suara ketika berbicara
13. Lakukan atraumatic care ketika melakukan tindakan keperawatan yang menyakitkan
14. Libatkan orangtua dalam perawatan bayinya
15. Berikan non-nutritive sucking
16. Periksa pertumbuhan dan perkembangan neonatus
17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons bayi.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat Darurat.</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MPASI)**		
	No.Dokumen 400.7.4/1898/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan makanan selain ASI pada bayi berusia 6-24 bulan.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi tambahan yang adekuat, aman, dan sesuai tahapan usia guna mencegah stunting serta risiko aspirasi.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. MPASI (sesuaikan jumlah, tekstur, dan variasi sesuai dengan usia bayi) b. Mangkuk, sendok, dan gelas c. Kain alas makan d. Kain lap makan/tisu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi kesiapan bayi dan ibu, atau pengasuh

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MPASI)**		
	No.Dokumen 400.7.4/1898/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	untuk pemberian MPASI 8. Pastikan tangan bayi dan ibu atau pengasuh dalam kondisi bersih 9. Posisikan anak duduk di pangkuan ibu atau di kursi yang aman 10. Pasangkan kain alas makan pada leher dan dada bayi 11. Hindarkan anak dari distraksi saat makan (seperti mendudukkan anak di depan televisi, gawai) 12. Dekatkan sendok berisi makanan ke mulut bayi dan biarkan bayi membuka mulutnya lebih dahulu (jangan memaksa untuk memasukkan makanan ke mulut bayi) 13. Berikan makanan secara perlahan 14. Hentikan pemberian makan jika bayi sudah menunjukkan tanda kenyang 15. Lepaskan kain alas makan segera setelah selesai makan 16. Bersihkan wajah dan tangan bayi dengan kain lap makan/tisu 17. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI BERCERITA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1899 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan cerita naratif seperti dongeng, mitos, legenda, dengan improvisasi tertentu untuk memulihkan masalah fisik dan/atau psikologis.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam memberikan terapi bercerita untuk meningkatkan interaksi sosial dan mengoptimalkan status perkembangan pasien.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kesiapan anak 7. Identifikasi minat anak terhadap cerita 8. Identifikasi tema yang disukai 9. Sepakati tema cerita yang akan digunakan bersama pasien 10. Jadwalkan terapi bercerita sesuai dengan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI BERCERITA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1899 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	kesepakatan yang telah dibuat 11. Siapkan tema cerita yang akan digunakan 12. Sediakan lingkungan yang nyaman 13. Atur posisi anak senyaman mungkin 14. Jalin keakraban dengan anak dan keluarga 15. Mulai bercerita dari hal yang sederhana hingga kompleks 16. Fokuskan pandangan pada anak 17. Minta tanggapan anak tentang tema yang diceritakan 18. Berikan umpan balik dan *reinforcement* positif 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI BERMAIN**		
	No.Dokumen 900.7.4/1900/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan media atau mainan untuk memfasilitasi anak dalam mengkomunikasikan persepsi, pengetahuan dan penguasaan anak terhadap lingkungannya.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam memberikan terapi bermain guna meningkatkan kemampuan kontrol diri anak serta mengoptimalkan status pertumbuhan dan perkembangan anak selama masa hospitalisasi.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Sediakan peralatan bermain yang aman, sesuai, kreatif, tepat guna, merangsang perkembangan anak, serta mendorong ekspresi pengetahuan dan perasaan anak 7. Sediakan waktu yang cukup untuk memungkinkan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI BERMAIN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1900/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	sesi bermain berjalan efektif 8. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 9. Atur sesi bermain untuk memfasilitasi hasil yang diinginkan 10. Tetapkan batasan untuk sesi latihan terapeutik 11. Motivasi anak untuk berbagi perasaan, pengetahuan, dan persepsi 12. Komunikasikan penerimaan perasaan, baik positif maupun negatif, yang diungkapkan melalui permainan 13. Monitor respons anak terhadap terapi 14. Monitor tingkat kecemasan anak selama terapi 15. Lanjutkan sesi bermain secara teratur untuk membangun kepercayaan dan mengurangi rasa takut akan peralatan atau perawatan yang tidak dikenal 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN BAYI SEBELUM PEMULANGAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1901/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menilai kondisi bayi sebelum pulang dari perawatan.
TUJUAN	Sebagai acuan dalam langkah-langkah menilai kesiapan fisik bayi serta memberikan edukasi perawatan pasca-rawat bagi orang tua sebelum bayi pulang.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Termometer b. Timbangan c. Meteran atau pita ukur d. Jam atau pengukur waktu e. Sarung tangan 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Lakukan pengukuran panjang badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar perut, dan lingkar dada 8. Lakukan pemeriksaan TTV (meliputi frekuensi nadi,

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMERIKSAAN BAYI SEBELUM PEMULANGAN**		
	No.Dokumen 400.7.9/1901/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	frekuensi napas, dan suhu) 9. Lakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki 10. Lakukan pemeriksaan kemampuan menyusu bayi 11. Pastikan TTV dalam batas normal dan stabil selama 12 jam sebelum pemulangan. Pastikan bayi telah BAK regular dan BAB 1 kali dalam 1 hari 12. Pastikan bayi tidak ada gejala sepsis 13. Pastikan bayi sudah diberikan imunisasi hepatitis B0 14. Ajarkan orang tua tentang perawatan bayi di rumah 15. Ajarkan orang tua tentang tanda bahaya pada bayi 16. Anjurkan orang tua untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat jika ada tanda bahaya pada bayi 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PALIATIF PADA ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1902 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan perawatan terpadu pada anak untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan bantuan dalam mengatasi nyeri dan gejala, dukungan spiritual serta psikososial dari diagnosis hingga akhir kehidupan dan kematian.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi petugas dalam memberikan pelayanan perawatan paliatif guna meningkatkan kualitas hidup anak secara terpadu serta mendampingi keluarga melewati fase kedukaan.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Losion b. Aromaterapi c. Baskom berisi air hangat/dingin d. Daftar nama dan nomor telepon kerohanian

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PALIATIF PADA ANAK**		
	No.Dokumen 400.7.4 /1902/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri 8. Berikan tindakan nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri atau meningkatkan kenyamanan (seperti hipnosis, akupresur, kompres hangat/dingin, pijat, pengaturan posisi) 9. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri atau ketidaknyamanan (seperti suhu, ruangan, pencahayaan, dan kebisingan) 10. Monitor keberhasilan tindakan nonfarmakologis yang sudah diberikan 11. Fasilitasi istirahat tidur dan tetapkan jadwal rutin tidur 12. Dukung keluarga dan pengasuh terlibat dalam program perawatan dan pengobatan 13. Fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan 14. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan 15. Perkenalkan dengan orang atau kelompok yang mengalami pengalaman yang sama 16. Sediakan sarana yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan ibadah 17. Fasilitasi pembimbingan rohani oleh keluarga atau rohaniawan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN TALI PUSAT**		
	No.Dokumen A00.7.4/1476/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan tindakan untuk pencegahan infeksi dan mempercepat proses terlepasnya tali pusat pada bayi baru lahir.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan perawatan tali pusat pada bayi baru lahir agar tetap bersih, kering, serta mencegah terjadinya infeksi.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Kasa steril c. Air bersih dalam kom d. Bengkok 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN TALI PUSAT**		
	No.Dokumen 900.7.9 /1976/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	8. Buka popok/pakaian bayi 9. Bersihkan tali pusat dengan menggunakan kasa yang telah diberikan air bersih 10. Keringkan tali pusat sampai benar-benar kering dengan menggunakan kasa 11. Buang kasa bekas mengeringkan tali pusat ke dalam bengkok 12. Pertahankan tali pusat dalam kondisi terbuka 13. Periksa tanda-tanda infeksi 14. Lipat popok di bawah sisa tali pusat (hindari tali pusat tertutup popok) 15. Rapikan bayi dan alat-alat yang digunakan 16. Lepaskan sarung tangan 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons bayi.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PIJAT BAYI**		
	No.Dokumen A00.7.4/1838/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/8
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan stimulasi kulit dan jaringan dengan berbagai teknik gerakan dan tekanan tangan untuk meningkatkan relaksasi, memperbaiki sirkulasi, dan/atau stimulasi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memberikan stimulasi pada bayi guna mengoptimalkan status pertumbuhan, perkembangan, serta meningkatkan sirkulasi darah.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Minyak bayi b. Handuk bayi 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pastikan lingkungan aman dan nyaman. 8. Libatkan orang tua dalam kegiatan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PIJAT BAYI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1838 / 2016	No.Revisi 05	Halaman : 2/8

9. Tuangkan minyak bayi di telapak tangan
10. Posisikan bayi sesuai area tubuh yang akan dipijat
11. Lakukan pemijatan pada kaki:
    a. Perahan India

       Pegang kaki bayi pada pangkal paha, seperti memegang pemukul soft ball. Gerakkan tangan ke bawah secara bergantian, seperti memerah susu
    b. Peras dan putar

       Peras dan putar pangkal paha dengan kedua tangan secara bersamaan secara lembut dimulai dari pangkal paha ke arah mata kaki
    c. Telapak kaki

       Urut dengan kedua ibu jari secara bergantian, dimulai dari tumit kaki menuju jari-jari di seluruh telapak kaki
    d. Tarik lembut jari

       Pijat jari kaki satu persatu dengan gerakan memutar dan lakukan tarikan lembut
    e. Gerakan peregangan

       Pijat telapak kaki mulai dari batas jari-jari ke arah tumit dengan mempergunakan sisi dari jari telunjuk, kemudian ulangi dari perbatasan jari ke arah tumit
    f. Titik tekanan

       Tekan-tekanlah kedua ibu jari secara bersamaan di seluruh permukaan telapak kaki dari arah tumit ke jari kaki
    g. Punggung kaki

       Pijat punggung kaki dari pergelangan kaki ke arah jari-jari secara bergantian dengan

mempergunakan kedua ibu jari secara bergantian

h. Peras dan putar pergelangan kaki

Buat gerakan seperti memeras dengan mempergunakan ibu jari dan jari- jari lainnya di pergelangan kaki bayi

i. Perahan cara Swedia

Pegang pergelangan kaki bayi dan gerakkan tangan secara bergantian dari pergelangan kaki ke pangkal paha

j. Gerakan menggulung

Pegang pangkal paha dengan kedua tangan. Buatlah gerakan menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki

k. Gerakan akhir

Rapatkan kedua kaki bayi dengan meletakkan kedua tangan secara bersamaan pada pangkal paha, lalu usap kedua kaki bayi dengan tekanan lembut dari paha ke arah pergelangan kaki

12. Lakukan pemijatan pada perut:

a. Mengayuh sepeda

Lakukan gerakan memijat pada perut bayi seperti mengayuh pedal sepeda, dari atas ke bawah perut, bergantian dengan tangan kanan dan kiri

b. Mengayuh sepeda dengan kaki diangkat Angkat kedua kaki bayi dengan salah satu tangan. Pijat perut bayi dari perut bagian atas sampai ke jari-jari kaki dengan tangan yang lain

c. Ibu jari ke samping

Letakkan kedua ibu jari di samping kanan dan

kiri pusar perut. Gerakkan kedua ibu jari ke arah tepi perut kanan dan kiri

d. Bulan matahari

Buat lingkaran searah jarum jam dengan tangan kiri mulai dari perut sebelah kanan bawah ke atas, kemudian kembali ke daerah kanan bawah. Gunakan tangan kanan untuk mambuat gerakan setengah lingkaran mulai dari daerah kanan bawah sampai bagian kiri bawah perut bayi. Tangan kiri selalu membuat bulatan penuh (matahari), sedangkan tangan kanan akan membuat gerakan setengah lingkaran (bulan)

e. Gerakan *I Love You*

1) "I" pijat perut bayi mulai dari bagian kiri atas ke bawah membentuk huruf "I"

2) "LOVE", pijatlah perut bayi membentuk huruf "L" terbalik, mulai dari kanan atas ke kiri atas, kemudian dari kiri atas ke kiri bawah

3) "YOU" pijat perut bayi membentuk huruf "U" terbalik, mulai dari kanan bawah (daerah usus buntu) ke atas, kemudian ke kiri, ke bawah, dan berakhir di perut kiri bawah

f. Gelembung atau jari jari berjalan

Gerakkan jari-jari anda pada perut bayi dan bagian kanan ke bagian kiri guna mengeluarkan gelembung-gelembung udara

13. Lakukan pemijatan pada dada:

a. Jantung besar

Buatlah gerakan yang menggambarkan jantung dengan meletakkan ujung- ujung jari kedua telapak tangan anda di tengah dada. Buat

gerakan ke atas sampai di bawah leher, kemudian ke samping di atas tulang klafikula, lalu ke bawah membentuk bentuk jantung

b. Kupu-kupu

Buatlah gerakan diagonal seperti gambaran kupu-kupu dimulai dengan tangan kanan membuat gerakan memijat menyilang dari tengah dada ke arah bahu kanan, lalu gerakkan tangan kiri anda menyilang dari tengah dada ke bahu kiri

14. Lakukan pemijatan pada tangan

a. Pijat ketiak

Buatlah gerakan memijat pada daerah ketiak dari atas ke bawah. Gerakan ini tidak dilakukan jika terdapat pembengkakan kelenjar di daerah ketiak

b. Perahan India

Gerakan seperti memerah susu sapi mulai dari pangkal lengan sampai pergelangan tangan

c. Peras dan putar

Peras dan putar lengan bayi dengan lembut mulai dari pangkal lengan ke pergelangan tangan

d. Membuka tangan

Pijat telapak tangan bayi dengan kedua ibu jari, dari pergelangan tangan kearah jari tangan bayi

e. Putar jari-jari

Pijat lembut jari bayi satu persatu menuju ke arah ujung jari dengan gerakan memutar

f. Punggung tangan

Usap punggung tangannya dari pergelangan tangan ke arah jari-jari dengan lembut

g. Peras pergelangan tangan

Putar dengan ibu jari dan jari telunjuk seolah memeras lembut pergelangan tangan

h. Perahan Swedia

Gerakan tangan kanan dan kiri anda secara bergantian dari pergelangan tangan bayi ke arah pangkal lengan

i. Gerakan menggulung

Peganglah lengan atas bayi dengan kedua telapak tangan dan lakukan gerakan menggulung dari pangkal lengan menuju ke arah pergelangan tangan

15. Lakukan pemijatan bagian muka

a. Dahi

Letakkan jari-jari kedua tangan anda pada pertengahan dahi. Tekankan jari- jari anda dengan lembut mulai dari tengah dahi ke samping kanan dan kiri. Lalu gerakan ke bawah ke daerah pelipis, buatlah lingkaran-lingkaran kecil di daerah pelipis, kemudian gerakan hingga ke bawah mata

b. Alis

Gunakan kedua ibu jari untuk memijat secara lembut alis mata dan kelopak mata, mulai dari tengah ke samping

c. Hidung

Letakkan kedua ibu jari anda pada pertengahan alis, Tekankan ibu jari anda dari pertengahan kedua alis turun melalui tepi hidung ke arah pipi dengan membuat gerakan ke samping dan ke atas

d. Mulut bagian atas

Letakkan kedua ibu jari anda di maksilaris. Gerakkan kedua ibu jari anda dari tengah ke samping dan ke atas ke daerah pipi

e. Mulut bagian bawah

Gunakan kedua ibu jari memijat mandibularis dengan gerakan dari tengah ke samping, kemudian ke atas ke arah atas

f. Lingkaran kecil di rahang

Gunakan ibu jari kedua tangan memutar seperti membuat lingkaran kecil

g. Belakang telinga

Belakang telinga Berikan tekanan lembut pada daerah belakang telinga kanan dan kiri Gerakkan ke arah pertengahan dagu di bawah dagu

16. Lakukan pemijatan pada punggung.

a. Gerakan maju mundur

Berikan posisi prone melintang. pijat sepanjang punggung bayi dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan, dari bawah leher sampai ke bokong bayi

b. Gerakan menyetrika

Tahan bokong bayi dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri memijat mulai dari leher ke bokong bayi

c. Gerakan menyetrika dan mengangkat

Ulangi gerakan menyetrika punggung, hanya kali ini tangan kanan memegang kaki bayi dan gerakan dilanjutkan sampai ke tumit kaki bayi

d. Gerakan melingkar

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PIJAT BAYI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1838/2026	No.Revisi 05	Halaman : 8/8
	Buatlah gerakan melingkar mulai dari batas tengkuk turun ke bawah di sebelah kanan dan kiri tulang punggung sampai di bokong. e. Gerakan menggaruk Tekankan dengan lembut kelima jari-jari tangan kanan pada punggung bayi sampai ke bokong bayi 17. Monitor respons bayi selama pemijatan 18. Ajarkan dan evaluasi pemahaman dan kemampuan orang tua atau keluarga mengenai gerakan pijat bayi yang diberikan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons bayi.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PERAWATAN DIRI : BERPAKAIAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1839/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan membantu dan memfasilitasi pasien untuk memenuhi kebutuhan berpakaian dan berhias secara mandiri dan optimal.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam membantu pasien memenuhi kebutuhan berpakaian, meningkatkan mobilisasi, dan menjaga kebersihan diri.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih, jika perlu b. Alat berhias (seperti sisir dan gunting pencukur rambut) 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Sediakan pakaian pada tempat yang mudah dijangkau

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PERAWATAN DIRI : BERPAKAIAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1839 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Sediakan pakaian pribadi, sesuai kebutuhan 10. Fasilitasi mengenakan pakaian, jika perlu 11. Fasilitasi berhias (seperti menyisir rambut, merapikan kumis dan jenggot) 12. Jaga privasi pasien selama berpakaian 13. Tawarkan untuk *laundry*, jika perlu 14. Berikan pujian terhadap kemampuan berpakaian secara mandiri 15. Lepaskan sarung tangan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PERAWATAN DIRI : MANDI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1840 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kebersihan diri pasien.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi perawat dalam memberikan dukungan perawatan diri: mandi untuk menjaga kebersihan tubuh dan kenyamanan pasien.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Handuk mandi 2 buah c. Selimut mandi d. Sabun mandi e. Waskom 2 buah berisi air hangat (43-46°C) f. Pakaian bersih g. Linen tambahan, jika perlu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PERAWATAN DIRI : MANDI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1840 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

h. Bengkok
i. Losion, jika perlu

6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
7. Pasang sarung tangan bersih
8. Jaga privasi pasien
9. Buka pakaian pasien dan perhatikan adanya luka, selang infus atau alat-alat kesehatan lainnya
10. Tutup bagian tubuh yang terbuka dengan selimut mandi
11. Bersihkan area kepala/wajah:
    a. Letakkan handuk di dada
    b. Bersihkan mata dari kantus sebelah dalam keluar, lalu keringkan
    c. Bersihkan wajah dan telinga, lalu keringkan
12. Bersihkan area lengan:
    a. Letakkan handuk memanjang di bawah lengan
    b. Bersihkan lengan terjauh terlebih dahulu
    c. Bersihkan tangan sampai ketiak dengan usapan memanjang dan tegas dari distal ke proksimal, lalu keringkan
13. Letakkan handuk di atas dada dan abdomen
14. Bersihkan area dada:
    a. Lipat handuk area dada ke arah umbilicus
    b. Bersihkan dada dengan usapan memanjang dan tegas, lalu keringkan
15. Bersihkan area abdomen:
    a. Lipat handuk area abdomen ke arah dada
    b. Bersihkan abdomen dengan usapan memanjang dan tegas, lalu keringkan
16. Bersihkan area kaki:
    a. Tutup kaki dengan selimut mandi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PERAWATAN DIRI : MANDI**		
	No.Dokumen 900.7.4 / 1890 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	b. Bersihkan kaki terjauh terlebih dahulu c. Buka selimut pada kaki yang akan dibersihkan, lalu pasang handuk memanjang di bawahnya d. Bersihkan kaki dengan usapan memanjang dan tegas, lalu keringkan 17. Bersihkan area punggung: a. Tutup badan pasien dengan selimut mandi b. Atur posisi pasien miring c. Letakkan handuk di sepanjang punggung dan bokong d. Bersihkan punggung dengan usapan memanjang dan tegas dari area leher hingga ke bokong, lalu keringkan e. Lakukan pemijatan pada punggung dan berikan losion, jika perlu 18. Bersihkan area genitalia: a. Tawarkan apakah akan membersihkan secara mandiri atau difasilitasi perawat b. Letakkan handuk pada area dada dan perut serta selimut mandi pada area kaki c. Bersihkan area genitalia, lalu keringkan 19. Fasilitasi mengenakan pakaian 20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 21. Lepaskan sarung tangan 22. Buang sarung tangan kotor ke dalam bengkok 23. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 24. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PERAWATAN GIGI PALSU**		
	No.Dokumen 400.7.4/1892/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengajarkan perawatan kebersihan mulut dan gigi palsu.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah edukasi bagi pasien agar mampu melakukan perawatan gigi palsu dan kebersihan mulut secara mandiri.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 6. Sediakan lingkungan yang kondusi 7. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 8. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 9. Identifikasi pengetahuan tentang perawatan gigi palsu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PERAWATAN GIGI PALSU**		
	No.Dokumen 400.7.9/1892/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Jelaskan prosedur membersihkan mulut dan gigi palsu 11. Anjurkan melepas gigi palsu bagian bawah terlebih dahulu kemudian gigi atas 12. Anjurkan memeriksa gigi palsu (retak, ujung tajam, ada bagian gigi yang hilang) 13. Anjurkan melepas gigi palsu minimal 1 jam (idealnya semalaman dan gigi palsu ditempatkan dalam cairan untuk gigi palsu atau air) 14. Anjurkan meletakkan gigi palsu jauh dari jangkauan anak-anak 15. Anjurkan memeriksa kondisi bibir, mulut, lidah, langit-langit, dan dasar mulut 16. Ajarkan membersihkan semua permukaan gigi palsu dengan sikat gigi lembut, dan bilas dengan air mengalir 17. Anjurkan menemui dokter gigi jika gigi palsu pecah, retak, atau terasa longgar 18. Evaluasi pemahaman pasien tentang edukasi yang telah diberikan 19. Berikan penguatan positif terhadap kemampuan yang didapat 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN KAKI**		
	No.Dokumen 900.7.9 / 1843 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan pemeriksaan dan pembersihan kaki untuk menjaga kebersihan serta mencegah infeksi kulit.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan perawatan kaki guna menjaga kebersihan, memelihara integritas kulit/jaringan, serta mencegah komplikasi luka pada pasien.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Set perawatan kaki (gunting kuku, sikat kaki, amplas kaki) b. Sarung tangan bersih c. Air bersih d. Sabun cair e. Pelembap kulit f. Handuk

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN KAKI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1843 / 2016	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	g. Pengalas h. Skalpel, jika perlu . 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang pengalas di bawah kaki 8. Pasang sarung tangan bersih 9. Periksa seluruh permukaan kaki dan kuku, termasuk sela-sela jari dan tumit kaki 10. Cuci kedua kaki dengan air bersih dan sabun/antiseptik 11. Sikat kaki dan kuku 12. Gunakan amplas kaki untuk menipiskan kalus ringan 13. Gunakan skalpel untuk mengikis kalus yang tebal dan keras, serta rapikan dengan menggunakan gerinda 14. Potong kuku kaki mengikuti bentuk normal jari kaki (tidak terlalu dekat dengan kulit dasar kuku) 15. Cuci kembali dengan air bersih dan keringkan seluruh permukaan kaki dengan handuk 16. Berikan pelembap pada seluruh permukaan kaki sampai tibia, kecuali telapak kaki dan sela-sela jari kaki 17. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 18. Lepaskan sarung tangan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat.		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN KUKU**		
	No.Dokumen: 400.7.4/1292/2026	No.Revisi: 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	
PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat kuku agar bersih dan sehat serta tidak mengalami lesi kulit akibat perawatan kuku yang tidak tepat		
TUJUAN	Perawatan Diri Meningkat, Tingkat Pengetahuan Meningkat, Integritas Kulit dan Jaringan Meningkat		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.		
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Gunting kuku c. Waskom berisi air hangat d. Handuk e. Sabun f. Pengalas 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang pengalas di bawah kaki 8. Pasang sarung tangan bersih 9. Tempat pengalas dia tas tempat tidur 10. Tempatkan waskom berisi air hangat di atas pengalas 11. Rendam jari-jari pasien dalam waskom berisi air 12. hangat dan sabun		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN KUKU**		
	No.Dokumen: 900.7.4/1292/2026	No.Revisi: 05	Halaman : 2/2
	13. Keringkan jari-jari tangan dan kaki dengan menggunakan handuk 14. Potong kuku tangan dan kaki mengikuti bentuk normal jari kaki (tidak terlalu dekat dengan kulit dasar kuku) 15. Cuci jari-jari tangan dan kaki serta keringkan dengan handuk 16. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 17. Lepaskan sarung tangan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN MULUT**		
	No.Dokumen 400.7.4/1925/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat kesehatan mulut serta mencegah terjadinya komplikasi
TUJUAN	Perawatan Diri Meningkat, Tingkat Pengetahuan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Handuk kecil c. Bengkok d. Sikat gigi dan pasta gigi e. Gelas untuk kumur f. Spatel lidah yang dibungkus kasa g. Klorheksidin oral 0,12-0,2% (atau NaCl 0,9%) h. Pelembab bibir i. Tisu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN MULUT**		
	No.Dokumen 400.7.9/1925/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Atur pasien pada posisi yang nyaman 9. Lakukan inspeksi pada seluruh rongga mulut dengan menggunakan spatel lidah 10. Letakkan handuk kecil di bagian dada atau selipkan di baju pasien 11. Letakkan bengkok di bawah dagu 12. Anjurkan menggosok gigi, membilasnya dengan air bersih dan membuang air cuci mulut ke bengkok. Jika tidak mampu menggosok gigi secara mandiri. renggangkan gigi atas dan bawah dengan spatel lidah dengan lembut, dan bersihkan mulut dengan spatel lidah yang telah dibasahi air atau pencuci mulut 13. Gosok lidah tetapi hindari refleks gag 14. Periksa kondisi gigi, gusi dan lidah pasien 15. Oleskan pelembab pada bibir, jika perlu 16. Rapikan pasien dan alat-alat yang telah digunakan 17. Lepaskan sarung tangan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN RAMBUT**		
	No.Dokumen 400.7.4/1926/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat kesehatan rambut dan kulit kepala serta mencegah terjadinya komplikasi
TUJUAN	Perawatan Diri Meningkat, Tingkat Pengetahuan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Kain penutup wajah c. Handuk d. Shampoo e. Air f. Teko atau timba g. Wadah penampung air bekas h. Pengalas tahan air i. Perlak atau alat khusus cuci rambut

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN RAMBUT**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1926 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/3

j. Apron
k. Sisir
l. Nampan atau troli untuk peralatan
m. Pengering rambut
n. Skerem atau tirai

6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
7. Pasang celemek
8. Jaga privasi dengan memasang skerem atau tirai
9. Posisikan posisi nyaman
10. Atur ketinggian tempat tidur
11. Angkat bantal pasien
12. Pasang pengalas bawah kepala, leher dan bahu
13. Pasang perlak gulung sebagai talang air bekas atau alat khusus cuci rambut bawah kepala
14. Tempatkan wadah penampung air bekas
15. Masukkan ujung perlak gulung atau alat khusus cuci rambut ke wadah air bekas 14. Tutupi dada dengan handuk
16. Instruksikan menutup mata
17. Tutup wajah dengan kain penutup
18. Lepas perhiasan rambut, jika ada
19. Pasang sarung tangan bersih
20. Basahi rambut dengan air menggunakan teko atau timba
21. Olesi rambut dengan shampoo hingga merata ke seluruh
22. Lakukan pijatan kulit kepala dengan jari tangan rambut kepala
23. Bilas rambut dengan air hingga bersih
24. Angkat perlak gulung atau alat khusus cuci rambut dari bawah kepala

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN RAMBUT**		
	No.Dokumen 400.7.4/1926/2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	25. Letakkan kepala pasien di atas pengalas 26. Buka tutup wajah pasien 27. Keringkan rambut dengan pengering rambut 28. Sisir rambut pasien 29. Angkat pengalas dan handuk di dada pasien 30. Pasang bantal pasien 31. Rapikan pasien dan alat-alat yang telah digunakan 32. Lepaskan apron dan sarung tangan 33. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 34. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**BIMBINGAN ANTISIPATIF**		
	No.Dokumen: 400.7.4 / 1927 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mempersiapkan pasien dan keluarga untuk mengantisipasi perkembangan atau krisis situasional
TUJUAN	Manajemen Kesehatan Meningkat, Manajemen Kesehatan Keluarga Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi metode penyelesaian masalah yang biasa digunakan 7. Identifikasi kemungkinan perkembangan atau krisis situasional yang akan terjadi dan dampaknya pada pasien dan keluarga 8. Fasilitasi memutuskan bagaimana masalah yang akan diselesaikan 9. Fasilitasi siapa yang akan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah 10. Fasilitasi mengidentifikasi sumber daya yang tersedia 11. Fasilitasi menyesuaikan diri dengan perubahan peran 12. Berikan referensi baik cetak maupun elektronik 13. Jadwalkan tindak lanjut untuk memantau atau memberi dukungan 14. Berikan nomor kontak yang dapat dihubungi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**BIMBINGAN ANTISIPATIF**		
	No.Dokumen: 400.7.4/1927/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**BIMBINGAN SISTEM KESEHATAN**		
	No.Dokumen: 400.7.9/1928/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	
PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan		
TUJUAN	Manajemen Kesehatan Meningkat , Tingkat Pengetahuan Meningkat, Peran Pemberi Asuhan Membaik		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.		
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi masalah kesehatan yang dirasakan 7. Identifikasi upaya yang dilakukan oleh individu, keluarga dan masyarakat 8. Bimbing pasien untuk mampu menyebutkan perubahan status kesehatan dan kekuatan yang dimiliki pasien dan keluarga secara mandiri 9. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan kesehatan 10. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan secara mandiri 11. Libatkan keluarga atau orang-orang terdekat untuk		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**BIMBINGAN SISTEM KESEHATAN**		
	No.Dokumen: 400.7.4/1928/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	pemenuhan kebutuhan kesehatan 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KELUARGA**		
	No.Dokumen: 400.7.9/1929/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 27 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan informasi kesehatan kepada pasien dan/atau keluarga sesuai kebutuhannya
TUJUAN	Tingkat Pengetahuan Meningkat, Status Koping Kelurga Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan edukasi 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Periksa kesiapan dan kemampuan pasien dan keluarga menerima informasi 8. Ciptakan suasana yang nyaman 9. Lakukan persiapan untuk edukasi sesuai kebutuhan pasien dan keluarga 10. Jelaskan materi edukasi kepada pasien dan keluarga 11. Evaluasi pemahaman pasien dan keluarga terhadap materi edukasi yang telah diberikan 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 13. Dokumentasikan edukasi yang telah dilakukan dan respons pasien serta keluarga

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KELUARGA**		
	No.Dokumen: 400.7.9/1929/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KESEHATAN**		
	No.Dokumen: A00.7.9/1930/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengajarkan pengelolaan faktor risiko masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih serta sehat
TUJUAN	Tingkat Pengetahuan Meningkat, Manajemen Kesehatan Meningkat, Pemeliharaan Kesehatan Meningkat, Tingkat Kepatuhan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Materi b. Media c. Alat peraga, jika perlu 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 7. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat 8. Jekaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan 9. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat 10. Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat 11. Berikan kesempatan untuk bertanya 12. Periksa pemahaman pasien tentang edukasi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KESEHATAN**		
	No.Dokumen: 400.7.9/1930/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah yang telah diberikan 14. Dokumentasikan edukasi kesehatan yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN KASUS**		
	No.Dokumen: 400.7.9/1931/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengkoordinasikan perawatan pasien untuk menurunkan biaya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mencapai hasil yang diharapkan
TUJUAN	Manajemen Kesehatan Meningkat, Peran Pemberi Asuhan Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan manajemen kasus 5. Jelaskan peran manajer kasus kepada pasien dan keluarga 6. Dapatkan persetujuan pasien atau keluarga untuk dilibatkan dalam program manajemen kasus 7. Periksa status kesehatan pasien 8. Identifikasi sumber daya atau pelayanan yang diperlukan 9. Monitor efektifitas biaya perawatan 10. Bina hubungan dengan pasien, keluarga dan tenaga kesehatan lain 11. Gunakan komunikasi efektif kepada pasien, keluarga dan tenaga kesehatan lain 12. Tentukan hasil (outcome) yang akan dicapai dengan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN KASUS**		
	No.Dokumen: 400.7.9 / 1931 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	mempertimbangkan masukan dari pasien/keluarga 13. Tentukan rencana keperawatan yang akan diimplementasikan dengan mempertimbangkan masukan dari pasien/keluarga 14. Modifikasi rencana keperawatan untuk meningkatkan efektifitas biaya, jika perlu 15. Koordinasikan perawatan pasien dengan tenaga kesehatan lain (seperti perawat lain, dokter, ahli gizi, fisoterapis, pekerja sosial) 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERENCANAAN PULANG**		
	No.Dokumen: 400.7.9/1932/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi perencanaan kebutuhan yang diperlukan pasien sejak masuk rumah sakit sampai setelah meninggalkan rumah sakit
TUJUAN	Manajemen Kesehatan Meningkat, Pemeliharaan Kesehatan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Media edukasi kesehatan (seperti leaflet, booklet, lembar balik) b. Alat kesehatan yang akan digunakan di rumah, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi indikasi pemulangan pasien 8. Identifikasi kesiapan pulang 9. Identifikasi topik-topik edukasi kesehatan yang dibutuhkan (seperti kebersihan tangan, diet, aktivitas, perawatan luka, pemantauan suhu, mandi, minum obat, gejala dan tanda kritis, alat-alat kesehatan yang digunakan di rumah) 10. Monitor respons pasien dan keluarga terhadap edukasi kesehatan 11. Berikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERENCANAAN PULANG**		
	No.Dokumen: 400.7.9/1932/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	keluarga 12. Siapkan pasien dan keluarga mendapatkan informasi tentang pelayanan rujukan, jika akan dirujuk 13. Jelaskan tindak lanjut perawatan dan pengobatan lanjutan 14. Ajarkan teknik kebersihan tangan 15. Ajarkan cara melakukan perawatan secara mandiri di rumah 16. Ajarkan cara menggunakan alat-alat yang akan digunakan di rumah 17. Anjurkan berperilaku hidup sehat selama di rumah 18. Anjurkan keluarga memberikan dukungan perawatan secara mandiri 19. Koordinasikan usulan perencanaan pulang kepada tenaga kesehatan lain 20. Periksa pemahaman pasien dan keluarga 21. Siapkan transportasi yang akan digunakan untuk pemulangan 22. Pastikan pasien sampai ke tempat yang dituju dengan aman 23. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 24. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN INTERAKSI SOSIAL**		
	No.Dokumen: 400.7.4/1844/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi dalam mempertahankan kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk interaksi sosial meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan lingkungan terapeutik 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam menjalin hubungan 8. Pertahankan kesabaran dalam mengembangkan hubungan 9. Latih bermain peran dalam kemampuan berkomunikasi 10. Latih meningkatkan kemampuan diri 11. Anjurkan berhubungan dengan orang lain yang

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN INTERAKSI SOSIAL**		
	No.Dokumen: 400.7.4/1844/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	memiliki kepentingan dan tujuan yang sama 12. Anjurkan untuk menghormati orang lain 13. Motivasi untuk komunikasi verbal 14. Motivasi untuk mempertahankan hubungan komunikasi verbal 15. Motivasi untuk melakukan kegiatan individu, keluarga dan kelompok 16. Anjurkan untuk melakukan aktivitas di luar lingkungan baru 17. Diskusikan perencanaan kegiatan yang akan datang 18. Anjurkan perencanaan dalam kegiatan khusus 19. Rujuk dalam komunitas lain, jika perlu 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN KELUARGA MERENCANAKAN PERAWATAN**		
	No.Dokumen: 400.7.4 / 1845 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi perencanaan pelaksanaan perawatan kesehatan keluarga
TUJUAN	Manajemen Kesehatan Meningkat, Status Koping Membaik, Proses Keluarga Membaik, Peran Pemberi Asuhan Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kebutuhan dan harapan keluarga tentang kesehatan 7. Identifikasi sumber-sumber yang dimiliki keluarga 8. Identifikasi tindakan yang dapat dilakukan keluarga 9. Identifikasi konsekuensi tidak melakukan tindakan bersama keluarga 10. Motivasi pengembangan sikap dan emosi yang mendukung upaya kesehatan 11. Gunakan sarana dan fasilitas yang ada dalam

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN KELUARGA MERENCANAKAN PERAWATAN**		
	No.Dokumen: 400.7.9/1845/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	keluarga 12. Ciptakan perubahan lingkungan rumah secara optimal 13. Informasikan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan keluarga 14. Anjurkan mengunakan fasilitas kesehatan yang ada 15. Ajarkan cara perawatan yang bisa dilakukan keluarga 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PENAMPILAN PERAN**		
	No.Dokumen: 400.7.9/1846/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi pasien dan keluarga untuk memperbaiki hubungan dengan mengklarifikasi dan memenuhi perilaku peran tertentu
TUJUAN	Pernampilan Peran Membaik, Proses Keluarga Membaik, Peran Menjadi Orang Tua Membaik , Proses Pengasuhan Membaik, Perlekatan Meningkat, Peran Pemberi Asuhan Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi peran yang ada dalam keluarga 7. Identifikasi peran yang tidak terpenuhi 8. Diskusikan strategi positif untuk mengelola perubahan peran 9. Diskusikan perilaku yang dibutuhkan untuk pengembangan peran

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PENAMPILAN PERAN**		
	No.Dokumen: 400.7.9/1846/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Fasilitasi adaptasi peran keluarga terhadap perubahan peran yang tidak. Diinginkan 11. Ajarkan perilaku baru yang dibutuhkan oleh pasien/orang tua untuk memenuhi peran 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 13. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasienditerima		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KOMUNIKASI EFEKTIF**		
	No.Dokumen: 400.7.9/1847/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengajarkan cara memberikan informasi kepada lawan bicara secara efektif
TUJUAN	Sebagai acuan Langkah-langkah untuk interaksi sosial meningkat, status koping membaik, pemeliharaan kesehatan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Siapkan lingkungan yang terapeutik 7. Identifikasi kesiapan dan kemampuan pasien dalam menerima informasi 8. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 9. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan 10. Jelaskan faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan komunikasi efektif

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KOMUNIKASI EFEKTIF**		
	No.Dokumen: 400.7.4/1847/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Ajarkan cara menggunakan komunikasi efektif 12. Ajarkan cara menyampaikan pesan dengan tepat 13. Ajarkan cara melakukan verifikasi pada pesan yang diterima 14. Berikan kesempatan bertanya 15. Periksa pemahaman pasien terkait edukasi yang diberikan 16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN SALEP MATA**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/319/ 2026	No.Revisi 03	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 27 Februari 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. Mustiko Wibowo Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Salep mata adalah salep yang digunakan pada mata. Sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mencegah infeksi mata pada bayi baru lahir
KEBIJAKAN	Sesuai Peraturan Direktur Nomor 03 tahun 2026 Tentang Kebijakan Pelayanan RSUD dr. Loekmono Hadi
PROSEDUR	1. Lakukan inform consent kepada keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan 2. Cuci tangan 3. Buka tutup dari tube 4. Dengan satu tangan, tarik kelopak mata bagian bawah perlahan-lahan 5. Tekan sejumlah kecil salep kedalam kelopak mata bagian bawah (± ¼ – ½ inci). Hati-hati agar tidak menyentuhkan ujung tube pada mata, kelopak mata, jari, dll 6. Tutup mata dengan lembut dan putar bola mata kesegala arah pada saat mata ditutup. 7. Gosok kelopak mata yang tertutup dengan lembut menggunakan jari untuk mendistribusikan obat melalui fornix. 8. Tutup kembali tube 9. Cuci tangan
UNIT TERKAIT	1. IGD PONEK 2. Ruang bersalin 3. PICU NICU 4. Farmasi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PADA PENGASUH**		
	No.Dokumen: 400.7.9 / 1848 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyediakan informasi dan dukungan yang diperlukan serta mengajarkan perubahan prilaku untuk memfasilitasi perawatan kepada orang lain
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk peran pemberi asuhan membaik, proses pengasuhan membaik, tingkat pengetahuan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi pemahaman dan kesiapan peran pengasuh 7. Identifikasi sumber dukungan dan kebutuhan istirahat pengasuh 8. Berikan dukungan pada pengsuh selama pasien mengalami kemunduran 9. Dukung keterbatasan pengasuh dan diskusikan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI PADA PENGASUH**		
	No.Dokumen: 400.7.4 / 1848 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	dengan pasien 10. Fasilitasi pengasuh untuk bertanya 11. Jelaskan dampak ketergantungan pasien pada pengasuh 12. Ajarkan pengasuh mengeksplorasi kekuatan dan kelemahannya 13. Ajarkan pengesuh cara memberikan dukungan perawatan diri (seperti mandi, BAB/BAK, berpakaian/berhias, makan/minum) 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KOORDINASI DISKUSI KELUARGA**		
	No.Dokumen: 400.7.9 / 1849 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyeimbangkan kegiatan keluarga untuk mencapai tujuan bersama anggota keluarga
TUJUAN	Sebagai acuan Langkah – Langkah untuk proses keluarga membaik, status koping keluarga membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi gangguan kesehatan setiap anggota keluarga 7. Ciptakan suasana rumah yang sehat dan mendukung perkembangan kepribadian anggota keluarga 8. Fasilitasi keluarga mendiskusikan masalah kesehatan yang sedang dialami 9. Pertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan 10. Libatkan keluarga dalam mengambil keputusan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KOORDINASI DISKUSI KELUARGA**		
	No.Dokumen: 400.7.4/1849/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	terkait tindakan yang tepat 11. Berikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit 12. Anjurkan anggota keluarga dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MOBILISASI KELUARGA**		
	No.Dokumen: 400.7.4/1850/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memanfaatkan kekuatan keluarga untuk mempengaruhi kesehatan pasien secara positif
TUJUAN	Manajemen Kesehatan Keluarga Meningkat, Proses Keluarga Membaik, Manajemen Kesehatan Meningkat, Peran Pemberi Asuhan Membaik, Status Koping Keluarga Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kekuatan dan sumber daya didalam keluarga dan masyarakat 7. Identifikasi kesiapan dan kemampuan anggota keluarga untuk belajar 8. Identifikasi keterbatasan, kemajuan, dan implikasi keperawatan 9. Bina hubungan saling percaya dengan anggota

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MOBILISASI KELUARGA**		
	No.Dokumen: 400.7.4/1850/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	keluarga 10. Berikan informasi kesehatan kepada keluarga sesuai kebutuhan 11. Buat keputusan rencana perawatan bersama anggota keluarga 12. Dukung kegiatan keluarga dalam mempromosikan kesehatan atau pengelolaan kondisi 13. Libatkan anggota keluarga untuk mengindentifikasi layanan kesehatan dan sumber daya masyarakat 14. Rujuk anggota keluarga pada dukungan kelompok 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MODIFIKASI PERILAKU KETERAMPILAN KELUARGA**		
	No.Dokumen: 900.7.9/1851/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 29 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengubah pengembangan atau peningkatan keterampilan sosial interpersonal
TUJUAN	Interaksi Sosial Meningkat, Keterlibatan Sosial Meningkat, Proses Keluarga Membaik, Proses pengasuhan Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Siapkan lingkungan terapeutik 7. Identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial 8. Identifikasi fokus pelatihan keterampilan sosial 9. Jelaskan respons dan konsekuensi keterampilan sosial 10. Latih keterampilan sosial secara bertahap 11. Motivasi untuk berlatih keterampilan sosial dan beri umpan baik positif terhadap kemampuan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MODIFIKASI PERILAKU KETERAMPILAN KELUARGA**		
	No.Dokumen: 400.7.9 / 1851 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	bersosialisasi 12. Anjurkan mengevaluasi pencapaian setiap interaksi 13. Libatkan keluarga selama latihan keterampilan social 14. Edukasi keluarga untuk dukungan keterampilan sosial 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENDAMPINGAN KELUARGA**		
	No.Dokumen: 400.7.4/1852/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mendampingi keluarga dan/atau anggota keluarga dalam menjalani program perawatan dan pengobatan atau menghadapi masalah kesehatan
TUJUAN	Manajemen Kesehatan Keluarga Meningkat, Proses Keluarga Membaik, Manajemen Kesehatan Meningkat, Peran Pemberi Asuhan Membaik , Status Koping Keluarga Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kebutuhan keluarga terkait masalah kesehatan keluarga 7. Identifikasi tugas kesehatan keluarga yang terhambat 8. Identifikasi dukungan spiritual yang mungkin dilakukan untuk keluarga 9. Bina hubungan saling percaya dengan keluarga

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENDAMPINGAN KELUARGA**		
	No.Dokumen: 400.7.4 /1852/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Yakinkan keluarga bahwa anggota keluarganya akan diberikan pelayanan terbaik 11. Dengarkan keinginan dan perasaan keluarga 12. Ajarkan mekanisme koping adaptif yang dapat digunakan keluarga 13. Dukung mekanisme koping adaptif yang digunakan keluarga 14. Berikan harapan yang realistis 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI DUKUNGAN KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1853 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan partisipasi anggota keluarga dalam perawatan emosional dan fisik
TUJUAN	Manajemen Kesehatan Keluarga Meningkat, Proses Keluarga Membaik, Manajemen Kesehatan Meningkat, Peran Pemben Asuhan Membaik , Status Koping Keluarga Membaik, Perlekatan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua 4. Identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 5. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Ciptakan lingkungan yang nyaman 8. Identifikasi kebutuhan dan harapan anggota keluarga 9. Identifikasi sumber daya fisik, emosional, dan pendidikan keluarga 10. Anjurkan keluarga bersikap asertif 11. Diskusikan anggota keluarga yang akan dilibatkan dalam perawatan 12. Diskusikan kemampuan dan perencanaan keluarga

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI DUKUNGAN KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.4/1853/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	dalam perawatan 13. Diskusikan dan jelaskan jenis perawatan di rumah 14. Diskusikan cara mengatasi kesulitan dalam perawatan 15. Fasilitasi program perawatan dan pengobatan yang dijalani anggota keluarga 16. Hargai keputusan yang dibuat keluarga 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI DUKUNGAN SOSIAL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1859 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

Pengertian	Meningkatkan partisipasi orang sekitar pasien dalam perawatan emosional dan fisik
Tujuan	Interaksi sosial meningkat , keterlibatan sosial meningkat, harapan meningkat, pemeliharaan kesehatan meningkat, manajemen kesehatan meningkat
Kebijakan	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi nomor 03 tahun 2026 tentang kebijakan pelayanan rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi kudus.
Prosedur	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua Identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau Nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kekuatan dan kelemahan menjalin hubungan 7. Anjurkan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama 8. Anjurkan penggunaan alat bantu (seperti kacamata Dan alat bantu dengar) 9. Anjurkan untuk berbagi masalah dengan orang lain

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI DUKUNGAN SOSIAL**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1859 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Anjurkan untuk menghormati hak orang lain 11. Anjurkan untuk mengekspresikan kemarahan secara tepat 12. Anjurkan perencanaan kegiatan khusus 13. Latih peningkatan kemampuan yang dimiliki 14. Latih permainan peran dalam keterampilan komunikasi 15. Berikan umpan balik positif terhadap aktivitas yang Dilakukan 16. Motivasi berpartisipasi dalam kegiatan individu, kelompok dan sosial 17. Motivasi untuk mempertahankan komunikasi verbal 18. Motivasi melakukan aktivitas di luar dan lingkungan Baru (seperti jalan-jalan, berbelanja) 19. Rujuk ke kelompok keterampilan, jika perlu 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan Respons pasien		
Unit terkait	1. Instalasi rawat inap 2. Instalasi rawat jalan 3. Instalasi gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI KEUTUHAN KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1795 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pasien untuk menjaga dan meningkatkan kerekatan dan keutuhan dalam keluarga
TUJUAN	Proses keluarga membaik , peran pemberi asuhan membaik, status koping keluarga membaik, perlekatan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi nomor 03 tahun 2026 tentang kebijakan pelayanan rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur lakukan kebersihan tangan 6 langkah 5. Identifikasi pemahaman keluarga terhadap masalah 6. Identifikasi adanya konflik utama antar anggota 7. Identifikasi mekanisme koping keluarga 8. Monitor hubungan antar anggota keluarga 9. Anjurkan anggota keluarga mempertahankan keharmonisan keluarga

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI KEUTUHAN KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.4/1945/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Fasilitas keluarga dalam melakukan pengambilan Keputusan dan pemecahan masalah 11. Fasilitasi komunikasi terbuka antar setiap anggota keluarga 12. Hargai privasi keluarga 13. Rujuk untuk terapi keluarga, jika perlu 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi rawat inap 2. Instalasi rawat jalan 3. Instalasi gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI KOMUNIKASI EFEKTIF**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1746 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan kemampuan komunikasi pasien untuk pengambilan keputusan terkait perawatan/pengobatan pasien
TUJUAN	Interaksi Sosial Meningkat, Status Koping Membaik, Status Koping Keluarga Membaik, Pemeliharaan Kesehatan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi prioritas metode komunikasi yang digunakan, sesuai dengan kemampuan 7. Identifikasi sumber pesan secara jelas 8. Jelaskan perlunya komunikasi efektif 9. Ajarkan memformulasikan pesan dengan tepat 10. Fasilitasi mengungkapkan isi pesan dengan jelas 11. Fasilitasi penyampaian struktur pesan secara logis

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PROMOSI KOMUNIKASI EFEKTIF</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.9 / 1796 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">12. Dukung pasien dan keluarga menggunakan komunikasi efektif
13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat darurat</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI PENGASUHAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1797 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi orang tua, anggota keluarga dan/atau pengasuh dalam memberikan dukungan dan perawatan yang komprehensif bagi keluarga yang mengalami atau berisiko mengalami masalah kesehatan
TUJUAN	Peran pemberi asuhan membaik , proses pengasuhan membaik, peran menjadi orang tua membaik , penampilan peran membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Lakukan kunjungan rumah sesuai dengan tingkat risiko 7. Fasilitasi orang tua dalam memiliki harapan yang realistis kemampuan dan perkembangan anak 8. Fasilitasi orang tua dalam menerima transisi peran sesuai tingkat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI PENGASUHAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1747 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Berikan bimbingan antisipasi yang diperlukan sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak 10. Fasilitasi orang tua dalam mengidentifikasi temperamen unik bayi 11. Berikan contoh upaya untuk meningkatkan interaksi orang tua-anak 12. Fasilitasi orang tua dalam mendapatkan dukungan dan berpartisipasi dalam parent group programs 13. Sediakan media untuk mengembangkan keterampilan pengasuhan 14. Fasilitasi orang tua mengembangkan keterampilan sosial dan koping 15. Fasilitasi mengatur penitipan anak, jika perlu 16. Ajarkan orang tua untuk menanggapi isyarat bayi 17. Periksa status kesehatan anak dan status imunisasi anak 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi rawat inap 2. Instalasi rawat jalan 3. Instalasi gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI PROSES EFEKTIF KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1748 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan tindakan untuk mempertahankan dan meningkatkan proses dalam keluarga
TUJUAN	Proses Keluarga Membaik, Peran Pemberi Asuhan Membaik , Proses Pengasuhan Membaik, Peran Menjadi Orang Tua Membaik , Penampilan Peran Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi tipe proses keluarga 7. Identikasi masalah atau gangguan dalam proses keluarga 8. Identifikasi kebutuhan perawatan mandiri di rumah 9. Pertahankan interaksi yang berkelanjutan dengan anggota keluarga 10. Motivasi anggota keluarga untuk melakukan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI PROSES EFEKTIF KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.4/1748/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	aktivitas bersama (seperti makan bersama, diskusi bersama keluarga) 11. Fasilitasi anggota keluarga melakukan kunjungan rumah sakit 12. Susun jadwal aktivitas perawatan mandiri di rumah untuk mengurangi gangguan rutinitas keluarga 13. Jelaskan strategi mengembalikan kehidupan keluarga yang normal kepada anggota keluarga 14. Diskusikan dukungan sosial dari sekitar keluarga 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI SOSIALISASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1749 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain
TUJUAN	Interaksi sosial meningkat, keterlibatan sosial meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi nomor 03 tahun 2026 tentang kebijakan pelayanan rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kemampuan berinteraksi dengan orang lain 7. Identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain 8. Anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap 9. Anjurkan berbagi pengalaman dengan orang lain 10. Latih bermain peran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 11. Latih mengekspresikan marah dengan tepat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PROMOSI SOSIALISASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1749 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Berikan umpan balik positif dalam setiap peningkatan kemampuan 13. Diskusikan perencanaan di masa depan 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi rawat inap 2. Instalasi rawat jalan 3. Instalasi gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PEMELIHARAAN RUMAH**		
	No.Dokumen 400.7.9/1952/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

Pengertian	Memfasilitasi dalam mempertahankan lingkungan rumah Bersih, aman dan mendukung pertumbuhan dan Perkembangan anggota keluarga
Tujuan	Tingkat cedera menurun, tingkat infeksi menurun, Tingkat jatuh menurun
Kebijakan	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi nomor 03 tahun 2026 tentang kebijakan pelayanan rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi kudus.
Prosedur	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi factor yang berkontribusi terhadap gangguan pemeliharaan rumah (seperti adanya tambahan anggota keluarga baru, adanya anggota keluarga yang sakit, adanya kematian anggota keluarga, masalah finansial) 7. Identifikasi kemampuan keluarga dalam mengelola kesehatan anggota keluarga (meliputi kemampuan keluarga dalam mengenal masalah, kemampuan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DUKUNGAN PEMELIHARAAN RUMAH**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1952 / 2016	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	keluarga dalam mengambil keputusan yang tepat, kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan anggota keluarga yang sakit di rumah, kemampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan rumah dan kemampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan) 8. Fasilitasi keluarga untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai keluarga dalam pemeliharaan rumah 9. Ajarkan keluarga cara menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan aman 10. Fasilitasi keluarga dalam memelihara kondisi rumah agar bersih, aman dan nyaman bagi keluarga 11. Libatkan anggota keluarga dalam memelihara kebersihan dan keamanan rumah. 12. Anjurkan keluarga menggunakan jasa pemeliharaan lingkungan rumah agar bersih dan aman, jika perlu perlu 13. Koordinasikan kondisi keluarga dengan tokoh masyarakat setempat, jika 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
Unit terkait	1. Instalasi rawat inap 2. Instalasi rawat jalan 3. Instalasi gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KESELAMATAN LINGKUNGAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1953/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengajarkan persiapan lingkungan fisik yang mendukung keamanan dan keselamatan
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, tingkat jatuh menurun, tingkat pengetahuan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi nomor 03 tahun 2026 tentang kebijakan pelayanan rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kesiapan pasien / keluarga untuk menerima informasi 7. Fasilitasi pasien / keluarga mengidentifikasi bahaya keamanan dan keselamatan di lingkungan 8. Jelaskan informasi tentang bahaya keamanan dan keselamatan di lingkungan sesuai kebutuhan dengan menggunakan media yang tepat meliputi: a. Pentingnya menghindari, meminimalkan atau menghilangkan bahaya lingkungan (bahaya fisik,

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KESELAMATAN LINGKUNGAN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1953 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	biologi dan kimia) b. Pentingnya menggunakan alat bantu seperti pegangan tangan, keset anti slip, jika tersedia c. Pentingnya menggunakan alat pelindung atau pengaman seperti pengunci pintu, penghalang sisi tempat tidur, alat pengekang pada pasien yang gelisah 9. Beri kesempatan keluarga bertanya 10. Jawab pertanyaan keluarga dengan bahasa yang mudah dimengerti 11. Berikan nomor telepon darurat yang dapat 12. Dihubungi pasien/keluarga dengan mudah 13. Lakukan evaluasi pengetahuan keluarga tentang keamanan dan keselamatan di lingkungan 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi rawat inap 2. Instalasi rawat jalan 3. Instalasi gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KESELAMATAN RUMAH**		
	No.Dokumen 400.7.9/1959/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 27 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengajarkan pengelolaan rumah untuk mempertahankan keamanan dan keselamatan rumah
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, tingkat jatuh menurun, tingkat pengetahuan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi nomor 03 tahun 2026 tentang kebijakan pelayanan rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kesiapan pasien dan keluarga untuk menerima informasi 7. Fasilitasi pasien dan keluarga mengidentifikasi kondisi keselamatan rumah 8. Jelaskan informasi tentang keselamatan rumah dengan menggunakan media yang tepat meliputi: a. a.Pentingnya penerangan yang cukup di dalam dan luar rumah b. b.Pentingnya manata perabotan rumah tangan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**EDUKASI KESELAMATAN RUMAH**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1959 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	dengan rapi dan dijangkau sesuai kebutuhan c. c.Pentingnya memeriksa alat rumah tangga dalam keadaan baik d. d.Pentingnya memastikan kabel listrik dalam keadaan baik e. Pentingnya memastikan tidak ada barang yang mudah terbakar di dekat kompor tertentu seperti f. Pentingnya memasang pegangan tangan pada tempat kamar mandi dan kamar sesuai kebutuhan g. Pentingnya memastikan lantai kamar mandi tidak licin h. Pentingnya memastikan suhu pemanas air tidak terlalu panas, jika tersedia 9. Anjurkan keluarga memasang alat detector kebakaran, sesuai kebutuhan 10. Beri kesempatan pasien dan keluarga bertanya 11. Jawab pertanyaan pasien dan keluarga dengan bahasa yang mudah dimengerti 12. Periksa pemahaman keluarga tentang keselamatan rumah 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi rawat inap 2. Instalasi rawat jalan 3. Instalasi gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IDENTIFIKASI RISIKO MASALAH KESEHATAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1955/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menemukan dan menganalisisis kemungkinan faktor-faktor risiko yang dapat mengganggu kesehatan akibat terpapar zat patogen, zat kimia toksik dan agen nosokomial
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi nomor 03 tahun 2026 tentang kebijakan pelayanan rumah sakit umum daerah dr. Loekmono hadi kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua Identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau Nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kondisi lingkungan pasien dari adanya zat patogen (seperti adanya percikan darah, Muntahan, urine, feses) 7. Identifikasi adanya zat kimia toksik yang berada di lingkungan pasien (seperti asap, debu, gas Beracun, cairan kimia) 8. Identifikasi agen nosokomial yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IDENTIFIKASI RISIKO MASALAH KESEHATAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1955 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Lakukan tindakan pengendalian risiko sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan (eliminasi: dihilangkan, subsitusi: mengganti dengan bahan yang lebih ditoleransi pasien, rekayasa: emodifikasi, administrasi atau penggunaan apd) 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi rawat inap 2. Instalasi rawat jalan 3. Instalasi gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS** **Rumah Sakit Umum Daerah** **dr. Loekmono Hadi** Jl. dr. Loekmono Hadi No. 19 Kudus	**KEBERSIHAN TANGAN SECARA *HANDRUB***		
	No. Dokumen : 400.7 / 719 / 2026	No. Revisi : 06	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 17 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, MKM Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	**Kebersihan Tangan Secara *Handrub*** adalah mencuci tangan dengan menggunakan cairan berbasis alkohol (70%) apabila tangan tidak tampak kotor, dilakukan selama 20 – 30 detik. Indikasi kebersihan tangan : 1. Sebelum kontak pasien; 2. Sebelum tindakan aseptik; 3. Setelah kontak darah dan cairan tubuh; 4. Setelah kontak pasien; 5. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk: 1. Memutus mata rantai penyebaran infeksi 2. Meningkatkan *patient safety* pasien, petugas dan masyarakat di rumah sakit
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi No. 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan
PROSEDUR	Persiapan : 1. Kuku petugas harus selalu bersih dan terpotong pendek, tanpa kuku palsu, tanpa memakai perhiasan cincin. 2. Gulung lengan baju. Pelaksanaan : 1. Tuangkan 2-3 cc antiseptik berbasis alkohol ke telapak tangan, kemudian ratakan ke seluruh permukaan tangan. 2. Gosok kedua telapak tangan hingga merata, ke arah berlawanan jarum jam. 3. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan telapak tangan kanan, dan sebaliknya. 4. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari tangan.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Semyum Kita **PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS** **Rumah Sakit Umum Daerah** **dr. Loekmono Hadi** Jl. dr. Loekmono Hadi No. 19 Kudus	**KEBERSIHAN TANGAN SECARA *HANDRUB***		
	No. Dokumen : 400.7 / 719 / 2026	No. Revisi : 06	Halaman : 2/2
	5. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. 6. Gosok berputar pada ibu jari tangan kiri dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. 7. Gosok dengan memutar ujung jari-jari dan kuku tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya (kearah berlawanan jarum jam). 8. Sesudah kering, tangan anda sudah bersih.		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit kerja		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KEBERSIHAN TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR MENGALIR**		
	No.Dokumen 400.7.4/2248/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan/atau mikroorganisme di tangan
TUJUAN	Tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Basahi tangan dengan air bersih yang mengalir 2. Tuangkan sabun cair 3-5 cc untuk menyabuni seluruh permukaan tangan sebatas pergelangan tangan 3. Gosok kedua telapak tangan hingga merata 4. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan 5. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari 6. Putar jari-jari sisi dalam dari kedua tangan dengan posisi saling mengunci 7. Gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya 8. Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya 9. Bilas kedua tangan dengan air mengalir 10. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KEBERSIHAN TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR MENGALIR**		
	No.Dokumen	No.Revisi	Halaman :
		05	2/2
	11. Gunakan handuk atau tisu untuk menutup keran dan buang ke tempat sampah dengan benar		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat inap 2. Instalasi Rawat jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN ISOLASI**		
	No.Dokumen 900.7.4/1956/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola pasien yang berisiko menularkan penyakit, mencederai atau merugikan orang lain
TUJUAN	Tingkat infeksi menurun, tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan skrining pasien yang membutuhkan isolasi 6. Tempatkan satu pasien untuk satu kamar 7. Pasang poster kewaspadaan standar di pintu kamar pasien 8. Lakukan kebersihan tangan pada 5 momen (sebelum kontak dengan pasien. sebelum tindakan aseptik, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien) 9. Pasang alat proteksi diri sesuai SPO sebelum masuk ruangan isolasi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN ISOLASI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1956 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Sediakan seluruh kebutuhan harian dan pemeriksaan sederhana di kamar pasien 11. Koordinir kebersihan kamar pasien dengan menggunakan desinfektan setiap hari 12. Dekontaminasi alat-alat kesehatan sesegera mungkin setelah digunakan 13. Masukkan bahan-bahan linen yang terkena cairan tubuh ke dalam trolley infeksius 14. Ajarkan kebersihan tangan dan pencegahan infeksi kepada pasien 15. Lepaskan alat proteksi diri setelah kontak dengan pasien 16. Gunakan pelindung saat melakukan transfer pasien 17. Minimalkan kontak dengan pasien, sesuai kebutuhan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat inap 2. Instalasi Rawat jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN KENYAMANAN LINGKUNGAN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1957 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola lingkungan untuk mengoptimalisasikan kenyamanan
TUJUAN	Status kenyamanan meningkat, tingkat nyeri menurun kontrol nyeri meningkat , termoregulasi membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi sumber ketidaknyamanan pasien (seperti kebersihan ruangan, suhu ruangan, ketenangan ruangan) 7. Periksa dampak ketidaknyamanan lingkungan terhadap kondisi fisik (seperti perubahan warna dan suhu kulit) dan psikologis pasien (perubahan perilaku, gelisah, marah) 8. Fasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan kenyamanan (seperti menciptakan lingkungan yang

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN KENYAMANAN LINGKUNGAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1957/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	bersih, membatasi pengunjung, mengatur suhu ruangan) 9. Monitor kondisi lingkungan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pasien setiap akan memberikan perawatan 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Dokumentasikan kondisi lingkungan dan kebutuhan kesalamatan pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat inap 2. Instalasi Rawat jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN KESELAMATAN LINGKUNGAN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1959/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola lingkungan fisik untuk meningkatkan keselamatan
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, tingkat jatuh menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Identifikasi kebutuhan keselamatan pasien (seperti kondisi fisik, fungsi kognitif dan riwayat perilaku pasien) 7. Periksa adanya perubahan kondisi lingkungan (seperti perubahan tata letak perabotan, ruang, alat yang digunakan) 8. Modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan risiko yang mungkin terjadi sesuai kebutuhan (seperti mengatur tata letak barang/ruang/alat yang digunakan pasien) 9. Gunakan perangkat pelindung yang tersedia (seperti pengunci pintu, rel samping tempat tidur,

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN KESELAMATAN LINGKUNGAN**		
	No.Dokumen 400.7A /1959/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	alat pengekang gerakan pada pasien yang gelisah) 10. Hubungi pihak yang berwenang untuk memenuhi keamanan dan keselamatan pasien, jika perlu 11. Pindahkan pasien ke lingkungan yang aman, jika tersedia 12. Monitor bahaya dan risiko yang ada di lingkungan setiap akan memberikan perawatan pada pasien 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan kondisi lingkungan dan kebutuhan kesalamatan pasien serta respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat inap 2. Instalasi Rawat jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN REAKSI ALERGI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1960/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola kondisi yang diakibatkan oleh stimulasi respons imunitas yang berlebihan akibat terpapar alergen
TUJUAN	Respons alergi lokal menurun, respons alergi sistemik menurun, tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Spigmomanometer b. Stetoskop c. Termometer d. Oksimetri nadi e. Jam atau pengukur waktu f. Gelang tanda alergi 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Ukur tanda-tanda vital (meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, suhu, saturasi oksigen)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN REAKSI ALERGI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1960 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	8. Identifikasi penyebab dan riwayat alergi (seperti obat, makanan, debu, udara, lareks, transfusi darah) 9. Monitor gejala dan tanda alergi (seperti muka merah, urtikaria, angiderma, batuk paroksismal, gelisah, dispnea, sianosis, wheezing, atau syok) 10. Monitor efek pemberian agen farmakologis (terutama 30 menit pertama) 11. Pasang gelang tanda alergi pada lengan, jika memiliki riwayat alergi atau mengalami alergi 12. Hentikan paparan alergen 13. Berikan bantuan hidup dasar selama terjadi syok anafilaktik 14. Informasikan tentang alergi yang dialami 15. Ajarkan cara menghindari dan mencegah paparan alergen 16. Ajarkan pertolongan pertama syok anafilaktik 17. Kolaborasi pemberian obat-obat alergi, jika diperlukan 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat inap 2. Instalasi Rawat jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PELEPASAN ALAT PELINDUNG DIRI : COVERALL**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1961 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melepas coverall untuk melindungi diri dari cedera atau penyakit akibat kontak dengan bahaya (hazards) di tempat kerja
TUJUAN	Tingkat infeksi menurun, tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Pastikan tersedia tempat limbah infeksius yang aman pada area pelepasan dan pembuangan APD 2. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah pada sarung tangan 3. Lepaskan apron dengan tubuh condong ke depan dan hati-hati untuk menghindari kontaminasi tangan 4. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah pada sarung tangan 5. Lepaskan penutup kepala dan leher dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi wajah 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah pada sarung tangan 7. Lepaskan coverall dan sarung tangan terluar 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah pada sarung tangan 9. Lepaskan pelindung mata dengan menarik tali dari belakang kepala dan letakkan dengan aman

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PELEPASAN ALAT PELINDUNG DIRI : COVERALL**		
	No.Dokumen 900.7.4 / 1961 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah pada sarung tangan Lepaskan masker dari belakang kepala dengan terlebih dahulu melepaskan tali bagian bawah ke atas kepala dan biarkan menggantung di depan, lalu lepaskan tali bagian atas dari bagian belakang kepala dan buang dengan aman 11. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah pada sarung tangan 12. Lepaskan sepatu boot karet tanpa menyentuh (atau buka sepatu jika memakai sepatu). Jika sepatu boot yang sama akan digunakan di luar pada area risiko tinggi, tetap gunakan tetapi bersihkan dan dekontaminasi secara benar sebelum meninggalkan area pelepasan 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah pada sarung tangan 14. Lepaskan sarung tangan secara hati-hati dengan teknik yang tepat dan buang dengan aman 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat inap 2. Instalasi Rawat jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PELEPASAN ALAT PELINDUNG DIRI : GOWN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1962 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melepas jubah (gown) untuk melindungi diri dari cedera atau penyakit akibat kontak dengan bahaya (hazards) di tempat kerja
TUJUAN	Tingkat infeksi menurun, tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Pastikan tersedia tempat limbah infeksius yang aman pada area pelepasan dan pembuangan APD 2. Lepaskan sarung tangan dengan hati-hati dan buang ke tempat limbah infeksius 3. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah dengan handrub 4. Lepaskan gown dengan melepas ikatan terlebih dahulu, lalu tarik dari belakang ke depan dengan menggulung dari bagian dalam ke arah bawah dan buang ke tempat limbah infeksius 5. Lakukan kebersihan tangan pada sarung tangan 6. Lepaskan pelindung mata degan menarik tali dari belakang ke depan dan buang dengan aman 7. Buka face shield atau google dengan hati-hati dan tempatkan ke wadah infeksius 8. Buka masker bedah dan buang ke tempat limbah infeksius

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PELEPASAN ALAT PELINDUNG DIRI : GOWN**		
	No.Dokumen 400.7.9/1962/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah dengan air mengalir dan sabun		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat inap 2. Instalasi Rawat jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN RISIKO BUNUH DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1963 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis risiko merugikan diri sendiri dengan maksud mengakhiri hidup
TUJUAN	Kontrol diri meningkat, risiko cedera menurun, identitas diri membaik, harga diri meningkat, harapan meningkat, keberdayaan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Periksa gejala risiko bunuh diri (seperti gangguan mood, halusinasi, delusi, panik, penyalahgunaan zat, kesedihan, gangguan kepribadian) 7. Periksa keinginan dan pikiran rencana bunuh diri 8. Periksa lingkungan bebas bahaya secara rutin (seperti barang pribadi, pisau cukur, jendela) 9. Periksa adanya perubahan mood atau perilaku 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Dokumentasikan hasil pemantauan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN RISIKO BUNUH DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1963/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat inap 2. Instalasi Rawat jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN RISIKO JATUH**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1969 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan, mengamati perkembangan, dan menganalisis faktor risiko jatuh yang berpotensi menimbulkan kerusakan fisik dan gangguan kesehatan
TUJUAN	Tingkat Jatuh Menurun, Tingkat Cedera Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Kancing/gelang kuning atau penanda risiko jatuh b. Alat bantu berjalan, jika perlu c. Lembar ceklist penilaian risiko jatuh 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Lakukan penilaian ulang risiko jatuh, sesuai tingkat isiko jatuh 8. Lakukan penilai perubahan status kognitif dan defisit fisik pasien 9. Identifikasi perilaku/faktor risiko jatuh 10. Identifikasi karakteristik lingkungan yang dapat meningkatkan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN RISIKO JATUH**		
	No.Dokumen 400.7.4/1964/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Lakukan penilaian kemampuan berjalan dan berpindah potensi jatuh 12. Jelaskan faktor risko dan tujuan dilakukan pemantauan kondisi pasien 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Dokumentasikan hasil pemantauan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN RISIKO PERILAKU KEKERASAN**		
	No.Dokumen 400.7.A/1965/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis risiko kemarahan yang diekspresikan secara berlebihan dan tidak terkendali secara verbal sampai dengan mencederai orang lain dan/atau merusak lingkungan
TUJUAN	Kontrol Diri Meningkat, Tingkat Cedera Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Periksa tanda/gejala perilaku kekerasan (meliputi pemikiran waham/deluasi, kecurigaan pada orang lain, halusinasi, berencana bunuh diri, disfungsi sistem keluarga, gangguan kognitif, disorientasi atau konfusi, kerusakan kontrol impuls. alam perasaan depresi, riwayat kekerasan, kelainan neorologis, lingkungan tidak teratur, penganiayaan/pengabaian anak, impulsif, ilusi) 7. Periksa faktor risiko spesifik perilaku kekerasan (seperti GAF Score, BPRS, OAS)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN RISIKO PERILAKU KEKERASAN**		
	No.Dokumen A00.7.9 /1965 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Dokumentasikan hasil pemantauan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN ALAT PELINDUNG DIRI : COVERALL**		
	No.Dokumen 400.7.9/1966/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasang coverall melindungi din dari cedera atau penyakit akibat kontak dengan bahaya (hazards) di tempat kerja
TUJUAN	Tingkat Infeksi Menurun, Tingkat Cedera Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Sarung tangan panjang c. Cover all d. Apron kedap air e. Masker N95 f. Pelindung wajah (face shield) atau kacamata (google) g. Sepatu boot 2. Lepaskan semua barang-barang pribadi (seperti perhiasan, jam tangan, gelang, telepon genggam) 3. Pakai baju scrub 4. Pasang masker N95 dan pastikan terpasang dengan erat dan nyaman 5. Pasang pelindung wajah (face shield) atau kacamata pelindung (google) dengan erat 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah dengan cairan antiseptik berbasis alcohol

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN ALAT PELINDUNG DIRI : COVERALL**		
	No.Dokumen 400.7.9/1966/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	7. Gunakan coverall hingga menutupi seluruh tubuh mulai dari kaki hingga kepala dan pastikan menutupi area kepala 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah dengan handrub 9. Pasang sarung tangan bersih dengan posisi dimasukkan ke dalam lengan baju coverall 10. Pasang sarung tangan panjang untuk menutupi seluruh permukaan tangan di atas coverall		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN ALAT PELINDUNG DIRI : GOWN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1967/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasang jubah (gown) untuk melindungi diri dari cedera atau penyakit akibat kontak dengan bahaya (hazards) di tempat kerja
TUJUAN	Tingkat Infeksi Menurun, Tingkat Cedera Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Gaun (gown) c. Masker bedah d.Pelindung wajah (face shield) atau kacamata (google) d. Sepatu tertutup 2. Lepaskan semua barang-barang pribadi (seperti perhiasan, jam tangan, gelang, telepon genggam) 3. Pakai baju scrub atau baju kerja dan sepatu tertutup 4. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah dengan handrub 5. Gunakan gown 6. Pasang masker bedah dan pastikan terpasang dengan benar (menutupi mulut dan hidung) 7. Pasang pelindung wajah (face shield) atau kacamata pelindung (google) dengan erat 8. Pasang penutup kepala 9. Pasang sarung tangan bersih

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN ALAT PELINDUNG DIRI : GOWN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1967/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN ALAT PENGAMAN**		
	No.Dokumen A00.7.9/1968/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan tindakan untuk memastikan keselamatan diri sendiri dan orang lain dengan memasang alat pengaman
TUJUAN	Tingkat Cedera Menurun, Tingkat Jatuh Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Pengaman tempat tidur c. Tangga tempat tidur, jika perlu d. Alat penyangga, jika perlu e. Alat pemanggil perawat (bel) 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Identifikasi kebutuhan keselamatan pasien (berdasarkan tingkat fungsi fisik dan kognitif serta riwayat perilaku sebelumnya) 9. Pasang alat pengaman (seperti pengekang, pagar tempat tidur, pintu dengan kunci)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN ALAT PENGAMAN**		
	No.Dokumen 900.7.9 / 1968 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	10. Dampingi selama kegiatan di luar ruang rawat, jika perlu 11. Berikan posisi tempat tidur yang rendah dan alat alat bantuan (seperti tangga tempat tidur, alat penyangga), jika perlu 12. Berikan alat untuk memanggil perawat 13. Jauhkan barang yang dapat membahayakan 14. Lepaskan sarung tangan 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN NECK COLLAR**		
	No.Dokumen 400.7.4 /1969 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memasang alat penyokong untuk imobilisasi leher atau tulang servikal
TUJUAN	Perfusi Serebral Meningkat, Tingkat Cedera Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Neck collar, sesuai ukuran 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Lakukan pengukuran neck collar 9. Lakukan imobilisasi leher pasien secara manual dengan kedua lengan perawat 10. Masukkan neck collar secara perlahan ke bagian belakang leher dengan sedikit melewati leher 11. Letakkan bagian neck collar yang berlekuk tepat pada dagu 12. Rekatkan 2 sisi neck collar satu sama lain

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMASANGAN NECK COLLAR**		
	No.Dokumen 400.7.9/1969/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	13. Lepas sarung tangan 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN IMUNISASI/VAKSIN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1970 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas di dalam tubuh serta mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi
TUJUAN	Tingkat Infeksi Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat alergi 6. Identifikasi kontraindikasi termasuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebelumnya 7. Identifikasi status imunisasi setiap kunjungan 8. Lakukan pemeriksaan fisik 9. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh, jika lebih dari 37.5°C tunda pemberian Imunisasi 10. Jelaskan vaksin yang akan diberikan, tujuan, manfaat dan cara pemberiannya 11. Jelaskan kemungkinan KIPI dan tatalaksananya 12. Lakukan pemeriksaan vaksin yang akan diberikan: a. Cek tanggal kadaluarsa

b. Cek freeze tag atau suhu lemari es untuk memastikan tidak pernah mengalami penurunan suhu
c. Cek VVM (Vaccine Vial Monitor)
d. Lakukan uji kocok VVM, jika perlu
   1) Siapkan vaksin kontrol yang dibekukan dalam freezer
   2) Pilih sampel vaksin yang akan diuji
   3) Kocok vaksin kontrol dan vaksin yang akan diuji
   4) Biarkan sesaat dan bandingkan pengendapan pada keduanya
   5) Jika kecepatan mengendap keduanya sama, atau vaksin yang akan diuji mengendap lebih cepat maka vaksin tersebut telah rusak karena pembekuan, maka jangan digunakan

13. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan:
    a. Sarung tangan bersih
    b. Obat vaksin yang telah dicek
    c. Spuit 1 cc atau sesuai kebutuhan
    d. Alcohol swab
    e. Air hangat
    f. Bengkok
    g. Perlak dan pengalas
14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
15. Pasang sarung tangan bersih
16. Siapkan jarum suntik dan spuit steril yang sesuai
17. Masukkan vaksin ke dalam spuit sesuai dosis
18. Buang udara pada spuit
19. Pasang perlak dan pengalas
20. Posisikan pasien dengan aman dan nyaman sesuai area penyuntikan
21. Desinfeksi area penyuntikan dengan alcohol swab

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN IMUNISASI/VAKSIN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1970/2026	No.Revisi 05	Halaman : 3/3
	(vaksin pasif) atau air hangat (vaksin aktif) 22. Injeksikan vaksin sesuai rute pemberian (IM, IK, SC) 23. Buang jarum spuit di safety box 24. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 25. Lepaskan sarung tangan 26. Anjurkan pasien melakukan imunisasi/vaksin sesuai jadwal berikutnya 27. Informasikan imunisasi yang diwajibkan pemerintah dan untuk kejadian khusus 28. Informasikan penundaan pemberian imunisasi tidak berarti mengulang jadwal imunisasi kembali 29. Informasikan penyedia layanan Pekan Imunisasi Nasional yang menyediakan vaksin gratis. 30. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah Dokumentasikan waktu pemberian, nama vaksin (merk dagang, batch), lokasi penyuntikan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TEPID SPONGE**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1971 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan tindakan kontrol panas tubuh melalui teknik kompres blok pada pembuluh darah superfisial dengan teknik seka
TUJUAN	Termoregulasi Membaik, Termorgulasi Neonatus Membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Baskom mandi yang berisi air hangat (37°C) sebanyak 2 buah c. Perlak dan pengalas d. Waslap minimal sebanyak 4 buah e. Selimut f. Handuk g. Pakaian ganti h. Termometer 6. Jaga privasi pasien (tutup pintu/gorden)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TEPID SPONGE**		
	No.Dokumen 400.7.9/1971/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	7. Pastikan lingkungan aman dan nyaman 8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Pasang sarung tangan bersih 10. Periksa suhu tubuh pasien 11. Pasang perlak dan pengalas 12. Lepaskan pakaian pasien 13. Tutup tubuh dengan selimut/handuk 14. Basahi waslap dengan air dan letakkan waslap yang sudah basah di bagian aksila dan lipatan paha selama 3-5 menit 15. Keringkan ekstremitas dan periksa kembali suhu pasien 16. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 17. Lepaskan sarung tangan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SKIN TO SKIN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1972/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memfasilitasi kontak kulit ibu dan bayi secara langsung selama satu jam
TUJUAN	Status Menyusui Membaik, Perlekatan Meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Bantal b. Handuk 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Identifikasi kesiapan dan kemampuan ibu dan bayi 8. Berikan posisi reclyning atau menggunakan bantal 9. Buka pakaian atas ibu 10. Keringkan bayi dengan handuk, kecuali bagian tangan 11. Letakkan bayi di bawah puting di antara kedua payudara 12. Nilai APGAR bayi 13. Biarkan ibu dan bayi melakukan kontak kulit selama

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMBERIAN TERAPI SKIN TO SKIN**		
	No.Dokumen 400.7.4/1972/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	satu jam 14. Berikan selimut menutupi tubuh bayi 15. Berikan topi pada kepala bayi 16. Bebaskan jalan napas bayi untuk menghindari SUPC (Sudden Unexpected Postpartum Collapse) 17. Anjurkan keluarga untuk mendampingi ibu 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons ibu dan bayi		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN CEDERA**		
	No.Dokumen 400.7.4/1973/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan menurunkan risiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik
TUJUAN	Tingkat Cedera Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Keset 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera 9. Identifikasi obat yang berpotensi menyebabkan cedera 10. Identifikasi kesesuaian alas kaki atau stocking elastis pada ekstremitas bawah 11. Sediakan pencahayaan yang memadai 12. Sosialisasikan cara penggunaan telepon, tempat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN CEDERA**		
	No.Dokumen 400.7.4/1973/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	tidur, penerangan ruangan dan lokasi kamar mandi 13. Posisikan barang-barang pribadi pasien di tempat yang mudah dijangkau 14. Pertahankan posisi tempat tidur di posisi terendah 15. Kunci roda tempat tidur atau kursi roda 16. Pasang pengaman tempat tidur pasien 17. Anjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk selama beberapa menit sebelum berdiri 18. Lepaskan sarung tangan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN INFEKSI**		
	No.Dokumen 400.7.9/1979/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menurunkan risiko terpapar organisme patogenik
TUJUAN	Tingkat Infeksi Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Handrub atau hand soap c. Hand towel atau tisu d. Alat pelindung diri sesuai kebutuhan (seperti topi pelindung, masker, apron atau jubah) e. Tempat sampah 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 9. Batasi jumlah pengunjung 10. Lakukan perawatan kulit jika ada risiko gangguan integritas kulit 11. Pertahankan teknik aseptik pada pasien dengan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN INFEKSI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1979/ 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	risiko tinggi 12. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 13. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar 14. Ajarkan etika batuk 15. Ajarkan cara memeriksa tanda dan gejala infeksi pada luka 16. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 17. Anjurkan meningkatkan asupan cairan 18. Lepaskan sarung tangan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN INFEKSI INTRAOPERATIF**		
	No.Dokumen 400.7.5 / 1975 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menurunkan risiko terpapar organisme patogenik pada periode intraoperasi
TUJUAN	Tingkat Infeksi Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Handrub atau hand soap c. Hand towel atau tisu d. Alat pelindung diri sesuai kebutuhan (seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah, pelindung mata, apron, sepatu boot sesuai model transmisi mikroorganisme) e. Tempat sampah 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan 8. Periksa sirkulasi udara di kamar operasi, sesuai protocol

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN INFEKSI INTRAOPERATIF**		
	No.Dokumen 400.7.5 / 1975 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Periksa alat-alat atau instrumen yang akan disterilisasi bersih dari kotoran (seperti darah atau cairan tubuh lainnya, bebas dari karat, ketajaman) 10. Periksa kelayakan alat steril yang akan digunakan untuk pembedahan (seperti tanggal sterilisasi/tanggal kadaluarsa, kelayakan pembungkus instrumen) 11. Periksa kelayakan sistem laminar airflow ventilator 12. Periksa kelayakan panel oksigen dan peralatan penunjang lainnya 13. Terapkan kewaspadaan umum (seperti cuci tangan aseptik, gunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah, pelindung mata, apron, sepatu boot sesual model transmisi mikroorganisme) 14. Pertahankan suhu tubuh dalam rentang normal 15. Desinfeksi kulit dengan klorheksidin 2%, atau sesuai protocol 16. Kolaborasi dengan medis untuk pemberian antibiotik profilaksis, sesuai indikasi 17. Gunakan baju, laken, alas, drape, dan pelindung luka sekali pakai (disposable) 18. Lakukan irigasi luka dengan cairan steril atau cairan pencuci 19. Gunakan hepafilter pada area khusus 20. Berikan penanda khusus pada pasien dengan penyakit menular 21. Lepaskan sarung tangan 22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 23. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN JATUH**		
	No.Dokumen 400.7.4/1976/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 29 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifiksi dan menurunkan risiko terjatuh akibat perubahan kondisi fisik atau fisiologis
TUJUAN	Tingkat Jatuh Menurun, Tingkat Cedera Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Kancing/gelang kuning atau penanda risiko jatuh c. Formulir penilaian risiko jatuh d. Alat tulis 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Lakukan penilaian tingkat risiko jatuh 8. Pasang kancing atau gelang kuning sebagai penanda risiko jatuh 9. Jelaskan manfaat kancing/gelang kuning penanda risiko jatuh 10. Monitor risiko jatuh minimal 1 kali setiap shift, atau sesuai tingkat risiko jatuh dan kebijakan institusi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN JATUH**		
	No.Dokumen A00.7.9 / 1976 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur 12. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh 13. Orientasikan ruangan pada pasien dan keluarga 14. Rendahkan ketinggian tempat tidur 15. Tempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan nurse station 16. Pasang pagar tempat tidur 17. Pastikan roda tempat tidur terkunci 18. Dekatkan bell dalam jangkauan pasien 19. Ajarkan cara menggunakan bel pemanggil 20. Dekatkan alat atau benda-benda yang dibutuhkan pasien dari jangkauan pasien 21. Berikan penerangan yang cukup 22. Pastikan lantai selalu dalam kondisi kering 23. Jelaskan faktor risiko jatuh dan pencegahan risiko jatuh 24. Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah 25. Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan 26. Anjurkan melebarkan jarak kedua kaki dengan meningkatkan keseimbangan saat berdiri 27. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 28. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGEKANGAN FISIK**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1750 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengggunakan perangkat pengekangan mekanis untuk membatasi fisik dan menurunkan risiko cedera pada pasien
TUJUAN	Kontrol diri meningkat, tingkat agitasi menurun, tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan, jika perlu b. Alat kekang 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan 8. Siapkan lingkungan terapeutik 9. Identifikasi kebutuhan untuk dilakukan pengekangan (restrain) 10. Sediakan staf yang memadai untuk melakukan pengekangan 11. Pasang tali kekang pada keempat ekstremitas

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGEKANGAN FISIK**		
	No.Dokumen 400.7.9/1750/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Amankan pengekangan dari batas jangkauan pasien 13. Monitor respons pasien terhadap pengekangan 14. Monitor kondisi kulit pada area pengekangan 15. Fasilitasi perubahan posisi secara berkala 16. Latih rentang gerak sendi sesuai kondisi pasien 17. Fasilitasi kebutuhan nutrisi, eliminasi, hidrasi dan kebersihan diri 18. Lepaskan sarung tangan 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGEKANGAN KIMIAWI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1751 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengggunakan agen psikofarmaka untuk membatasi fisik dan menurunkan risiko cedera pada pasien
TUJUAN	Kontrol diri, tingkat agitasi menurun, tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Agen psikofarmaka, sesuai program 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan 8. Identifikasi kebutuhan untuk dilakukan pengekangan (seperti agitasi dan kekerasan) 9. Berikan agen psikofarmaka untuk pengekangan kimiawi, sesuai program 10. Libatkan keluarga dalam mengambil keputusan pengekangan kimiawi 11. Monitor riwayat pengobatan dan alergi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGEKANGAN KIMIAWI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1751 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	12. Monitor respons agitasi sebelum dan sesudah pengekangan kimiawi 13. Monitor tingkat kesadaran dan tanda-tanda vital secara berkala, sesuai kondisi pasien 14. Latih rentang gerak sendi, sesuai kondisi pasien 15. Fasilitasi kebutuhan nutrisi, eliminasi, hidrasi dan kebersihan diri 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGONTROLAN INFEKSI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1752 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengendalikan penyebaran infeksi dan perburukan komplikasi akibat infeksi
TUJUAN	Tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Handrub atau hand soap c. Hand towel atau tisu d. Alat pelindung diri, sesuai kebutuhan e. Tempat sampah 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Terapkan kewaspadaan universal dengan menggunakan alat pelindung dini (seperti sarung tangan, masker, pelindung wajah, pelindung mata, apron, sepatu boot sesuai model transmisi mikroorganisme) 8. Tempatkan pasien pada ruang isolasi bertekanan

positif untuk pasien yang mengalami penurunan imunitas

9. Tempatkan pasien pada ruang isolasi bertekanan negatif untuk pasien dengan resiko penyebaran infeksi via droplet atau udara
10. Sterilisasi dan desinfeksi alat-alat, furnitur, lantai, sesuai kebutuhan
11. Gunakan hepafilter pada area khusus (seperti kamar operasi)
12. Berikan tanda khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit menular
13. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar
14. Ajarkan etika batuk dan/atau bersin
15. Lepaskan sarung tangan dan alat pelindung diri lainnya
16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien

UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENJAHITAN LUKA**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1753 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyatukan ujung luka dengan menggunakan jarum dan benang jahit steril
TUJUAN	Integritas kulit dan jaringan meningkat, tingkat infeksi menurun, tingkat perdarahan menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Hecting set b. Sarung tangan bersih c. Sarung tangan steril d. Cairan antiseptik e. Obat anestesi lokal f. Spuit 3 cc 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Bersihkan area luka dengan cairan antiseptik 9. Berikan anestesi lokal di area luka 10. Lepas sarung tangan bersih dan pasang sarung

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENJAHITAN LUKA**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1753 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	tangan steril 11. Jahit luka dengan memasukkan jarum tegak lurus terhadap permukaan kulit 12. Tarik jahitan cukup kencang sampai kulit tidak tertekuk 13. Kunci jahitan dengan simpul 14. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 15. Lepas sarung tangan 16. Informasikan cara merawat jahitan 17. Informasikan tentang waktu pelepasan jahitan 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN AMPUTASI**		
	No.Dokumen 400.7.4/1759/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis sebelum dan sesudah amputasi bagian tubuh
TUJUAN	Citra tubuh meningkat, integritas kulit/jaringan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Cairan antiseptik c. Kasa d. Plester e. Obat-obat topikal (antibiotik), jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Monitor adanya edema pada stump 9. Monitor nyeri phantom pada tungkai (seperti rasa terbakar, kram, berdenyut, rasa remuk atau kesemutan) 10. Monitor prosthesis secara teratur (seperti stabilitas,

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN AMPUTASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1759 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	kemudahan pergerakan, efisiensi energi, tampilan sat berjalan) 11. Monitor penyembuhan luka pada area insisi 12. Monitor masalah psikologis (seperti depresi, kecemasan) 13. Identifikasi modifikasi dalam pakaian, sesuai kebutuhan 14. Fasilitasi penggunaan matras/kasur pengurang tekanan 15. Posisikan stump (puntung/ujung bagian yang diamputasi) pada kesejajaran tubuh yang benar 16. Tempatkan stump bawah lutut (below-the-knee) dalam posisi ekstensi 17. Hindari meletakan stump pada posisi menggantung untuk menurunkan edema dan stasis vaskuler 18. Balut stump, sesuai kebutuhan 19. Lakukan pereda nyeri nonfarmakologis (seperti TENS, phonophoresis,pemijatan), sesuai kebutuhan 20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 21. Fasilitasi menghadapi proses berduka karena kehilangan bagian tubuh 22. Motivasi merawat stump secara mandiri 23. Jelaskan bahwa nyeri phantom dapat terjadi beberapa minggu setelah pembedahan yang dapat dipicu oleh tekanan pada area lain 24. Lepas sarung tangan 25. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 26. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN BAYI DALAM INKUBATOR**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1755 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan perawatan pada bayi berat badan lahir rendah (BBLR) atau bayi sakit dengan menggunakan alat khusus yang dapat memberikan suhu lingkungan yang optimal
TUJUAN	Termoregulasi membaik
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Unit Inkubator dan matras b. Laken bersih c. Aquadest steril 6. Periksa fungsi unit inkubator 7. Hubungkan inkubator ke sumber listrik 8. Nyalakan inkubator 9. Isi humidifier inkubator dengan aquadest steril sesuai dengan batas air yang ada pada humidifier 10. Setting menu (suhu/humidifikasi) inkubator disesuaikan berat badan/gestasi bayi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN BAYI DALAM INKUBATOR**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1755 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Pasang laken pada matras 12. Berikan waktu 30-60 menit untuk menghangatkan incubator 13. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 14. Masukkan bayi dalam inkubator 15. Buka pakaian bayi, kecuali diapers agar memudahkan pengamatan 16. Pasang skin probe untuk memonitor suhu kulit 17. Monitor suhu bayi dan setting suhu inkubator setiap 3 jam 18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 19. Bersihkan inkubator setiap shift 20. Ganti inkubator setiap 1 minggu sekali 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INTEGRITAS KULIT**		
	No.Dokumen 400.7.A / 1756 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat kulit untuk menjaga keutuhan dan kelembaban kulit serta mencegah perkembangan mikroorganisme
TUJUAN	Integritas kulit dan jaringan meningkat, perawatan diri meningkat, tingkat pengetahuan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Obat-obat antidote, sesuai dengan jenis obat kemoterapi b. Paracetamol c.Pengalas d. Alat kompres (cold pack) e.Alat pengaman diri (seperti masker, penutup kepala, sarung tangan, google, gaun, apron) f. Kasa steril kecil g. Spuit 1 cc h. Spuit 3 cc i. Perekat/plester j. Transparant film k. Hidroaktif (ektratin) l. Bantal

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INTEGRITAS KULIT**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1756 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	m. Tempat sampah kemoterapi n. Safety box 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Hentikan aliran infus 8. Identifikasi obat antineoplastik yang diberikan 9. Gunakan alat pelindung diri 10. Pasang pengalas di bawah daerah yang mengalami ekstravasasi 11. Buka balutan infus 12. Lepaskan selang infus dari kateter vena dan biarkan kateter vena tetap di tempat 13. Hindari adanya tetesan obat kemoterapi 14. Tutup selang infus dengan kasa steril dan beri perekat 15. Lakukan aspirasi cairan sebanyak mungkin dari kateter vena 16. Aspirasi cairan secara subkutan di sekitar daerah penusukan untuk menarik obat di dalam jaringan 17. Berikan kompres dingin atau hangat sesual obat jenis kemoterapi merujuk pada daftar "Cytostatica Crash Card" 18. Istirahatkan tangan yang mengalami ekstravasasi dan ditinggikan 30 dengan satu bantal selama 2x24 jam 19. Tandai daerah yang mengalami ekstravasasi 20. Pasang transparant film pada daerah penusukan atau daerah ektravasasi 21. Buang sampah dan alat yang telah digunakan dalam wadah khusus untuk sampah kemoterapi dan untuk benda tajam ke dalam safety box 22. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 23. Lepaskan sarung tangan 24. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 25. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN INTEGRITAS KULIT AKIBAT PEMBERIAN OBAT ANTINEOPLASTIK**		
	No.Dokumen 400.7.9/1977/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat kulit untuk menjaga keutuhan, kelembaban, pencegahan perluasan efek obat antineoplastik
TUJUAN	Intergritas kulit/jaringan meningkat, tingkat nyeri menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Obat-obat antidote, sesuai dengan jenis obat kemoterapi b. Paracetamol c. Pengalas d. Alat kompres (cold pack) e. Alat pengaman diri (seperti masker, penutup kepala, sarung tangan, google, gaun, apron) f. Kasa steril kecil g. Spuit 1 cc h. Spuit 3 cc i. Perekat/plester j. Transparant film k. Hidroaktif (ektratin) l. Bantal

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	PERAWATAN INTEGRITAS KULIT AKIBAT PEMBERIAN OBAT ANTINEOPLASTIK		
	No.Dokumen 400.7.4/1977/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	m. Tempat sampah kemoterapi n. Safety box 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Hentikan aliran infus 8. Identifikasi obat antineoplastik yang diberikan 9. Gunakan alat pelindung diri 10. Pasang pengalas di bawah daerah yang mengalami ekstravasasi 11. Buka balutan infus 12. Lepaskan selang infus dari kateter vena dan biarkan kateter vena tetap di tempat 13. Hindari adanya tetesan obat kemoterapi 14. Tutup selang infus dengan kasa steril dan beri perekat 15. Lakukan aspirasi cairan sebanyak mungkin dari kateter vena 16. Aspirasi cairan secara subkutan di sekitar daerah penusukan untuk menarik obat di dalam jaringan 17. Berikan kompres dingin atau hangat sesual obat jenis kemoterapi merujuk pada daftar "Cytostatica Crash Card" 18. Istirahatkan tangan yang mengalami ekstravasasi dan ditinggikan 30 dengan satu bantal selama 2x24 jam 19. Tandai daerah yang mengalami ekstravasasi 20. Pasang transparant film pada daerah penusukan atau daerah ektravasasi 21. Buang sampah dan alat yang telah digunakan dalam wadah khusus untuk sampah kemoterapi dan untuk benda tajam ke dalam safety box 22. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 23. Lepaskan sarung tangan 24. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 25. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN KEMOTERAPI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1757 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola pemberian agen antineoplastik
TUJUAN	Integritas jaringan/kulit meningkat, tingkat nausea menurun, status kenyamanan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Alkohol 70% b. Kassa kecil steril c. Alcohol swab d. Obat premedikasi (seperti dexamethason, ranitidin, ondansentron) e. Obat kemoterapi dalam wadah khusus, sesuai protokol f. Spuit 3 cc dan 5 cc g. Tempat sampah kemoterapi h. Pengalas i. Alat pelindung diri (seperti masker, tutup

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN KEMOTERAPI**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1757 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2

	kepala, sarung tangan, google, gaun, apron) 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Lakukan double check dan prinsip 5 benar 8. Atur posisi pasien 9. Pasang pengalas di bawah daerah pemasangan infus 10. Gunakan alat-alat pelindung diri yang sudah disiapkan 11. Periksa kepatenan vena tempat pemasangan infus 12. Berikan premedikasi 30 menit sebelum pemberian obat kemoterapi 13. Berikan obat kemoterapi sesuai dengan protokol dan rute pemberiannya 14. Anjurkan melapor jika pasien merasakan keluhan seperti terbakar, perih, sakit pada saat pemberian obat kemoterapi 15. Periksa kepatenan vena pada setiap pemberian obat kemoterapi 16. Hentikan pemberian jika timbul rasa sakit, kemerahan dan rasa seperti terbakar pada daerah pemasangan infus 17. Buang sampah kemoterapi ke dalam wadah khusus sampah kemoterapi 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang telah digunakan 19. Lepaskan sarung tangan 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN LUKA**		
	No.Dokumen 400.7.9/1758/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan meningkatkan penyembuhan luka serta mencegah terjadinya komplikasi luka
TUJUAN	Integritas kulit dan jaringan meningkat, tingkat nyeri menurun, tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Sarung tangan steril c. Cairan antiseptik d. Alat cukur rambut, jika perlu e. Set perawatan luka 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Monitor karakteristik luka (meliputi drainase, wama, ukuran dan bau) 9. Monitor tanda-tanda infeksi 10. Lepaskan balutan dan plester secara perlahan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN LUKA**		
	No.Dokumen 400.7.9/1758/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	11. Cukur rambut sekitar daerah luka, jika perlu 12. Lepaskan sarung tangan bersih dan pasang sarung tangan steril 13. Bersihkan luka dengan cairan NaCl atau pembersih nontoxic, sesuai kebutuhan 14. Bersihkan jaringan nekrotik, jika ada 15. Berikan salep yang sesuai dengan kondisi luka, jika perlu 16. Pasang balutan sesuai jenis luka 17. Ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase 18. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 19. Anjurkan konsumsi makanan tinggi kalori dan protein 20. Ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri 21. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 22. Lepaskan sarung tangan 23. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 24. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien,		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN LUKA BAKAR**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1759 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat luka akut dan luka kronik akibat trauma termal
TUJUAN	Integrigritas jaringan/kulit meningkat , status cairan meningkat, status elektrolit meningkat, tingkat infeksi menurun, tingkat nyeri menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan steril b. Cairan antiseptik c. Kasa d. Plester e. Set perawatan luka f. Obat-obat premedikasi, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan steril 8. Identifikasi penyebab luka bakar 9. Identifikasi durasi terkena luka bakar dan riwayat

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PERAWATAN LUKA BAKAR</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4 / 1759 / 2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">penanganan luka sebelumnya
10. Monitor kondisi luka (meliputi presentasi ukuran luka, derajat luka, perdarahan, warna dasar luka, infeksi, eksudat, bau luka, kondisi tepi luka)
11. Gunakan teknik aseptik selama merawat luka
12. Lepaskan balutan lama dengan menghindari nyeri dan pendarahan
13. Rendam dengan air steril, jika balutan lengket pada luka
14. Bersihkan luka dengan cairan steril (seperti NaCl 0.9%, cairan antiseptik)
15. Gunakan balutan sesuai dengan kondisi luka (seperti hyrocolloid, polymer. crystalline celullosa)
16. Jelaskan tanda dan gejala infeksi
17. Anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein
18. Kolaborasi prosedur debridemen (enzimatik, biologis, mekanis, autolitik), jika perlu
19. Berikan antibiotik, jika diprogramkan
20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
21. Lepaskan sarung tangan
22. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
23. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dan respons pasien (posisi kodok)</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat Darurat</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN METODE KANGURU**		
	No.Dokumen 400.7.4/1760/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memberikan perawatan pada bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dengan metode kontak kulit dengan kulit
TUJUAN	Pemulihan pascabedah meningkat, integritas kulit dan jaringan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Kain panjang atau baju khusus Perawatan Metode Kanguru (PMK) b. Topi bayi c. Popok (diapers) d. Termometer 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Ukur suhu tubuh bayi 8. Buka pakalan bayi kecuali popok 9. Atur posisi ibu senyaman mungkin 10. Buka pakaian bagian atas ibu 11. Pasangkan baju kanguru pada ibu, jika tersedia

	12. Posisikan bayi melekat pada dada ibu dengan posisi menghadap ke ibu antara kedua payudara (posisi kodok) 13. Atur kepala bayi ke salah satu sisi dan agak tengadah 14. Lakukan fiksasi bayi pada dada ibu dengan mengunakan baju PMK atau pasangkan kain panjang dan pakaikan kembali pakaian bagian atas ibu 15. Pakaikan topi pada kepala bayi 16. Lakukan PMK selama minimal 1 jam 17. Periksa tanda-tanda vital bayi selama PMK 18. Anjurkan ibu melapor jika mendapati adanya tanda bahaya pada bayi selama PMK (seperti bayi gelisah, sesak napas) 19. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi 20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons bayi serta ibu
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PASCAOPERATIF**		
	No.Dokumen 900.7.4 / 1761 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan memberikan asuhan pada pasien yang telah menjalani tindakan operasi untuk meningkatkan pemulihan kondisi dan mencegah terjadinya komplikasi
TUJUAN	Pemulihan pascabedah meningkat, integritas kulit dan jaringan meningkat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Cairan antiseptik c. Jam atau pengukur waktu d. Oksimetri nadi e. Spigmomanometer f. Stetoskop g. Termometer h. Selimut penghangat, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PASCAOPERATIF**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1761 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	7. Pasang sarung tangan bersih 8. Atur pasien dalam posisi aman dan nyaman (seperti semi Fowler, Fowler, berbaring miring, atau posisi lainnya sesuai kebutuhan) 9. Monitor tanda-tanda vital dan saturasi oksigen (setiap 15 menit pada jam pertama, setiap 30 menit pada 2 jam berikutnya, setiap jam selama 4 jam berikutnya, dan akhirnya setiap 4 jam) 10. Berikan selimut penghangat, jika perlu 11. Periksa warna dan kondisi kulit 12. Periksa balutan (meliputi warna, bau, adanya drainase, dan jumlah drainase) 13. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 14. Lepaskan sarung tangan 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PREOPERATIF**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1762 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan menyiapkan pasien untuk menjalani prosedur operasi dan mencegah komplikasi serta perburukan saat prosedur operasi
TUJUAN	Tingkat ansietas menurun, tingkat infeksi menurun, tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Spigmomanometer c. Termometer d. Stetoskop e. Jam atau pengukur waktu f. EKG g. Timbangan h. Glukometer i. Cairan antiseptik j. Alat cukur k. Obat-obat premedikasi, jika perlu 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Periksa lokasi dan jenis operasi, sesuai program

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PREOPERATIF**		
	No.Dokumen 900.7.4 / 1762 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	9. Jaga privasi pasien 10. Periksa apakah formulir persetujuan sebelum operasi ditandatangani, disaksikan, dan benar; 11. Periksa tanda-tanda vital, berat badan, EKG dan kadar glukosa darah 12. Ambil sampel darah untuk pemeriksaan kimia darah (meliputi darah lengkap fungsi ginjal, fungsi hati dan/atau pemeriksaan lainnya), sesuai kebutuhan 13. Fasilitasi pemeriksaan penunjang (seperti radiologi atau pemeriksaan lainnya). sesuai kebutuhan 14. Ajarkan teknik mengurangi nyeri pascaoperasi, latihan napas, batuk efektif, dan preoparative teaching lainnya sesuai kebutuhan 15. Puasakan minimal 6 jam sebelum pembedahan 16. Bebaskan area kulit yang akan dioperasi dari rambut atau bulu tubuh 17. Anjurkan pasien mandi dengan cairan antiseptik (seperti klorheksidin 25%) maksimal 1 jam dan minimal malam hari sebelum pembedahan 18. Fasilitasi pasien mengenakan pakaian/gaun rumah sakit 19. Minta pasien melepaskan perhiasan dan prostesis (seperti lensa kontak, bulu mata palsu, gigi palsu, dan sebagainya) 20. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 21. Lepaskan sarung tangan 22. Pastikan kelengkapan dokumen-dokumen preoperasi (seperti surat persetujuan operasi, hasil radiologi, hasil laboratorium) 23. Koordinasi dengan perawat kamar bedah 24. Transfer ke kamar operasi dengan alat transfer yang sesuai (seperti kursi roda, brankar, tempat tidur) 25. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 26. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN SIRKUMSISI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1763 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan merawat luka sirkumsisi serta mencegah komplikasi yang mungkin terjadi akibat sirkumsisi
TUJUAN	Integritas kulit/jaringan meningkat, tingkat nyeri menurun, tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Spigmomanometer c. Stetoskop d. Termometer e. Jam atau pengukur waktu f. Kasa g. Plester h. Set perawatan luka i. Cairan antiseptik Obat-obat topikal (antibiotik dan analgesik), jika perlu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN SIRKUMSISI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1763 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Periksa keadaan umum (meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, suhu tubuh, tingkat nyeri, tanggal sirkumsisi) 9. Periksa kondisi luka (meliputi ukuran luka, jenis luka, perdarahan, warna dasar luka, infeksi, eksudat, bau luka, kondisi jaringan tepi luka) 10. Monitor adanya perdarahan (meliputi warna balutan, rembesan darah) 11. Monitor adanya komplikasi pascasirkumsisi (seperti concealed penis, phimosis, skin bridge, retensi urine, pistula, nekrosis, hipospadia iatrogenik) 12. Terapkan teknik aseptik selama merawat luka sirkumsisi 13. Terapkan atraumatic care pada pasien anak 14. Lebas balutan secara perlahan 15. Ganti balutan sesuai kondisi luka 16. Berikan obat topikal (antibiotik), jika perlu 17. Anjurkan menggunakan celana pelindung khusus untuk mencegah nyeri akibat gesekan pakaian, jika tersedia 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 19. Lepaskan sarung tangan 20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**SKRINING PASIEN ISOLASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1764 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan penapisan pasien yang dicurigai memiliki penyakit infeksius yang dilakukan pada kontak pertama pasien
TUJUAN	Tingkat infeksi menurun, tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Alat Pelindung Diri (seperti masker N95, sarung tangan, google), sesuai kebutuhan b. Formulir skrining 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang Alat Pelindung Diri (APD), sesuai kebutuhan menggunakan 8. Berikan masker bedah pada pasien, jika belum 9. Lakukan skrining dengan memeriksa gejala dan faktor risiko: 10. a. Gejala: 1) Demam (≥38 °C) atau riwayat demam

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**SKRINING PASIEN ISOLASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1764 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2

2) Batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan
3) Sesak napas atau SpO2 <90%
4) Diare, mual, muntah, kurang nafsu makan, nyeri perut, gangguan penciuman, nyeri otot, atau keletihan
5) Terdapat hasil pemeriksaan infeksi reaktif

b. Faktor risiko:

1) Riwayat perjalanan (luar negeri atau transmisi lokal) pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala
2) Memiliki riwayat paparan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala:
   a) Riwayat kontak dengan pasien terduga/terkonfirmasi penyakit infeksius
   b) Bekerja atau
   c) Memiliki riwayat bepergian ke tempat umum (seperti pasar, bandara, terminal, mall)

11. Tempatkan pasien yang terduga atau terkonfirmasi penyakit infeksius pada ruangan yang tersendiri (ruangan isolasi)
12. Informasikan hasil skirining
13. Lepaskan APD
14. Dokumentasikan hasil skrining

UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TRANSFER PASIEN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1765 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan dan mengirimkan pasien ke ruangan lain
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, tingkat jatuh menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Brankar atau kursi roda, sesuai kebutuhan c. Tabung oksigen, jika perlu d. Emergency kit, jika perlu e. Formulir transfer pasien f. Rekam medis pasien 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Periksa keadaan umum pasien 9. Lengkapi formulir transfer pasien 10. Koordinasi dengan perawat ruangan yang dituju bahwa pasien telah siap ditransfer 11. Transfer pasien ke ruangan yang dituju dengan alat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TRANSFER PASIEN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1765 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	transfer yang sesuai (seperti brakar, kursi roda) 12. Monitor kondisi pasien selama proses transfer 13. Lakukan dukungan ventilasi selama transfer, jika perlu 14. Pindahkan pasien dari brankar atau kursi roda ke tempat tidur ruangan yang dituju 15. Lakukan serah terima pasien dengan perawat ruangan yang dituju 16. Lepas sarung tangan 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**SKRINING PASIEN ISOLASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1764 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Melakukan penapisan pasien yang dicurigai memiliki penyakit infeksius yang dilakukan pada kontak pertama pasien
TUJUAN	Tingkat infeksi menurun, tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Alat Pelindung Diri (seperti masker N95, sarung tangan, google), sesuai kebutuhan b. Formulir skrining 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang Alat Pelindung Diri (APD), sesuai kebutuhan menggunakan 8. Berikan masker bedah pada pasien, jika belum 9. Lakukan skrining dengan memeriksa gejala dan faktor risiko: 10. a. Gejala: 1) Demam (≥38 °C) atau riwayat demam

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**SKRINING PASIEN ISOLASI**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1764 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2

2) Batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan
3) Sesak napas atau SpO2 <90%
4) Diare, mual, muntah, kurang nafsu makan, nyeri perut, gangguan penciuman, nyeri otot, atau keletihan
5) Terdapat hasil pemeriksaan infeksi reaktif

b. Faktor risiko:

1) Riwayat perjalanan (luar negeri atau transmisi lokal) pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala
2) Memiliki riwayat paparan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala:
   a) Riwayat kontak dengan pasien terduga/terkonfirmasi penyakit infeksius
   b) Bekerja atau
   c) Memiliki riwayat bepergian ke tempat umum (seperti pasar, bandara, terminal, mall)

11. Tempatkan pasien yang terduga atau terkonfirmasi penyakit infeksius pada ruangan yang tersendiri (ruangan isolasi)
12. Informasikan hasil skirining
13. Lepaskan APD
14. Dokumentasikan hasil skrining

UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TRANSFER PASIEN**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1765 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menyiapkan dan mengirimkan pasien ke ruangan lain
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, tingkat jatuh menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Brankar atau kursi roda, sesuai kebutuhan c. Tabung oksigen, jika perlu d. Emergency kit, jika perlu e. Formulir transfer pasien f. Rekam medis pasien 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan bersih 8. Periksa keadaan umum pasien 9. Lengkapi formulir transfer pasien 10. Koordinasi dengan perawat ruangan yang dituju bahwa pasien telah siap ditransfer 11. Transfer pasien ke ruangan yang dituju dengan alat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TRANSFER PASIEN**		
	No.Dokumen 400.7.4 / 1765 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	transfer yang sesuai (seperti brakar, kursi roda) 12. Monitor kondisi pasien selama proses transfer 13. Lakukan dukungan ventilasi selama transfer, jika perlu 14. Pindahkan pasien dari brankar atau kursi roda ke tempat tidur ruangan yang dituju 15. Lakukan serah terima pasien dengan perawat ruangan yang dituju 16. Lepas sarung tangan 17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TRIASE**		
	No.Dokumen 400.7.9 / 1766 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Memilah pasien yang tiba instalasi gawat darurat sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan pasien
TUJUAN	Ventilasi spontan meningkat, sirkulasi spontan meningkat, curah jantung meningkat, perfusi serebral meningkat, kapasitas adaptif intrakranial meningkat, tingkat perdarahan menurun, tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan ruangan dan peralatan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Formulir triase 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan 8. Catat tanggal dan jam kedatangan pasien 9. Identifikasi cara kedatangan pasien (seperti datang sendiri, berjalan, kursi roda, ambulans, telentang, digendong) 10. Identifikasi status konfirmasi (SPGTD atau non-

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">TRIASE</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.4/1766/2026</td><td>No.Revisi

05</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">SPGDT), jika pasien rujukan
11. Periksa jalan napas, pernapasan, sirkulasi dan kesadaran
12. Identifikasi keluhan utama dan riwayat kesehatan singkat
13. Tentukan kategori triase berdasarkan hasil pemeriksaan
14. Identifikasi kriteria isolasi (seperti batuk >2 minggu, demam atau riwayat demam, riwayat kontak dengan pasien penyakit menular, riwayat perjalanan dari daerah pandemi)
15. Transfer (disposisi) pasien ke zona atau ruangan yang sesuai dengan kategori triase (seperti zona merah, zona kuning, zona hijau, ruang isolasi)
16. Lakukan pengkajian dan penanganan awal sesuai response time kategori triase
17. Lepaskan sarung tangan
18. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
19. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dan respons pasien.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat Darurat</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TRIASE BENCANA**		
	No.Dokumen 300.2/2031/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menetapkan prioritas perawatan korban bencana pada fase tanggap darurat
TUJUAN	Ventilasi spontan meningkat, sirkulasi spontan meningkat, curah jantung meningkat, perfusi serebral meningkat, kapasitas adaptif intrakranial meningkat, tingkat perdarahan menurun, tingkat cedera menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan b. Label triase (triage tag) c. Alat tulis 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 7. Pasang sarung tangan 8. Periksa RPM (Repiration: frekuensi napas; Perfusion: denyut nadi atau pengisian kapiler, Mental status: tingkat kesadaran) 9. Tentukan kategori triase berdasarkan hasil

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TRIASE BENCANA**		
	No.Dokumen 300.2/2031/2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	pemeriksaan 10. Pasang label triase sesuai kategori triase 11. Pilah korban ke zona yang sesuai dengan kategori triase (seperti zona merah, zona kuning, zona hijau, zona hitam) 12. Lakukan pengkajian dan penanganan awal sesuai response time kategori triase 13. Lepaskan sarung tangan 14. Dokumentasikan hasil triase dan respons korban		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN RISIKO PERILAKU KEKERASAN**		
	No.Dokumen 400.7.A/1965/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengumpulkan dan menganalisis risiko kemarahan yang diekspresikan secara berlebihan dan tidak terkendali secara verbal sampai dengan mencederai orang lain dan/atau merusak lingkungan
TUJUAN	Kontrol Diri Meningkat, Tingkat Cedera Menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujan dan langkah-langkah prosedur 5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 6. Periksa tanda/gejala perilaku kekerasan (meliputi pemikiran waham/deluasi, kecurigaan pada orang lain, halusinasi, berencana bunuh diri, disfungsi sistem keluarga, gangguan kognitif, disorientasi atau konfusi, kerusakan kontrol impuls. alam perasaan depresi, riwayat kekerasan, kelainan neorologis, lingkungan tidak teratur, penganiayaan/pengabaian anak, impulsif, ilusi) 7. Periksa faktor risiko spesifik perilaku kekerasan (seperti GAF Score, BPRS, OAS)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMANTAUAN RISIKO PERILAKU KEKERASAN**		
	No.Dokumen A00.7.9 /1965 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	8. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 9. Dokumentasikan hasil pemantauan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN KESEHATAN KERJA**		
	No.Dokumen 400.7 / 1958 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mengidentifikasi dan mengelola lingkungan kerja untuk meningkatkan kesehatan pekerja
TUJUAN	Tingkat cedera menurun, tingkat jatuh menurun, tingkat infeksi menurun
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Identifikasi kesehatan pekerja (meliputi fungsi fisik, jiwa, sosial, spiritual dan pola kebiasaan sehari-hari yang berpengaruh terhadap kesehatan seperti pola makan/minum, aktivitas dan istirahat, manajemen stres) 2. Identifikasi kebijakan kesehatan kerja (meliputi standar prosedur kesehatan kerja, administrasi dan penerapannya) 3. Identifikasi faktor risiko kesehatan kerja (seperti hazard fisik, kimia, biologi, ergonomik dan psikososial serta kecelakaan kerja di lingkungan kerja) 4. Periksa adanya label atau tanda pada zat atau alat yang berbahaya 5. Pasang label atau tanda pada zat atau alat yang berbahaya sesuai kebutuhan 6. Berikan informasi pada pekerja terkait zat dan alat yang berbahaya bagi kesehatan pekerja

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN KESEHATAN KERJA**		
	No.Dokumen 400.7 / 1958 / 2026	No.Revisi 05	Halaman : 2/2
	7. Berikan pertolongan pertama pada pekerja yang mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan kerja akut 8. Rujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, jika perfu 9. Monitor kondisi pekerja dan lingkungan kerja minimal enam bulan sekali 10. Dokumentasikan kondisi pekerja, lingkungan kerja dan penangannya dalam catatan keperawatan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat inap 2. Instalasi Rawat jalan 3. Instalasi Gawat darurat		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI BERMAIN** **UNTUK PASIEN GANGGUAN JIWA**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1099 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Intervensi keperawatan jiwa yang menggunakan media permainan terstruktur (individu maupun kelompok) sebagai sarana terapeutik untuk merealisasikan emosi terpendam, melatih hubungan interpersonal, serta meningkatkan fungsi kognitif dan motorik pasien gangguan jiwa.
TUJUAN	1. Mengurangi Isolasi Sosial: Mendorong interaksi dan komunikasi verbal/non-verbal dengan orang lain. 2. Kanalisasi Emosi: Menyediakan sarana yang aman untuk menyalurkan energi berlebih, kecemasan, atau agresi secara adaptif. 3. Stimulasi Kognitif & Konsentrasi: Melatih daya ingat, fokus, serta kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving*). 4. Meningkatkan Harga Diri: Memberikan rasa pencapaian (*sense of accomplishment*) melalui aktivitas yang menyenangkan.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Lakukan verifikasi identitas pasien dan kaji rekam medis (kondisi psikologis saat ini). 2. Tentukan tujuan permainan berdasarkan masalah keperawatan utama pasien. 3. Siapkan media permainan yang aman (pastikan tidak ada benda tajam/berbahaya). 4. Siapkan diri perawat dan ciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari distraksi.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI BERMAIN** **UNTUK PASIEN GANGGUAN JIWA**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1099 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/3

5. Ucapkan salam hangat
6. perkenalkan diri.
7. Validasi perasaan dan kondisi psikis pasien hari ini.
8. Jelaskan jenis permainan, tujuan, dan aturan main.
9. Buat kontrak waktu (umumnya 20–30 menit) dan tempat.
10. Mintalah persetujuan dan kesediaan pasien (*informed consent* verbal).
11. Posisikan pasien dalam posisi duduk/berdiri yang nyaman.
12. Peragakan atau jelaskan aturan permainan dengan singkat dan jelas.
13. Minta pasien untuk memulai permainan.
14. Bimbing pasien untuk mengekspresikan perasaannya selama bermain (contoh: *"Bagaimana perasaannya saat menyusun warna ini?"*).
15. Jika pasien menunjukkan tanda-tanda frustrasi atau ketegangan, hentikan sejenak dan berikan bimbingan de-eskalasi emosi.
16. Hentikan permainan setelah durasi waktu kontrak selesai.
17. Ajak pasien merapikan alat permainan bersama-sama.
18. Evaluasi Subjektif: Tanyakan perasaan pasien setelah mengikuti terapi bermain (contoh: *"Bagaimana perasaannya setelah kita bermain tadi?"*).
19. Evaluasi Objektif: Ulas pencapaian pasien secara singkat dan berikan penghargaan/apresiasi atas usahanya.
20. Rencanakan tindak lanjut (kegiatan permainan lanjutan atau intervensi lain).

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI BERMAIN** **UNTUK PASIEN GANGGUAN JIWA**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1099 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 3/3
	21. Ucapkan Salam penutup. 22. Catat pada lembar catatan perkembangan keperawatan: a. Waktu pelaksanaan dan jenis permainan yang digunakan. b. Tingkat partisipasi, rentang konsentrasi, dan ekspresi emosi pasien. c. Kemampuan interaksi sosial dan respons pasien terhadap pujian. d. Tanda-tanda distress atau perubahan perilaku jika ada.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat Inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGKAJIAN RISIKO BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/643/2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 11 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Pengkajian risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri adalah serangkaian proses penilaian obyektif yang dilakukan perawat atau dokter untuk menggali ide, rencana, niat, serta perilaku menyakiti diri sendiri (self-harm) atau upaya mengakhiri hidup pada pasien. Sejak datang di IGD dan atau selama perawatan
TUJUAN	1. Mengidentifikasi secara komprehensif tingkat risiko pasien untuk melakukan tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri. 2. Menentukan rencana asuhan keperawatan dan medis yang tepat serta aman guna meminimalkan risiko mencederai diri selama masa perawatan. 3. Memastikan implementasi langkah-langkah keselamatan lingkungan dan pengawasan pasien berjalan sesuai dengan derajat risikonya.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi nomor 03 tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien dengan benar. 4. Beritahukan tentang prosedur dan tujuan tindakan kepada pasien dan keluarga. 5. Jaga privasi pasien (menutup tirai atau pintu kamar wawancara). 6. Cuci tangan sesuai standar keselamatan pasien. 7. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 8. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur tindakan pengkajian. 9. Lakukan pendekatan secara empati, tenang, hangat, dan tidak menghakimi (clear mutual explanation). 10. Melakukan evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek berikut:

a. Faktor Risiko Klinis: Menggali keluhan depresi berat, keputusasaan, insomnia akut, atau adanya halusinasi perintah (*command hallucinations*) untuk menyakiti diri.
b. Ideasi (Gagasan): Menanyakan frekuensi, durasi, dan intensitas pikiran bunuh diri yang muncul.
c. Rencana dan Metode: Mengidentifikasi apakah pasien sudah memikirkan cara, waktu, tempat, atau ketersediaan alat untuk melakukan aksi tersebut.
d. Riwayat Perilaku Masa Lalu: Memeriksa rekam medis atau menanyakan langsung terkait riwayat percobaan bunuh diri atau perilaku melukai diri (*cutting, burning*) sebelumnya.

11. Risiko Rendah: skor 0-3, Ideasi bersifat pasif, tidak ada rencana kliinis spesifik, kontrol diri baik.
12. Risiko Sedang: skor 4-6, Ideasi aktif, ada pemikiran metode, namun tidak ada niat segera.
13. Risiko Tinggi:skor 10+. Ideasi aktif disertai rencana spesifik, persiapan alat, atau adanya riwayat percobaan bunuh diri dalam waktu dekat.
14. Menyingkirkan semua benda yang berpotensi membahayakan dari sekitar pasien (tali, kabel, benda tajam, kaca, obat-obatan, zat kimia, sabuk).
15. Memindahkan pasien ke area perawatan yang mudah dipantau langsung oleh *Nurse Station*.
16. Melakukan pembatasan akses lingkungan (kunci jendela, pastikan pintu toilet tidak dapat dikunci dari dalam).
17. Pengawasan Ketat: Menerapkan protokol observasi melekat 24 jam untuk Risiko Tinggi (pasien tidak boleh ditinggalkan sendirian sama sekali, termasuk saat ke toilet).
18. Memastikan kepatuhan minum obat dipantau ketat secara langsung (*Direct Observation Therapy*).
19. Melaporkan hasil pengkajian risiko kepada DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) Utama.
20. Melakukan konsultasi Cito ke Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater) untuk pasien dengan kategori Risiko Tinggi guna penanganan psikofarmaka dan psikoterapi lanjutan.
21. Melakukan tindakan penyelamatan jiwa (*Life Saving*) segera apabila terjadi insiden percobaan melukai diri/bunuh diri selama perawatan, lalu melaporkan sebagai Insiden Keselamatan Pasien (IKP) ke Komite

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGKAJIAN RISIKO BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/643/2026	No.Revisi 01	Halaman : 3/3
	Keselamatan Pasien RS (KKPRS) dalam waktu maksimal 2 X 24 jam.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. Instalasi Rawat Inap (Ruang Perawatan Umum & Jiwa) 3. Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik Jiwa) 4. Komite Keperawatan 5. Komite Medis 6. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS) 7. Satuan Pengamanan / Sekuriti		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**SKRINING RISIKO BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/644/2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 11 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Skrining risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri adalah proses evaluasi proaktif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (perawat atau dokter) untuk mengidentifikasi pasien yang memiliki kecenderungan, ide, rencana, atau perilaku menyakiti diri sendiri (self-harm) atau mengakhiri hidupnya.
TUJUAN	1. Mendeteksi secara dini adanya risiko bunuh diri atau perilaku melukai diri sendiri pada pasien yang mengakses layanan rumah sakit. 2. Mencegah terjadinya tindakan bunuh diri atau cedera fisik akibat melukai diri sendiri selama pasien berada dalam perawatan rumah sakit. 3. Menentukan tingkat intervensi dan proteksi yang tepat sesuai dengan derajat risiko pasien (Rendah, Sedang, Tinggi).
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi nomor 03 tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Identifikasi kembali kecocokan identitas fisik pasien dengan gelang identitas. 8. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur tindakan pengkajian secara jelas, ramah, dan empati. 9. Lakukan pendekatan secara empati, tenang, hangat, dan tidak menghakimi demi membangun hubungan saling percaya (*clear mutual explanation*). 10. Sediakan lingkungan wawancara yang aman, tenang, dan menjamin privasi pasien. 11. Melakukan wawancara klinis menggunakan instrumen skrining formal (Columbia *Suciede Severity-Screening)*

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**SKRINING RISIKO BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI**		
	No.Dokumen A00.7.3.9/699/2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/3

dengan mengajukan pertanyaan terstruktur secara hati-hati:

12. Pernahkah Anda berharap mati atau berharap bisa tidur dan tidak bangun lagi?
13. Pernahkah Anda benar-benar berpikir untuk bunuh diri?
14. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana caranya?
15. Pernahkah Anda memiliki pikiran-pikiran ini dan berniat untuk mewujudkannya?
16. Sudahkah Anda mulai memikirkan atau menyusun detail cara bunuh diri? Apakah Anda berniat melaksanakan rencana ini?
17. Pernahkah Anda melakukan sesuatu, mulai melakukan sesuatu, atau bersiap melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidup Anda?
18. Jika YA, tanyakan: Apakah ini terjadi dalam tiga bulan terakhir?
19. Risiko Rendah (Ada ide, tidak ada rencana/niat):
    a. Edukasi diberikan kepada pasien dan pihak keluarga.
    b. Melakukan observasi rutin berkala di setiap shift perawatan.
20. Risiko Sedang (Ada ide dan metode, tidak ada rencana spesifik):
    a. Melaporkan hasil temuan risiko kepada DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan).
    b. Melakukan konsultasi penanganan klinis ke Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater).
    c. Melakukan observasi berkala secara rutin (misal tiap 1-2 jam) serta memastikan lingkungan fisik sekitar pasien aman.
21. Risiko Tinggi (Ada niat kuat, rencana spesifik, atau riwayat percobaan baru):
    a. Melakukan *Safewards Intervention* / Protokol Pengawasan Ketat secara melekat selama 24 jam penuh.
    b. Menyingkirkan semua benda berbahaya di sekitar jangkauan pasien (seperti tali, kabel, benda tajam, kaca, zat kimia, obat-obatan berlebih, sabuk, korek api).
    c. Memastikan pasien didampingi oleh pihak keluarga atau staf medis setiap saat tanpa jeda, termasuk ketika ke kamar mandi.
    d. Menghubungi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater) sesegera mungkin untuk penanganan

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">SKRINING RISIKO BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.3.9/699/2026</td><td>No.Revisi

01</td><td>Halaman :

3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">darurat psikiatri.
22. Mencatat seluruh data hasil skrining, skor tingkat risiko, serta tindakan proteksi keselamatan yang dilakukan ke dalam Berkas Rekam Medis Elektronik maupun Manual (Lembar Asesmen Awal Keperawatan/Medis)</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2. Instalasi Rawat Inap (Ruang Perawatan Umum & Jiwa)
3. Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik Jiwa/Umum)
4. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS)</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI ELEKTROKONVULSIF (ECT)**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/645/2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 11 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi Elektrokonvulsif (Electroconvulsive Therapy / ECT) adalah suatu jenis pengobatan somatik untuk memicu kejang grand mal secara buatan dengan mengalirkan arus listrik dosis aman melalui elektroda yang ditempatkan pada pelipis pasien. Terapi ini dapat berupa ECT konvensional atau MECT (Modified Electroconvulsive Therapy) yang menggunakan relaksan otot dan anestesi ringan guna memulihkan gangguan jiwa tertentu.
TUJUAN	1. Mengurangi atau menghilangkan gejala klinis akut pada pasien dengan gangguan jiwa berat (seperti Depresi Berat dengan kecenderungan bunuh diri, Skizofrenia Katatonik, Manik Akut, atau psikosis yang tidak merespon obat). 2. Mencapai efek terapeutik yang cepat dan aman guna meminimalkan risiko mencederai diri sendiri atau orang lain.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	A. Tahap Orientasi dan Persiapan Awal (Di Ruang Perawatan) 1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri staf medis/keperawatan yang bertugas. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Beritahukan tentang prosedur dan tujuan tindakan ECT kepada pasien dan keluarga. 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan. 7. Identifikasi kembali kecocokan identitas fisik pasien dengan gelang identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 8. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur

tindakan secara rinci dan empati kepada keluarga/pasien.

9. Pastikan *Informed Consent* telah ditandatangani dan diverifikasi oleh DPJP.
10. Pasangkan status puasa kepada pasien selama minimal 6 jam sebelum tindakan dimulai.
11. Lepaskan seluruh protesa (gigi palsu, lensa kontak), perhiasan, d an peniti dari tubuh pasien, serta memastikan rambut pasien bersih bebas minyak.
12. Ukur tanda-tanda vital (Tensi, Nadi, Suhu, RR) dan memastikan pasien sudah buang air kecil sebelum dibawa ke ruang ECT.

B. Tahap Persiapan Alat & Lingkungan (Di Ruang ECT)

1. Menyiapkan mesin ECT (konvensional/MECT) beserta kelengkapannya dan melakukan uji fungsi alat (*self-test*).
2. Menyiapkan peralatan resusitasi dan kedaruratan medis (*Emergency Trolley*) lengkap dengan oksigen, *suction apparatus*, dan *Airway Management Kit*.
3. Menyiapkan bahan habis pakai meliputi jelly konduktor, *bite blocks* (ganjalan mulut), kasa steril, dan alkohol swab.

C. Tahap Pelaksanaan Tindakan ECT

1. Memposisikan pasien telentang (*supine*) di atas tempat tidur tindakan tanpa bantal, memasang sabuk pengaman longgar jika diperlukan.
2. *(Untuk MECT)*: Memastikan Dokter Spesialis Anestesi memberikan premedikasi, sedatif, dan relaksan otot sesuai dosis klinis.
3. Membersihkan area pelipis (bilateral/unilateral) menggunakan alkohol swab, kemudian mengoleskan jelly konduktor pada elektroda mesin ECT.
4. Memasukkan *bite blocks* yang telah dibungkus kasa ke dalam mulut pasien untuk melindungi lidah dan gigi dari trauma akibat kejang.
5. Memfiksasi area persendian utama pasien secara ringan dan fleksibel (tidak menahan kejang secara kaku untuk menghindari cedera fraktur).
6. Memastikan DPJP Psikiatri menentukan dosis energi listrik, menempelkan elektroda pada pelipis pasien, dan menekan tombol stimulus.
7. Mengamati fase kejang pasien (fase tonik-klonik hingga selesai) dan memastikan mesin mencatat durasi kejang efektif (minimal 20-30 detik).

D. Tahap Pasca-Tindakan & Pemulihan (Recovery Room)

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">TERAPI ELEKTROKONVULSIF (ECT)</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.3.9/645/2026</td><td>No.Revisi

01</td><td>Halaman :

3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">1. Membersihkan sisa jelly di pelipis dan lendir/air liur di mulut pasien menggunakan suction jika diperlukan setelah kejang berhenti.
2. Memberikan oksigenasi menggunakan simple mask atau nasal cannula (2-4 L/menit) hingga pasien bernapas adekuat dan sadar penuh.
3. Memposisikan pasien secara miring (mantel position / posisi pemulihan) untuk mencegah aspirasi akibat hipersalivasi.
4. Memantau ketat tanda-tanda vital, tingkat kesadaran, dan tanda agitasi pasca-ECT secara berkala (tiap 15 menit) di ruang pemulihan.
5. Mengorientasikan pasien terhadap waktu, tempat, dan orang sekitar secara ramah setelah pasien sadar penuh.
6. Mengembalikan pasien ke ruang perawatan asal apabila kondisi hemodinamik stabil, fungsi kognitif pulih dasar, dan tidak ada tanda komplikasi.
E. Dokumentasi
1. Mencatat seluruh detail tindakan ke dalam berkas rekam medis pasien meliputi: tanggal/jam pelaksanaan, dosis energi listrik, durasi kejang klinis, obat premedikasi yang digunakan, tanda-tanda vital sebelum-selama-sesudah tindakan, serta respon subjektif pasien.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap (Ruang Perawatan Jiwa / Psikiatri)
2. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
3. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS)</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TATALAKSANA PENCEGAHAN RISIKO BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/646/2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 11 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tatalaksana pencegahan risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri adalah rangkaian tindakan klinis, keperawatan, dan modifikasi lingkungan yang dilakukan secara proaktif untuk mengintervensi, melindungi, dan mengawasi pasien yang teridentifikasi memiliki risiko menyakiti diri sendiri (self-harm) atau mengakhiri hidup selama berada di lingkungan rumah sakit.
TUJUAN	1. Memberikan perlindungan, intervensi, dan penanganan segera bagi pasien dengan risiko bunuh diri atau melukai diri sendiri. 2. Meminimalkan atau menghilangkan faktor lingkungan fisik yang dapat memfasilitasi tindakan bunuh diri atau cedera fisik spontan. 3. Mengoordinasikan pelayanan interdisiplin secara integratif (keperawatan, medis, psikiatri, dan satuan pengamanan) demi menjamin keselamatan pasien (*patient safety*).
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi nomor 03 tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Beritahukan tentang prosedur dan tujuan tindakan pengkajian risiko kepada pasien dan keluarga. 5. Jaga privasi pasien 6. Cuci tangan 7. Identifikasi kembali kecocokan identitas fisik pasien dengan gelang identitas. 8. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur tindakan pengkajian secara jelas, ramah, dan empati. 9. Lakukan pendekatan secara empati, tenang, hangat, dan tidak menghakimi demi membangun hubungan

saling percaya (*clear mutual explanation*).

10. Sediakan lingkungan wawancara yang aman, tenang, dan menjamin privasi pasien.
11. Melakukan pembersihan dan sterilisasi kamar rawat pasien dari benda-benda berpotensi bahaya (seperti tali, kabel, sikat gigi listrik, hanger besi, pecahan kaca, pisau cukur, obat pribadi, zat kimia/cairan pembersih, ikat pinggang, dan korek api).
12. Memastikan jendela kamar dalam kondisi terkunci aman (tidak dapat dibuka penuh) dan memastikan pintu toilet tidak memiliki sistem penguncian dari dalam demi mempermudah akses darurat staf.
13. Menempatkan pasien dengan kategori Risiko Tinggi pada tempat tidur (*bed*) yang berada di bawah pengawasan visual langsung atau paling dekat dengan Pos Perawat (*Nurse Station*).
14. Menerapkan protokol pengawasan melekat 24 jam (*continuous 1:1 observation*) bagi pasien risiko tinggi.
15. Memastikan pasien sama sekali tidak ditinggalkan tanpa pendampingan visual konstan dari keluarga atau staf medis, termasuk saat berada di dalam toilet.
16. Melakukan pemantauan dan observasi berkala secara ketat (minimal setiap 1-2 jam) untuk pasien dengan kategori risiko sedang, serta mencatat perkembangan status emosional pada lembar observasi khusus.
17. Menyimpan seluruh persediaan obat pasien di Pos Perawat secara aman, serta memastikan tidak diperkenankan ada obat di samping tempat tidur pasien.
18. Melakukan pemberian obat di bawah pengawasan langsung perawat untuk memastikan seluruh dosis benar-benar ditelan dan mencegah pasien mengumpulkan obat untuk tujuan overdosis (*stockpiling*).
19. Membangun komunikasi terapeutik yang tenang, empati, jujur, dan transparan melalui teknik penjelasan bersama secara jelas (*clear mutual explanation*).
20. Melakukan validasi perasaan atau beban psikologis pasien tanpa memvalidasi atau membenarkan gagasan bunuh dirinya, serta membantu pasien mengidentifikasi faktor koping internal maupun eksternal yang positif.
21. Melaporkan hasil penilaian serta kondisi klinis pasien segera kepada DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) Utama.
22. Mengajukan lembar konsultasi status Cito ke Dokter

	Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater) untuk penatalaksanaan psikofarmaka agresif atau pertimbangan tindakan pembatasan fisik (*restraint*) jika pasien mengalami kondisi gaduh gelisah yang membahayakan jiwa. 23. Mengamankan pasien oleh staf yang mendapati pertama kali apabila terjadi tindakan melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri aktif selama masa perawatan, serta segera meminta bantuan darurat medis untuk tindakan penyelamatan jiwa (*Life Saving*). 24. Melaporkan kejadian tersebut setelah kondisi fisik pasien stabil sebagai Insiden Keselamatan Pasien (IKP) kategori Kejadian Sentinel atau Kejadian Nyaris Cedera (KNC) ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS) dalam waktu maksimal 2x24 jam.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. Instalasi Rawat Inap (Ruang Perawatan Umum, Intensif, dan Jiwa) 3. Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik Jiwa / Spesialis Kedokteran Jiwa) 4. Komite Keperawatan 5. Komite Medis 6. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS) 7. Instalasi Farmasi 8. Satuan Pengamanan / Sekuriti

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN PERILAKU AGRESIF DALAM TERAPI KELOMPOK**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1081 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Langkah-langkah penanganan keperawatan untuk mencegah, membatasi, dan mengendalikan eskalasi perilaku merusak/agresif yang muncul secara tiba-tiba dari pasien saat sesi terapi kelompok berlangsung.
TUJUAN	1. Menjaga keselamatan fisik pasien, anggota kelompok lain, dan perawat. 2. Mencegah eskalasi kekerasan tanpa membubarkan fungsi terapeutik kelompok.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Skrining riwayat atau tanda-tanda awal eskalasi (*restlessness*, pandangan tajam, nafas cepat) dari setiap peserta kelompok. 2. Tegaskan aturan dasar kelompok pada awal sesi (termasuk komitmen tidak melukai dan menghargai sesi). 3. Bicara dengan nada tenang, jelas, dan non-konfrontatif. Jangan memotong atau menyudutkan pasien. 4. Berdiri atau duduk pada jarak aman (1–2 meter). 5. Ucapkan Salam 6. Perkenalkan diri 7. Jika pasien tetap teragitasi/agresif, minta tim co-leader membawa pasien keluar ruangan dengan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MANAJEMEN PERILAKU AGRESIF DALAM TERAPI KELOMPOK**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1081 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/2
	tenang menuju ruang tenang (*de-escalation area*) untuk penanganan individu. 8. Leader mengambil alih kelompok dan memberikan pemahaman ringkas kepada peserta lain agar tetap tenang, lalu melanjutkan terapi. 9. Lakukan *debriefing* bersama tim perawat setelah terapi kelompok selesai. 10. Evaluasi faktor pemicu (*trigger*) agresivitas pasien tersebut. 11. Dokumentasikan insiden, tindakan de-eskalasi, dan kondisi akhir pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN WAHAM**		
	No.Dokumen 400.7.4/1082/2026	No.Revisi 05	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan diagnosis keperawatan waham dengan mengorientasikan pasien pada realitas dan melatih pemenuhan kebutuhan dasar serta kemampuan positif pasien. Asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami Waham (Keyakinan yang salah dan dipertahankan secara kuat, tidak sesuai dengan kenyataan, serta tidak dapat diubah dengan penalaran logis).
TUJUAN	1. Agar pasien waham mampu berorientasi pada realitas. 2. Agar pasien mampu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. 3. Agar pasien waham mampu melakukan kegiatan positif sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Mengajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm. 3. Memperkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shift apa). 4. Menjelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien. 5. Menanyakan nama pasien dan nama yang suka

	dipanggil. 6. Menanyakan perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan pasien. 7. Melakukan kontrak pertemuan (waktu, tempat, dan topik). 8. Mendengarkan ungkapan keyakinan pasien tanpa mendebat dan tanpa membenarkan isi wahamnya. 9. Memberikan validasi emosi dan rasa aman kepada pasien *(misal: "Saya mengerti Bapak/Ibu merasa cemas/khawatir, tetapi di sini Bapak/Ibu aman bersama kami").* 10. Menanyakan kebutuhan dasar pasien yang belum terpenuhi *(misal: haus, lapar, kebersihan diri, atau rasa aman).* 11. Mengajak pasien melakukan kegiatan nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut *(misal: minum air, makan, atau merapikan tempat tidur).* 12. Memberikan pujian atas keberhasilan pasien dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasarnya. 13. Menanyakan perasaan pasien setelah melakukan kegiatan tersebut. 14. Meminta pasien mengulang kembali / mengingat kegiatan yang telah dilakukan hari ini. 15. Menyusun jadwal kegiatan harian bersama pasien. 16. Melakukan kontrak pertemuan kedua yang terdiri dari: kontrak waktu, tempat, dan topik *(melatih kemampuan/hobi positif pasien).*
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**ALUR PENERIMAAN PASIEN OLEH PERAWAT DI UNIT PERAWATAN INTENSIF PSIKIATRI (UPIP)**		
	No.Dokumen 400.7.6/1083/2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Alur penerimaan pasien oleh perawat di ruang UPIP (Unit perawatan intensif psikiatri) adalah urutan langkah langkah yang dilakukan perawat UPIP dalam menerima pasien yang berasal dari IGD dan Poli Psikiatri,ruang perawatan stabilisasi psikiatri keruang UPIP
TUJUAN	Sebagai langkah langkah untuk penerimaan pasien di ruang UPIP
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. DPJP/Dokter jaga menetujui pasien yang masuk ke UPIP mulai instalasi gawat darurat /poli psikiatri. 2. Perawat IGD mulai mentranfer dan serah terima masuk ke ruang UPIP 3. Perawat UPIP memperkenalkan diri,menanyakan nama pasien dan tanggal lahir. 4. Perawat UPIP menerima pasien masuk. 5. Perawat melakukan pengkajian tingkat resiko menc€derai diri sendiri orang lain dan lingkungan. a. Bila pasien masuk dengan kondisi agresif/amuk resiko tinggi : 1) Perawat segera melakukan menejemen krisis 2) Perawat melakukan pemeriksaan keamanan (spotchek) 3) Perawat menempatkan pasien dikamar intensif . 4) Perawat melakukan assessment awal rawat inap

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**ALUR PENERIMAAN PASIEN OLEH PERAWAT DI UNIT PERAWATAN INTENSIF PSIKIATRI (UPIP)**		
	No.Dokumen 400.7.6/1083/2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	kepada keluarga. 5) Perawat melakukan edukasi kepada keluarga 6) Tentang tindakan intensif :mengenal masalah dan fiksasi (mekanik dan kimia) 7) Perawat mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan 8) Perawat melakukan komunikasi efektif kepada DPJP untuk melaporkan kondisi pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PSIKOEDUKASI PASIEN DAN KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1084/2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Psikoedukasi adalah intervensi terapeutik yang terstruktur berupa pemberian informasi, pendidikan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial kepada pasien serta keluarga untuk meningkatkan pemahaman mengenai gangguan jiwa, pengobatan, pencegahan kekambuhan, strategi koping, dan proses pemulihan (recovery). Psikoedukasi merupakan bagian integral dari terapi modalitas dan dilakukan secara individual maupun kelompok sebagai upaya meningkatkan kemampuan pasien dan keluarga dalam mengelola penyakit secara mandiri.
TUJUAN	A. Tujuan Umum Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pasien serta keluarga dalam mengelola gangguan jiwa sehingga meningkatkan kepatuhan terapi, kemampuan adaptasi, dan kualitas hidup. B. Tujuan Khusus Setelah mengikuti psikoedukasi, peserta mampu: 1. Menjelaskan diagnosis dan kondisi yang dialami. 2. Memahami faktor penyebab dan faktor pencetus kekambuhan. 3. Menjelaskan manfaat terapi dan pengobatan. 4. Mengenali efek samping obat serta cara

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PSIKOEDUKASI PASIEN DAN KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.3.9/1089/2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/3

	mengatasinya. 5. Mengenali tanda peringatan dini kekambuhan. 6. Menerapkan strategi koping adaptif. 7. Menyusun jadwal aktivitas harian. 8. Mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa. 9. Mengetahui sumber layanan kesehatan dan dukungan sosial. 10. Berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	A. Tahap Pra Interaksi 1. melakukan pengkajian kebutuhan edukasi 2. menentukan materi 3. menyiapkan media 4. menyusun rencana pembelajaran B. Tahap Orientasi 1. mengucapkan salam 2. memperkenalkan diri 3. menjelaskan tujuan kegiatan 4. menyampaikan kontrak waktu 5. melakukan pre-test sederhana untuk mengetahui pengetahuan awal peserta C. Tahap Kerja 1. menyampaikan materi secara sistematis 2. menggunakan bahasa yang mudah dipahami 3. melibatkan peserta dalam diskusi 4. memberikan demonstrasi bila diperlukan 5. memberikan kesempatan bertanya 6. melakukan klarifikasi terhadap informasi yang

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PSIKOEDUKASI PASIEN DAN KELUARGA</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.3.4/1084/
2026</td><td>No.Revisi

00</td><td>Halaman :

3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">belum dipahami;
7. memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
D. Tahap Evaluasi
1. melakukan tanya jawab
2. meminta peserta mengulang informasi penting
3. melakukan post-test
4. mengevaluasi perubahan pengetahuan dan sikap.
E. Tahap Terminasi
1. menyimpulkan materi
2. memberikan leaflet atau media edukasi
3. menyampaikan pesan utama
4. menyusun rencana tindak lanjut
5. menutup kegiatan dengan salam</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Ruang rawat inap Psikiatri</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI REKREASI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1085 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSEIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Intervensi keperawatan terstruktur berbasis kegiatan rekreatif/hiburan (seperti olahraga ringan, jalan-jalan di taman, menonton film, atau permainan kelompok) untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial.
TUJUAN	1. Memecah kebosanan (*hospitalization fatigue*). 2. Meningkatkan sosialisasi dan interaksi positif antar-pasien. 3. Menurunkan tingkat ketegangan dan ketenangan emosi.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Pastikan status fisik dan psikis pasien aman untuk beraktivitas luar ruangan/kelompok. 2. Ucapkan salam 3. Perkenalkan diri 4. Kumpulkan pasien, jelaskan jenis kegiatan rekreasi dan aturan keselamatan. 5. Pandu pasien melaksanakan aktivitas rekreasi yang disepakati. 6. Dorong pasien untuk saling berinteraksi dan menikmati aktivitas tanpa unsur kompetisi kaku. 7. Pantau keamanan dan kondisi fisik-psikis seluruh peserta secara proaktif. 8. Kumpulkan kembali pasien, minta kesan dan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI REKREASI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1085 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/2
	perasaan mereka 9. Evaluasi adanya peningkatan keterlibatan sosial. 10. Dokumentasikan tindakan serta tingkat keikutsertaan pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI REMINISCENCE**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1086 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi stimulasi kognitif dan emosional dengan cara memfasilitasi pasien mengenang kembali pengalaman masa lalu yang menyenangkan melalui media pemicu (foto, lagu, atau objek kenangan).
TUJUAN	1. Meningkatkan daya ingat dan stimulasi kognitif (terutama lansia/demensia). 2. Meningkatkan rasa berharga (*self-esteem*) dan rasa puas atas perjalanan hidup. 3. Mengurangi gejala depresi dan isolasi sosial.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Pelajari latar belakang riwayat hidup pasien dari keluarga/rekam medis. 2. Salam, perkenalan, dan bina hubungan saling percaya (BHSP) 3. Jelaskan tujuan interaksi dan kontrak waktu (20–30 menit). 4. Ucapkan salam 5. Perkenalkan diri 6. Jelaskan Tujuan Terapi 7. Tunjukkan/perdengarkan media nostalgia (foto/lagu) 8. Berikan pertanyaan terbuka pemicu ingatan (contoh: *"Bisa ceritakan foto ini diambil saat acara apa?"*)

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI REMINISCENCE**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1086 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/2
	9. Minta pasien menceritakan momen menyenangkan atau prestasi masa lalu 10. Berikan penguatan positif pada setiap ingatan yang dibagikan secara antusias 11. Evaluasi suasana hati (*mood*) pasien setelah bernostalgia 12. Simpulkan poin-poin cerita positif dari pasien. 13. Dokumentasikan tingkat partisipasi dan respons emosional pasien		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI RELAKSASI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1089 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Intervensi keperawatan dengan melatih napas dalam dan/atau relaksasi otot progresif (*Progressive Muscle Relaxation*) untuk menstimulasi sistem saraf parasimpatis.
TUJUAN	1. Menurunkan denyut nadi, tekanan darah, dan frekuensi napas. 2. Menurunkan kecemasan, nyeri, dan ketegangan fisik.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Kaji tanda-tanda vital dan tingkat kecemasan pasien. 2. Ucapkan Salam 3. Jelaskan prosedur napas dalam/otot progresif. 4. Posisikan pasien terlentang atau duduk bersandar dengan nyaman. 5. Anjurkan pasien menarik napas pelan lewat hidung (hitungan 1–4), tahan (1–2 detik), lalu hembuskan perlahan lewat mulut (hitungan 1–6). Ulangi 3–5 kali. 6. Pandu pasien menegangkan kelompok otot (tangan, bahu, wajah, perut) selama 5 detik, lalu melepaskannya perlahan sambil merasakan sensasi rileks. 7. Evaluasi tingkat kecemasan/skala nyeri sesudah tindakan. 8. Anjurkan pasien melakukan latihan ini mandiri saat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI RELAKSASI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1087 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/2
	stres timbul. 9. Dokumentasikan tindakan dalam rekam medis.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI SPIRITUAL**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1088 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Intervensi keperawatan jiwa yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan spiritual/kerohanian (seperti doa, zikir, membaca kitab suci, atau refleksi iman) sesuai keyakinan pasien.
TUJUAN	1. Memberikan rasa damai, harapan (*hope*), dan kepasrahan positif. 2. Mengurangi keputusasaan dan kecemasan ekstensial.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Identifikasi agama dan keyakinan spiritual pasien melalui rekam medis/wawancara 2. Bina hubungan percaya dan bersikap hormat terhadap keyakinan pasien 3. Ucapkan salam 4. Perkenalkan diri 5. Diskusikan fokus bimbingan spiritual yang diinginkan. 6. Bimbing pasien melakukan ibadah/doa sederhana sesuai kemampuan fisik dan mentalnya. 7. Putarkan atau bacakan ayat/doa yang membawa ketenangan. 8. Dengarkan ungkapan kepasrahan atau keraguan spiritual pasien tanpa menghakimi (*non-judgmental*). 9. Evaluasi tingkat ketenangan emosional pasien pasca

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI SPIRITUAL**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1088 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/2
	bimbingan spiritual. 10. Dokumentasikan intervensi dan respons spiritual pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI SUPORTIF**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1089 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan non-farmakologis dengan memberikan dorongan, empati, penerimaan, serta penguatan (*reinforcement*) untuk menstabilkan emosi dan memperkuat mekanisme koping adaptif pasien.
TUJUAN	1. Mengurangi kecemasan dan stres emosional. 2. Meningkatkan kepercayaan diri dan mekanisme koping positif. 3. Mencegah komplikasi gangguan psikologis berlanjut
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Evaluasi kondisi emosional pasien dan siapkan catatan medis. 2. Ucapkan salam 3. perkenalkan diri 4. validasi identitas pasien 5. Jelaskan tujuan dan kontrak waktu (15–20 menit). 6. Dengarkan keluhan dan ungkapan perasaan pasien secara aktif (*active listening*). 7. Berikan validasi atas perasaan pasien (contoh: *"Saya paham masalah ini berat untuk Anda"*). 8. Identifikasi kemampuan dan keberhasilan masa lalu yang pernah dicapai pasien. 9. Berikan dorongan positif/pujian (*reinforcement*) atas usaha sekecil apa pun.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI SUPORTIF**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1089 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/2
	10. Bantu pasien merumuskan koping sederhana untuk mengatasi stresor saat ini. 11. Evaluasi respons subjektif (perasaan) dan objektif pasien. 12. Berikan *feedback* positif atas kerja sama pasien. 13. Dokumentasikan tindakan dan repons pasien pada rekam medis.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) DEFISIT PERAWATAN DIRI**		
	No.Dokumen 900.7.6 / 1090 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Defisit Perawatan Diri adalah terapi modalitas keperawatan jiwa yang bertujuan meningkatkan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas perawatan diri secara mandiri melalui pembelajaran, demonstrasi, latihan, pengulangan, dan penguatan dalam suasana kelompok yang suportif. Terapi ini berfokus pada peningkatan kemampuan pasien dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Activity of Daily Living/ADL), meliputi kebersihan diri, berhias, berpakaian, makan dan minum, toileting, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
TUJUAN	A. Tujuan Umum Meningkatkan kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas perawatan diri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar secara optimal dan mempertahankan kesehatan fisik maupun psikososial. B. Tujuan Khusus Setelah mengikuti TAK Defisit Perawatan Diri, pasien mampu: 1. Menjelaskan pentingnya kebersihan diri. 2. Melakukan mandi dengan benar. 3. Menyikat gigi sesuai langkah yang benar. 4. Mencuci rambut secara mandiri. 5. Menyisir rambut dan berhias sesuai kebutuhan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) DEFISIT PERAWATAN DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1090/ 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/4
	6. Memakai pakaian bersih dan rapi. 7. Makan dan minum secara mandiri. 8. Menggunakan toilet dengan benar. 9. Mencuci tangan menggunakan enam langkah. 10. Menjaga kebersihan tempat tidur dan lingkungan sekitar.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.		
PROSEDUR	A. Tahap Pra Interaksi 1. menyeleksi peserta sesuai indikasi 2. mempelajari hasil pengkajian 3. menyiapkan alat dan media 4. memastikan keamanan lingkungan B. Tahap Orientasi 1. Leadermengucapkan salam 2. Leader memperkenalkan diri dan tim 3. Leader menjelaskan tujuan terapi 4. Leader menjelaskan manfaat menjaga kebersihan diri 5. Leader menyepakati aturan kelompok dan kontrak waktu C. Tahap Kerja Sesi 1 – Edukasi Kebersihan Diri 1. Materi meliputi: ➢ pentingnya mandi ➢ menjaga kebersihan kulit ➢ kebersihan rambut ➢ kebersihan kuku ➢ kebersihan mulut		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) DEFISIT PERAWATAN DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1090/ 2026	No.Revisi 00	Halaman : 3/4

- manfaat kebersihan diri terhadap kesehatan dan penerimaan sosial.

2. Diskusi dilakukan secara interaktif untuk menggali kebiasaan peserta.

Sesi 2 – Demonstrasi Mandi dan Kebersihan Mulut

1. Leader mendemonstrasikan:
   - langkah mandi yang benar
   - penggunaan sabun dan sampo
   - cara menyikat gigi
   - membersihkan lidah dan berkumur
2. Peserta mempraktikkan sesuai kemampuan dengan bimbingan fasilitator

Sesi 3 – Berhias dan Berpakaian

1. Peserta berlatih:
   - menyisir rambut
   - bercukur (bila sesuai dan aman)
   - mengenakan pakaian bersih
   - merapikan penampilan
2. Leader memberikan penguatan terhadap hasil latihan.

Sesi 4 – Makan, Minum, dan Cuci Tangan

1. Peserta dilatih:
   - mencuci tangan dengan enam langkah;
   - menggunakan alat makan dengan benar;
   - makan secara mandiri;
   - membersihkan alat makan setelah digunakan.
2. Leader menekankan pentingnya kebersihan sebelum dan sesudah makan.

Sesi 5 – Toileting dan Kebersihan Lingkungan

1. Peserta dilatih:
   - menggunakan toilet dengan benar;

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) DEFISIT PERAWATAN DIRI</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.6 / 1090 / 2026</td><td>No.Revisi

00</td><td>Halaman :

4/4</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">➢ membersihkan diri setelah BAK/BAB
➢ mencuci tangan setelah dari toilet
➢ merapikan tempat tidur
➢ membuang sampah pada tempatnya
➢ menjaga kebersihan lingkungan sekitar
D. Tahap Terminasi
1. Leader merangkum hasil kegiatan
2. Leader mengevaluasi kemampuan peserta
3. Leader memberikan penguatan positif
4. Leader menyusun target latihan mandiri
5. Leader menyampaikan jadwal evaluasi berikutnya
6. Leader menutup kegiatan dengan salam</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Ruang rawat inap Psikiatri</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI OKUPASI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1091 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Pemberian aktivitas atau kegiatan terarah (kerajinan, berkebun, menggambar, memasak) untuk memulihkan/meningkatkan fungsi fisik, mental, dan kognitif pasien.
TUJUAN	1. Meningkatkan keterampilan motorik dan daya konsentrasi. 2. Meningkatkan harga diri dan rasa memiliki pencapaian (*sense of accomplishment*). 3. Mempersiapkan pasien untuk beradaptasi dengan aktivitas hidup sehari-hari.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Kaji kemampuan motorik, tingkat kognitif, dan minat pasien. 2. Ucapkan Salam 3. Jelaskan kegiatan okupasi yang akan dilakukan dan hasilnya 4. Bimbing pasien memulai aktivitas tahap demi tahap sederhana 5. Dampingi pasien tanpa mengintervensi berlebihan untuk melatih kemandirian 6. Berikan pujian terhadap proses dan hasil karya pasien 7. Pastikan semua peralatan keselamatan terjaga

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">TERAPI OKUPASI</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

100.7.6 / 1091 / 2026</td><td>No.Revisi

00</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(terutama benda tajam/berat)
8. Minta pasien menceritakan perasaannya terhadap hasil karyanya
9. Rapikan alat-alat bersama pasien
10. Dokumentasikan partisipasi, rentang konsentrasi, dan respons emosional</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Ruang rawat inap Psikiatri</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SPO)** **TERAPI KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1093 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi Keluarga adalah terapi modalitas keperawatan jiwa yang melibatkan keluarga sebagai mitra utama dalam proses perawatan pasien. Terapi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan keluarga dalam merawat pasien, mendukung proses pemulihan, mencegah kekambuhan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Terapi keluarga memandang keluarga sebagai satu sistem yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, perubahan positif pada keluarga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi pasien.
TUJUAN	A. Tujuan Umum Meningkatkan kemampuan keluarga dalam memberikan dukungan, perawatan, dan pengawasan terhadap pasien secara efektif sehingga tercapai proses pemulihan yang optimal. B. Tujuan Khusus Setelah mengikuti terapi keluarga, keluarga diharapkan mampu: 1. Menjelaskan penyakit yang dialami pasien. 2. Memahami penyebab, tanda, dan gejala kekambuhan. 3. Menjelaskan manfaat dan efek samping obat. 4. Mengawasi kepatuhan minum obat.

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SPO)
TERAPI KELUARGA</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.6 /1093/
2026</td><td>No.Revisi

00</td><td>Halaman :

2/4</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">5. Memberikan dukungan emosional kepada pasien.
6. Berkomunikasi secara terapeutik dengan pasien.
7. Mengelola stres dalam keluarga.
8. Mengenali tanda bahaya yang memerlukan pertolongan tenaga kesehatan.
9. Memanfaatkan sumber daya dan layanan kesehatan di masyarakat.
10. Menyusun rencana perawatan pasien di rumah.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">A. Tahap Pra Interaksi
1. mengidentifikasi kebutuhan keluarga
2. mengkaji pengetahuan keluarga
3. mengidentifikasi masalah yang dihadapi keluarga
4. menyiapkan materi terapi
B. Tahap Orientasi
1. mengucapkan salam
2. memperkenalkan diri
3. memperkenalkan anggota tim
4. menjelaskan tujuan terapi
5. membuat kontrak waktu
6. menjelaskan aturan selama terapi
7. Membangun hubungan saling percaya dengan seluruh anggota keluarga.
C. Tahap Kerja
Sesi 1 – Edukasi Gangguan Jiwa
1. Materi meliputi:
a. pengertian gangguan jiwa
b. penyebab yang bersifat biologis, psikologis, dan</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SPO)** **TERAPI KELUARGA**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1093 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 3/4

social

c. tanda dan gejala
d. perjalanan penyakit;
e. faktor yang memengaruhi kekambuhan

2. Keluarga diberi kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan pengalaman merawat pasien.

Sesi 2 – Kepatuhan Pengobatan

1. Jelaskan nama dan fungsi obat
2. Jelaskan jadwal minum obat
3. Jelaskan efek samping yang umum
4. Jelaskan cara mengatasi efek samping ringan
5. Jelaskan pentingnya tidak menghentikan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan
6. Keluarga diajarkan membuat jadwal pengingat minum obat dan kontrol.

Sesi 3 – Komunikasi Terapeutik

1. Melatih keluarga untuk mendengarkan secara aktif
2. Melatih keluarga untuk berbicara dengan nada tenang
3. Melatih keluarga untuk menghindari kritik dan celaan
4. Melatih keluarga untuk memberikan dukungan positif
5. Melatih keluarga untuk membantu pasien mengekspresikan perasaan.
6. Dilakukan role play antara anggota keluarga dan perawat.

Sesi 4 – Perawatan Pasien di Rumah

1. Materi meliputi:
   - pemenuhan kebutuhan dasar
   - pengawasan aktivitas sehari-hari

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SPO)
TERAPI KELUARGA</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.6 / 1093 / 2026</td><td>No.Revisi

00</td><td>Halaman :

4/4</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">➢ penyusunan jadwal aktivitas;
➢ stimulasi kemandirian;
➢ pengelolaan stres;
➢ pencegahan kekambuhan.
2. Perawat membantu keluarga menyusun rencana perawatan yang realistis.
Sesi 5 – Pencegahan Kekambuhan dan Dukungan Lanjutan
1. Jelaskan tanda peringatan dini kekambuhan;
2. Jelaskan tindakan yang harus dilakukan bila gejala muncul
3. Jelaskan pentingnya kontrol rutin;
4. Jelaskan dukungan keluarga dan masyarakat;
5. Jelaskan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan
6. Keluarga menyusun rencana tindak lanjut setelah pasien pulang.
D. Tahap Terminasi
1. merangkum hasil terapi;
2. mengevaluasi pemahaman keluarga;
3. memberikan kesempatan bertanya;
4. menyusun kontrak tindak lanjut;
5. menutup terapi dengan salam.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Ruang rawat inap Psikiatri</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI MUSIK**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1094 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Intervensi keperawatan menggunakan alunan musik (instrumen, rekreasional, atau lagu favorit) untuk memengaruhi kondisi emosional, fisik, dan mental pasien
TUJUAN	1. Mengurangi ketegangan otot dan kecemasan. 2. Meningkatkan *mood* dan konsentrasi. 3. Memfasilitasi ekspresi emosi secara aman.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Cek indikasi pasien dan kaji minat jenis musik yang disukai. 2. Ucapkan Salam 3. Jelaskan tujuan terapi musik. 4. Atur posisi pasien senyaman mungkin (duduk/berbaring). 5. Putarkan musik pilihan dengan volume yang proporsional dan nyaman. 6. Anjurkan pasien memejamkan mata, fokus pada irama, dan membiarkan tubuhnya rileks. 7. Lakukan pengamatan respons fisiologis (napas, ketegangan otot) dan emosional pasien selama 15–30 menit. 8. Secara perlahan turunkan volume musik hingga selesai. 9. Tanyakan tingkat kecemasan/kenyamanan pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI MUSIK**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1094 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/2
	setelah mendengar musik. 10. Catat jenis musik yang digunakan dan tingkat respons adaptif pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI KOGNITIF PERILAKU (CBT) BERBASIS KEPERAWATAN**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1095 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Intervensi keperawatan untuk membantu pasien mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah pikiran otomatis negatif (*cognitive distortion*) serta pola perilaku maladaptif menjadi pikiran dan perilaku yang adekuat.
TUJUAN	1. Mengubah persepsi negatif pasien terhadap diri, lingkungan, dan masa depan. 2. Membentuk pola koping dan perilaku adaptif baru.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Identifikasi pikiran otomatis negatif yang mendasari keluhan pasien. 2. Ucapkan Salam 3. Perkenalkan diri 4. jelaskan konsep hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. 5. Sepakati target pikiran/perilaku yang ingin diperbaiki 6. Bimbing pasien mengidentifikasi pikiran otomatis negatif saat timbul stresor (misal: *"Saya tidak berguna"*) 7. Bantu pasien menguji bukti (*examination of evidence*) dari pikiran tersebut (misal: *"Apa buktinya Anda tidak berguna? Adakah hal positif yang pernah dilakukan?"*) 8. Bimbing pasien merevisi pikiran otomatis negatif menjadi pikiran alternatif yang rasional dan realistis.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI KOGNITIF PERILAKU (CBT) BERBASIS KEPERAWATAN**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1095 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/2
	9. Berikan tugas rumah (*homework*) seperti mencatat pikiran harian 10. Evaluasi kemampuan pasien mengenali distorsi kognitifnya 11. Berikan penguatan positif dan instruksi tugas mandiri 12. Dokumentasikan progres restrukturisasi kognitif pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI INDIVIDU**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1096 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi Individu merupakan terapi modalitas keperawatan jiwa yang dilakukan melalui hubungan terapeutik antara seorang perawat dengan seorang pasien secara tatap muka, menggunakan komunikasi terapeutik dan intervensi keperawatan yang terencana untuk membantu pasien mengenali masalah, mengembangkan kemampuan koping, meningkatkan fungsi psikososial, serta mencapai tujuan asuhan keperawatan. Terapi individu menjadi dasar dalam pemberian asuhan keperawatan jiwa karena memungkinkan perawat memberikan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi klinis, diagnosis keperawatan, budaya, nilai, dan kemampuan pasien.
TUJUAN	A. Tujuan Umum Membantu pasien mencapai perubahan perilaku yang adaptif melalui hubungan terapeutik yang profesional sehingga mampu mengatasi masalah kesehatan jiwa secara optimal. B. Tujuan Khusus Setelah mengikuti terapi individu, pasien diharapkan mampu: 1. Membangun hubungan saling percaya dengan perawat. 2. Mengungkapkan perasaan, pikiran, dan masalah yang dihadapi. 3. Mengenali penyebab masalah yang dialami. 4. Mengidentifikasi kemampuan dan sumber koping yang dimiliki. 5. Mengembangkan strategi koping yang adaptif. 6. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. 7. Menyusun tujuan pemulihan yang realistis. 8. Menunjukkan peningkatan fungsi psikososial

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI INDIVIDU**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1096 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/3

	sesuai kondisi.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. mengkaji kondisi terkini pasien 2. menetapkan tujuan sesi 3. menentukan teknik komunikasi yang akan digunakan 4. menyiapkan media bila diperlukan 5. memastikan keamanan lingkungan 6. mengucapkan salam 7. memperkenalkan diri 8. memanggil pasien dengan nama yang disukai 9. menjelaskan tujuan dan manfaat terapi 10. membuat kontrak waktu (20–45 menit sesuai kondisi pasien) 11. menyepakati tempat pelaksanaan 12. Lakukan intervensi sesuai tujuan terapi dan diagnosis keperawatan 13. Bantu pasien mengungkapkan: ➢ perasaan ➢ pikiran ➢ pengalaman ➢ keluhan ➢ harapan ➢ hambatan yang dialami 14. mengidentifikasi ➢ faktor pencetus ➢ faktor predisposisi ➢ respons pasien ➢ dampak terhadap kehidupan sehari-hari.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI INDIVIDU**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1096 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 3/3
	15. bantu pasien mengenali kemampuan yang dimiliki 16. bantu pasien memilih cara mengatasi masalah yang sehat 17. bantu pasien melatih keterampilan sesuai diagnosis keperawatan. 18. Berikan pujian atas keberhasilan 19. Berikan motivasi 20. Berikan umpan balik konstruktif 21. Berikan dukungan emosional. 22. merangkum hasil pembicaraan 23. mengevaluasi pemahaman pasien 24. menyepakati latihan mandiri hingga pertemuan berikutnya 25. membuat kontrak sesi selanjutnya 26. menutup terapi dengan salam.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI HUBUNGAN SALING PERCAYA (BHSP)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1098 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi Hubungan Saling Percaya (BHSP) merupakan intervensi keperawatan terapeutik yang bertujuan membangun hubungan profesional antara perawat dan pasien melalui komunikasi terapeutik yang dilandasi rasa saling percaya, saling menghargai, empati, penerimaan tanpa menghakimi, dan konsistensi. BHSP menjadi dasar seluruh intervensi keperawatan jiwa karena keberhasilan terapi sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan terapeutik yang terjalin.
TUJUAN	A. Tujuan Umum Membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien sehingga pasien bersedia bekerja sama dalam proses asuhan keperawatan. B. Tujuan Khusus Pasien mampu: 1. Mengenal perawat yang merawatnya. 2. Merasa aman selama berinteraksi. 3. Mengungkapkan perasaan dan masalah yang dialami. 4. Menunjukkan sikap kooperatif. 5. Bersedia mengikuti program terapi. 6. Berpartisipasi aktif dalam proses keperawatan.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI HUBUNGAN SALING PERCAYA (BHSP)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1098 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/3
	Hadi Kudus.		
PROSEDUR	1. Evaluasi diri (periksa perasaan, ketakutan, atau kecemasan pribadi sebelum bertemu pasien). 2. Pelajari data latar belakang dan riwayat kesehatan pasien dari rekam medis. 3. Siapkan rencana interaksi (topik yang akan dibicarakan, waktu, dan tempat). 4. Cuci tangan sesuai standar SPO kebersihan tangan. 5. Ucapkan salam 6. Memperkenalkan Diri 7. Validasi & Evaluasi Keadaan: Jelaskan tujuan dari pertemuan/tindakan yang akan dilakukan secara ringkas dan jelas. 8. Tetapkan kesepakatan waktu, topik, serta lokasi pelaksanaan kegiatan/interaksi. 9. Yakinkan pasien bahwa informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya untuk kepentingan terapi/perawatan. 10. Tunjukkan sikap empatik, tenang, ramah, dan jujur: 11. Dengarkan keluhan pasien secara aktif tanpa menyela (*active listening*). 12. Validasi atau tanggapi perasaannya (misal: "Saya mengerti Bapak merasa khawatir dengan kondisi ini..."). 13. Berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya atau mengekspresikan perasaannya secara bebas. 14. Hindari sikap menghakimi (*non-judgmental*), menyalahkan, atau memberikan janji yang tidak realistis. 15. Tanyakan perasaan pasien setelah berinteraksi (misal: "Bagaimana rasanya setelah kita berbincang-bincang tadi?"). 16. Rencana Tindak Lanjut (RTL): Berikan dorongan		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI HUBUNGAN SALING PERCAYA (BHSP)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1098 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 3/3
	positif atau tugas mandiri sederhana jika diperlukan. 17. Kontrak Pertemuan Berikutnya: Tentukan topik, waktu, dan tempat untuk pertemuan berikutnya bersama pasien. 18. Ucapkan terima kasih atas kerja sama pasien dan berikan salam. 19. Cuci tangan setelah tindakan selesai.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) SOSIALISASI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1100/ 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Sosialisasi adalah intervensi keperawatan jiwa yang menggunakan dinamika kelompok sebagai media untuk melatih kemampuan pasien berinteraksi dengan orang lain, meningkatkan keterampilan komunikasi, membangun hubungan interpersonal, serta mengurangi perilaku menarik diri atau isolasi sosial. Terapi dilakukan secara bertahap melalui serangkaian sesi yang terstruktur, sehingga pasien memperoleh kesempatan untuk belajar, mempraktikkan, dan mengevaluasi keterampilan sosial dalam lingkungan yang aman dan suportif.
TUJUAN	A. Tujuan Umum Meningkatkan kemampuan pasien dalam berinteraksi sosial secara adaptif sehingga mampu menjalin hubungan interpersonal yang sehat di lingkungan rumah sakit maupun masyarakat. B. Tujuan Khusus Setelah mengikuti TAK Sosialisasi, pasien diharapkan mampu: 1. Mengenal anggota kelompok. 2. Memperkenalkan diri dengan benar. 3. Menjalin kontak mata selama komunikasi. 4. Mengawali percakapan sederhana.

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) SOSIALISASI</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.6 / 1100 / 2026</td><td>No.Revisi

00</td><td>Halaman :

2/4</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">5. Mempertahankan percakapan.
6. Mendengarkan lawan bicara secara aktif.
7. Mengungkapkan pendapat dengan sopan.
8. Bekerja sama dalam kelompok.
9. Menghargai pendapat orang lain.
10. Berinteraksi secara mandiri di lingkungan perawatan.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">A. Tahap Pra Interaksi
1. mengidentifikasi peserta yang memenuhi kriteria
2. mempelajari kondisi masing-masing peserta
3. menyiapkan alat dan ruangan
4. menyusun rencana kegiatan
B. Tahap Orientasi
Leader:
1. mengucapkan salam
2. memperkenalkan diri dan tim
3. mengajak peserta memperkenalkan diri
4. menjelaskan tujuan TAK
5. menjelaskan aturan kelompok (tidak saling mengejek, bergiliran berbicara, menjaga kerahasiaan);
6. menyepakati lama kegiatan.
C. Tahap Kerja
1. Sesi 1 – Perkenalan
Peserta diminta:
➢ menyebutkan nama panggilan
➢ asal atau tempat tinggal (bila sesuai)</td></tr>
</table>

- hobi atau kegiatan yang disukai

Leader memberikan penguatan kepada setiap peserta.

2. Sesi 2 – Memulai Percakapan

Peserta berlatih:

- menyapa teman
- bertanya kabar
- mengajukan pertanyaan sederhana
- menjawab pertanyaan dengan sopan

3. Sesi 3 – Mempertahankan Percakapan

Peserta berlatih:

- mendengarkan lawan bicara
- memberikan tanggapan yang sesuai
- menjaga kontak mata
- berbicara bergantian

4. Sesi 4 – Kerja Sama Kelompok

Peserta mengikuti permainan atau tugas kelompok yang memerlukan:

- komunikasi
- kerja sama
- saling membantu
- pengambilan keputusan bersama

5. Sesi 5 – Interaksi Sosial Mandiri

Peserta diminta mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi sehari-hari di ruang perawatan dan melaporkan pengalamannya pada sesi evaluasi.

D. Tahap Terminasi

Leader:

1. merangkum kegiatan;
2. meminta peserta menyampaikan kesan dan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) SOSIALISASI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1100 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 4/4
	perasaan 3. memberikan umpan balik positif 4. menyepakati latihan mandiri 5. menyampaikan jadwal sesi berikutnya 6. menutup kegiatan dengan salam		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) STIMULASI PERSEPSI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1101 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Stimulasi Persepsi adalah terapi modalitas keperawatan jiwa yang menggunakan berbagai rangsangan sensorik, kognitif, dan aktivitas terstruktur untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam mengenali, menginterpretasikan, dan memberikan respons yang tepat terhadap stimulus dari lingkungan. Terapi ini bertujuan mempertahankan dan meningkatkan fungsi kognitif, konsentrasi, perhatian, daya ingat, kemampuan berpikir logis, serta ketepatan persepsi melalui aktivitas yang dilakukan secara berkelompok.
TUJUAN	A. Tujuan Umum Meningkatkan kemampuan pasien dalam menerima, mengolah, dan merespons stimulus lingkungan secara tepat sehingga mendukung fungsi psikososial dan kemandirian. B. Tujuan Khusus Setelah mengikuti terapi, pasien diharapkan mampu: 1. Memusatkan perhatian selama kegiatan. 2. Mengenali benda, warna, bentuk, suara, atau gambar dengan benar. 3. Mengingat informasi sederhana. 4. Mengikuti instruksi secara berurutan. 5. Mengungkapkan hasil pengamatan secara verbal. 6. Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. 7. Meningkatkan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah sederhana. 8. Bekerja sama dengan anggota kelompok.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) STIMULASI PERSEPSI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1101 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/3
	Hadi Kudus.		
PROSEDUR	A. Tahap Pra Interaksi 1. mengidentifikasi peserta yang sesuai kriteria; 2. menyiapkan alat dan media 3. mengatur ruangan 4. memastikan keamanan lingkungan B. Tahap Orientasi Leader: 1. mengucapkan salam 2. memperkenalkan tim 3. mengajak peserta memperkenalkan diri 4. menjelaskan tujuan terapi 5. menjelaskan aturan kelompok 6. membuat kontrak waktu C. Tahap Kerja 1. Sesi 1 – Stimulasi Visual ➢ mengenali gambar ➢ membedakan warna ➢ mencocokkan bentuk ➢ menyebutkan nama benda 2. Sesi 2 – Stimulasi Auditori ➢ mendengarkan suara ➢ mengenali sumber suara ➢ mengikuti instruksi lisan ➢ mengulang kata atau kalimat sederhana. 3. Sesi 3 – Stimulasi Memori ➢ mengingat daftar benda ➢ permainan menghafal gambar ➢ mengingat nama anggota kelompok ➢ menyebutkan kembali informasi yang diberikan. 4. Sesi 4 – Stimulasi Berpikir Logis ➢ mengurutkan gambar ➢ menyelesaikan puzzle ➢ mengelompokkan benda ➢ menjawab pertanyaan sederhana ➢ memecahkan masalah sederhana 5. Sesi 5 – Integrasi Persepsi ➢ permainan kelompok ➢ diskusi sederhana ➢ simulasi aktivitas sehari-hari		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) STIMULASI PERSEPSI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1101 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 3/3
	➢ evaluasi kemampuan mengenali stimulus lingkungan. D. Tahap Terminasi 1. Leader menyimpulkan hasil kegiatan 2. Leader memberikan kesempatan peserta menyampaikan pengalaman 3. Leader memberikan penguatan positif 4. Leader menjelaskan latihan yang dapat dilakukan secara mandiri 5. Leader menutup kegiatan dengan salam.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) ORIENTASI REALITA**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1102 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Orientasi Realita adalah terapi modalitas keperawatan jiwa yang bertujuan membantu pasien meningkatkan kemampuan mengenali dan mempertahankan orientasi terhadap waktu, tempat, orang, dan situasi melalui aktivitas kelompok yang terstruktur. Terapi ini diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan orientasi akibat gangguan jiwa kronis, gangguan neurokognitif ringan, disorientasi ringan, atau penurunan fungsi kognitif yang masih memungkinkan mengikuti kegiatan kelompok.
TUJUAN	A. Tujuan Umum Meningkatkan kemampuan pasien mengenali realitas lingkungan sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan perawatan maupun kehidupan sehari-hari. B. Tujuan Khusus Setelah mengikuti TAK Orientasi Realita, pasien mampu: 1. Menyebutkan nama lengkapnya. 2. Mengenali identitas diri (umur, alamat, pekerjaan bila memungkinkan). 3. Menyebutkan nama rumah sakit dan ruang perawatan. 4. Menyebutkan tanggal, hari, bulan, dan tahun.

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) ORIENTASI REALITA</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.6 / 1102 / 2026</td><td>No.Revisi

00</td><td>Halaman :

2/4</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">5. Mengenali pagi, siang, sore, dan malam.
6. Mengenali perawat dan anggota kelompok.
7. Menjelaskan aktivitas yang sedang dilakukan.
8. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">A. Tahap Pra Interaksi
1. mengidentifikasi peserta
2. mempelajari hasil pengkajian
3. menyiapkan alat
4. menyiapkan ruangan
5. memastikan keamanan lingkungan.
B. Tahap Orientasi
Leader:
1. mengucapkan salam
2. memperkenalkan diri dan tim
3. mengajak peserta memperkenalkan diri
4. menjelaskan tujuan terapi
5. menjelaskan aturan kelompok
6. membuat kontrak waktu
7. Leader kemudian melakukan orientasi awal dengan menanyakan:
• nama peserta
• hari
• tanggal
• tempat kegiatan
C. Tahap Kerja
1. Sesi 1 – Orientasi Orang
• menyebutkan nama sendiri;</td></tr>
</table>

- mengenal nama anggota kelompok
- mengenal nama perawat.

2. Sesi 2 – Orientasi Tempat
   - menyebutkan nama rumah sakit
   - menyebutkan nama ruang perawatan
   - mengenali lokasi penting (toilet, ruang makan, ruang terapi).
3. Sesi 3 – Orientasi Waktu
   - menyebutkan hari
   - menyebutkan tanggal
   - menyebutkan bulan dan tahun
   - mengenali pagi, siang, sore, dan malam
   - mencocokkan aktivitas dengan waktu.
4. Sesi 4 – Orientasi Situasi
   - menyebutkan kegiatan yang sedang dilakukan;
   - menjelaskan alasan dirawat;
   - mengenali jadwal aktivitas harian di ruang perawatan.
5. Sesi 5 – Integrasi Orientasi Realita
   - permainan tanya jawab
   - simulasi aktivitas harian
   - diskusi kelompok
   - latihan menyebutkan identitas, waktu, tempat, dan situasi secara lengkap

D. Tahap Terminasi

Leader:

1. merangkum hasil terapi
2. memberikan kesempatan peserta menyampaikan pengalaman
3. memberikan penguatan positif

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) ORIENTASI REALITA**		
	No.Dokumen 900.7.6 / 1102 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 4/4
	4. menyepakati latihan orientasi mandiri 5. menutup kegiatan dengan salam		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) HARGA DIRI RENDAH (HDR)**		
	No.Dokumen 100.7.6 / 1103 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Harga Diri Rendah adalah terapi modalitas keperawatan jiwa yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu pasien mengenali potensi diri, meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri, mengembangkan kemampuan yang dimiliki, serta membangun perilaku yang lebih percaya diri dan adaptif. Terapi dilakukan secara bertahap melalui aktivitas yang mendorong pasien mengenali aspek positif diri, menerima kekurangan secara realistis, dan berlatih menggunakan kemampuan yang masih dimiliki dalam kehidupan sehari-hari.
TUJUAN	A. Tujuan Umum Meningkatkan harga diri pasien sehingga mampu menerima diri secara positif, mengembangkan kemampuan yang dimiliki, serta meningkatkan fungsi sosial dan kemandirian. B. Tujuan Khusus Setelah mengikuti TAK Harga Diri Rendah, pasien diharapkan mampu: 1. Mengenali kelebihan yang dimiliki. 2. Mengenali kemampuan yang masih dapat dilakukan. 3. Mengidentifikasi pengalaman keberhasilan yang pernah dicapai.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) HARGA DIRI RENDAH (HDR)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1103 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 2/5

	4. Menyampaikan pendapat secara percaya diri. 5. Menghargai diri sendiri dan orang lain. 6. Memilih aktivitas sesuai kemampuan. 7. Menyusun rencana pengembangan diri. 8. Menunjukkan peningkatan rasa percaya diri dalam berinteraksi.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	A. Tahap Pra Interaksi 1. menyeleksi peserta 2. mempelajari hasil pengkajian 3. menyiapkan ruangan 4. menyiapkan media 5. memastikan keamanan lingkungan B. Tahap Orientasi 1. Leader mengucapkan salam 2. Leader memperkenalkan diri dan tim 3. Leader mengajak peserta memperkenalkan diri 4. Leader menjelaskan tujuan terapi 5. Leader menjelaskan aturan kelompok 6. Leader membuat kontrak waktu 7. Leader membangun suasana yang hangat dan saling menghargai agar peserta merasa aman untuk menyampaikan pengalaman. C. Tahap Kerja Sesi 1 – Mengenal Diri Sendiri 1. Peserta diminta: a. menyebutkan nama b. menceritakan hal yang disukai

c. menyebutkan tiga kelebihan diri
d. menceritakan pengalaman yang membanggakan

2. Leader membantu peserta yang masih kesulitan menemukan kelebihan dirinya

Sesi 2 – Mengenali Kemampuan yang Dimiliki

1. Peserta diajak mengidentifikasi kemampuan yang masih dapat dilakukan, misalnya:
   a. merawat diri
   b. membantu pekerjaan ringan
   c. beribadah
   d. membaca
   e. menulis
   f. memasak
   g. berkebun
   h. menjahit
   i. menggambar
   j. menyanyi
2. Leader memberikan penguatan terhadap setiap kemampuan yang diungkapkan.

Sesi 3 – Mengembangkan Kemampuan

1. Peserta memilih satu kemampuan yang ingin dikembangkan.
2. Dilakukan simulasi atau praktik sederhana sesuai kemampuan, misalnya:
   a. melipat pakaian
   b. menyusun meja makan
   c. menggambar
   d. membaca nyaring
   e. merangkai bunga
   f. membuat kerajinan sederhana

Sesi 4 – Berpikir Positif

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) HARGA DIRI RENDAH (HDR)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1103 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 4/5

1. Leader mengajak peserta mendiskusikan:
   a. pikiran negatif yang sering muncul
   b. cara mengubah pikiran negatif menjadi lebih realistis dan positif;
   c. kalimat afirmasi positif.

   Contoh afirmasi:

   "Saya memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan."

   "Saya berharga dan layak dihargai."

   "Saya mampu belajar hal baru."
2. Peserta diminta mengucapkan afirmasi secara bergantian.

Sesi 5 – Menyusun Rencana Pengembangan Diri

1. Peserta menyusun target sederhana yang dapat dilakukan setiap hari, misalnya:
   a. mandi secara mandiri
   b. mengikuti terapi sesuai jadwal
   c. berbicara dengan teman
   d. membantu merapikan tempat tidur
   e. mengikuti kegiatan rehabilitasi
2. Leader membantu peserta menetapkan target yang realistis dan dapat dievaluasi.

D. Tahap Terminasi

1. Leader merangkum hasil kegiatan
2. Leader meminta peserta menyampaikan kesan dan manfaat terapi
3. Leader memberikan penghargaan atas partisipasi peserta
4. Leader menyepakati latihan mandiri
5. Leader menyampaikan jadwal terapi berikutnya
6. Leader menutup kegiatan dengan salam

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) HARGA DIRI RENDAH (HDR)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1103 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 5/5
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) HALUSINASI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1109 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Halusinasi adalah terapi modalitas keperawatan jiwa yang menggunakan dinamika kelompok untuk membantu pasien mengenali, memahami, dan mengendalikan halusinasi melalui latihan keterampilan (*coping skill*) yang dilakukan secara bertahap dan berulang. Terapi ini merupakan intervensi keperawatan berbasis bukti yang bertujuan meningkatkan kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasi sehingga dampaknya terhadap fungsi sehari-hari dapat berkurang. Terapi dilaksanakan dalam suasana kelompok yang aman, suportif, dan terapeutik.
TUJUAN	A. Tujuan Umum Meningkatkan kemampuan pasien dalam mengenali dan mengontrol halusinasi sehingga mampu mempertahankan orientasi realita serta meningkatkan fungsi psikososial. B. Tujuan Khusus Setelah mengikuti terapi, pasien mampu: 1. Menjelaskan pengertian halusinasi. 2. Mengidentifikasi jenis halusinasi yang dialami. 3. Mengidentifikasi waktu munculnya halusinasi. 4. Mengidentifikasi situasi pencetus halusinasi. 5. Mengidentifikasi respons yang muncul saat

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) HALUSINASI</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.6 / 1104/ 2026</td><td>No.Revisi

00</td><td>Halaman :

2/4</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">halusinasi terjadi.
6. Mempraktikkan teknik menghardik halusinasi.
7. Mematuhi pengobatan sesuai anjuran.
8. Mengalihkan perhatian dengan bercakap-cakap bersama orang lain.
9. Mengurangi halusinasi melalui aktivitas terjadwal.
10. Menggunakan strategi pengendalian halusinasi secara mandiri.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">A. Tahap Pra Interaksi
1. mempelajari hasil pengkajian pasien;
2. memilih peserta sesuai kriteria;
3. menyiapkan alat dan ruangan;
4. menyusun rencana kegiatan.
B. Tahap Orientasi
1. Leader mengucapkan salam;
2. Leader memperkenalkan diri dan anggota tim;
3. Leader mengajak peserta memperkenalkan diri;
4. Leader menjelaskan tujuan terapi;
5. Leader menjelaskan aturan kelompok;
6. Leader membuat kontrak waktu.
7. Leader menciptakan suasana yang aman sehingga peserta merasa nyaman untuk berbagi pengalaman.
C. Tahap Kerja
1. Sesi 1 – Mengenal Halusinasi
Peserta diajak:
➢ menjelaskan pengalaman halusinasi;</td></tr>
</table>

- menyebutkan jenis halusinasi;
- mengenali isi halusinasi;
- mengidentifikasi waktu munculnya halusinasi;
- mengenali situasi yang memicu halusinasi.

Leader memberikan edukasi mengenai halusinasi dan menegaskan bahwa pengalaman tersebut merupakan gejala penyakit yang dapat dikendalikan dengan terapi.

2. Sesi 2 – Latihan Menghardik Halusinasi

   Leader mendemonstrasikan cara menghardik halusinasi dengan tegas, misalnya:

   "Tidak! Saya tidak mau mendengarkan. Pergi!"

   Peserta kemudian mempraktikkan teknik tersebut secara bergantian.

   Leader memberikan umpan balik dan penguatan terhadap teknik yang dilakukan peserta.

3. Sesi 3 – Kepatuhan Minum Obat
   - manfaat obat antipsikotik
   - pentingnya minum obat secara teratur
   - dampak jika obat dihentikan tanpa anjuran tenaga kesehatan
   - cara mengingat jadwal minum obat

   Peserta berdiskusi mengenai pengalaman dalam menjalani terapi obat dan hambatan yang dihadapi.

4. Sesi 4 – Mengalihkan Halusinasi

   Peserta dilatih untuk:
   - mengajak orang lain berbicara ketika halusinasi muncul
   - bergabung dalam aktivitas kelompok
   - melakukan aktivitas yang disukai

- meminta bantuan perawat atau keluarga apabila

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) HALUSINASI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1104 / 2026	No.Revisi 00	Halaman : 4/4
	halusinasi sulit dikendalikan Dilakukan simulasi percakapan sederhana antara peserta. 5. Sesi 5 – Menyusun Jadwal Aktivitas Harian Peserta dibimbing untuk menyusun jadwal kegiatan yang mencakup: ➢ bangun tidur ➢ mandi dan kebersihan diri ➢ makan ➢ ibadah ➢ terapi ➢ olahraga ringan ➢ rekreasi ➢ istirahat Leader menjelaskan bahwa aktivitas yang teratur dapat membantu mengurangi munculnya halusinasi. D. Tahap Terminasi Leader: 1. merangkum materi yang telah dipelajari; 2. mengevaluasi kemampuan peserta; 3. memberikan penguatan positif; 4. menyepakati latihan mandiri di ruang perawatan atau di rumah; 5. menyampaikan jadwal terapi berikutnya; 6. menutup kegiatan dengan salam.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *KNOW EACH OTHER* (SALING KENAL SATU SAMA LAIN)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1179 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Suatu tindakan untuk membina hubungan terapeutik antara staff dengan pasien dalam menyediakan informasi yang lebih sehingga pasien mengenal lebih dekat.
TUJUAN	1. Membantu mengawali percakapan antara staff dengan pasien 2. Memberikan rasa nyaman dan aman pasien selama berada diruangan / selama perawatan 3. Membantu pasien memilih staff dalam berbagi rasa dan berbicara tentang minat 4. Mencegah meningkatnya konflik yang disebabkan karena staf 5. Meningkatkan harga diri pasien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	PEMANFAATAN POSTER KNOW EACH OTHERS 1. Identifikasi kebutuhan Know Each Others: awal perawatan 2. Identifikasi kebutuhan Know Each Others: Jenuh, kesepian 3. Ajak pasien ke Poster Know Each Others Staf 4. Ucapkan salam pembuka 5. Perkenalkan nama dan profesi 6. Jelaskan tujuan pertemuan 7. Tanyakan perasaan saat ini 8. Buat kontrak pertemuan (topik dan lama pertemuan) 9. Tanyakan apakah sudah mengenal nama dan hobi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *KNOW EACH OTHER*** **(SALING KENAL SATU SAMA LAIN)**		
	No.Dokumen 100.7.6/1179/2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/3

staf diruangan

10. Tanyakan pasien apakah bisa membaca
11. Jika bisa, minta pasien membaca 1-2 profil staf
12. Jelaskan maksud dari membaca profil staf
13. Jika bisa, minta pasien membaca kalimat kutipan, kalimat mutiara
14. Jelaskan maksud dan tujuan membaca kalimat kutipan
15. Tanyakan apakah pasien sudah memahaminya
16. Tanyakan perasaan setelah mengetahui profil staf dan baca kata mutiara
17. Minta pasien baca profil staf yang lain saat ada waktu luang
18. Ucapkan salam penutup

PEMBUATAN PROFIL PASIEN

1. Kumpulkan 3-8 pasien yang sudah stabil emosinya dan cukup kooperatif
2. Ucapkan salam pembuka
3. Perkenalkan nama dan profesi
4. Jelaskan tujuan pertemuan
5. Lakukan kontrak pertemuan (topik dan lama pertemuan)
6. Persilahkan pasien minum atau BAK
7. Berikan setiap pasien selembar kertas kosong dan Bollpoint
8. Minta pasien menulis profil (Nama lengkap dan nama panggilan)
9. Minta pasien menulis sesuatu yang disukai dan tidak disukai
10. Minta pasien menulis hobi
11. Minta pasien menulis musik favorit, film favorit, makanan favorit, dll
12. Jika tidak bisa menulis tuliskan
13. Minta pasien satu persatu membaca profilnya masing-masing
14. Minta pasien lain menanggapi/bertanya terkait profil pasien tsb
15. Tanyakan perasaan setelah mengetahui profil pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *KNOW EACH OTHER*** **(SALING KENAL SATU SAMA LAIN)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1179 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 3/3
	lain 16. Sampaikan perawat akan menyimpan profil pasien 17. Profil pasien akan dikembalikan ketika pulang, jika menghendaki 18. Ucapkan salam pembukaan 19. Persilahkan pasien istirahat		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *MUTUAL HELP MEETING*** **(PERTEMUAN YANG BERMUTU DAN MEMBANTU)**		
	No.Dokumen 900.7.6 / 1180 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	*Mutual Help Meeting* adalah kegiatan yang dilakukan setidaknya dua kali seminggu di ruang perawatan dengan memberi dukungan melalui saling mengakui, meminta, menawarkan dan membantu satu sama lain dalam mengurangi tingkat konflik.
TUJUAN	1. Melatih reaksi emosional terhadap perilaku pengguna layanan 2. Memvalidasi kebutuhan dukungan pengguna layanan 3. Melatih rasa saling menghargai antara pengguna layanan 4. Meningkatkan harga diri pengguna layanan 5. Meningkatkan rasa hormat dan rasa menjadi bagian di ruang perawatan 6. Membantu pengguna layanan membentuk perilaku baru 7. Membantu pengguna layanan mempercepat keluar dari rumah sakit
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	PERSIAPAN KELOMPOK 1. Kenali tanda -tanda agitasi (jika tidak agitasi), lanjut berikutnya 2. Ucapkan salam 3. Perkenalkan nama dan profesi 4. Jelaskan tentang rencana pertemuan kelompok 5. Jelaskan tentang jumlah pertemuan selama sepekan 6. Jelaskan tentang topik yang dibicarakan dalam

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *MUTUAL HELP MEETING*** **(PERTEMUAN YANG BERMUTU DAN MEMBANTU)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1180 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/3
	pertemuan 7. Jika bisa, minta pasien membaca kalimat kutipan, kalimat mutiara 8. Jelaskan maksud dan tujuan membaca kalimat kutipan 9. Bantu pasien mengidentifikasi topik yang akan didiskusikan bersama 10. Bantu pasien mengidentifikasi lama pertemuan diskusi bersama 11. Bantu pasien menulis hasil kesepakatan pada kertas/ papan tulis 12. Berikan reinforcement positif 13. Ucapkan salam penutup, sampai jumpa PELAKSANAAN DISKUSI KELOMPOK 14. Mengingatkan kontrak pertemuan bersama 15. Lakukan prosedur Mutual help Meeting sesuai dengan prosedur TAK 16. Biarkan pasien berdiskusi dengan cara dan gayanya, perawat memandu 17. Pastikan semua pasien aktif berdiskusi/ dapat kesempatan 18. Berikan reinforcement positif 19. Tanyakan perasaan setelah berdiskusi bersama 20. Ingatkan untuk topik pertemuan berikutnya PERSIAPAN MUTUAL HELP MEETING INDIVIDU 21. Ucapkan salam 22. Perkenalkan nama dan profesi 23. Jelaskan ada waktu konsultasi dengan topik bebas dengan perawat 24. Jelaskan lama waktu konsultasi dengan topik bebas 25. Minta pasien memilih topik bebas yang ingin didiskusikan dg perawat 26. Minta pasien memilih perawat yang akan diajak		

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">IMPLEMENTASI MUTUAL HELP MEETING
(PERTEMUAN YANG BERMUTU DAN MEMBANTU)</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.6 / 1180 / 2026</td><td>No.Revisi

01</td><td>Halaman :

3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">diskusi
27. Minta pasien menetapkan berapa lama akan diskusi
28. Minta pasien menulis atau bantu menulis rencana konsultasi
29. Ingatkan pasien terkait rencana konsultasi yang telah dibuat
30. Ingatkan perawat yang dikontrak melalui hand over/ operan shift
31. Lakukan Mutual help Meeting Individu sesuai dengan prosedur interaksi
32. Jika sudah terlaksana perawat memberikan paraf dan nama terang</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Ruang rawat inap Psikiatri
2. Ruang rawat Jalan Psikiatri</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONTROL MARAH PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA VERBAL**		
	No.Dokumen 900.7.6 / 1492 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan diagnose keperawatan resiko perilaku kekerasan yang belum mampu kontrol marah secara asertif. Tindakan keperawatan ini terdiri dari cara kontrol dengan fisik, sosial, spiritual dan obat.
TUJUAN	1. Agar pasien gangguan jiwa mampu kontrol emosi dengan positif saat muncul rasa marah dengan bicara secara asertif 2. Agar pasien gangguan jiwa dapat terlatih cara kontrol marah secara verbal yang asertif saat tiba tiba ada rangsang yang membuat pasien jengkel / marah. 3. Agar pasien gangguan jiwa mampu menerapkan cara kontrol marah secara verbal yang asertif apabila nanti sudah kembali ke rumah
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi nomor 03 tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm 3. Perkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shif apa) 4. Jelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien 5. Tanyakan pada pasien nama, nama yang suka dipanggil 6. Tanyakan pada pasien perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan 7. Lakukan kontrak pertemuan yang terdiri dari waktu, tempat, dan topik. 8. Tanyakan apakah Latihan cara control marah secara fisik sudah dilakukan secara mandiri 9. Berikan pujian saat pasien sudah mampu melakukannya 10. Berikan contoh cara kontrol marah dengan fisik yaitu: a. Perawat duduk di kursi dengan sikap santai. b. Perawat memberikan contoh kalimat cara kontrol marah secara verbal "maaf saya tidak bisa ikut

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONTROL MARAH PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA VERBAL**		
	No.Dokumen 400.7.6/1492/2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	kegiatan itu sebab saya bantu ibu saya di rumah". c. Perawat memberikan contoh cara yang lain "ibu...saya ijin pinjam gelasnya buat saya pakai minum ya.. terima kasih bu". d. Perawat meminta pasien untuk melakukan hal serupa yang sudah diberi contoh e. Perawat mendampingi pasien dan memberikan pujian saat pasien mampu melakukan kontrol marah dengan verbal f. Perawat menjelaskan pada pasien cara kontrol marah ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun dan bisa berapa kalipun dalam sehari 11. Tanyakan pada pasien perasaan setelah mencoba Latihan control marah dengan verbal; menolak dan meminta yang baik 12. Minta pasien untuk mengulang kembali cara kontrol marah dengan verbal: menolak dan meminta yang baik 13. Berikan pujian atas keberhasilan pasien control marah verbal: meminta dan menolak yang baik 14. Lakukan kontrak pertemuan kedua dengan pasien yang terdiri dari: kontrak waktu, tempat dan topik (cara control marah spiritual)		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**CODE WHITE**		
	No.Dokumen 400.7.3.9/1530/2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Code White Psikiatri adalah prosedur tindakan darurat yang diaktifkan ketika pasien jiwa keluar atau pulang meninggalkan RSUD dr. Loekmono Hadi tanpa izin/sepengetahuan petugas dan belum diizinkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
TUJUAN	Mengupayakan pasien kembali untuk menjalani pengobatan dan perawatan di RSUD dr. Loekmono Hadi ruang perawatan jiwa (Cempaka 1).
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Petugas Rumah Sakit /Perawat ruangan yang pertama kali mengetahui pasien hilang/melarikan diri segera meminta bantuan dengan **menelepon nomor 1111**. 2. Petugas melakukan hal-hal berikut saat melapor: a. Memperkenalkan diri. b. Menyampaikan maksud untuk **mengaktifkan *CODE WHITE***. c. Menyebutkan nama ruangan secara jelas (contoh: Ruang Cempaka 1). 3. Petugas operator/security yang menerima laporan segera menyiarkan panggilan darurat melalui *Paging System*: **"CODE WHITE ... CODE WHITE ... CODE WHITE"** 4. **Respon Cepat Security:** Petugas security yang bertugas segera **menutup seluruh pintu akses masuk**

dan keluar rumah sakit (*lockdown*).

5. **Pencarian:** Tim Security bersama staf perawat menyisir area dalam dan luar rumah sakit.
6. **Penanganan Saat Ditemukan:**
   a. Lakukan teknik pendekatan dan komunikasi secara tenang.
   b. Gunakan **Teknik Cara Memegang Pasien** yang aman (*Restraint*) sesuai standar pelatihan:
      - **Pendekatan 2-3 Petugas:** Mengunci area lengan dan pergelangan tangan pasien dari samping tanpa mencederai.
      - **Pendekatan Tim Utuh (5 Petugas):** Masing-masing mengamankan kepala/leher, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri jika pasien mengalami agitasi/amuk berat.
7. **Pelaporan Internal:** Penanggung jawab shift melaporkan kejadian secara berjenjang kepada atasan langsung dengan sepengetahuan PPJP secara tertulis menggunakan formulir yang tersedia.
8. **Koordinasi:** Lakukan koordinasi langsung dengan supervisi dan unit security.
9. **Kondisi Pasien Ditemukan:** Perawat berkolaborasi dengan Dokter Jaga untuk penanganan dan evaluasi medis selanjutnya
10. **Kondisi Pasien Tidak Ditemukan:**
    a. Hubungi pihak keluarga/penanggung jawab pasien.
    b. Security melaporkan kejadian ke **POLSEK setempat**, lalu bukti pelaporan diserahkan ke Pusat Informasi & Pengaduan (PIP), Bidang Keperawatan, dan Pelayanan.
    c. Jika **lebih dari 2 X 24 jam** pasien belum ditemukan, PIP membuat pemberitahuan melalui media elektronik.
    d. Rekam Medis (RM) pasien dikembalikan ke Instalasi Rekam Medis.
    e. Dilakukan pembinaan internal kepada petugas terkait.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**CODE WHITE**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1530/2026	No.Revisi 00	Halaman : 3/3
	11. Evaluasi Secara berkala mengevaluasi dan memperbaiki prosedur sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman kejadian di lapangan. 12. Manajemen: Memastikan tersedianya sumber daya yang memadai dan memantau implementasi *CODE WHITE.* 13. Staf Medis: Melaksanakan prosedur penanganan sesuai dengan protokol dan memastikan keselamatan pasien. 14. Staf Pendukung (Security & Umum): Memberikan dukungan logistik, pengamanan pintu akses, dan komunikasi sehingga respons darurat berjalan efektif.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap Psikiatri 2. Instalasi Gawat darurat 3. Satuan pengamanan (SATPAM) 4. Instalasi Informasi 5. Instalasi Rekam Medis 6. Pusat Informasi & Pengaduan (PIP)		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DEFISIT PERAWATAN DIRI: BERDANDAN**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1201 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan diagnose keperawatan deficit perawatan diri: berdandan dengan mengikutsertakan peran serta pasien, keluarga memahami manfaat berdandan, cara berdandan agar pasien tampak sehat dan bugar. (cantik dan ganteng)
TUJUAN	1. Agar pasien memahami manfaat berdandan bagi diri sendiri dan akibat bila tidak mandi teratur. 2. Agar pasien dapat mengungkapkan perasaannya setelah berdandan. 3. Agar pasien dapat menggunakan alat untuk berdandan sesuai kebutuhan. 4. Agar pasien dapat meningkatkan harga diri saat kondisi tubuh pasien sehat dan bugar
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi nomor 03 tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm 3. Perkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shif apa) 4. Jelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien 5. Tanyakan pada pasien nama, nama yang suka dipanggil 6. Tanyakan pada pasien perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan 7. Lakukan kontrak pertemuan yang terdiri dari waktu, tempat, dan topik. 8. Bantu pasien pasien dalam persiapan berdandan (perempuan: bedak, sisir, tali rambut, lipstick. Laki laki: sisir, minyak rambut, alat potong rambut). 9. Temani pasien selama pasien berdandan dengan memberikan instruksi langkah langkah saat pasien berdandan 10. diskusikan dengan pasien setelah pasien selesai berdandan: manfaat, akibat dan langkah-langkah berdandan 11. Lakukan edukasi pada pasien untuk melakukan berdandan secara mandiri dan sesuai waktu kapan berdandan 12. Dampingi pasien dan memberikan pujian saat pasien mampu melakukan berdandan baik mandiri atau didampingi 13. Jelaskan pada pasien bahwa kemampuan tersebut bisa

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DEFISIT PERAWATAN DIRI: BERDANDAN**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1201 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	dilakukan dengan bimbingan dari perawat, orang tua, keluarga yang lain. 14. Tanyakan pada pasien perasaan setelah pasien berdandan. 15. Minta pasien untuk mengulang kembali langkah langkah berdandan yang baik 16. Berikan pujian atas keberhasilan pasien hari ini. 17. Lakukan kontrak pertemuan kedua dengan pasien yang terdiri dari: kontrak waktu, tempat dan topik		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DEFISIT PERAWATAN DIRI: MANDI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1200 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan diagnose keperawatan deficit perawatan diri: mandi dengan mengikutsertakan peran serta pasien, keluarga memahami manfaat mandi, cara mandi agar pasien mendapatkan badan yang sehat dan bugar.
TUJUAN	1. Agar pasien memahami manfaat mandi bagi diri sendiri dan akibat bila tidak mandi teratur 2. Agar pasien dapat mengungkapkan perasaannya setelah mandi 3. Agar pasien dapat menggunakan alat mandi sesuai kebutuhan 4. Agar pasien dapat meningkatkan harga diri saat kondisi tubuh pasien sehat dan bugar
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Mengucapkan salam 2. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm 3. Perawat memperkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shif apa) 4. Jelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien 5. Tanyakan pada pasien nama, nama yang suka dipanggil 6. Tanyakan pada pasien perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan 7. Lakukan kontrak pertemuan yang terdiri dari waktu, tempat, dan topik. 8. Bantu pasien pasien dalam persiapan mandi: alat mandi, pakaian ganti. 9. Temani pasien selama pasien mandi dengan memberikan instruksi langkah langkah saat pasien mandi. 10. Diskusikan dengan pasien setelah pasien selesai mandi: manfaat mandi, akibat mandi dan langkah-langkah mandi 11. Lakukan edukasi pada pasien untuk melakukan mandi secara mandiri dan sesuai waktu kapan mandi 12. Dampingi pasien dan memberikan pujian saat pasien

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DEFISIT PERAWATAN DIRI: MANDI**		
	No.Dokumen A00.7.6 / 1200 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	mampu melakukan mandi baik mandiri atau didampingi 13. Jelaskan pada pasien bahwa kemampuan tersebut bisa dilakukan dengan bimbingan dari perawat, orang tua, keluarga yang lain. 14. Tanyakan pada pasien perasaan setelah pasien mandi. 15. Minta pasien untuk mengulang kembali langkah langkah mandi yang baik 16. Berikan pujian atas keberhasilan pasien hari ini. 17. Lakukan kontrak pertemuan kedua dengan pasien yang terdiri dari: kontrak waktu, tempat dan topik (berdandan)		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN HARGA DIRI RENDAH**		
	No.Dokumen 400.7.6/1204/2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan diagnose keperawatan harga diri rendah dengan mengajak pasien kegiatan sesuai dengan aspek dan kemampuan pasien yang positif.
TUJUAN	1. Agar pasien harga diri rendah mampu mengidentifikasi aspek positif yang dimiliki 2. Agar pasien mampu mengidentifikasi kemampuan positif yang dimiliki 3. Agar pasien harga diri rendah mampu melakukan kegiatan positif sesuai dengan aspek dan kemampuannya.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Perawat mengucapkan salam 2. Perawat mengajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm 3. Perawat memperkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shif apa) 4. Perawat menjelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien 5. Perawat menanyakan pada pasien nama, nama yang suka dipanggil 6. Perawat menanyakan pada pasien perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan 7. Perawat melakukan kontrak pertemuan yang terdiri dari waktu, tempat, dan topik. 8. Perawat menanyakan aspek positif yang dimiliki pasien, misal pasien cantik, ganteng, suka bergaul, rendah hati, mengalah, jujur dll. 9. Perawat memberikan pujian atas keberhasilan pasien mampu mengungkapkan perasaan tersebut 10. Perawat menanyakan kemampuan positif yang dimiliki pasien, misal memiliki keluarga, memiliki anak anak yang hebat, bisa membuat kerajinan tangan, mampu membetulkan mesin yang rusak, mampu bercocok tanam, mampu memasak dll. 11. Perawat mengajak pasien untuk melakukan salah satu

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN
HARGA DIRI RENDAH</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.6 /1204/
2026</td><td>No.Revisi

01</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">kemampuan yang dimilki pasien:
a. "ibu bagaimana kalau kita hari ini bercerita tentang kemampuan ibu yang pandai memasak" kira kira kita akan cerita tentang masa kapa ya bu?"
b. "saya akan siapkan kertas dan alat tulis ya bu, kita akan catat langkah langkah memasak sayur lodeh?"
c. "ibu mau menulis sendiri atau perawat bantu menuliskan?"
d. "baiklah bu, bagaimana kalau kita mulai dari menulis bumbu apa saja untuk masak sayur lodeh?
e. "selanjutnya kita menuliskan langkah langkah membuat sayur lodeh
12. Perawat meminta pasien untuk membacakan Kembali apa yang pasien tulis
13. Perawat mendampingi pasien dan memberikan pujian saat pasien mampu menulis dan membacakan kemampuan pasien hari ini.
14. Perawat menjelaskan pada pasien bahwa kemampuan tersebut bisa dilakukan dengan bimbingan dari perawat, orang tua, keluarga yang lain.
15. Perawat menyanyakan pada pasien perasaan setelah melakukan kegiatan menulis cara memasak.
16. Perawat meminta pasien untuk mengulang kembali kegiatan cara memasak hari ini
17. Perawat memberikan pujian atas keberhasilan pasien membuat catatan cara memasak.
18. Perawat melakukan kontrak pertemuan kedua dengan pasien yang terdiri dari: kontrak waktu, tempat dan topik (cara bertanam bunga di dalam pot)</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Ruang rawat inap Psikiatri
2. Ruang rawat Jalan Psikiatri</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ISOLASI SOSIAL: MENARIK DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1202 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan diagnose keperawatan isolasi sosial menarik diri dengan mengajak pasien berkenalan pada satu orang, dua orang dan kelompok.
TUJUAN	1. Agar pasien isolasi sosial: menarik diri dapat mengungkapkan perasaannya 2. Agar pasien isolasi sosial: menarik diri mampu berkenalan dengan orang lain secara individu 3. Agar pasien isolasi sosial: menarik diri mampu berkenalan diri di dalam kelompok.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm 3. Perkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shif apa) 4. Jelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien 5. Tanyakan pada pasien nama, nama yang suka dipanggil 6. Tanyakan pada pasien perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan 7. Lakukan kontrak pertemuan yang terdiri dari waktu, tempat, dan topik. 8. Tanyakan penyebab pasien tidak mau bersosialisasi, keuntungan memiliki kawan, kerugian tidak memiliki akwan. 9. Berikan pujian atas keberhasilan pasien mampu mengungkapkan perasaan tersebut 10. Ajak pasien untuk berkenalan dengan satu orang. 11. Berikan contoh cara berkenalan dengan orang lain: a. "mohon ijin apakah saya boleh berkenalan dengan bapak?" b. Sambal berjabat tangan, "perkenalkan nama saya Budi, saya berasal dari Brebes, apabila boleh tahu, bapak nama siapa dan berasal dari mana?" c. "terima kasih ya pak mau berkenalan dengan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ISOLASI SOSIAL: MENARIK DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1202 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	saya". d. Perawat mencontohkan ini bisa 2 – 3 kali. 12. Minta pasien untuk melakukan hal serupa sesuai contoh dari perawat 13. Dampingi pasien dan memberikan pujian saat pasien mampu berkenalan dengan satu orang. 14. Jelaskan kegiatan berkenalan tersebut bisa dilakukan dimanapun, kapanpun dan bisa dengan orang disekitar kita. 15. Tanyakan pada pasien perasaan setelah mencoba berkenalan dengan satu orang. 16. Minta pasien untuk mengulang kembali cara berkenalan dengan satu orang 17. Berikan pujian atas keberhasilan pasien berkenalan dengan satu orang 18. Lakukan kontrak pertemuan kedua dengan pasien yang terdiri dari: kontrak waktu, tempat dan topik (cara control berkenalan dengan 2 orang).		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**BERKUNJUNG DI BANGSAL JIWA**		
	No.Dokumen 400.7.6/1203/2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 27 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Berkunjung ke bangsal jiwa bertUjuan untuk menjenguk pasien, mengikuti kegiatan edukasi, atau bahkan untuk menambah wawasan tentang kesehatan mental
TUJUAN	1. Mendukung proses terapi dan penyembuhan pasien 2. Mengatur tentang waktu dan batas berkunjung
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Jelaskan Prosedur berkunjung di Rawat Inap Jiwa pada waktu penerimaan pasien baru 3. Berkunjung hanya diperbolehkan pada hari Sabtu jam 09 00 s/d 12 00 WIB 4. Bila keluarga menghendaki berkunjung di hari selain hari sabtu maka, keluarga harus membuat kontrak wakfu yang telah ditentukan yang diminta keluarga. (dicatat di lembar Edukasi pasien Dan Keluarga. Anak umur dibawah 10 tahun dilarang berkunjung, kecuali ada hal-hal khusus yang dapat dipertimbangkan (untuk mendukung terapi / persetujuan petugas). 5. Pasien hanya boleh ditemui di ruang kunjungan, tidak diperbolehkan di dalam ruang perawatan 6. Sebelum menemui pasien harus lapor pada perawat yang berdinas saat itu Tidak diperbolehkan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**BERKUNJUNG DI BANGSAL JIWA**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1203 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 2/2
	memberikan uang, rokok, benda tajam atau benda berbahaya lainnya pada pasien. 7. Apabila ingin memberikan sesuatu (makanan, pakaian, uang, dan lain-lainnya) diluar jam berkunjung dapat dititipkan pada perawat tanpa harus menemui pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Satuan Pengamanan (SATPAM)		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FAMILY GATHERING TERPADU SEMARPATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1199 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Kegiatan mempertemukan beberapa keluarga pasien, pasien dan petugas bangsal jiwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi pemberian edukasi kesehatan jiwa, berbagi masalah dan pengalaman keluarga dan unjuk kemampuan positif pasien untuk pemberdayaan pasien dan keluarga dalam rangka menurunkan angka readmisi di Ruang rawat inap jiwa RSUD dr Loekmono Hadi Kudus.
TUJUAN	1. Meningkatkan kepedulian, peran serta, dan kerjasama antara pihak RSUD dr Loekmono Hadi Kudus (dalam hal ini adalah psikiater, perawat jiwa dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan asuhan pasien) dengan pihak keluarga yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan seorang pasien. 2. Agar keluarga dapat mendukung dan menyelaraskan terapi yang telah diberikan kepada ODGJ sehingga segera pulih 3. Pemberdayaan keluarga dan pasien untuk sembuh secara paripurna 4. Turunnya angka readmisi pasien jiwa
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. berikan informasi kepada keluarga pasien 1 hari sebelum kegiatan hari Sabtu jam 09 00 s/d 11 30 di Ruang Cempaka 1 RSUD dr Loekmono Hadi Kudus 3. Pasien yang bertugas memulai acara dengan Pembukaan 4. Pasien yang bertugas membacakan ayat suci al qur'an dan sholawat 5. Kepala Ruang cempaka 1 memberikan sambutan 6. Perawat memperkenalkan Petugas Pemberi Asuhan Jiwa (Psikiater dan Perawat Jiwa) Ruang Cempaka 1

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FAMILY GATHERING TERPADU SEMARPATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1199 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 2/2
	Perawat menjelaskan tujuan pertemuan dengan keluarga pasien dan pasien 7. Petugas memberikan materi terkait dengan permasalahan jiwa 8. Perawat memberikan kesempatan kepada masing-masing dari keluarga pasien untuk menyampaikan riwayat sakit jiwa pasien serta permasalahan selama merawat dirumah. 9. Perawat memberikan sesi tanya jawab dan sharing dari keluarga 10. Petugas memberikan tanggapan dari permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing keluarga pasien 11. Unjuk kemampuan pasien Ruang Cempaka 1 12. Pasien memberikan pesan dan kesan selama di rawat inap 13. Doa dan Penutup		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FAMILY GATHERING TERPADU SEMARPATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1219 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Kegiatan mempertemukan beberapa keluarga pasien, pasien dan petugas bangsal jiwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi pemberian edukasi kesehatan jiwa, berbagi masalah dan pengalaman keluarga dan unjuk kemampuan positif pasien untuk pemberdayaan pasien dan keluarga dalam rangka menurunkan angka readmisi di Ruang rawat inap jiwa RSUD dr Loekmono Hadi Kudus.
TUJUAN	1. Meningkatkan kepedulian, peran serta, dan kerjasama antara pihak RSUD dr Loekmono Hadi Kudus (dalam hal ini adalah psikiater, perawat jiwa dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan asuhan pasien) dengan pihak keluarga yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan seorang pasien. 2. Agar keluarga dapat mendukung dan menyelaraskan terapi yang telah diberikan kepada ODGJ sehingga segera pulih 3. Pemberdayaan keluarga dan pasien untuk sembuh secara paripurna 4. Turunnya angka readmisi pasien jiwa
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri (nama dan peran) sebagai Petugas Pemberi Asuhan Jiwa Ruang Cempaka 1. 3. Identifikasi pasien dan keluarga menggunakan minimal dua identitas baku (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 4. Beritahu tentang prosedur dan tujuan tindakan *Family Gathering* kepada seluruh peserta yang hadir. 5. Jaga privasi pasien dan kenyamanan lingkungan selama kegiatan berlangsung. 6. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah sebelum memulai aktivitas dan berinteraksi. 7. Perawat memberikan informasi/undangan kepada

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FAMILY GATHERING TERPADU SEMARPATRI**		
	No.Dokumen A00.7.6 / 1214 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 2/2
	keluarga pasien 1 hari sebelum kegiatan (Hari Sabtu, jam 09.00 s/d 11.30 WIB) di Ruang Cempaka 1 RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. 8. Pasien yang bertugas memulai acara dengan Pembukaan. 9. Pasien yang bertugas membacakan ayat suci Al-Qur'an dan sholawat. 10. Kepala Ruang Cempaka 1 memberikan sambutan resmi. 11. Perawat memperkenalkan Petugas Pemberi Asuhan Jiwa (Psikiater dan Perawat Jiwa) Ruang Cempaka 1. 12. Perawat menjelaskan kembali tujuan pertemuan spesifik hari ini secara interaktif dengan keluarga pasien dan pasien. 13. Petugas/Psikiater memberikan pemaparan materi terkait dengan permasalahan gangguan jiwa dan manajemennya. 14. Perawat memberikan kesempatan kepada masing-masing keluarga pasien untuk menyampaikan riwayat sakit jiwa pasien serta dinamika/permasalahan selama merawat pasien di rumah. 15. Perawat membuka sesi tanya jawab dan sharing interaktif dari pihak keluarga. 16. Petugas memberikan tanggapan, solusi, dan edukasi medis dari permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing keluarga pasien. 17. Unjuk kemampuan/bakat (rehabilitasi psikososial) oleh pasien Ruang Cempaka 1. 18. Pasien memberikan pesan dan kesan selama menjalani masa rawat inap. 19. Sesi Doa dan Penutup acara. 20. Rapikan kembali pasien, keluarga, serta alat-alat/fasilitas ruangan yang digunakan. 21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah setelah kegiatan selesai. 22. Dokumentasikan pelaksanaan prosedur *Family Gathering*, daftar hadir, serta respons/perkembangan psikologis pasien selama kegiatan.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang Rawat Inap Jiwa 2. Sub Bagian Rumah Tangga 3. PKRS		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FIKSASI MEKANIS : RESTRAIN**		
	No.Dokumen 400.7.6/1206/2026	No.Revisi 03	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Suatu bentuk tindakan menggunakan tali untuk mengekang atau membatasi gerakan ekstrimitas individu yang berperilaku di luar kendali, yang merupakan intervensi terakhir jika perilaku pasien sudah tidak dapat diatasi atau dikontrol dengan strategi perilaku maupun modifikasi lingkungan.
TUJUAN	➢ Memberikan keamanan fisik dan psikologis individu. ➢ Supaya tidak mencedarai diri sendiri atau orang lain. ➢ Agar tidak merusak barang sekitar pasien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Siapkan petugas terlatih sebanyak 3 – 5 orang. 2. Lakukan informed consent secara lisan dan tuliskan di dalam status pasien. 3. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan, bukan sebagai hukuman tapi untuk mengamankan pasien, orang lain dan lingkungan dari perilaku pasien yang tidak terkontrol. 4. Siapkan ruang isolasi/alat pengikat (restraint) yang aman. 5. Lakukan kontrak/kesepakatan untuk mengontrol perilakunya. 6. Pilih alat pengikat yang aman dan nyaman, terbuat dari bahan katun.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FIKSASI MEKANIS : RESTRAIN**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1206 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 2/3

7. Pengikatan dilakukan oleh min. 4 orang; satu orang memegang kepala pasien, 2 orang memegang ekstremitas atas dan 1 orang memegang ekstremitas bawah.
8. Pengikatan dilakukan di tempat tidur bukan di sisi tempat tidur dengan posisi terlentang, kedua kaki lurus, kedua lengan di samping badan.
9. Ikatan sebaiknya tidak terlalu kencang, juga tidak longgar untuk mencegah cedera.
10. Beri bantal di daerah kepala.

Hal-hal yang penting diperhatikan pada tindakan restrain:

1. Pada kondisi gawat darurat, restrain/seklusi dapat dilakukan tanpa order dokter
2. Sesegera mungkin (< 1 jam) setelah melakukan restrain/seklusi, perawat melaporkan pada dokter untuk mendapatkan legalitas tindakan baik secara verbal maupun tertulis
3. Evaluasi dilakukan 2 jam
4. Waktu minimal reevaluasi oleh dokter adalah 8 jam
5. Lakukan observasi pengekangan setiap 30 menit. Hal-hal yang perlu diobservasi:
    a. tanda-tanda vital.
    b. tanda-tanda cedera yang berhubungan dengan proses pengikatan o nutrisi dan hidrasi.
    c. sirkulasi dan rentang gerak ekstremitas (kuat lemahnya ikatan)
    d. higiene dan eliminasi
    e. status fisik dan psikologis
    f. kesiapan klien untuk dilepaskan dari pengikatan, termasuk tanda vital
6. Lakukan perawatan pada daerah pengikatan, pantau kondisi kulit yang diikat (warna, temperatur, sensasi),

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FIKSASI MEKANIS : RESTRAIN**		
	No.Dokumen 900.7.6 / 1206 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 3/3
	lakukan latihan gerak pada tungkai yang diikat secara bergantian setiap 30 menit, lakukan perubahan posisi pengikatan. 7. Libatkan dan latih pasien untuk mengontrol perilaku sebelum ikatan dibuka secara bertahap 8. Kurangi pengekangan secara bertahap, misalnya: ikatan dibuka satu persatu secara bertahap dimulai dari pergelangan tangan yang tidak dominan, dilanjutkan pergelangan tangan lainnya, selanjutnya jika pasien tidak menunjukkan perilaku agresif lepaskan pengekangan pada pergelangan tangan kanan dan terakhir tangan kiri. 9. Jika klien sudah mulai dapat mengontrol perilakunya, maka pasien sudah dapat dicoba untuk berinteraksi tanpa pengikatan dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan yaitu jika kembali perilakunya tidak terkontrol maka pasien akan diisolasi/dilakukan pengikatan kembali		
UNIT TERKAIT	1. IGD 2. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FIKSASI MEKANIS : SEKLUSI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1207 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi dengan mengurung pasien dalam ruangan khusus, sehingga pasien tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut secara bebas pada pasien dengan perilaku kekerasan yang mebahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan
TUJUAN	➢ Supaya tidak mencedarai orang lain. ➢ Agar tidak merusak barang sekitar pasien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Kenalkan diri petugas 3. Jelaskan pada pasien / penanggung jawab pasien mengapa harus dikurung 4. Tempatkan pasien pada ruang khusus 5. Seklusi dapat dilakukan tanpa mengunci kamar atau dengan mengunci kamar, sesuai kebutuhan 6. Pastikan ruang aman, bebas dari alat/barang yang berbahaya termasuk kemungkinan dapat digunakan untuk mencedirai diri atau bunuh diri 7. Siapakan kasur tanpa seprei dan sarung bantal 8. Hal-hal yang penting diperhatikan pada tindakan seklusi : a. Pada kondisi gawat darurat, seklusi dapat dilakukan tanpa order dokter

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**FIKSASI MEKANIS : SEKLUSI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1209 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 2/2
	b. Sesegera mungkin (< 1 jam) setelah melakukan seklusi, perawat melaporkan pada dokter untuk mendapatkan legalitas tindakan baik secara verbal maupun tertulis c. Evaluasi dilakukan 4 jam I untuk klien > 18 th, 2 jam I untuk anak-anak dan usia 9-17 tahun 9. Waktu minimal reevaluasi oleh dokter adalah 8 jam untuk usia > 18 th dan 4 jam untuk usia < 17 tahun a. Selama seklusi pasien diobservasi tiap 10-15 menit,: ➢ Tanda-tanda cedera yang berhubungan dengan seklusi ➢ Nutirisi dan hidrasi ➢ Vital sign ➢ Hygiene dan eliminasi ➢ Status fisik dan psikologis ➢ Kesiapan klien untuk dibebaskan dari seklusi b. Selalu mencatat dengan lengkap alasan pengurungan, perjalanan terapi & respon pasien terhadap terapi selama pengurungan		
UNIT TERKAIT	1. IGD 2. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *BAD NEWS MITIGATION* (IDENTIFIKASI BERITA BURUK)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1181 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	*Bad News Mitigation* adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat sepanjang pelayanan rawat inap terkait hal-hal yang membuat bingung dan menghambat pemahaman pasien tentang sesuatu yang terjadi diluar maupun di dalam RS (misalnya: orang-orang disekitar pasien, peralatan dan sarana prasarana, peraturan, kejadian yang tidak diinginkan dan dilihatnya, kejadian di luar rumah sakit dan tidak sesuai yang diharapkan) sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya ketegangan (disstress) yang berdampak pada perilaku iritabel, agresif, kekerasan fisik, bunuh diri, dan melarikan diri dari RS.
TUJUAN	1. Mengenali sejak dini hal-hal yang membuat pasien tidak nyaman dan meningkatkan konflik 2. Menemukan tindakan persuasif untuk menurunkan kejadian kekerasan fisik, bunuh diri dan melarikan diri 3. Menurunkan tindakan restrain dan seklusi serta penggunaan obat tambahan 4. Mempersingkat lama rawat 5. Menghemat pembiayaan RS
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm 3. Perkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shif apa) 4. Jelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien 5. Tanyakan pada pasien nama, nama yang suka dipanggil 6. Tanyakan pada pasien perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan 7. Lakukan kontrak pertemuan yang terdiri dari waktu, tempat, dan topik. 8. Tanyakan apakah ada hal/ sesuatu yang membuat tidak nyaman 9. Jika ada , tanyakan kejadian/ peristiwa apa yang

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *BAD NEWS MITIGATION* (IDENTIFIKASI BERITA BURUK)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1181 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	membuat tidak nyaman 10. Berikan kesempatan pasien untuk BAK atau minum terlebih dahulu 11. Tanyakan apa ada kondisi sarana & prasarana yang membuat tidak nyaman 12. Tanyakan apa ada kondisi pasien lain yang membuat tidak nyaman 13. Tanyakan apa ada tata tertib yang ada di ruangan membuat tidak nyaman 14. Tanyakan apa adanya kunjungan keluarga membuat tidak nyaman 15. Tanyakan apa ada sikap perawat dan dokter yang membuat tidak nyaman 16. Tanyakan apa keberadaan di rumah sakit membuat tidak nyaman 17. Sampaikan perawat memahami ini sulit bagi pasien 18. Tanyakan perasaan setelah mengungkapkan ketidaknyamanannya 19. Tawarkan bantuan untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut 20. Rencanakan pemberian reassurance 21. Ucapkan salam Penutup 22. Tulis hasil mitigasi berita buruk dalam buku Bad News Mitigations		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *CALM DOWN METHODS* (METODE MENURUNKAN KETEGANGAN DAN AGITASI)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1182 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	*Calm Down Methods* adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat sepanjang pelayanan rawat inap ketika pasien dalam kondisi agitasi dan pasien belum siap untuk bercerita pada petugas dengan cara penggalian mekanisme koping yang digunakan ketika menghadapi ketegangan dan agitasi baik berada dalam ruangan yang tenang dan nyaman maupun peralatan yang mampu memberikan ketenangan dan kelonggaran pikiran. Petugas atau perawat membantu atau memfasilitasi pasien untuk mendapatkannya.
TUJUAN	1. Meningkatkan kemampuan pasien dalam memperdayakan dirinya dalam kontrol diri terhadap perilaku agresif 2. Memberikan kesempatan bagi pasien untuk awal eskalasi ketegangan pikiran dan perilaku 3. Memberikan kesempatan pasien untuk mengekspresikan dan ventilasi pikiran dan perasaan melalui alat atau ruangan 4. Menurunkan tindakan restrain dan seklusi serta penggunaan obat tambahan 5. Meningkatkan harga diri pasien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Kenali tanda -tanda agitasi 2. Ucapkan salam 3. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm 4. Perkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shif apa) 5. Jelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien 6. Tanyakan pada pasien nama, nama yang suka dipanggil 7. Tanyakan pada pasien perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *CALM DOWN METHODS*** **(METODE MENURUNKAN KETEGANGAN DAN AGITASI)**		
	No.Dokumen	No.Revisi	Halaman :
	900.7.6 / 1182 / 2026	01	2/3

8. Lakukan kontrak pertemuan yang terdiri dari waktu, tempat, dan topik.
9. Tanyakan apakah ada hal/ sesuatu yang membuat tidak nyaman
10. Jika ada , tanyakan kejadian/ peristiwa apa yang membuat tidak nyaman
11. Berikan kesempatan pasien untuk BAK atau minum terlebih dahulu
12. Tanyakan apa ada kondisi sarana & prasarana yang membuat tidak nyaman
13. Tanyakan apa ada kondisi pasien lain yang membuat tidak nyaman
14. Tanyakan apa ada tata tertib yang ada di ruangan membuat tidak nyaman
15. Tanyakan apa adanya kunjungan keluarga membuat tidak nyaman
16. Tanyakan apa ada sikap perawat dan dokter yang membuat tidak nyaman
17. Tanyakan apa keberadaan di rumah sakit membuat tidak nyaman
18. Sampaikan perawat memahami ini sulit bagi pasien
19. Berikan reinforcement positif
20. Buat kontrak topik pertemuan
21. Buat kontrak lama pertemuan
22. Buat tempat kontrak pertemuan
23. Tawarkan pada pasien, akan ditemani atau sendirian
24. Berikan kesempatan pada pasien menggunakan peralatan 30-60 menit
25. Kunjungi ulang pasien setelah waktu yang disepakati selesai/habis
26. Tanyakan perasaan pasien setelah menggunakan peralatan/ ruangan
27. Tanyakan apakah ada penurunan ketegangan pikiran
28. Berikan reinforcement positif
29. Tawarkan apakah sudah siap untuk bercerita ketidak nyamanannya
30. Jika belum siap, persilahkan pasien istirahat/ berkegiatan yang lain
31. Jelaskan jika membutuhkan bantuan perawat, segera temui perawat
32. Buat kontrak topik pertemuan
33. Buat kontrak lama pertemuan
34. Buat kontrak tempat pertemuan
35. Ucapkan salam penutup

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *CALM DOWN METHODS* (METODE MENURUNKAN KETEGANGAN DAN AGITASI)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1182 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 3/3
	36. Persilahkan pasien untuk istirahat 37. Bereskan peralatan/ ruangan		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *CLEAR MUTUAL EXPECTATION* (HARAPAN PASIEN DAN STAF YANG JELAS KEBERADAAN DI RS)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1189 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	*Clear Mutual Expectation* adalah kegiatan yang dilakukan di ruang perawatan dengan cara menyusun harapan perilaku yang harus dilakukan oleh staf dan pasien yang jelas dan konsisten, sehingga harapan dalam berperilaku diketahui oleh kedua belah pihak.
TUJUAN	1. Setiap staf maupun pasien akan menyadari perilaku yang diharapkan 2. Meningkatkan konsisten staf dalam memberikan asuhan pada pasien 3. Mengurangi konflik yang terjadi akibat ketidakjelasan perilaku pasien maupun staf 4. Mengurangi konflik yang terjadi akibat kurang konsistennya staf terhadap pelaksanaan pekerjaan 5. Berkurangnya agresi verbal pada staf dan pasien lain 6. Tersedia dokumentasi kejadian agresi/ perilaku mencelakai diri dan orang lain sebagai palang keamanan (*Safety Cross*)
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	A. PEMBUATAN CLEAR MUTUAL EXPECTATION PASIEN DENGAN PASIEN 1. Ucapkan salam 2. Identifikasi kebutuhan pasien akan harapan bersama 3. Kumpulkan beberapa pasien 4. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm 5. Perkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shif apa) 6. Jelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien 7. Tanyakan pada pasien nama, nama yang suka dipanggil 8. Tanyakan pada pasien perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *CLEAR MUTUAL EXPECTATION* (HARAPAN PASIEN DAN STAF YANG JELAS KEBERADAAN DI RS)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1189 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/3
	9. Lakukan kontrak pertemuan yang terdiri dari waktu, tempat, dan topik. 10. Jelaskan tata cara diskusi harapan bersama yang bermutu 11. Tanyakan pada pasien hal yang membuat tidak nyaman selama di ruangan 12. Pastikan semua pasien mendapatkan kesempatan bercerita 13. Berikan Reinforcemen positif 14. Bantu pasien menyimpulkan permasalahan yang ada di ruangan 15. Tanyakan pada pasien perilaku pasien atau perawat yang diharapkan 16. Pastikan semua pasien mendapatkan kesempatan sampaikan ide/gagasan 17. Bantu pasien menyimpulkan perilaku yang diharapkan/ inginkan 18. Berikan Reinforcemen positif 19. Bantu pasien membuat kalimat sepakatan supaya perilaku tdk terjadi lagi 20. Ketik harapan perilaku bersama pasien atau staf yang disepakati 21. Print dan lamilating 22. Tempelkan pada dinding yang mudah diakses perawat dan pasien. B. MEMANFAATKAN POSTER CLEAR MUTUAL EXPECTATIONS PADA PASIEN; 1. Identifikasi kebutuhan pasien akan harapan bersama 2. Perkenalkan nama dan profesi 3. Jelaskan tujuan pertemuan 4. Buat kontrak pertemuan (Topik dan lama pertemuan) 5. Minta pasien membaca/ bacakan poster Clear Mutual Expectations 6. Jelaskan makna atau arti yang ada di poster Clear Mutual Expectations 7. Tanyakan apakah sudah memahaminya 8. Tanyakan apakah ada yang mau ditanyakan 9. Minta pasienbaca kembali jika ada waktu luang/ perawat bacakan ulang 10. Tanyakan perasaan pasien setelah tahu harapan perilaku bersama 11. Persilahkan pasien istirahat		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI DISCHARGE MESSAGES (PESAN PELEPASAN / PEMINDAHAN ATAU PEMULANGAN)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1190/ 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Suatu tindakan yang menyediakan metode lebih lanjut untuk menanamkan harapan dan menyampaikan pesan otoritatif dari pasien lama pada pasien baru tentang tujuan dan manfaat dari penerimaan perawatan selama berada di ruang perawatan melalui pohon harapan.
TUJUAN	1. Memperjelas harapan dan tujuan dirawat di rumah sakit 2. Menurunkan kecemasan dan kekhawatiran pasien selama perawatan 3. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam asuhan selama di ruangan 4. Menurunkan risiko melarikan diri pada semua pasien yang dirawat
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	PEMANFAATAN POHON HARAPAN 1. Identifikasi kebutuhan Discharge Messages: Saat awal/ akhir shift 2. Identifikasi kebutuhan Discharge Messages: pasien jenuh/ mengeluh 3. Ajak pasien ke pohon harapan 4. Perkenalkan nama dan profesi 5. Jelaskan tujuan pertemuan 6. Jelaskan kesan dan pesan di daun dibuat oleh pasien

yg sudah pulang

7. Tanyakan perasaan saat ini
8. Buat kontrak pertemuan (topik dan lama pertemuan)
9. Tanyakan apakah bisa membaca
10. Jika tidak bisa membaca/ bacakan
11. Minta pasien membaca/ bacakan 1-2 kesan di daun
12. Jelaskan maksud isi kesan yang ada pada daun
13. Minta pasien membaca/ bacakan 1-2 pesan di daun
14. Jelaskan maksud isi pesan yang ada pada daun
15. Tanyakkan apakah sudah paham dengan maksud dari kesan dan pesan
16. Tanyakkan apakah sudah paham dengan maksud dari kesan dan pesan
17. Tanyakan apakah ada yang mau ditanyakan
18. Tanyakan perasaan setelah mengetahui isi kesan dan pesan
19. Minta pasien membaca kesan dan pesan lainnya saat waktu luang
20. Ucapkan salam penutup
21. Persilahkan pasien istirahat

TATA CARA PEMBUATAN KESAN DAN PESAN PADA DAUN/ KUPU.KUPU:

1. Identifikasi kebutuhan Discharge Messages: pasien sudah BLPL (boleh pulang)
2. Identifikasi kebutuhan Discharge Messages: dijemput pulang keluarga
3. Ucapkan salam pembuka
4. Perkenalkan nama dan profesi
5. Jelaskan tujuan pertemuan
6. Tanyakan perasaan saat ini
7. Buat kontrak pertemuan (topik dan lama pertemuan)
8. Berikan sebuah potongan kertas berbentuk daun atau kupu-kupu & bollpoint

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI DISCHARGE MESSAGES (PESAN PELEPASAN / PEMINDAHAN ATAU PEMULANGAN)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1190 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 3/3
	9. Jelaskan Maksud dari kesan terhadap sikap petugas, fasilitasi, dll 10. Pandu pasien membuat kesan yang paling mendalam, bantu jika tidak dapat menulis 11. Jelaskan maksud membuat pesan untuk pasien yang lain 12. Pandu pasien membuat pesan terhadap pasien berikutnya, bantu menulis jika tidak dapat menulis 13. Berikan perekat pada kertas dibalik tulisan 14. Minta pasien menempelkan pada ranting pohon 15. Minta pasien menempelkan pada ranting pohon 16. Tanyakan bagaimana perasaan setelah membuat kesan dan pesan 17. Ucapkan salam penutup		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI POSITIVE WORDS**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1183 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	*Positive Words* adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat sepanjang pelayanan rawat inap ucapan saat hand over maupun saat pelaksanaan tindakan berupa kata positif, kata-kata yang menghormati, menghargai pasien dengan selalu menyampaikan kemajuan pasien, komentar baik bukan keburukan atau ketidakmampuan pasien.
TUJUAN	1. Memberikan rasa optimis bagi pasien bahwa akan baik-baik saja dan nyaman berada dalam ruang perawatan 2. Meningkatkan kemampuan pasien terhadap kemampuan diri yang positif 3. Meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan 4. Meningkatkan harga diri pasien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Identifikasi kebutuhan pasien akan Kata-Kata positif 2. Persiapan hand over (siapkan buku referensi penjelasan psikologis) 3. Ucapkan salam pembuka 4. Sebutkan nama pasien dan register pasien 5. Berikan pasien apresiasi positif (sudah membaik, tenang, luar biasa, dll) 6. Jika pasien baru (sebutkan kemampuan yg masih dimiliki saat dirumah) 7. Sebutkan kemampuan pasien kendalikan emosi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI POSITIVE WORDS**		
	No.Dokumen 400.7.6/1183/2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	(wajah rileks, koheren, dll) 8. Sebutkan sesuatu yang sudah dinikmati (mau nonton TV, makan, ibadah, dll) 9. Sebutkan kemampuan berkonstribusi memenuhi kebutuhan (minum obat, tidur) 10. Sebutkan kemampuan mengekspresikan minat (bersedia latihan, TAK) 11. Sebutkan kemampuan ungkapkan pikiran dan perasaan (mampu talk downs) 12. Sebutkan pencapaian yg sudah bisa (mampu latihan menghardik) 13. Sebutkan keterlibatan dalam kegiatan harian (sudah ikut menyapu, TAK, dll) 14. Sebutkan hal menarik tentang pasien (sudah ada inisiatif, bisa diajak diskusi) 15. Tidak ucapkan kata yang berkonotasi negatif (sulit diatur, rewel, profokatif) 16. Tidak memberikan label negatif (menyalahkan, meremehkan pasien) 17. Sebutkan kata-kata positif baru kata-kata negatif jika harus disampaikan 18. Ketika menyebutkan kata-kata negatif disertai dengan 19. Ucapkan salam penutup 20. Lakukan hand over, diarea yang jauh dari pasien (idealnya tertutup)		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *REASSURANCE*** **(PEMBERIAN JAMINAN KEJELASAN DAN KEPASTIAN)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1184 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	*Reassurance* adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat sepanjang pelayanan rawat inap ketika pasien dalam kondisi agitasi dengan cara memberikan informasi baik secara langsung (verbal) maupun tidak langsung (poster atau gambar) sehingga pasien akan memperluas kesadaran diri terkait masalahnya, alasan dirawat, program pengobatan dan perawatan yang akan dijalani, lama perawatan serta sega;a peraturan yang ada di ruang perawatan sehingga pasien perilaku agitasi dan agresif dapat dihindari
TUJUAN	1. Meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman psikologis terhadap permasalahan yang dihadapi 2. Meningkatkan pemahaman pasien tentang alasan dirawat, lama dirawat, pengobatan yang harus dijalani, peraturan yang ada di ruang perawatan 3. Meningkatkan pemahaman pasien tentang mengapa sesuatu terjadi pada dirinya dan orang lain 4. Meningkatkan pemahaman pasien perilaku apa yang diharapkan dilakukan agar kejadian tidak menyenangkan tidak dialaminya
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Kenali tanda -tanda agitasi/kebutuhan informasi 2. Ucapkan salam 3. Perkenalkan nama dan profesi 4. Check nama pasien dan tanggal lahir 5. Jelask kondisi Pasien saat ini

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *REASSURANCE*** **(PEMBERIAN JAMINAN KEJELASAN DAN KEPASTIAN)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1184 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	6. Jelaskan tujuan pertemuan 7. Tanyakan yang membuat tidak nyaman (Lakukan Bad News Mitigations) 8. Tanyakan apakah ada yang ingin diketahui atau tanyakan 9. Tanyakan apakah ada yang diharapkan atau diinginkan 10. Buat kontrak topik pertemuan 11. Buat kontrak lama pertemuan 12. Buat tempat kontrak pertemuan 13. Jelaskan selama menjelaskan, pasien mendengarkan, ada waktu Tanya 14. Jelaskan/ fasilitasi pasien sesuai jaminan dan kepastian yang diinginkan 15. Orientasikan pasien dengan poster atau media yang ada di ruangan 16. Jelaskan tidak semua yang diharapkan/diinginkan harus terpenuhi saat ini 17. Tanyakan pada pasien apakah ada yang hendak ditanyakan lagi 18. Tanyakan perasaan pasien setelah mendapatkan reassurance 19. Tanyakan pasien infomasi/ jaminan apa yang sudah didapatkannya 20. Berikan Reinforcemen positif 21. Jelaskan jika membutuhkan bantuan perawat, segera temui perawat 22. Buat kontrak topik pertemuan berikutnya 23. Buat kontrak lama pertemuan 24. Buat kontrak tempat pertemuan 25. Ucapkan salam penutup 26. Persilahkan pasien istirahat		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *SOFT WORDS*** **(KATA – KATA YANG LEMBUT)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1187 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	*Soft Words* adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat sepanjang pelayanan rawat inap berupa ucapan yang lembut, bersahabat, peraturan yang jelas dan poster-poster yang jelas dan memotivasi pasien untuk semangat, berusaha mengatasi masalahnya dan menurunkan ketegangan pikiran akibat ketidakjelasan dan ketidakpastian berada di RS
TUJUAN	1. Memperluas keterampilan perawat/ staf dalam memberikan informasi yang menenangkan pasien 2. Meningkatkan emosi pasien yang positif sehingga tetap semangat optimis dan nyaman menjalani masa pengobatan dan perawatan 3. Meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan 4. Meningkatkan harga diri pasien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Identifikasi kebutuhan pasien akan Kata-Kata Lunak 2. Ajak pasien ke Poster Soft Words atau Message of The Day 3. Ucapkan salam pembuka 4. Perkenalkan nama dan profesi 5. Jelaskan tujuan pertemuan 6. Buat kontrak pertemuan (Topik dan lama pertemuan) 7. Tanyakan apakah pasien bisa membaca atau tidak

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *SOFT WORDS*** **(KATA – KATA YANG LEMBUT)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1187 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	8. Minta pasien membaca poster/ kalimat, jika tidak bisa di bacakan 9. Tanyakan pada pasien apakah sudah memahami 10. Berikan Reinforcemen positif 11. Jelaskan pada pasien makna atau maksud dari kalimat yang dibaca 12. Tanyakan apakah ada yang mau ditanyakan 13. Tanyakan perasaan pasien setelah membaca kalimat/kata positif 14. Minta pasien membaca kata-kata lunak/ soft words yang lain di waktu luang 15. Ucapkan salam penutup 16. Ganti kata-kata lunak dalam Message of the day setiap hari		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *TALK DOWN*** **(BERBICARA UNTUK MENENANGKAN PASIEN)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1188 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	*Talk Down* adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat sepanjang pelayanan rawat inap ketika pasien dalam kondisi agitasi dan pasien sudah siap bercerita pada petugas dengan melakukan de-eskalasi (melalui gambar atau tulisan) atau de-eskalasi verbal (melalui bercerita) untuk melonggarkan pikiran (*cognitive defusion*) sehingga ketegangan dan agitasi menurun. Kegiatan De-eskalasi mencakup: meminta pasien bercerita, mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, melakukan klarifikasi, dan menawarkan bantuan.
TUJUAN	1. Membangun keterampilan manajemen diri (emosional, pikiran pasien) 2. Meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman psikologis terhadap permasalahan yang dihadapi 3. Menghindari tindakan restrain dan seklusi 4. Meningkatkan kohesifitas antara staf dan pasien dalam saling mendukung
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Identifikasi kebutuhan Talk Downs: pasien agitasi 2. Ucapkan salam pembuka 3. Perkenalkan nama dan profesi 4. Jelaskan kondisi pasien saat ini 5. Tawarkan bantuan untuk menemani bercerita 6. Jelaskan tujuan pertemuan 7. Minta kesediaan pasien untuk bercerita 8. Buat kontrak pertemuan (topik dan lama pertemuan) 9. Tetapkan bersama pasien lokasi khusus untuk bercerita

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**IMPLEMENTASI *TALK DOWN*** **(BERBICARA UNTUK MENENANGKAN PASIEN)**		
	No.Dokumen 900.7.6 / 1188 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/3

10. Berikan kesempatan pasien untuk BAK atau minum terlebih dahulu
11. Tawarkan pasien apakah mau minum hangat
12. Tanyakan perasaan pasien saat ini
13. Jelaskan apapun yang diceritakan pasien akan dirahasiakan
14. Minta ijin pasien untuk bisa sambil menulis
15. Minta pasien ceritakan kejadian/peristiwa yang membuat tidak nyaman
16. Minta pasien akibat kejadian tersebut, pikiran apa yang muncul
17. Tanyakan berapa sering pikiran tersebut muncul
18. Minta pasien ceritakan perasaan yang muncul akibat pikiran tersebut
19. Dengarkan pasien secara aktif (tidak menyela cerita pasien)
20. Tulis yang diceritakan pasien
21. Tanyakan pada pasien tindakan yang dilakukan saat tidak nyaman muncul
22. Catat tindakan adaptif dan maladaptif yang sudah dilakukan
23. Minta ijin pasien untuk menyampaikan kembali yg sudah diceritakan
24. Sampaikan yg dialami situasi sulit yang harus dihadapi
25. Sampaikan jika perawat/ orang lain mengalami akan rasakan yg sama
26. Sampaikan semua orang punya masalah, dan harus diatasi mulai dari membicarakannya
27. Sampaikan menceritakan masalah hal bagus utk atasi masalah
28. Sampaikan bahwa perawat percaya, pasien dapat menghadapinya
29. Sampaikan semua orang di ruangan ini, akan membantunya
30. Tanyakan perasaan pasien saat ini
31. Tanyakan apa yang diharapkan dan diinginkan pasien saat ini
32. Tawarkan perawat bisa membantunya
33. Jelaskan pasien dapat menggunakan cara yang

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">IMPLEMENTASI TALK DOWN
(BERBICARA UNTUK MENENANGKAN PASIEN)</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.6 / 1188 / 2026</td><td>No.Revisi

01</td><td>Halaman :

3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">sudah baik dalam mengatasi masalah terdahulu
34. Fasilitasi pasien mengatasi masalahnya (jika mungkin)
35. Minta temui perawat jika ada hal lain yang hendak dibicarakan
36. Ucapkan salam penutup
37. Persilahkan pasien istirahat</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Ruang rawat inap Psikiatri</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KOMUNIKASI KELUARGA / PASIEN PSIKIATRI MELALUI MEDIA SOSIAL**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1195 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan Media Sosial untuk berdiskusi dan konsultasi tentang kondisi dan perkembangan pasien yang sedang di rawat.
TUJUAN	1. Keluarga pasien mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien yang sedang dirawat di Ruang Cempaka 1. 2. Sebagai Media pemberian Edukasi tentang Kesehatan Jiwa.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Keluarga pasien diberi tahu prosedur dan tata cara menghubungi nomor ruangan rawat inap jiwa 3. Petugas menanyakan keperluan keluarga 4. Keluarga berkonsultasi melalui chaV panggilan 5. Dokter / Perawat memberikan jawaban dari pertanyaan / Konsultasi keluarga pasien 6. Keluarga / pasien dikasih kesempatan untuk menggunakan panggilan telpon / video telpon 7. Akhiri dengan ucapkan salam
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KOMUNIKASI KOMUNITAS PASIEN RAWAT INAP DENGAN MEDIA SOSIAL "PERMADI SAKTI"**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1196 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Menggunakan Media sosial Whatsapp, untuk berdiskusi dan konsultasi tentang kondisi dan perkembangan keluarga yang mengalami gangguan psikiatri.
TUJUAN	1. Keluarga dapat mengakses media Sosial tentang perkembangan kondisi kesehatan pasien. 2. Keluarga pasien mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien yang sedang dirawat di Ruang Cempaka 1. 3. Sebagai Media pemberian Edukasi tentang Kesehatan Jiwa. 4. Angka Readmisi dapat berkurang.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Keluarga Mengakses barcode dan Link untuk dapat bergabung di Group Whats app Ruang Cempaka 1 2. Keluarga berkonsultasi menggunakan Media digital (Whats App) 3. DoKer / Perawat memberikan jawaban dari pertanyaan / Konsultasi keluarga pasien. 4. Petugas Kesehatan Memberikan Edukasi tentang Kesehatan Jiwa, Melalui Whats App Group' "PERMADI SAKTI".
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONTROL HALUSINASI PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA KEGIATAN POSITIF**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1215 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan diagnose keperawatan halusinasi agar tidak membahayakan pada pasien, orang lain dan lingkungan. Tindakan keperawatan ini terdiri dari cara kontrol halusinasi ada menghardik, kegiatan rutin dan obat.
TUJUAN	1. Agar pasien gangguan jiwa mampu kontrol halusinasi dengan kegiatan yang positif 2. Agar pasien gangguan jiwa dapat terlatih cara kontrol halusinasi dengan kegiatan positif saat tiba tiba halusinasi muncul 3. Agar pasien gangguan jiwa mampu menerapkan cara kontrol halusinasi dengan kegiatan positif apabila nanti sudah kembali ke rumah
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi nomor 03 tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm 3. Perkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shif apa) 4. Jelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien 5. Tanyakan pada pasien nama, nama yang suka dipanggil 6. Tanyakan pada pasien perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan 7. Lakukan kontrak pertemuan yang terdiri dari waktu, tempat, dan topik. 8. Tanyakan apakah halusinasi masih muncul dan cara kontrol halusinasi dengan menghardik sudah dilakukan secara mandiri. 9. Berikan pujian atas keberhasilan pasien kontrol halusinasi dengan cara menghardik 10. Berikan contoh cara kontrol halusinasi dengan kegiatan (misal kegiatan merapikan tempat tidur): a. Perawat mengajak pasien ke tempat tidur pasien.

	b. Perawat menjelaskan cara merapikan tempat tidur c. Perawat memberikan contoh merapikan sprai, memakai sarung bantal dan melipat selimut. d. Perawat menjelaskan merapikan tempat tidur tersebut bisa dilakukan pada bangun tidur, saat tempat tidur belum rapi dll. e. Perawat mencontohkan ini bisa 2 – 3 kali. 11. Minta pasien untuk melakukan hal serupa sesuai contoh dari perawat 12. Dampingi pasien dan memberikan pujian saat pasien mampu merapikan tempat tidur: merapikan sprai, memakai sarung bantal dan melipat selimut. 13. Jelaskan pada pasien cara kontrol halusinasi dengan kegiatan bisa dengan cara yang lain seperti: bercocok tanam, menyapu, melihat TV dll. 14. Jelaskan kegiatan tersebut bisa dilakukan dimanapun, kapanpun dan bisa berapa kalipun dalam sehari saat halusinasi muncul. 15. Tanyakan pada pasien perasaan setelah mencoba Latihan kontrol halusinasi dengan kegiatan. 16. Minta pasien untuk mengulang kembali cara kontrol halusinasi dengan cara kegiatan 17. Berikan pujian atas keberhasilan pasien kontrol halusinasi dengan cara kegiatan 18. Lakukan kontrak pertemuan kedua dengan pasien yang terdiri dari: kontrak waktu, tempat dan topik (cara control halusinasi dengan manfaat obat)
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONTROL HALUSINASI PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA MENGHARDIK**		
	No.Dokumen 400.7.6/1197/2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan diagnose keperawatan halusinasi agar tidak membahayakan pada pasien, orang lain dan lingkungan. Tindakan keperawatan ini terdiri dari cara kontrol halusinasi ada menghardik, kegiatan rutin dan obat.
TUJUAN	1. Agar pasien gangguan jiwa mampu kontrol halusinasi dengan tepat 2. Agar pasien gangguan jiwa dapat terlatih cara kontrol halusinasi saat tiba tiba halusinasi muncul 3. Agar pasien gangguan jiwa mampu menerapkan cara kontrol halusinasi apabila nanti sudah kembali ke rumah
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi nomor 03 tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien. 4. Jelaskan tujuan tindakan. 5. Jaga privasi pasien. 6. Cuci tangan. 7. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak ± 60–90 cm. 8. Tanyakan nama panggilan yang disukai pasien. 9. Tanyakan isi halusinasi, berapa lama halusinasi muncul, sekali muncul halusinasi berapa detik / menit, situasi seperti apa saja halusinasi muncul dan respon apa yang pasien rasakan saat halusinasi muncul. 10. Jelaskan cara kontrol halusinasi dengan cara mengahrdik 11. Berikan contoh cara kontrol halusinasi dengan menghardik: a. Perawat duduk di kursi dengan sikap santai. b. Perawat meletakkan kedua tangan dikedua paha c. Perawat memberikan contoh saat halusinasi muncul (misal: halisinasi pendengaran), tutup

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONTROL HALUSINASI PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA MENGHARDIK**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1197 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	mata, letakkan tangan untuk menutup kedua telinga. d. Perawat memberikan contoh kalimatnya "pergi kamu halusinasi suara palsu, saya tidak mau mendengarkan kamu lagi sebab kamu suara palsu". e. Perawat menjelaskan kalimat tersebut bisa diucapkan dalam hati atau diucapkan secara pelan / lirih saja. f. Perawat mencontohkan ini bisa 2 – 3 kali. 12. Minta pasien untuk melakukan hal serupa sesuai contoh dari perawat 13. Dampingi pasien dan memberikan pujian saat pasien mampu melakukan kontrol halusinasi dengan menghardik. 14. Jelaskan pada pasien cara kontrol halusinasi ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun dan bisa berapa kalipun dalam sehari saat halusinasi muncul. 15. Tanyakan pada pasien perasaan setelah mencoba Latihan kontrol halusinasi dengan menghardik. 16. Minta pasien untuk mengulang kembali cara kontrol halusinasi dengan cara menghardik 17. Berikan pujian atas keberhasilan pasien kontrol halusinasi dengan cara menghardik 18. Lakukan kontrak pertemuan kedua dengan pasien yang terdiri dari: kontrak waktu, tempat dan topik (cara Kontrol halusinasi dengan kegiatan positif).		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONTROL MARAH PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA FISIK**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1222 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan diagnose keperawatan resiko perilaku kekerasan yang belum mampu kontrol marah secara asertif. Tindakan keperawatan ini terdiri dari cara kontrol dengan fisik, sosial, spiritual dan obat.
TUJUAN	1. Agar pasien gangguan jiwa mampu kontrol emosi dengan positif saat muncul rasa marah 2. Agar pasien gangguan jiwa dapat terlatih cara kontrol marah saat tiba tiba ada rangsang yang membuat pasien jengkel / marah. 3. Agar pasien gangguan jiwa mampu menerapkan cara kontrol marah apabila nanti sudah kembali ke rumah
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi nomor 03 tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam. 2. Perkenalkan diri. 3. Identifikasi pasien. 4. Jelaskan tujuan tindakan. 5. Jaga privasi pasien. 6. Cuci tangan. 7. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak ± 60–90 cm. 8. Tanyakan nama panggilan yang disukai pasien. 9. Tanyakan perasaan/kondisi pasien saat ini. 10. Buat kontrak waktu, tempat, dan topik pembicaraan. 11. Perawat menanyakan sebab marah, tanda gejala orang marah, marah yang biasa dialami, akibat marah yang dilakukan. 12. Perawat menjelaskan cara kontrol marah ada 4: cara fisik, cara verbal, cara sosial dan spiritual 13. Perawat memberikan contoh cara kontrol marah dengan fisik yaitu: a. Perawat duduk di kursi dengan sikap tegak. b. Perawat meletakkan kedua tangan dikedua paha c. Perawat ambil nafas dari hidung dan ditahan, dalam

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONTROL MARAH PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA FISIK**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1222 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	hitungan 5 kali lalu dihembuskan lewat mulut d. Perawat saat menghembuskan nafas sambal memukul bantal dan berkata saya "saya jengkel dengan kamu" atau bisa ucapan Astaqirulloh". e. Perawat mencontohkan ini bisa 2 – 3 kali Gerakan 14. Perawat meminta pasien untuk melakukan hal serupa yang sudah diberi contoh 15. Perawat mendampingi pasien dan memberikan pujian saat pasien mampu melakukan kontrol marah dengan fisik 16. Perawat menjelaskan pada pasien cara kontrol marah ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun dan bisa berapa kalipun dalam sehari 17. Perawat menyanyakan pada pasien perasaan setelah mencoba Latihan control marah dengan fisik; nafas dalam pukul bantal 18. Perawat meminta pasien untuk mengulang kembali cara kontrol marah dengan fisik: nafas dalam pukul bantal. 19. Perawat memberikan pujian atas keberhasilan pasien control marah fisik: nafas dalam pukul bantal. 20. Perawat melakukan kontrak pertemuan kedua dengan pasien yang terdiri dari: kontrak waktu, tempat dan topik (cara control marah verbal: meminta / menolak yang baik).		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONTROL MARAH PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA SPIRITUAL**		
	No.Dokumen 900.7.6 / 1221 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan diagnose keperawatan resiko perilaku kekerasan yang belum mampu kontrol marah secara asertif. Tindakan keperawatan ini terdiri dari cara kontrol dengan fisik, sosial, spiritual dan obat.
TUJUAN	1. Agar pasien gangguan jiwa mampu kontrol emosi dengan positif saat muncul rasa marah dengan spiritual 2. Agar pasien gangguan jiwa dapat terlatih cara kontrol marah secara spiritual saat tiba tiba ada rangsang yang membuat pasien jengkel / marah. 3. Agar pasien gangguan jiwa mampu menerapkan cara kontrol marah secara spiritual apabila nanti sudah kembali ke rumah
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi nomor 03 tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm 3. Perkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shif apa) 4. Jelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien 5. Tanyakan pada pasien nama, nama yang suka dipanggil 6. Tanyakan pada pasien perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan 7. Lakukan kontrak pertemuan yang terdiri dari waktu, tempat, dan topik. 8. Tanyakan apakah Latihan cara control marah secara fisik dan verbal sudah dilakukan secara mandiri 9. Berikan pujian saat pasien sudah mampu melakukannya 10. Berikan contoh cara kontrol marah dengan spiritual yaitu:

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**KONTROL MARAH PADA PASIEN RESIKO PERILAKU KEKERASAN DENGAN CARA SPIRITUAL**		
	No.Dokumen A00.7.6 / 1221 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	a. Perawat duduk di kursi atau duduk dilantai dengan alas dan sikap santai. b. Perawat memberikan contoh kalimat cara control marah psiritual "membaca istigfar, berdoa, mengaji". c. Perawat meminta pasien untuk melakukan hal serupa yang sudah diberi contoh. d. Perawat mendampingi pasien dan memberikan pujian saat pasien mampu melakukan kontrol marah dengan spiritual. e. Perawat menjelaskan pada pasien cara kontrol marah ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun dan bisa berapa kalipun dalam sehari. 11. Tanyakan pada pasien perasaan setelah mencoba Latihan kontrol marah dengan spiritual 12. Minta pasien untuk mengulang kembali cara kontrol marah dengan spiritual 13. Berikan pujian atas keberhasilan pasien kontrol marah spiritual 14. Lakukan kontrak pertemuan kedua dengan pasien yang terdiri dari: kontrak waktu, tempat dan topik (cara control marah secara fisik)		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MENCEGAH PASIEN MELARIKAN DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1213 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Mencegah agar pasien tidak meninggalkan rumah sakit tanpa seijin dengan petugas ruang keperawatan
TUJUAN	1. Pasien tidak meninggalkan rumah sakit 2. Pasien kooperatif dalam proses pengobatan & perawatan 3. Mempercepat proses penyembuhan 4. Pengobatan menjadi lebih efektif
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Pada setiap serah terima awal dan akhir dinas (operan) petugas menghitung jumlah pasien dan melihat kondisi pasien 2. Kepala ruang membagi habis pasien kepada perawat penanggung jawab pasien / perawat primer (PPJP/PP) untuk bertanggung jawab terhadap pasien yang menjadi kelolaannya dibantu oleh perawat associate di bawahnya 3. Identifikasi dan beri penandaan khusus pada pasien yang berisiko atau mempunyai riwayat melarikan diri 4. Pastikan tidak ada jalan / akses bagi pasien untuk melarikan diri 5. Akses keluar ruangan harus selalu dalam keadaan terkunci 6. Menemani pasien jika berada di luar area ruang

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**MENCEGAH PASIEN MELARIKAN DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.6/1213/2026	No.Revisi 04	Halaman : 2/2
	Cempaka 1, pada saat dan sesudah dibesuk 7. Beri aktivitas sesuai kemampuannya dan pantau terus selama melakukan aktivitas 8. Jika pasien tidak ada dalam ruangan petugas harus mencari sampai dipastikan pasien 9. Jika pasien gelisah atau bingung, kolaborasi dengan tim medis pemberian penenang 10. Motivasi keluarga untuk memenuhi kebutuhan pasien (membesuk secara teratur, menjemput pasien yang sudah boleh pulang) 11. Jika ada pasien yang keluar dari ruang Cempaka 1 atau keluyuran disekitar rumah sakit seluruh petugas RSUD dr Loekmono Hadi Kudus wajib menghubungi petugas di bangsal perawatan jiwa (Cempaka 1) dan mengantar kembali. 12. Pastikan system keamanan pendukung rumah sakit dalam siap dalam 24 jam		
UNIT TERKAIT	1. Seluruh karyawan 2. Sekuriti Rumah Sakit 3. Rekanan : petugas cleaning, warung makan, petugas parkir		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN SERAGAM KERJA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1194 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Ketentuan penggunaan pakaian kerja yang dirancang khusus untuk memudahkan ruang gerak dan mobilitas perawat dalam melakukan penanganan pasien jiwa, baik dalam tindakan asuhan keperawatan rutin maupun penanganan situasi darurat (gaduh gelisah).
TUJUAN	1. Memastikan perawat dapat bergerak fleksibel saat melakukan tindakan protektif atau bantuan hidup pada pasien. 2. Menjamin keamanan dan keselamatan perawat selama berinteraksi dengan pasien di ruang pelayanan jiwa.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Perawat menggunakan seragam yang tidak membatasi gerak tubuh (tidak ketat) untuk memudahkan mobilisasi cepat. a. Hari senin (kaos olahraga biru tua) b. Selasa (kaos Perkeswa Abu-abu) c. Rabu (kaos olahraga merah) d. Kamis (kaos Perkeswa Hitam tosca) e. Jumat (kaos Olahraga Putih) f. Sabtu (kaos Olahraga ungu) g. Minggu (kaos Perkeswa Merah tua) 2. Menggunakan tanda pengenal (ID Card) dengan model jepit untuk menghindari risiko ditarik atau disalahgunakan oleh pasien. 3. Baju kerja tidak boleh dipakai saat bernagkat/ pulang kerja dan pada waktu keluar dari ruangan perawatan jiwa. 4. Bagi perawat yang berhijab, wajib menggunakan model

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN SERAGAM KERJA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 900.7.6 / 1194 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	hijab bergo/instan (masukkan jilbab bergo/instan kedalam seragam/ baju kerja, tidak berpeniti. 5. Tidak diperkenankan menggunakan aksesori yang menjuntai atau tajam (kalung, anting, bros besar) yang dapat membahayakan perawat saat menangani pasien. 6. Menggunakan alas kaki tertutup dengan sol karet yang tidak licin untuk mendukung kecepatan gerak dan perlindungan kaki.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN SERAGAM PASIEN DIRAWAT INAP PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1193 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Seragarn pasien jiwa adalah pdkAian khusus yang dikenakan oleh pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa atau fasilitas kesehatan jiwa. Seragam ini memiliki fungsi untuk mengidentifikasi pasien, membedakan jenis kelamin, atau bahkan mengidentifikasi tingkat risiko pasien.
TUJUAN	1. Seragam dapat membantu membedakan pasien dengan staf, sehingga memudahkan komunikasi dan pengawasan. 2. Seragam yang nyaman dapat mengurangi stres dan kecemasan pasien. 3. Seragam yang sederhana dan tidak memiliki kantong atau aksesoris yang berpotensi membahayakan dapat mengurangi risiko pasien menyakiti diri sendiri atau orang lain. 4. Seragam yang mudah dikenali dapat membantu staf.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien 4. Beritahu tentang prosedur 5. Jaga privasi pasien 6. Memberikan pakaian seragam pasien untuk di

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN SERAGAM PASIEN DIRAWAT INAP PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1193 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	pakai selama masa perawatan. 7. Memasukan pasien kedalam bangsal.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENANGANAN *BULLYING* DI RUANG RAWAT INAP PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1198 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Buttying alau perundungan adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tindakan ini dapat berupa fisik, verbal, atau sosial, dan biasanya dilakukan secara berulang-ulang.
TUJUAN	Mencegah perilaku bullying berupa menyakiti, mengintimidasi, atau membuat orang lain merasa tidak berdaya.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Pasien korban bullying : a. Ucapkan Salam b. Perkenalkan diri c. Identifikasi pasien d. Jaga privasi pasien e. Bina hubungan saling percaya dengan pasien korban bulliying f. Identifikasi penyebab, jenis bullying pasien g. Berikan motivasi ke pasien untuk bisa sharing perasaannya dan permasalahannya h. Berikan dukungan pada korban bulying dalam bentuk melibatkan pasien untuk mengikuti

	kegiatan positif di lingkungan ruangan i. Latih pasien mengikuti kegiatan positif sesuai kemampuannya j. Berikan Reinforcement positif pada pasien, atas capaian kegiatan positifnya k. Berikan edukasi ke pasien untuk berperilaku baik dengan tidak membalas berperilaku buruk pada pelaku bullying l. Jika pasien bingung dan gelisah maka perlu terapi medis. 2. Pasien pelaku bullying a. Ucapkan Salam b. Perkenalkan diri c. Identifikasi pasien d. Jaga privasi pasien e. Bina hubungan saling percaya f. Identifikasi penyebab, jenis bullying g. Latih pasien menghentikan perilaku buruknya dengan cara melatih pasien mengikuti kegiatan positif di lingkungannya h. Berikan Edukasi ke pasien tentang dampak perilaku bulying terhadap orang lain Jika pasien bingung dan gelisah maka perlu terapi medis . 3. Petugas pelaku bullying a. Bina hubungan saling percaya b. Identifikasi penyebab, jenis bullying c. Edukasi petugas untuk menghentikan perilaku buruknya dengan cara melatih petugas mengikuti kegiatan positif di lingkungannya d. Berikan surat peringatan ke Petugas yang melakukan bullying
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENANGANAN PASIEN MELARIKAN DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1211 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Pasien yang pulang atau meninggalkan rumah sakit tanpa ijin / sepengetahuan petugas.
TUJUAN	Mengupayakan pasien kembali untuk menjalani pengobatan dan perawatan di RSUD dr Loekmono Hadi Ruang Perawatan Jiwa
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Segera aktifkan system keamanan rumah sakit pada saat pasien diketahui melarikan diri 2. Segera laporkan kepada atasan langsung dengan sepengetahuan PPJP baik langsung ditemukan atau tidak ditemukan 3. Laporan kepada atasan langsung adalah laporan secara tertulis tentang kronologi kejadian. (form laporan pasien melarikan diri) 4. Laporan yang telah dibuat diteruskan ke petugas Security. 5. Koordinasi. dengan supervisor dan security untuk mencari pasien disekitar ruangan dan sekitar lingkungan rumah sakit.. 6. Apabila pasien sudah ditemukan, perawat jaga berkolaborasi dengan dokter jaga untuk penanganan pasien. 7. Apabila pasien tidak langsung ditemukan atau ditemukan dalam kondisi cidera fisik sampai meninggal,maka perawat jaga harus memberitahukan keluarga dan dilakukan tindakan pelayanan masalah fisik / meninggal 8. Lakukan kolaborasi dengan dokter jaga untuk

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENANGANAN PASIEN MELARIKAN DIRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1211 / 2026	No.Revisi 04	Halaman : 2/2
	penanganan pasien yang ditemukan dalam kondisi cedera atau meninggal 9. Petugas Security segera lapor ke Polsek dan bukti laporan diserahkan kepada Sub Bagian PIP dan Bidang Keperawatan dan Pelayanan. 10. Apabila pasien tidak ditemukan lebih dari 24 jam, mak Sub Bagian PIP membuat surat penyampaian berita pada media elektronik. 11. Dalam waktu 2 x 24 jam, jika pasien belum ditemukan maka RM segera dilengkapi dan dikembalikan ke instalasi RM dan apabila keluarga menghendaki pasien dirawat kembali di RSJ maka harus melalui prosedur pendaftaran ulang. 12. Atasan langsung memberikan pembinaan kepada petugas 13. Petugas tidak dapat dituntut oleh keluarga apabila petugas telah melakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku.		
UNIT TERKAIT	1. Bidang Keperawatan 2. Bidang Pelayanan 3. Bagian Tata Usaha 4. Instalasi Gawat Darurat 5. Security		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENATALAKSANAAN GADUH GELISAH/AGITASI**		
	No.Dokumen 400.7.6/1208/2026	No.Revisi 03	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Kegawatdaruratan psikiatrik adalah suatu kondisi yang ditandai oleh adanya gangguan pada pikiran, perasaan dan perilaku seseorang yang memerlukan perhatian dan intervensi terapeutik segera. Termasuk di dalamnya kondisi yang berhubungan dengan gaduh gelisah (agitasi, agresif, perilaku kekerasan) dan percobaan bunuh diri, ditandai : Psikomotor meningkat ➢ Banyak bicara ➢ Mondar-mandir ➢ Lari-lari ➢ Loncat-loncat ➢ Destruktif ➢ Bingung Afek/emosi excitement ➢ Marah-marah ➢ Mengancam ➢ Agresif ➢ Ketakutan ➢ Euphoria
TUJUAN	Pasien tenang dan tidak gaduh gelisah lagi
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENATALAKSANAAN GADUH GELISAH/AGITASI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1208 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 2/2
PROSEDUR	1. Lakukan prinsip penatalaksanaan Kegawatdaruratan Psikiatri (strategi umum, modifikasi lingkungan) 2. Lakukan prinsip menenangkan dan menjamin keamanan 3. Lakukan penilaian kesadaran dan tanda-tanda cedera 4. Tawarkan untuk mengontrol kondisi gaduh gelisah dengan pemberian medikasi oral 5. Bila terapi oral ditolak atau gagal, dapat diberikan injeksi sesuai dengan kebutuhan 6. Bila pasien sulit untuk ditenangkan untuk pemberian injeksi, dapat dilakukan tindakan pengikatan fisik (restraint) dengan tujuan untuk membantu pasien mengendalikan diri, menjaga keselamatan pasien, dan memudahkan pemberian obat 7. Setelah kondisi pasien tenang, lakukan pemeriksaan yang diperlukan. Observasi pasien setiap 15 menit sekali, catat adanya peningkatan atau penurunan perilaku (terkait dengan perilaku, verbal, emosi, dan fisik) 8. Lakukan penilaian secara lengkap : wawancara, pemeriksaan fisik, neurologis dan status mental. 9. Lanjutkan medikasi dalam bentuk oral.		
UNIT TERKAIT	1. IGD 2. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL DIRAWAT INAP PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1220 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Pelecehan seksual adalah tindakan di sengaja yang mengarah pada seksualitas korban dan menyebabkan dampak buruk. Tindakan ini bias berupa verbal (kata-kata) atau non verbal (isyarat, gerakan) dan fisik (sentuhan) yang tidak diinginkan dan merendahkan martabat korban.
TUJUAN	Memastikan lingkungan Rumah Sakit aman dan nyaman bagi semua pasien, keluarga, pengunjung dan staf.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan Salam 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 4. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 5. Melaporkan ke perawat jaga jika terjadi tindakan kekerasan seksual Identifikasi adanya perlakuan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasien / petugas rawat inap psikiatri 6. Identifikasi ketidaksesuaian penjelasan dari pasien / petugas 7. Identifikasi adanya tanda-tanda trauma 8. Perawat jaga melaporkan ke kepala ruang jika terjadi

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL DIRAWAT INAP PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1220 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	kekerasan seksual 9. Menyelidiki laporan secara professional dan transparan 10. Kepala ruang membuat laporan ke tim PMKP Melindungi identitas dan kerahasiaan korban selama proses penanganan 11. Memberikan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban 12. Melakukan tindakan disiplin terhadap pelaku (bila yang melakukan petugas RS) sesuai peraturan RS dan ketentuan hokum 13. Memberikan pendampingan dan dukungan kepada pelaku untuk proses pemulihan dan rehabilitasi		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1191 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Penerimaan pasien baru merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh perawat ketika ada pasien baru datang ke sebuah ruangan rawat inap.
TUJUAN	1. Mengetahui keadaan pasien dan keluarga 2. Pasien bisa langsung menempati ruang perawatan 3. Mengetahui kondisi dan keadaan klien secara umum 4. Menurunkan tingkat kecemasan pasien saat MRS
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Tempat tidur dalam keadaan bersih dan siap pakai 2. Fasilitas yang bersedia dalam kondisi baik 3. Meja dan kursi pasien dalam keadaan bersih 4. Paket perawatan / souvenir 5. Lembar orientasi pasien baru dan keluarga 6. Berkas rekam medis 7. Peralatan untuk pemeriksaan dalam yang terdiri dari termometer, tensimeter, timbangan BB bila perlu. 8. Tahapan Penerimaan Pasien Baru : 9. Menyiapkan kelengkapan administrasi 10. Menyiapkan kelengkapan kamar sesuai pesanan 11. Menyiapkan format penerimaan pasien baru 12. Menyiapkan buku status pasien dan fommat pengkajian 13. Keperawatan 14. Menyiapkan inform consent 15. Menyiapkan nursing kids 16. Menyiapkan lembar tata tertib pasien, keluarga dan

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP PSIKIATRI</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.6 / 1191 / 2026</td><td>No.Revisi

01</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">pengunjung ruangan
17. Pasien datang diruangan diterima oleh perawat Perawat memperkenalkan diri pada klien dan keluarganya
18. Perawat melakukan identifikasi kepada pasien untuk menentukan perawatan di UPIP atau di ruang maintenance
19. Perawat bersama dengan petugas lain memindahkan pasien ke tempat tidur (apabila pasien datang dengan berangkat atau kursi roda) dan berikan posisi yang nyaman
20. Perkenalkan pasien baru dengan pasien yang sekamar
21. Setelah pasien tenang dan situasi sudah memungkinkan perawat memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang orientasi ruangan perawatan (termasuk perawat yang bertanggung jawab dan sentralisasi obat), medis (dokter yang bertanggung jawab dan jadwal visit) dan tata tertib ruangan.
22. Perawat menanyakan kembali tentang kejelasan dan informasi yang telah disampaikan
23. Perawat melakukan pengkajian terhadap pasien sesuai dengan format
24. Perawat menunjukkan kamar atau tempat tidur klien dan mengantarkan ke tempat yang telah ditetapkan.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Ruang rawat inap Psikiatri</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGELOLAAN PASIEN GELANDANGAN / TIDAK ADA IDENTITAS DIRUANG PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 400.7.3.4 /2152/ 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 September 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Staf Ahli Bupati Kudus bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19731008 200501 2 009	

PENGERTIAN	Pasien yang memerlukan perawatan dan pengobatan namun selama 2x24 jam: 1. Tidak ada keluarga /penanggung jawab 2. Tidak ada tempat tinggal dan pekerjaan
TUJUAN	Sebagai acuan untuk memberikan pelayanan kepada pasien terlantar /gelandangan sesuai prosedur yang yang berlaku.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	A. Tahap Penerimaan pasien 1. Pengantar (SatpolPP ,Relawan, Dinsos, atau Masyarakat Umum) mengisi formulir kronologi pernyataan penanggung jawab yang membawa pasien ke RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. 2. Petugas TPPRI melakukan pendataan 3. Pasien di masukkan IGD untuk dilakukan penanganan 4. Pasien dimasukkan ke Ruang Rawat inap Psikiatri 5. Petugas ruang melakukan identifikasi dan perawatan selanjutnya B. Tahap koordinasi internal 1. Petugas administrasi Ruang Rawat Inap Psikiatri melaporkan ke bidang pelayanan medik

2. Petugas Kerja Sosial Medis (Pekerja Sosial/Pekerja Sosial Kesehatan) atau Bagian Humas Rumah Sakit mendatangi pasien untuk melakukan asesmen penelusuran identitas dan asal-usul (apabila pasien kooperatif dan dapat diajak berkomunikasi).

C. Tahap koordinasi eksternal

1. Rumah Sakit memberitahukan kepada Dinas Sosial bahwa ada pasien gelandangan yang sedang di rawat di ruang rawat inap jiwa
2. Memberi tahu petugas DUKCAPIL untuk melakukan perekaman identitas.

D. Tahap Pemulangan

1. DPJP menyatakan pasien secara medis sudah stabil dan diperbolehkan pulang (*Discharge Planning*).
2. Perawat atau Petugas Penanggung Jawab Pasien (PPJP) melakukan verifikasi ulang status pasien (memastikan pasien memang tidak memiliki identitas/keluarga).

E. Tahap Pelaksanaan Pemulangan

1. Setelah mendapat surat persetujuan penerimaan atau konfirmasi dari Dinas Sosial/Panti Sosial:
   - Dokter membuat Resume Medis dan instruksi obat pulang (jika ada).
   - Perawat menyiapkan kebutuhan personal dasar pasien (pakaian yang layak dan bekal obat).
2. Pihak Dinas Sosial/ bila sudah ditemukan identitasnya Keluarga menjemput pasien langsung di Rumah Sakit (dengan sepengetahuan Dinas Sosial)
3. Melakukan penandatanganan Pasien Terlantar antara pihak Rumah Sakit dan pihak Dinas

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">PENGELOLAAN PASIEN GELANDANGAN / TIDAK ADA IDENTITAS DIRUANG PSIKIATRI</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.3.9/2152/2026</td><td>No.Revisi

01</td><td>Halaman :

3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Sosial/Panti Sosial di Buku Pulang Pasien.
F. Tahap Administrasi & Pencatatan
1. Petugas RS mendokumentasikan BAST yang telah ditandatangani kedua belah pihak ke dalam rekam medis pasien.
2. Petugas RS mendokumentasikan dengan sebuah bukti Foto Petugas Ruangan, Pasien, dan Petugas yang menjemputnya (Dinas Sosial/Satpol PP)
3. Bagian Kasir/Keuangan mengurus proses pembiayaan pasien sesuai dengan regulasi penjaminan pasien terlantar/PMKS yang berlaku (misal: APBD, Jamkesda, atau anggaran Rumah Sakit/CSR).
4. Status pasien di sistem informasi rumah sakit (SIMRS) ditutup secara resmi.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat darurat
4. Instalasi Humas
5. Instalasi Rekam Medis</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGELOLAAN PASIEN GELANDANGAN / TIDAK ADA IDENTITAS DIRUANG PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 100.7.6 / 1219 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Pasien yang memerlukan perawatan dan pengobatan di namun selama 2x24 jam: 1. Tidak ada keluarga /penanggung jawab 2. Tidak ada tempat tinggal dan pekerjaa
TUJUAN	Sebagai acuan untuk memberikan pelayanan kepada pasien terlantar /gelandangan sesuai prosedur yang yang berlaku
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Pengantrar pasien mengisi formulir kronologi I pemyataan penanggung jawab yang membawa pasien ke RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus 2. Pasien dimasukkan ke Ruang Rawat inap Psikiatri 3. Petugas ruang rawat inap psikiatri melaporkan ke bidang pelayanan medik 4. Rumah Sakit memberitahukan kepada Dinas Sosial bahwa ada pasien gelandangan yang sedang di rawat di ruang rawat inap jiwa 5. Memberi tahu petugas DUKCAPIL untuk melakukan perekaman identitas.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rekam Medik 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Ruang rawat inap Psikiatri

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGGUNAAN OBAT YANG BAIK DAN BENAR PADA PASIEN GANGGUAN JIWA**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1216 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan memahami manfaat obat / farmakologi dengan baik dan benar sesuai dengan advis dokter dengan harapan pasien tidak putus obat.
TUJUAN	1. Agar pasien gangguan jiwa mampu memahami manfaat obat bagi Kesehatan jiwanya 2. Agar pasien gangguan jiwa dapat mengerti akibat apabila pasien putus obat sendiri 3. Agar pasien gangguan jiwa mampu memberikan contoh pada pasien yang lain apabila pasien taat minum obat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi nomor 03 tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Ajak pasien duduk berhadapan dengan jarak 60 – 90 cm 3. Perkenalkan diri (nama, nama yang suka dipanggil, kerja pada shif apa) 4. Jelaskan maksud dan tujuan melakukan interaksi dengan pasien 5. Tanyakan pada pasien nama, nama yang suka dipanggil 6. Tanyakan pada pasien perasaan / kondisi yang sekarang dirasakan 7. Lakukan kontrak pertemuan yang terdiri dari waktu, tempat, dan topik. 8. Tanyakan tanda gejala apa saja yang dirasakan sebelum pasien minum obat 9. Diskusikan dengan pasien akibat bila pasien tidak teratur minum obat 10. Diskusikan dengan pasien apa yang akan pasien rasakan bila pasien tidak teratur minum obat lagi 11. Diskusikan dengan pasien, setelah pasien memahami akibat bial putus obat apakah pasien mau berhenti minum obat atau akan dilanjutkan minum obatnya. 12. Berikan pujian atas kehebatan pasien untuk taat minum obat

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PENGGUNAAN OBAT YANG BAIK DAN BENAR PADA PASIEN GANGGUAN JIWA**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1216 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	13. Tanyakan pada pasien perasaan setelah pasien paham akan manfaat obat dan akibat bila putus obat. 14. Minta pasien untuk mengulang kembali manfaat apa saja dari obat yang pasien minum 15. Berikan pujian atas keberhasilan pasien pemahaman pasien akan manfaat obat buat Kesehatan pasien 16. Lakukan kontrak pertemuan kedua dengan pasien yang terdiri dari: kontrak waktu, tempat dan topik (cara control marah spiritual)		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang rawat Jalan Psikiatri		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN PASCA ECT**		
	No.Dokumen 400.7.6/1210/2026	No.Revisi 03	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Perawatan pasca tindakan ECT adalah penatalaksanaan pada pasien setelah dilakukan tindakan ECT (Electro Convulsive Therapy).
TUJUAN	1. Meningkatkan mutu pelayanan. 2. Memantau kondisi pasien pasca tindakan ECT. 3. Mengetahui terjadinya komplikasi pasca tindakan sedini mungkin. 4. Terlaksananya keselamatan pasien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Periksa kesadaran dan tanda-tanda vital pasien setiap 30 menit, lakukan pengawasan selama 3 jam pasca tindakan. 2. Waspadai terjadinya postural hipotensi pada saat pasien mencoba berdiri. 3. Bila terjadi muntah atau hipotensi laporkan pada dokter ruangan. 4. Bila pasien masih pusing, tawarkan untuk berbaring atau tidur kembali. 5. Bila tidak ada keluhan dalam waktu setengah jam, pasien diperbolehkan minum dan makan.
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Psikiater 3. Dokter Anestesi 4. Dokter Jaga IGD

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PERAWATAN TOTAL PASIEN PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1218 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Pasien yang sedang di rawat di ruang psikiatri tidak boleh ditunggui demi kelancaran dalam pemberian terapi kepada pasien peikiatri
TUJUAN	1. Memberikan lingkungan bebas stressor pada pasien 2. Memberikan kebebasan pasien dalam mengungkapkan perasaannya.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri. 3. Berikan edukasi kepada pasien / keluarga dengan bahasa lang mudah dipahami tentang kebijakan diruang jiwa (Pasien jiwa yang di rawat inap tidak boleh ditunggui Keluarga). 4. Minta Keluarga pasien untuk mengisi nama penanggung jawab serta nomer telpon yang bisa dihubungi pada Lembar yang telah disediakan. 5. Bila ada keadaan darurat atau kepentingan ,petugas akan menghubungi nomer telpon keluarga 6. Ucapkan salam penutup
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RUJUKAN PASIEN JIWA KE LUAR RUMAH SAKIT**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1212 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Rujukan adalah Suatu proses penanganan pasien dengan mengirimkan pasien ke fasilitas pelayannan kesehatan yang lebih tinggi karena pasien tidak mampu ditangani difasilitas kesehatan saat ini dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu dengan menstabilkan pasien terlebih dahulu.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah- langkah dalam mendampingi pasien yang akan dirujuk keselamatan untuk menjaga pasien dalam perjalanan.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Surat rujukan telah dibuat sesuai prosedur pelayan rujukan 2. Perawat memberikan informasi lewat telpon tentang kondisi pasien kepada keluarga dan menyampaikan kalau pasien perlu dirujuk. 3. Perawat melakukan sisrute kepada Rumah Sakit yang dituju. 4. Perawat memberitahukan kepala petugas ambulance. Perawat membawa surat perintah tugas dari Rumah Sakit. Pasien dikirim ketempat yang dituju dengan pendamping pasien, 1 atau 2 peawat dengan membawa Emergency Psikiatri kit. 5. Selama pendampingan pasien, perawat selalu

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**RUJUKAN PASIEN JIWA KE LUAR RUMAH SAKIT**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1212 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 2/2
	memonitor dan mencatat kondisi pasien selama dalam perjalanan dalam blangko monitor. 6. Serah terima pasien antara perawat dengan perawat rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lain yang dituju. 7. Perawat kembali ke Rumah Sakit membuat laporan hasil perjalanan.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ambulancce		

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TATALAKSANA PEMULANGAN PASIEN RAWAT INAP PSIKIATRI**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1192 / 2026	No.Revisi 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Pemulangan pasien dalam keadaan sehat atau membaik adalah serangkaian proses kegiatan pemulangan pasien rawat inap dimulai pada saat Dokter penanggung jawab Pelayanan (DPJP) menyatakan pasien diperbolehkan pulang sampai pasien mendapatkan surat kontrol, terapi lanjutan dirumah, hasil pemeriksaan penunjang dan kuitansi pembayaran (untuk pasien umum).
TUJUAN	Sebagai acuan untuk pedoman petugas dalam pelayanan pasien yang sudah boleh pulang.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. DPJP menentukan tanggal kepulangan pasien 2. Perawat menghubungi keluarga t hari sebelum tanggal kepulangan 3. DPJP melengkapi dan menandatangani : a. Rekam medis terintegrasi b. Resume medis c. Lembar masuk dan keluar pasien , menulis diagnose akhir. d. Menulis resep untuk obat pulang e. Menulis surat konsultasi / pengantar bila pasien memerlukan konsultasi. 4. Perawat melengkapi dan mengecek kelengkapan berkas pasien pulang Perawat memberikan surat

	pengantar kepada keluarga pasien untuk menyelesaikan administrasi pembiayaan pasien. 5. Keluarga pasien menyerahkan bukti administrasi kepada petugas diruang rawat. 6. Perawat menyerahkan kepada keluarga pasien : a. Resume medis asli b. Pesan pasien pulang beserta penjelasan mengenai waktu dan tempat control, nama dan alamat instansi. c. Surat kontrol, surat konsul (bila dikonsulkan) surat keterangan d. Hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan e. Obat pulang beserta penjelasan mengenai cara peminuman dan dosis. f. Perawat melepaskan / mengganti baju pasien dengan baju yang sudah dibawakan keluarga dari rumah 7. Perawat menggunting gelang identitas pasien 8. Meminta nomor Hp keluarga untuk memudahkan komunikasi dengan keluarga 9. Sampaikan komitmen gratifikasi "Kami sangat berteimakasih apabila Bapak / Ibu untuk tidak membeikan bingkisan / barang / sesuatu kepada kami ". 10. Perawat mendampingi pasien menuju kendaraan pribadi / ambulance di pintu keluar Rumah Sakit
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri 2. Ruang Rekam Medik 3. Unit Farmasi 4. Kasir

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1217 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 22 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Terapi aktivitas kelompok adalah aktivitas membantu anggotanya untuk identitas hubungan yang kurang efektif dan mengubah tingkah laku yang maladaptive (Stuart & Sundeen, 1998). Terapi aktivitas kelompok merupakan salah satu terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada sekelompok klien yang mempunyai masalah keperawatan yang sama. Aktivitas digunakan sebagi terapi, dan kelompok digunakan sebagai target asuhan (Kelliat, 2005)
TUJUAN	1. Meningkatkan kemampuan menguji kenyataan yaitu memperoleh pemahaman dan cara membedakan sesuatu yang nyata dan khayalan. 2. Meningkatkan sosialisasi dengan memberikan kesempatan untuk berkumpul, berkomunikasi dengan orang lain, saling memperhatikan memberikan tanggapan terhadap pandapat maupun perasaan ortang lain. 3. Membangkitkan motivasi bagi kemajuan fungsi-fungsi psikologis seperti fungsi kognitif dan afektif. 4. Penyaluran emosi, merupakan suatu kesempatan yang sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan mentalnya
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Memilih klien sesuai dengan indikasi (homogenitas) 3. Membuat kontrak dengan klien, mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. 4. Salam terapeutik (Salam dari terapis kepada klien) 5. perkenalkan nama dan panggilan terapis (pakai papan nama), menanyakan nama dan panggilan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK)**		
	No.Dokumen 400.7.6 / 1217 / 2026	No.Revisi 03	Halaman : 2/2
	semua klien (beri papan nama). 6. Menanyakan perasaan klien saat ini. 7. Terapis menjelaskan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan, aturan main sebagai berikut : jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, harus minta ijin kepada terapis, lama kegiatan 45 menit, setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. 8. Terapis menjelaskan maksud dan tujuan serta prosedur terapi kelompok dan juga masalah yang akan dibicarakan dalam kelompok. Topik atau masalah dapat ditentukan oleh terapis atau usul klien. 9. Terapis sebaiknya bersifat moderat dan menghindarkan kata-kata yang dapat diartikan sebagai perintah. Terapis bukanlah guru, penasehat atau bukan pula wasit. Terapis lebih banyak pasif atau katalisator 10. Dalam prosesnya kalau terjadi bloking, terapis dapat membiarkan sementara. Bila bloking terlalu lama, terapis atau co-terapis merangsang anggota yang banyak bicara agar mengajak temannya yang kurang banyak bicara. 11. Kalau terjadi kekacauan, anggota yang menimbulkan terjadinya kekacauan dikeluarkan dan terapi aktifitas kelompok berjalan terus dengan memberikan penjelasan kepada semua anggota kelompok. 12. Setiap komentar atau permintaan yang datang dari anggota diperhatikan dan di tanggapi dengan sungguh-sungguh 13. Terapis meminta klien (sesuai tema dan jenis TAK) dimulai dari klien yang sebelah kanan, secara berurutan sampai semua klien mendapat giliran. Hasilnya tulis di whiteboard. 14. Beri pujian kepada klien yang melakukan dengan baik 15. Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok. 16. Terapis meminta klien melaporkan isi, waktu, situasi dan perasaannya jika terjadi halusinasi. 17. Menyepakati TAK yang akan datang.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang rawat inap Psikiatri		